INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

-- Medicina livre, contra os preços abusivos na medicina.

-- Venda proibida

-- @Livremedicina - twitter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345457)

Enunciado: Jovem masculino com 21 anos, feriu a região plantar esquerda ao caminhar descalço pela praia e pisar em um prego enferrujado. Fez de imediato limpeza com água corrente e procurou pronto atendimento, onde se observou lesão puntiforme profunda, limpa, sem corpos estranhos e sem nenhum outro dado relevante. Referia boa saúde e portava carteira vacinal, na qual constava última dose de vacina contra o tétano há 6 anos. Quanto à conduta a ser tomada, além dos cuidados locais, assinale a alternativa CORRETA:

A) Não há necessidade de conduta adicional.

B) Vacina (1 reforço) apenas.

C) Vacina (1 reforço) e soro antitetânico apenas.

D) Apenas administrar penicilina G benzatina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343778)

Enunciado: Atualmente, as telas, antes restritas à televisão, evoluíram para dispositivos de mídia como smartphones e tablets e fazem parte do cotidiano de pessoas de diferentes níveis sociais e faixas etárias, inclusive crianças em idades cada vez mais precoces. Usando seus conhecimentos sobre o tema, marque a resposta correta sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso de tela na infância.

A) Crianças com idades entre 2 e 5 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 2 horas/dia, sempre com supervisão de pais/cuidadores/responsáveis.

B) Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e desconectar 1-2 horas antes de dormir.

C) Adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogames a 5 horas/dia, e nunca deixar ""virar a noite"" jogando.

D) Crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 3 horas/dia, sempre com supervisão de pais/responsáveis.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343785)

Enunciado: L.D.O., comparece em consulta de puericultura com sua filha de 4 meses de idade, para solicitar orientações quanto ao calendário vacinal. Relata que a criança esteve internada nos últimos 15 dias devido a um quadro de pneumonia e que as últimas vacinas realizadas as foram as do segundo mês de vida. Qual das opções abaixo corresponde a conduta adequada para atualização do calendário vacinal

A) Meningocócica conjugada C deve ser administrada hoje e a Pentavalente, Rotavírus, VIP, Pneumocócica conjugada 10 devem ser administradas na próxima semana.

B) Meningocócica conjugada 10 devem ser administrada hoje e retorno em 1 mês para atualizar as outras vacinas.

C) Meningocócica conjugada C e a Pentavalente.

D) Meningocócica conjugada C, Pentavalente, VIP, Penumocócica conjugada 10, Rotavírus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343794)

Enunciado: Escolar com 10 anos de idade, comparece em consultório pediátrico com índice de massa corporal (IMC) de 20kg/m². Após observar a curva de IMC, defina o diagnóstico do estado nutricional da criança.

A) Sobrepeso.

B) Risco de sobrepeso.

C) Eutrofia.

D) Obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345478)

Enunciado: Gestante de 16 anos refere ter tomado 2 doses da vacina contra o HPV antes de engravidar. A última dose foi há 1 ano. Assinale a opção que indica a orientação que deverá ser dada em relação à 3ª dose:

A) Pode ser administrada durante a gravidez.

B) Deverá ser postergada para depois do parto.

C) Não pode ser utilizada no período de lactação.

D) Deverá repetir todo o esquema vacinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343809)

Enunciado: A utilização de curvas de crescimento no acompanhamento de crianças na Atenção Primária é ferramenta importante para o diagnóstico precoce de desnutrição infantil. As curvas são compostas por marcações em um gráfico que indicam os parâmetros de normalidade, que podem ser representadas por linhas conforme os chamados escores Z ou pelos percentis. Em um gráfico Peso-idade, se uma criança de 1 ano e 4 meses tem o peso marcado justamente em cima da linha do percentil 50, isso indica que:

A) A criança tem o peso igual à mediana para a idade.

B) A criança pesa menos que 50% das crianças da mesma idade.

C) A criança está em situação de desnutrição, devendo ser encaminhada imediatamente ao pediatra.

D) A criança não precisa mais ser acompanhada com a marcação na curva, pois seu peso está normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345501)

Enunciado: Criança com 7 meses de vida realizando consulta de puericultura. O pediatra observou que seu cartão de vacinas está atrasado. Avaliando o cartão, tinha realizado as seguintes vacinas: BCG, hepatite B ao nascer; com 2 meses fez a Penta /VIP/Penumococo 10 e Rotavírus; aos 3 meses a Meningocco C. Quais as vacinas estão faltando nessa faixa etária segundo cartão de vacinas do Ministério da Saúde?

A) 4 meses: VIP; 5 meses: Meningocócica C; 6 meses: Penta, VIP e Gripe.

B) 4 meses: Penta, VIP, Rotavírus e Pneumocócica 10; 5 meses: Meningocócica C; 6 meses: Penta, VIP e Gripe.

C) 4 meses: Penta, VIP, Rotavírus; 5 meses: Meningocócica C; 6 meses: Penta, VIP e Gripe.

D) 4 meses: Rotavírus e Pneumocócica 10; 5 meses: Meningocócica C; 6 meses: Penta, VIP e Gripe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281144)

Enunciado: Menino de 6 anos foi mordido, na mão esquerda, pelo cão da vizinha pego na rua há 2 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a conduta a ser tomada deve ser:

A) vacina antirrábica 2 doses (0 e 3 dias após exposição) + observação do cão por 10 dias, encerrar o caso, se nada ocorrer com o animal.

B) observar o cão por 10 dias.

C) vacina antirrábica 3 doses (0, 3 e 7 dias após exposição).

D) vacina antirrábica 5 doses.

E) vacina antirrábica 5 doses (0, 3, 7, 14 e 28 dias após exposição) + soro antirrábico por tratar-se de lesão grave (mãos).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281149)

Enunciado: Considerando que alterações hormonais podem estar presentes em algumas síndromes genéticas, assinale a alternativa correta.

A) Pacientes com cromossomopatias que possuem peso e comprimento normais ao nascer serão adultos com estatura normal.

B) Na síndrome de Prader-Willi, apesar da presença de baixa estatura e obesidade, não são identificadas alterações hormonais.

C) Pacientes com acondroplasia apresentam desproporção dos segmentos corporais e deficiência grave de hormônio de crescimento.

D) Na síndrome de Turner, a baixa estatura é devida ao hipogonadismo e à deficiência de hormônio de crescimento.

E) Pacientes portadores da síndrome de Down e da síndrome de Turner possuem maior risco para desenvolverem hipotireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283333)

Enunciado: A vacinação contra a febre amarela na gestação é:

A) Contraindicada.

B) Recomendada da mesma forma que para não grávidas.

C) Recomendada quando em viagens para zonas endêmicas.

D) Recomendada de rotina em gestações suscetíveis.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281183)

Enunciado: Segundo o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde do Brasil (2017), a idade máxima da criança para receber vacina contra Hepatite A, para quem perdeu a oportunidade de se vacinar, anteriormente, foi ampliada para:

A) 2 anos.

B) 3 anos.

C) 4 anos.

D) 6 anos.

E) 8 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281185)

Enunciado: O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde do Brasil (2017) não prevê vacina contra:

A) vírus do sarampo, rubéola e caxumba.

B) vírus da hepatite B.

C) meningococo do tipo C.

D) meningococo do tipo B.

E) vírus papiloma humano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251919)

Enunciado: Com relação a vacinação contra o HPV, na adolescência, assinale com a recomendação atual do Ministério da Saúde:

A) Três doses com intervalo de 6 meses em meninas de 9 a 14 anos.

B) Duas doses com intervalo de 6 meses em meninos de 9 a 14 anos.

C) Duas doses com intervalo de 6 meses em meninas de 11 a 14 anos.

D) Duas doses com intervalo de 6 meses em meninos de 11 a 14 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251920)

Enunciado: A desnutrição energético-proteica ainda é frequentemente encontrada no nosso país, principalmente no nosso estado, logo marque a alternativa CORRETA sobre essa patologia:

A) A forma clínica marasmo tem como característica alterações na pele, alterações no cabelo, hepatomegalia e face de lua cheia.

B) A terapia nutricional inicial para o tratamento dos desnutridos graves deve ser hipercalórica e hiperproteica na primeira semana de tratamento.

C) Os sinais de desidratação na criança desnutrida são mais difíceis de ser avaliados pela escassez de tecido celular subcutâneo, sendo sinais clínicos como frequência cardíaca, débito urinário muito importantes.

D) A reposição de ferro e de zinco deve ser realizadas na fase de estabilização junto ao tratamento de infecções e correção dos distúrbios metabólicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251932)

Enunciado: Com relação a obesidade infantil, marque a alternativa INCORRETA.

A) Os casos de sobrepeso no Brasil vêm aumentando nas últimas três décadas.

B) Medicamentos como sibutramina e orlistat podem ser usados no tratamento farmacológico desta entidade em adolescentes.

C) A abordagem interdisciplinar é considerada a maneira mais adequada para o tratamento da obesidade infantil.

D) O consumo energético deve ser reduzido drasticamente, com dietas rígidas visando a perda de peso rapidamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251934)

Enunciado: As assertivas abaixo são relativas a desnutrição energético-protéica, tipo Kwashiorkor, EXCETO:

A) Alterações na pele (lesões hipocrômicas ao lado de hipercrômicas, com descamação).

B) Hepatomegalia (decorrente da esteatose).

C) Desaparecimento da bola de Bichat.

D) Ascite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217700)

Enunciado: O raquitismo é uma doença caracterizada pela redução da mineralização da placa epifisária de crescimento, corresponde à apresentação clínica da deficiência da vitamina D em lactentes e crianças maiores. Para prevenção dessa patologia, o Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria propõe algumas recomendações. Marque qual alternativa contempla melhor essa recomendação.

A) Exposição solar diária de 30 minutos/dia, para lactentes apenas com fraldas no 1º ano de vida, ou de 2 horas semanais em lactentes em uso de vestimentas com exposição apenas da face e mãos, além da suplementação profilática de vitamina D na dose de 400 UI/dia a partir da 1ª semana de vida até os 12 meses de idade, e de 600 UI/dia dos 12 aos 24 meses para crianças não amamentadas ao seio materno.

B) Exposição solar diária de 30 minutos/semana, para lactentes apenas com fraldas no 1º ano de vida, ou de 2 horas semanais em lactentes em uso de vestimentas com exposição apenas da face e mãos, além da suplementação profilática de vitamina D na dose de 200 UI/dia a partir da 1ª semana de vida até os 12 meses de idade, e de 400 UI/dia dos 12 aos 24 meses para crianças amamentadas ou não ao seio materno.

C) Exposição solar diária de 30 minutos/semana, para lactentes apenas com fraldas no 1º ano de vida, ou de 2 horas semanais em lactentes em uso de vestimentas com exposição apenas da face e mãos, além da suplementação profilática de vitamina D na dose de 400 UI/dia a partir da 1ª semana de vida até os 12 meses de idade, e de 600 UI/dia dos 12 aos 24 meses para crianças não amamentadas ao seio materno.

D) Exposição solar diária de 30 minutos/semana, para lactentes apenas com fraldas no 1º ano de vida, ou de 2 horas semanais em lactentes em uso de vestimentas com exposição apenas da face e mãos, além da suplementação profilática de vitamina D na dose de 400 UI/dia a partir da 1ª semana de vida até os 12 meses de idade, e de 600 UI/dia dos 12 aos 24 meses para crianças amamentadas ou não ao seio materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182618)

Enunciado: Com relação à Desnutrição Energética Proteica (DEP) grave na infância, leia as assertativas: I. Os sinais clássicos de hipoglicemia como palidez, hipotermia, sudorese e perda da consciência nem sempre estão presentes. II. São distúrbios hidroeletrolíticos frequentes no desnutrido: hipopotassemia, hiponatremia, hipermagnesemia e hiperfosfatemia, III. São 3 etapas de tratamento da DEP grave: fase de estabilização ou inicial, fase de reabilitação ou de crescimento rápido e fase de seguimento ou acompanhamento. Quais afirmativas estão CORRETAS?

A) I, II e III.

B) I e II.

C) II e III.

D) I e III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182665)

Enunciado: Nos últimos anos, o Ministério da Saúde (MS) vem realizando várias mudanças no Calendário Básico Vacinal, qual das recomendações abaixo NÃO faz parte do calendário preconizado atualmente pelo MS?

A) A vacina contra o HPV é preconizada para meninos de 12 a 13 anos.

B) O reforço da BCG deve ser feito aos 10 anos.

C) A vacina contra a febre amarela deve ser administrada em dose únicas aos 9 meses.

D) A vacinação contra a hepatite A é recomendada aos 15 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183214)

Enunciado: A vacina contra Haemophilus influenzae tipo b não protege contra qual das patologias abaixo:

A) Meningite.

B) Otite.

C) Artrite séptica.

D) Epiglotite.

E) Celulite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159090)

Enunciado: Criança de 4 meses de idade vem à consulta médica trazida pela mãe, que está bastante preocupada, pois a filha não apresentou a reação esperada da BCG. O pediatra constata que não tem cicatriz da vacina na região deltoide do braço direito. A conduta mais indicada nesse caso é:

A) Revacinar imediatamente.

B) Realizar PPD, se reator, iniciar tratamento.

C) Aguardar até 6 meses de vida, se não fizer cicatriz, deverá ser revacinada.

D) Nenhuma das alternativas acima está correta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135951)

Enunciado: De acordo com a classificação de desnutrição segundo Gómez, um lactente cujo o peso se encontra maior ou igual ao percentil 61 e menor ou igual ao percentil 75 apresenta-se em qual categoria nutricional?

A) Eutrófico;

B) Desnutrição de 1° grau ou leve;

C) Desnutrição de 2° grau ou moderada;

D) Desnutrição de 3° grau ou grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108791)

Enunciado: Paciente de cinco anos de idade, sexo feminino, peso de 44 kg, com dificuldade parcial de locomoção (não acompanha os coleguinhas nas atividades físicas), vítima de bullying no colégio devido ao elevado peso, com acantose nigricans e apneia do sono. Exames: glicemia de 115 mg/dl em jejum; triglicerídeos de 151 mg/dl; colesterol total de 300 mg/dl; HDL de 32 mg/dl; LDL de 120 mg/dl e PAS de 120 x 81 mmHg. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a diretriz de aterosclerose na infância e na adolescência, qual a melhor opção terapêutica?

A) Iniciar estatinas e ciprofibrato imediatamente.

B) Internar a paciente e prepará-la para cirurgia bariátrica.

C) Acompanhar e direcionar a paciente para nutricionista, educador físico, apoio psicológico para a paciente e família, fazendo um atendimento com equipe interdisciplinar.

D) Iniciar imediatamente antilipêmicos, anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84474)

Enunciado: Na Doença Celíaca marque as assertivas Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 1º ( ) Pode ser causada também por ingestão do leite de vaca. 2º ( ) É uma intolerância transitório induzida pelo glúten na dieta. 3º ( ) É uma enteropatia mediada por linfócitos T em indivíduos geneticamente predispostos. 4º ( ) A forma clássica caracteriza-se por diarreia crônica com fezes volumosas, pálidas e gordurosas podendo ter evolução grave. 5º ( ) Leite, derivados e ovos não são permitidos na dieta do doente celíaco. Assinale as alternativas corretas na ordem marcada:

A) FFVVF;

B) VFFVF;

C) VFVFF;

D) FFVFV;

E) FVFVV;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84494)

Enunciado: Atualmente a obesidade é um problema de saúde pública tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento, acometendo inclusive as crianças. Em relação à obesidade e aos fatores de risco a ela associados, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O Índice de Massa Corporal (IMC) é o peso em kg dividido pelo quadrado da altura em metros.

B) A amamentação do recém-nascido reduz os riscos de dislipidemia e diabetes na idade adulta.

C) Síndrome metabólica é definida como a associação de obesidade, IMC acima de 30 e aumento da circunferência abdominal.

D) Em crianças considera-se sobrepeso o IMC acima do percentil 85 para a idade e sexo e obesidade o IMC acima de 95.

E) A obesidade infantil secundária à endocrinopatia ocorre em menos de 1% dos casos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84470)

Enunciado: Em relação às dislipidemias, em que idade se deve avaliar o perfil lipídico como rotina em crianças e quais os valores desejáveis?

A) Aos 10 anos. Colesterol total < 150 mg/dl, LDL colesterol < 100 mg/dl, HDL colesterol 45 mg/dl, triglicerídeos < 100 mg/dl.

B) Aos 7 anos. Colesterol total 150 mg/dl, LDL colesterol 120 mg/dl, HDL colesterol 45 mg/dl, triglicerídeos 120 mg/dl.

C) Aos 15 anos. Colesterol total <150 mg/dl, LDL colesterol <100 mg/dl, HDL colesterol 45 mg/dl, triglicerídeos <100 mg/dl.

D) Aos 10 anos. Colesterol total 160 mg/dl, LDL colesterol 120 mg/dL, HDL colesterol 45 mg/dl, triglicerídeos <100 mg/dl.

E) Aos 15 anos. Colesterol total 160 mg/dl, LDL colesterol 120 mg/dl, HDL colesterol 45 mg/dl, triglicerídeos 120 mg/dl.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50100)

Enunciado: Escolar de oito anos de idade, sexo masculino, com sobrepeso, tem a Pressão Arterial (PA) aferida no percentil 95. Após duas aferições, em consultas separadas, a PA se mantém no percentil 95. A conduta CORRETA é:

A) Iniciar imediatamente tratamento para hipertensão arterial;

B) Considerar que a pressão é limítrofe normal para a idade e manter rotina pediátrica;

C) Realizar avaliação diagnóstica e iniciar tratamento farmacológico;

D) Monitorar PA, se persistir elevada, realizar avaliação diagnóstica e considerar tratamento para hipertensão arterial;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37129)

Enunciado: Sobre Síndrome Metabólica (SM) na infância, é correto afirmar que:

A) Os critérios diagnósticos são diferentes dos critérios diagnósticos dos adultos.

B) Os pontos de cortes para os componentes são idênticos aos dos adultos.

C) Os pontos de corte devem ser obtidos da distribuição para cada variável de acordo com o sexo e a idade correspondendo aos percentis 5 e 95.

D) A PA maior ou igual a 130 x 80 mmHg é considerada hipertensão na infância.

E) Diferentemente dos adultos, não está relacionado com a obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29391)

Enunciado: Ao fazer uma visita domiciliar para uma família da área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família com o objetivo de estudar o caso de uma criança de 9 meses que a agente comunitária de saúde apontou como problemática, você analisa as curvas de crescimento e constata que a criança do percentil 3 do índice peso/idade, e vem apresentando dificuldade de ganho de peso desde os 8 meses. Somente a partir deste dado objetivo o médico pode inferir que essa criança provavelmente apresenta um quadro de:

A) obesidade.

B) sobrepeso.

C) normalidade.

D) risco nutricional.

E) desnutrição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307027)

Enunciado: Mulher, 20 anos de idade, estudante de veterinária, procura por pronto-atendimento após mordedura de mico (sagui de tufo branco, com nome científico Callithrix jacchus), há 4 horas. Refere que o animal está em cativeiro, podendo ser observado, e aparentemente está saudável. Nega comorbidades. Ao exame, apresenta pequeno ferimento cortocontuso superficial em braço direito, sem outras alterações. Diante do caso, Considerando a classificação do acidente em relação à raiva, é correto afirmar:

A) O acidente é considerado leve por ter atingido um membro.

B) O acidente é considerado grave por ter sido causado por mamífero silvestre.

C) O acidente é considerado leve por ser superficial e o animal ser observável.

D) O acidente é considerado grave por tratar-se de ferimento em membro superior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307028)

Enunciado: Mulher, 20 anos de idade, estudante de veterinária, procura por pronto-atendimento após mordedura de mico (sagui de tufo branco, com nome científico Callithrix jacchus), há 4 horas. Refere que o animal está em cativeiro, podendo ser observado, e aparentemente está saudável. Nega comorbidades. Ao exame, apresenta pequeno ferimento cortocontuso superficial em braço direito, sem outras alterações. Diante do caso, Em relação à profilaxia de raiva, pode ser afirmar:

A) É obrigatória profilaxia com vacinas e imunoglobulina antirrábica ou soro antirrábico.

B) É necessária profilaxia com esquema vacinal, que pode ser suspenso após observação do animal por 10 dias.

C) Como o animal é passível de observação, e sem sinais sugestivos de raiva, não há necessidade de profilaxia.

D) A profilaxia deve ser mantida, independentemente do resultado negativo na análise laboratorial do animal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307029)

Enunciado: Mulher, 20 anos de idade, estudante de veterinária, procura por pronto-atendimento após mordedura de mico (sagui de tufo branco, com nome científico Callithrix jacchus), há 4 horas. Refere que o animal está em cativeiro, podendo ser observado, e aparentemente está saudável. Nega comorbidades. Ao exame, apresenta pequeno ferimento cortocontuso superficial em braço direito, sem outras alterações. Diante do caso, Em relação à conduta mais adequada, é correto afirmar:

A) A mordedura do animal pode transmitir alguns tipos de herpes, sendo indicada medicação antiviral.

B) Deve-se utilizar solução alcoólica na limpeza da lesão, para evitar infecção secundária.

C) Como a paciente é estudante de veterinária, deverá receber vacina antirrábica anualmente.

D) A notificação compulsória é desnecessária, sendo obrigatória se for animal sintomático para raiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315209)

Enunciado: Qual a patologia caracterizada pela triade dos três Ds (demência, diarreia e dermatite);

Ocorre por carência de que elemento específico?

A) Escorbuto - vitamina C.

B) Beriberi - vitamina D.

C) Pelagra ? niacina.

D) Anemia - fator intrínseco.

E) Porfiria - serotonina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275988)

Enunciado: Rafael, 6 anos, foi à UBS acompanhado de sua mãe apresentando febre moderada, conjuntivite com fotofobia, tosse intensa e manchas branco-azuladas com halo eritematoso na mucosa jugal. O quadro inicial durou dois dias. No terceiro dia, isto é, no dia da consulta, surgiram lesões maculopapulares eritematosas com áreas de pele sã de permeio. A mãe de Rafael afirma que as lesões começaram próximo à linha de implantação capilar, região retroauricular e nuca. A mãe de Rafael, Ana, estava preocupada, pois é uma gestante de 25 semanas. Além disso, afirmou também que na casa onde moram há Jorge, 4 meses, Maria, 1 ano e Bernardo, 14 anos. Por fim, ao ser questionada, Ana revelou que nenhum de seus filhos é imunocomprometido e que não lembrava se seus filhos eram vacinados. Em relação à prevenção pós- exposição de Ana, Jorge, Maria e Bernardo, assinale a alternativa CORRETA.

A) Ana, Jorge, Maria e Bernardo irão receber a vacinação de bloqueio ao final da consulta.

B) Ana e Jorge irão receber a vacinação de bloqueio ao final da consulta.

C) Apenas Jorge irá receber a vacinação de bloqueio ao final da consulta.

D) Apenas Maria irá receber a vacinação de bloqueio ao final da consulta.

E) Maria e Bernardo irão receber a vacinação de bloqueio ao final da consulta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275991)

Enunciado: Pedro, 1 ano, vai à UBS acompanhado de seu pai para consulta regular. O médico solicita o cartão de vacina de Pedro e verifica que ele necessita das vacinas de 1 ano de idade. Segundo o Ministério da Saúde, quais seriam as vacinas a serem administradas em uma criança de 1 ano?

A) Apenas o reforço da Pneumocócica 10V e a 1ª dose da Tríplice viral.

B) Reforço da Pneumocócica 10V, reforço da Meningocócica C e 1ª dose da Tríplice viral.

C) Apenas o reforço da Pneumocócica 10V e o reforço da Meningocócica C.

D) Apenas a 1ª dose da Tríplice viral.

E) Apenas o reforço da Meningocócica C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283745)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando o parâmetro "escore z", adotado pela OMS, indique a classificação correta para o peso e a estatura dessa lactente.

A) Ganho de peso e de estatura adequados.

B) Ganho de peso e crescimento inadequados.

C) Ganho de peso adequado e crescimento inadequado.

D) Ganho de peso inadequado e crescimento adequado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231365)

Enunciado: A imunização antitetânica é recomendada para as gestantes para a prevenção do tétano neonatal. Para gestantes sem história de vacinação, iniciar o esquema o mais precocemente possível em qualquer fase da gestação, com intervalos de 30 a 60 dias. Pelo geral estas vacinas estão proscritas na gravidez, exceto:

A) Hepatite A e B; Vacina contra influenza (inclusive H1N1)

B) Rubéola; sarampo.

C) Caxumba.

D) Pólio oral (Sabin).

E) Varicela; febre amarela.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249204)

Enunciado: Sobre a criança com déficit de crescimento, assinale a alternativa correta.

A) O crescimento do perímetro cefálico é mais afetado pela nutrição inadequada.

B) A ingestão oral da criança pode ser limitada por atrasos do desenvolvimento, com incoordenação da sucção-deglutição- respiração e sonolência.

C) O prematuro raramente apresenta aversão ao contato oral.

D) A restrição de crescimento intrauterino é a causa mais comum de déficit de crescimento em prematuros.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252918)

Enunciado: Menino, 15 dias de vida, nascido com idade gestacional de 35 semanas, pesando 1700g, chega a UBS para acompanhamento de Puericultura. No momento, seu peso é de 1750g. Está ativo e em aleitamento misto. Não iniciou vacinação na maternidade. Com base no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, indique qual o momento indicado pelo PNI para início do esquema vacinal nessa criança.

A) Até os 28 dias de vida.

B) Até os 30 dias de vida.

C) Nas primeiras 12 horas de vida.

D) Nas primeiras 24 horas de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252919)

Enunciado: Menino, 15 dias de vida, nascido com idade gestacional de 35 semanas, pesando 1700g, chega a UBS para acompanhamento de Puericultura. No momento, seu peso é de 1750g. Está ativo e em aleitamento misto. Não iniciou vacinação na maternidade. Indique qual(is) vacina(s) deve(m) ser administrada(s) nessa criança nesse momento.

A) apenas BCG.

B) apenas vacina contra Hepatite B.

C) BCG e vacina contra Hepatite B.

D) BCG e vacinas contra Hepatite A e B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252920)

Enunciado: Menino, 15 dias de vida, nascido com idade gestacional de 35 semanas, pesando 1.700g, chega a UBS para acompanhamento de Puericultura. No momento, seu peso é de 1.750g. Está ativo e em aleitamento misto. Não iniciou vacinação na maternidade. Indique o momento adequado para o retorno desse bebê ao posto de vacinação, para dar andamento ao esquema de imunização.

A) Retornar quando atingir 2.500 g de peso.

B) Retornar quando atingir 2.000 g de peso.

C) Retornar quando completar 30 dias de vida.

D) Retornar quando completar 2 meses de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252927)

Enunciado: Menino, 8 meses de idade, é levado à consulta de puericultura na UBS, para iniciar acompanhamento. Foi amamentado exclusivamente com leite materno até os 5 meses de idade. Atualmente usa leite integral de vaca e outros alimentos introduzidos na mesma época. A caderneta da criança demonstra que nasceu com idade gestacional de 37 semanas e 3 dias; Apgar 7 e 9; sem intercorrências; Peso: 2980g; Comprimento: 49cm. Não há registro de dados antropométricos posteriores. Os Testes de Triagem Neonatal não apresentaram alterações. Ao exame físico, ativo, hidratado, bom estado geral, mucosas hipocoradas +/4. Há 2 dentes incisivos inferiores e os superiores em processo de eclosão. Auscultas cardíaca e pulmonar sem anormalidades. Sem alterações em abdome, em genitália e em extremidades. No momento, Peso: 6030g; Comprimento 69cm. Considerando os gráficos antropométricos, adotados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, informe a classificação dessa criança quanto ao Peso e Comprimento no nascimento:

A) Ambos adequados para a idade gestacional.

B) Ambos inadequados para a idade gestacional.

C) Peso adequado e Comprimento inferior ao esperado para a idade gestacional.

D) Peso inferior ao esperado e Comprimento adequado para a idade gestacional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252928)

Enunciado: Menino, 8 meses de idade, é levado à consulta de puericultura na UBS, para iniciar acompanhamento. Foi amamentado exclusivamente com leite materno até os 5 meses de idade. Atualmente usa leite integral de vaca e outros alimentos introduzidos na mesma época. A caderneta da criança demonstra que nasceu com idade gestacional de 37 semanas e 3 dias; Apgar 7 e 9; sem intercorrências; Peso: 2980g; Comprimento: 49cm. Não há registro de dados antropométricos posteriores. Os Testes de Triagem Neonatal não apresentaram alterações. Ao exame físico, ativo, hidratado, bom estado geral, mucosas hipocoradas +/4. Há 2 dentes incisivos inferiores e os superiores em processo de eclosão. Auscultas cardíaca e pulmonar sem anormalidades. Sem alterações em abdome, em genitália e em extremidades. No momento, Peso: 6030g; Comprimento 69cm. Indique a classificação dessa criança quanto ao Peso e ao Comprimento, no momento atual.

A) Ambos adequados para a idade.

B) Ambos inadequados para a idade.

C) Peso adequado e Estatura inferior ao esperado para a idade.

D) Peso inferior ao esperado e Estatura adequada para a idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252929)

Enunciado: Menino, 8 meses de idade, é levado à consulta de puericultura na UBS, para iniciar acompanhamento. Foi amamentado exclusivamente com leite materno até os 5 meses de idade. Atualmente usa leite integral de vaca e outros alimentos introduzidos na mesma época. A caderneta da criança demonstra que nasceu com idade gestacional de 37 semanas e 3 dias; Apgar 7 e 9; sem intercorrências; Peso: 2980g; Comprimento: 49cm. Não há registro de dados antropométricos posteriores. Os Testes de Triagem Neonatal não apresentaram alterações. Ao exame físico, ativo, hidratado, bom estado geral, mucosas hipocoradas +/4. Há 2 dentes incisivos inferiores e os superiores em processo de eclosão. Auscultas cardíaca e pulmonar sem anormalidades. Sem alterações em abdome, em genitália e em extremidades. No momento, Peso: 6030g; Comprimento 69cm. Indique a idade a partir da qual o Índice de Massa Corpórea é o indicador mais adequado para avaliar a proporção Peso/Estatura.

A) 1 ano.

B) 2 anos.

C) 5 anos.

D) 10 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252933)

Enunciado: No Brasil, o câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente entre mulheres, após o câncer de mama, com alta mortalidade e faz, por ano, 4800 vítimas fatais. Em 2012, as estimativas foram de 17540 casos novos, com risco estimado variando de 17 a 21 casos a cada 100 mil mulheres, com grandes iniquidades regionais, sendo maiores as incidências registradas em estados com menor nível de desenvolvimento socioeconômico. BRASIL, Ministério da Saúde. Informe Técnico sobre a Vacina Papiloma Vírus Humano (HPV) na Atenção Básica. A vacina contra o HPV, considerando sua disponibilidade pelo SUS, faz parte do calendário vacinal para:

A) Crianças a partir de 2 anos.

B) Mulheres a partir de 12 anos.

C) Mulheres de 9 a 14 anos e homens de 11 a 14 anos.

D) Mulheres e homens de 11 a 22 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201773)

Enunciado: A imunização antitetânica é recomendada para as gestantes para a prevenção do tétano neonatal. Para gestantes sem história de vacinação, iniciar o esquema o mais precocemente possível em qualquer fase da gestação, com intervalos de 30 a 60 dias. Pelo geral estas vacinas estão proscritas na gravidez, exceto:

A) Hepatite A e B; Vacina contra influenza (inclusive H1N1)

B) Rubéola; sarampo.

C) Caxumba.

D) Pólio oral (Sabin).

E) Varicela; febre amarela.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219913)

Enunciado: Lactente de 6 meses, em consulta da puericultura, apresenta vacinação atualizada, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, mas a mãe relata que criança não apresenta cicatriz da vacina BCG. Ao exame físico, lactente sem a marca da BCG. A MELHOR CONDUTA em relação a vacina de BCG neste caso será:

A) Fazer teste anti-HIV para excluir imunodepressão e, se negativo, revacinar.

B) Não revacinar, acompanhar a evolução até os doze meses.

C) Revacinar aos doze meses de vida, se assintomática.

D) Revacinar sem qualquer exame laboratorial prévio, se assintomática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219897)

Enunciado: Escolar de 8 anos, gênero masculino, comparece ao centro de saúde acompanhado por sua mãe que se mostra preocupada com o peso da criança. À avaliação clínica foram encontrados peso de 34 kg e estatura de 125 cm. A criança tem uma alimentação rica em guloseimas e gorduras. Realiza atividades físicas na escola 2 vezes na semana. Em casa, gosta de ficar assistindo televisão e jogando jogos no computador por aproximadamente 3 horas por dia. Ao exame, apresenta hepatomegalia (fígado a 3 cm RCD) não dolorosa e aumento do panículo adiposo, sem outros achados significativos. Diante do quadro exposto acima e utilizando o gráfico e a equação abaixo, a conduta INCORRETA para o caso é:

A) Considerar o diagnóstico de sobrepeso para este paciente e solicitar exames laboratoriais: glicemia de jejum e perfil lipídico.

B) Indicar ultrassonografia abdominal para avaliar a hepatomegalia que pode estar relacionada ao acúmulo de gordura no fígado.

C) Orientar melhores hábitos alimentares e atividade física adequada à idade para contribuir para perda de peso.

D) Realizar acompanhamento ambulatorial da pressão arterial do paciente já que hipertensão arterial pode ocorrer nessa situação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212186)

Enunciado: Uma doença cujo substrato de eliminação é a saliva é a

A) raiva.

B) sífilis.

C) gonorreia.

D) hepatite B.

E) tuberculose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212156)

Enunciado: Bruna, 8 meses e 18 dias, foi levada ao posto de vacinas para atualização de seu cartão vacinal. Como permaneceu 45 dias internada em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, devido a seu nascimento prematuro (32 semanas), até o momento recebeu: 01 dose da BCG; 01 dose da vacina contra hepatite B; 02 doses da vacina pentavelente; 02 doses da vacina VIP; 02 doses da vacina meningocócica C conjugada; 01 dose da vacina contra Rotavírus; 01 dose da vacina pneumocócica 10-valente conjugada. Qual a melhor proposta para essa atualização, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde?

A) Administração da terceira dose da vacina pentavelente e terceira dose da vacina VIP.

B) Administração da terceira dose da vacina VIP e segunda dose da vacina pneumocócica 10-valente conjugada.

C) Administração da terceira dose da vacina pentavelente, segunda dose contra o Rotavírus, segunda dose da vacina pneumocócica 10-valente conjugada.

D) Administração da terceira dose da vacina pentavelente, terceira dose da vacina VIP, segunda dose da vacina pneumocócica 10-valente conjugada.

E) Administração da terceira dose da vacina pentavelente, terceira dose da vacina VIP, segunda dose contra o Rotavírus, segunda dose da vacina pneumocócica 10-valente conjugada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216290)

Enunciado: Recomenda-se precaução na vacinação dos indivíduos com história pregressa da síndrome de Guillain-Barré (SGB), mesmo sabendo ser bastante rara. Os riscos e benefícios devem ser discutidos com o médico. NÃO podemos, apenas, concordar que

A) raramente algumas vacinas de vírus vivos atenuados ou mortos podem anteceder à síndrome de Guillain-Barré (SGB).

B) Guillain-Barré se manifesta clinicamente como polirradiculoneurite inflamatória com lesão de desmielinização, parestesias e deficit motor ascendente de intensidade grave, apenas.

C) geralmente, os sintomas aparecem entre 7 e 21 dias, no máximo até 42 dias (6 semanas) após a exposição ao possível agente desencadeante.

D) até o momento, há poucas evidências se a vacina influenza pode aumentar o risco de recorrência da SGB em indivíduos com história pregressa desta patologia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182774)

Enunciado: Considerando a terapêutica na Síndrome Metabólica Infantil, assinale a alternativa CORRETA:

A) O sucesso do tratamento consiste em uma perda de peso de, pelo menos, 10% em 2 anos de segmento e no máximo aproximação dos índices de peso para estatura ou IMC para a idade e sexo preconizados pela OMS.

B) O sucesso do tratamento consiste em uma perda de peso de, pelo menos, 15% em 2 anos de segmento e no máximo aproximação dos índices de peso para a estatura ou IMC para a idade e sexo preconizados pela OMS.

C) O sucesso do tratamento consiste em uma perda de peso de, pelo menos, 10% em 1 ano de segmento e no máximo aproximação dos índices de peso para estatura ou do IMC para a idade e sexo preconizados pela OMS.

D) O sucesso do tratamento consiste em uma perda de peso de, pelo menos, 15% em 1 ano de segmento e no máximo aproximação dos índices de peso para estatura ou do IMC para a idade e sexo preconizados pela OMS.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182779)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA em relação às estratégias terapêuticas utilizadas no tratamento da Síndrome Metabólica:

A) Orlistate é a medicação de escolha na resistência à insulina, intolerância à glicose ou diabetes mellitus tipo 2.

B) O tratamento medicamentoso é contraindicado em crianças menores de 12 anos.

C) O tratamento medicamentoso deve ser postergado o máximo possível.

D) Em jovens entre 16 e 18 anos, poderá ser indicado o tratamento cirúrgico naqueles que apresentarem o escore-Z maior que +2 na análise do IMC por idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187797)

Enunciado: Em relação à imunização do prematuro é ERRADO afirmar:

A) BCG: dose única, deve ser adiada até que o peso esteja igual ou maior que 2kg

B) Hepatite B: em três doses (0, 2 e 4 meses) em recém-nascidos com idade gestacional < 32 semanas ou peso < 2kg

C) Rotavírus: é contraindicada sua administração em ambiente hospitalar

D) Tríplice (DPT): utilizar preferencialmente vacinas acelulares

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182800)

Enunciado: Pacientes com Diabetes Mellitus (DM) apresentam maior risco presumido de infecção pneumocócica grave e complicações decorrentes de Infuenza, recomendando-se atenção especial a essas vacinas em pacientes diabéticos. Sobre isso, somente NÃO podemos concordar com o item:

A) As duas medidas mais efetivas para prevenir doenças infecciosas são as higiênicas e a imunização.

B) A decisão para recomendar uma vacina envolve a avaliação dos riscos da doença, os benefícios da vacinação, sem considerar os riscos associados à sua realização.

C) Os níveis glicêmicos são importantes para o manejo e acompanhamento dos pacientes diabéticos, porém não existem relatos na literatura que contra-indiquem vacinação por alteração dos níveis glicêmicos, bem como pontos de corte glicêmicos que contra-indiquem as vacinas.

D) Não se considera o DM desaconselhável a nenhuma vacina, respeitando suas indicações de acordo com cada faixa etária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182811)

Enunciado: A decisão para recomendar uma vacina envolve a avaliação dos riscos da doença, os benefícios da vacinação e os riscos associados à sua realização. Não faz parte da decisão um dos itens abaixo, indique-o:

A) Não se considera o DM desaconselhável a nenhuma vacina.

B) Recomenda-se vacina conjugada pneumocócica 13-valente a todas as crianças entre 2 e 23 meses de idade e para as de alto risco entre 24 e 59 meses de idade.

C) A vacinação para Influenza é recomendada para pacientes diabéticos e deve ser administrada anualmente.

D) A vacina contra herpes-zóster está recomendada para adultos com mais de 70 anos sem história prévia da doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181365)

Enunciado: A Organização Mundial de Saúde define obesidade como excesso de gordura corporal que apresenta riscos à saúde. Assinale a alternativa correta.

A) A medida da circunferência abdominal deve ser realizada na altura da cicatriz umbilical.

B) A medida das pregas cutâneas não é recomendada para estimativa de adiposidade.

C) A circunferência abdominal avalia indiretamente a gordura visceral e não tem relação com comorbidades.

D) Crianças maiores de 2 anos com incremento da curva do IMC (índice de massa corporal) não são consideradas de risco para obesidade.

E) A relação circunferência abdominal/estatura "maior que" 0,5 é utilizada para avaliação de risco para desenvolvimento de Diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152639)

Enunciado: Dentre as doenças abaixo, qual das opções contém apenas doenças imunopreveníveis?

A) Tétano, escarlatina e sarampo.

B) Difteria, calazar e sarampo.

C) Coqueluche, rubéola e malária.

D) Febre amarela, tétano e difteria.

E) NDA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161354)

Enunciado: Das vacinas abaixo, aponte aquela que NÃO pode ser utilizada em gestante, mesmo que previamente exposta ao agente.

A) Raiva.

B) Sarampo.

C) Hepatite B.

D) Tétano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158798)

Enunciado: Dadas as afirmativas sobre a vacina BCG, I. Os eventos adversos associados à BCG são pouco frequentes e dependem da cepa utilizada. II. Confere proteção maior contra as formas graves, como meningite tuberculosa, tuberculose miliar e morte, do que contra as formas pulmonares. III. O tamanho da cicatriz deixada pela BCG, o qual se mantém com o tempo, é menor em recém-nascidos do que em escolares e adultos. IV. No Brasil, a maioria das crianças vacinadas com a BCG-ID apresenta cicatriz, recomendando-se revacinar aquelas que não apresentarem nenhuma reação local até três meses após a vacinação. verifica-se que está(ão) correta(s):

A) III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158758)

Enunciado: Uma criança de um ano e quatro meses de vida vem para acompanhamento ambulatorial de puericultura, sem queixas no momento. Em seu cartão de vacinas, consta: Uma dose da BCG ao nascer. Uma dose da vacina contra hepatite B ao nascer. Uma dose da vacina contra rotavírus, aos dois meses de vida. Três doses da vacina VIP, aos dois/quatro e seis meses de vida. Três doses da vacina pentavalente, aos dois/quatro e seis meses de vida. Duas doses da vacina contra o pneumococo, aos dois e quatro meses de vida. Três doses da vacina contra meningite C, aos três e cinco meses de vida, e reforço aos 12 meses de vida. Uma dose da vacina contra a hepatite A, aos quinze meses de vida. Sobre o calendário vacinal dessa criança, é correto afirmar que ele está:

A) Desatualizado, devendo as próximas vacinas serem os reforços da DPT e VOP aos cinco anos.

B) Desatualizado, devendo as próximas vacinas serem os reforços da DPT e VOP aos quatro anos.

C) Desatualizado, pois faltam ser administradas: reforço da vacina contra poliomielite (VOP), reforço com a vacina DPT, reforço da vacina contra o pneumococo e dose da vacina tríplice viral.

D) Desatualizado, pois faltam ser administradas: reforço da vacina contra poliomielite (VOP), segunda dose da vacina contra o rotavírus, reforço com a vacina DPT e reforço da vacina contra o pneumococo.

E) Desatualizado, pois faltam ser administradas: reforço da vacina contra poliomielite (VOP), segunda dose da vacina contra o rotavírus, reforço com a vacina DPT, reforço da vacina contra o pneumococo e dose da vacina tríplice viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134870)

Enunciado: Uma criança de 2 anos é levada ao Posto de Saúde devido a lesões na pele. Ao exame físico, apresenta quadro clínico de kwashiorkor com presença de lesões cutâneas infectadas nos membros inferiores, em consequência da deiscência da pele secundária a edema. Qual é a MELHOR conduta frente a esse quadro?

A) Orientar a mãe para fazer curativos locais com solução de permanganato de potássio e pomada de bacitracina.

B) Encaminhar com urgência para internação e tratar a criança como sepse.

C) Receitar para casa cefalosporina VO e tratamento tópico para as lesões de pele.

D) Orientar para observar e retornar se houver piora do estado geral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134050)

Enunciado: Dentre as linhas de cuidado na atenção integral à saúde da criança propostas pelo Ministério da Saúde do Brasil, temos a atenção às doenças prevalentes. Das doenças a seguir, indique a única que NÃO é considerada como doença prevalente na infância:

A) Diarreias.

B) Dermatoses.

C) Doenças respiratórias.

D) Sífilis e rubéola congênitas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134054)

Enunciado: A prevalência da obesidade tem aumentado de forma acelerada nas crianças brasileiras. Ela pode comprometer de forma significativa à saúde, não só da criança, mas do adulto que ela será. Entre as medidas a seguir, aponte a única que NÃO tem impacto positivo na prevenção da obesidade.

A) Aleitamento materno.

B) Atividade física regular.

C) Uso de hipoglicemiante oral.

D) Reduzir o uso de alimentos processados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134317)

Enunciado: A vacina contra Haemophilus influenzae é feita no primeiro ano de vida. Das alternativas a seguir, marque a conduta adotada pelo Programa Nacional de Imunizações em relação a ela:

A) Primeiro, segundo e quarto meses de vida.

B) Nono mês de vida.

C) Segundo, quarto e sexto meses de vida.

D) Segundo, terceiro e quarto meses de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134260)

Enunciado: Assinale a alternativa que indica a PRINCIPAL causa de obesidade em crianças.

A) Síndrome de Cushing pós-corticoterapia.

B) Hipotireoidismo.

C) Insuficiência respiratória aguda.

D) Erro alimentar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134262)

Enunciado: Em relação à obesidade é INCORRETO afirmar que

A) As patologias de etiologia genética geralmente cursam com baixa estatura.

B) Tratamentos medicamentosos não podem ser usados em pacientes abaixo de 18 anos.

C) O risco de DM tipo II em crianças obesas deve ser avaliado, principalmente no início da puberdade.

D) Os pacientes com obesidade exógena geralmente têm estatura normal ou elevada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134819)

Enunciado: Admite-se que uma criança de seis meses e meio de idade, amamentada exclusivamente no peito, nascida com 38 semanas de gestação e peso de 2.500 g, tem raquitismo por deficiência de vitamina D. Seus achados de exame físico incluíram todos os seguintes, com EXCEÇÃO de

A) crescimento inadequado.

B) contas costocondrais (rosário raquítico).

C) pernas arqueadas.

D) amolecimento do crânio (craniotabes).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134265)

Enunciado: Na infância a obesidade deve ser considerada doença nutricional grave, pois algumas complicações podem se instalar nessa faixa etária, com EXCEÇÃO de

A) Esofagite eosinofílica.

B) Hipertensão arterial.

C) Osteoartrites.

D) Pseudotumor cerebral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110553)

Enunciado: Você recebe no ambulatório uma adolescente de 15 anos com 1,60 m de altura e 88 kg de peso. Dentre os possíveis distúrbios decorrentes da obesidade que esta paciente deve apresentar, podemos citar:

A) Alterações da visão.

B) Alterações da voz.

C) Alterações dermatológicas.

D) Alterações esplênicas.

E) Alterações renais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110559)

Enunciado: Menor de 3 anos de idade pesa 8.900 g e mede 92 cm. Nasceu a termo com 3.300 g.

Considerando o estado nutricional, como deve ser classificada esta criança?

A) Obesidade.

B) Sobrepeso.

C) Eutrofia.

D) Desnutrição grau II.

E) Desnutrição grau III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110566)

Enunciado: Objetivando prevenir complicações e investigar as já existentes, quais exames devem ser solicitados para uma criança que se encontra no percentil 98 no gráfico de peso?

A) Tomografia do Crânio, Hemograma, raios X do tórax;

B) Parasitológico de fezes, Sumário de Urina, Colesterol total;

C) Hemograma, Densitometria óssea, Triglicerídeos;

D) Glicemia de jejum, Colesterol, Triglicerídeos;

E) Uréia, ácido úrico, creatinina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110571)

Enunciado: Escolar do sexo masculino de sete anos e seis meses de idade, previamente saudável, trazido ao seu consultório com queixa de baixa estatura. A família tem boa renda e as condições alimentares são adequadas. A altura da mãe é de 1.55 m (p25) e a do pai de 1.75 m (p50-75). Traz exames complementares realizados previamente com resultados dentro do padrão normal. Atualmente a criança mede 1.16 m e pesa 20 kg, tem desenvolvimento neuropsicomotor e exame físico normais. A melhor conduta é:

A) Tranquilizar a família e reavaliar o crescimento em 6 a 12 meses.

B) Solicitar novos exames complementares e

raios X de sela túrcica.

C) Encaminhar ao endocrinologista para avaliação.

D) Solicitar dosagem de hormônio do crescimento.

E) Solicitar T4 livre, TSH e cintilografia de tireoide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49640)

Enunciado: Na criança desnutrida, podem-se observar várias alterações no tubo digestivo, com consequências importantes para o processo de digestão e absorção de nutrientes. Assinale a afirmativa correta:

A) A hipocloridria gástrica pode levar à má digestão de lactose.

B) A hipotrofia das criptas pode levar à má absorção de nutrientes.

C) A atrofia das vilosidades intestinais pode levar à má digestão de carboidratos.

D) A hipotrofia pancreática pode levar à má absorção da glicose.

E) A esteatose hepática pode originar insuficiência hepática aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49575)

Enunciado: Diante de um adolescente obeso, com percentil de cintura abdominal acima de 90, quais condutas terapêuticas seriam corretas para ajudá-lo a perder peso?

A) Restrição rigorosa de dieta a fim de perder peso rapidamente, proibindo o consumo de açúcar e gorduras.

B) A quantidade de refeições para, no máximo, três ao dia.

C) Incentivar o consumo de frutas e verduras, restringir com pouca ingestão de carne.

D) Diminuir o tempo tomado com atividades sedentárias e praticar exercícios com intensidade moderada.

E) Indicar tratamento medicamentoso com inibidores de apetite durante tempo prolongado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298263)

Enunciado: Lactente de oito meses de idade é atendido na UBS da sua comunidade com quadro de resfriado comum há três dias. Exame físico: bom estado geral, temp. axilar = 36,7o C. No Cartão da Criança, verifica-se a seguinte cobertura vacinal: BCG na alta neonatal (sem cicatriz); vacina contra hepatite B (HB): duas doses no 1o e 30o dias de nascimento; 1a dose das DPT+Hib, VOP (vacina oral contra poliomielite) e antirrotavírus monovalente humana (VORH) aos dois meses de idade. De acordo com o PNI/MS do Brasil, nesse lactente, na oportunidade, devem-se aplicar as seguintes vacinas:

A) DPT+Hib, BCG, VIP e VORH.

B) DPT+Hib, HB e VIP.

C) DPT+Hib, HB,VIP e VORH.

D) DPT+Hib, BCG, HB e VOP

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286745)

Enunciado: Gestante, 20 semanas, com passado vacinal desconhecido, foi ao pré-natal com resultado de exames: HBsAg não reagente, Anti HBc não reagente; Toxoplasmose IgG reagente; Rubéola IgM e IgG não reagente; VDRL negativo. Segundo recomendações do Ministério da Saúde e baseado no resultado dos exames acima, quais vacinas a gestante deverá tomar?

A) Hepatite B; tríplice bacteriana acelular adulto ou dupla bacteriana adulto e influenza

B) Influenza; Hepatite B; tríplice viral, e tríplice bacteriana acelular adulto

C) Tríplice bacteriana acelular adulto ou dupla bacteriana adulto; influenza e tríplice viral

D) Tríplice bacteriana acelular adulto; tríplice viral; antitetânica; Rubéola

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286761)

Enunciado: Sobre as hipovitaminoses é CORRETO afirmar que:

A) As vitaminas do complexo B são cofatores nos processos relacionados à síntese proteica e tem como fontes principais os cereais integrais.

B) A vitamina K é hidrossoluvel e tem importância na síntese de fatores da coagulação intrínseco e extrínseco.

C) A vitamina A tem grande importância na prevenção de xeroftalmia e tem como fontes principais os vegetais verdes escuros como espinafre, bócolis e vagens.

D) A vitamina D é sintetizada através da exposição à radiação solar e pode sofrer influências de fatores como a latitude, estação do ano e poluição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286773)

Enunciado: Na investigação de baixa estatura das meninas, faz-se necessário investigar:

A) Hematúria macroscópica

B) Hipertensão arterial

C) Síndrome de Turner

D) Hipoaldosteronismo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286776)

Enunciado: Logo após o parto, a parturiente informa que o marido acabou de fazer diagnóstico de TB pulmonar bacilífera. Nesse caso, a conduta CORRETA é:

A) Suspender a amamentação.

B) Iniciar isoniazida logo ao nascimento.

C) Iniciar esquema RIP logo ao nascimento.

D) Realizar lavado gástrico, RX tórax e realizar BCG.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

256604)

Enunciado: Pré-escolar recebeu por meses megadoses de vitamina A levando a sintomas subagudos ou crônicos de intoxicação, o quadro mais típico é:

A) Diplopia, pressão intracraniana aumentada, limitação de movimento.

B) Fotofobia, ceratocomalacia, cegueira

C) Ceratomalacia, cegueira, pressão intracraniana aumentada.

D) Fotofobia, defeito do esmalte dentário, diplopia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252284)

Enunciado: Pré?escolar de 4 anos, sexo masculino, foi levado ao pediatra por apresentar anorexia, cefaleia, vômito, ressecamento e descamação irritativa da pele, lesões seborreicas cutânea, rachadura nos cantos da boca, alopecia. Refere que faz uso de polivitamínico por tempo prolongado. A hipótese mais provável é hipervitaminose crônica de vitamina:

A) E

B) D

C) A

D) B2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208404)

Enunciado: É contraindicação absoluta à vacina de febre amarela:

A) Infecção pelo HIV

B) Alergia a ovo

C) Idade menor que 6 meses

D) Uso de corticosteroides

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208351)

Enunciado: Quais das vacinas abaixo, apesar de não fazer parte do calendário vacinal, pode ser realizada na gestante em situações especiais:

A) Sarampo

B) BCG

C) Meningocócica (ACWY)

D) Rubéola (MPSV4)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208332)

Enunciado: Adolescente de 15 anos, procurou o serviço de emergência devido à lesão perfurante em pé esquerdo, ocorrida há 48h em zona rural. Sua genitora não sabe informar sobre a situação vacinal. A conduta neste caso é:

A) Penicilina benzatina.

B) Vacina dupla tipo adulto.

C) Vacina dupla tipo adulto e imunoglobulina antitetânica.

D) Eritromicina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208341)

Enunciado: JPP, sexo masculino, 12 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para regularizar suas vacinas. Em sua caderneta vacinal constam as seguintes anotações: - BCG com um mês de vida; - DPT e vacina oral contra poliomielite aos 2, 4, 6, 15 meses de vida e cinco anos de idade; - Vacina tríplice viral com um ano de vida; - Uma dose da vacina contra hepatite B aos 10 anos; - Uma dose da vacina contra febre amarela aos cinco anos. Quais vacinas deverão ser aplicadas nesse adolescente nessa visita?

A) Segunda dose de hepatite B, reforço da dupla adulto (dT), uma dose de febre amarela, uma dose de Meningocócica C, primeira dose de HPV.

B) Segunda dose de hepatite B, reforço da dupla adulto (dT), segunda dose de tríplice viral, uma dose de Meningocócica C, primeira dose de HPV.

C) Segunda dose de hepatite B, segunda dose da tríplice viral, primeira dose de Pneumocócica 10V e reforço da dupla adulto (dT).

D) Segunda dose contra hepatite B, segunda dose da tríplice viral, febre amarela, reforço da dupla adulto (dT), uma dose de HPV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208384)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta as alterações causadas pela deficiência de zinco:

A) Diarreia, hipogonadismo hipogonadotrófico, demência.

B) Alopécia, dermatite periorificial, infecção bacteriana de repetição.

C) Demência, diarreia, coiloníquia.

D) Coiloníquia, dermatite em áreas fotossensíveis, diarreia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208322)

Enunciado: Em 2018, vivenciamos um surto de sarampo em alguns estados do Brasil, doença considerada erradicada do país há anos, o que tornou imperativo o reforço no esquema vacinal da população. As doses de vacina recomendadas para este agravo são, EXCETO:

A) Duas doses de tríplice viral entre 5 e 9 anos de idade.

B) Duas doses de tríplice viral para menores de 5 anos.

C) Não vacinar pessoas gestantes ou menores de 6 meses de idade.

D) Casos suspeitos da doença não devem ser vacinados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208337)

Enunciado: Desde 1990, não há registro de Poliomielite no Brasil mas a doença ainda ocorre em outras regiões no planeta. Com a reintrodução do sarampo no país, a preocupação agora é também com a Poliomielite, redobrando os cuidados para manter uma boa cobertura vacinal. A vacinação contra este agravo deve ser:

A) A única forma de evitar a doença é através da vacinação e de profilaxia pós-contato com antibióticos de amplo espectro

B) As crianças entre um e cinco anos de idade devem tomar 3 doses da vacina injetável contra Poliomielite (VIP)

C) Feita com vacina oral (VOP) e com a vacina injetável (VIP) sendo agravo de notificação semanal negativa/positiva

D) Durante as campanhas como a que ocorreu em agosto deste ano, todas as crianças menores de cinco anos devem receber a VIP

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208385)

Enunciado: Mariana, traz o seu filho Mateus, de 1 mês e 3 dias para a consulta de puericultura na UBS. Ela está preocupada porque no local onde foi administrada a vacina BCG surgiu uma pústula e a criança sente dor à manipulação do membro. Sobre o plano de manejo deste problema, qual a alternativa que contempla a conduta adequada?

A) Tranquilizar Mariana, informando que se trata da evolução esperada para a lesão vacinal, orientando a limpeza com água e sabão.

B) Administrar mupirocina tópico por se tratar de um quadro de infecção bacteriana secundária.

C) Prescrever isoniazida até a regressão completa da lesão.

D) Notificar o caso como evento adverso da vacina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208440)

Enunciado: Adriana, 29 anos, G2 A0 P1, IG = 17s, vem para consulta de pré-natal na UBS, trazendo seu cartão de vacina onde se observa três doses de vacina antitetânica aplicadas na gestação anterior há sete anos. Em relação à profilaxia do tétano neonatal, deve-se:

A) Reiniciar o esquema vacinal com três doses, devido ao tempo desde a última vacina.

B) Orientar que a mesma está imunizada, não sendo necessária dose de reforço.

C) Aplicar reforço após o parto, a fim de proteger a próxima gestação.

D) Orientar a necessidade de dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176101)

Enunciado: A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é considerada, atualmente, a Doença Sexualmente Transmissível (DST) mais comum. Referente às mudanças no Calendário Nacional de Vacinação para o ano de 2017, consideramos adequado a realização da vacina HPV quadrivalente para meninas com:

A) 9 a 14 anos de idade em 2 doses, respeitando o intervalo mínimo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose.

B) 9 a 14 anos em 3 doses, sendo a segunda dose após 1 mês da primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira.

C) Para pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS, permanece o esquema de 2 doses com intervalo mínimo de 6 meses, abrangendo faixa etária de 9 a 26 anos.

D) Para pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS, amplia-se o esquema para 3 doses sendo a segunda dose após 1 mês da primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira, abrangendo faixa etária de 9 a 26 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176015)

Enunciado: Em agosto do presente ano, o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (DEVAE) divulgou a ocorrência de surtos de parotidite (caxumba) na cidade de Manaus. Baseado em seus conhecimentos sobre a doença, responda a alternativa CORRETA:

A) A partir deste ano, a parotidite torna-se uma doença de notificação compulsória para o Estado do Amazonas, haja vista o número de surtos institucionais desde o mês de abril na cidade de Manaus.

B) Nos casos de parotidite em crianças com menos de 5 anos de idade, observamos perda neurossensorial da audição, de início súbito e unilateral, em mais da metade dos casos registrados.

C) Por apresentar importante tropismo pelo Sistema Nervoso Central (SNC), podemos observar como principal complicação da parotidite a encefalite.

D) O diagnóstico de parotidite é eminentemente clinicoepidemiológico, não havendo necessidade de exame complementar específico em casos de suspeita da doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176091)

Enunciado: Lactente de 8 meses sendo alimentada predominantemente com leite, não aceita frutas ou sucos, chega ao ambulatório e sua mãe relata: irritabilidade, perda do apetite, febre baixa, inchaço nas pernas (joelhos e tornozelos) mantendo quando na deitado posição ?sapo virado?? com barriga para cima, joelhos e quadris semiflexionado. Qual a deficiência de vitamina?

A) B.

B) C.

C) E.

D) K.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176026)

Enunciado: Comorbidades associadas à obesidade na síndrome metabólica de um adolescente de 13 anos. Quais os possíveis sintomas?

A) Acantose nigricans, poliúria, polidipsia.

B) Adiposidade central, resistência à insulina, dislipidemia, hipertensão e intolerância à glicose.

C) Menstruação irregular, resistência à insulina, hiperandrogenia.

D) Dislipidemia, hipertensão, acantose nigricans, poliúria, hiperandrogenia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176116)

Enunciado: O Calendário Nacional de Vacinação 2017, do Ministério da Saúde preconiza sobre a vacina quadrivalente contra HPV (Papiloma Vírus Humano):

A) O intervalo vacinal é de 2 meses.

B) Mulheres/homens convivendo com HIV/AIDS também recebem quatro doses.

C) Duas doses da vacina para mulheres entre 9 e 14 anos e, para homens entre 11 e 13 anos.

D) A faixa etária para os que vivem com HIV/AIDS é de 9 a 14 anos para ambos os sexos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176110)

Enunciado: Dentre as mudanças propostas no Calendário Nacional de Vacinação do Brasil, 2017, podemos citar:

A) A vacina meningocócica C será feita em duas doses, independentemente do esquema vacinal anterior.

B) Introdução da vacina Meningocócica C para a faixa etária de 12 a 13 anos para ambos os sexos.

C) A vacina contra febre amarela deve ser administrada aos 15 meses, dose única.

D) A vacina contra febre amarela é contraindicada em gestantes e pessoas infectadas pelo HIV independentemente da contagem das células CD4.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176118)

Enunciado: O Programa Nacional de Imunização preconiza que o profissional da área médica:

A) Só receba a vacina contra hepatite B após dosar o anticorpo contra Hepatite B (HBsAG).

B) Após a primeira dose da vacina, deve ser feita a dosagem do anti-HBs para avaliar soro-conversão.

C) Seja imunizado com 3 doses da vacina contra Hepatite B no esquema de 0, 1 e 6 meses.

D) Caso não haja soro-conversão, não é recomendada nova vacinação contra este agravo devendo-se administrar a Imunoglobulina humana anti-hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151923)

Enunciado: Em relação aos cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde para o acompanhamento dos adolescentes podemos citar, EXCETO:

A) Vacinação contra a HPV (Papilomavírus Humano) para adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 8 a 15 anos no esquema de 3 doses com intervalos de 2 meses entre cada dose.

B) O acompanhamento do desenvolvimento estatural e do índice de massa corporal, da maturação sexual, da saúde bucal e do calendário vacinal através da Caderneta do Adolescente.

C) O Programa Saúde na Escola (PSE) cujo obejtivo é reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e construir uma cultura de paz nas escolas.

D) Garantia de direito à saúde sexual e resprodutiva com livre escolha de métodos contraceptivos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151955)

Enunciado: Periodicamente, o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde sofre mudanças. Em 2016 mais algumas modificações ocorreram, dentre as quais podemos citar:

A) As vacinas meningocócica, VIP e pneumocócica podem ser aplicadas apenas até os 15 meses de idade.

B) A vacina peneumocóccica 10 valente será feita em duas doses (1 e 6 meses), com reforço preferencialmente aos 15 meses.

C) Vacina meningocócica C continua sendo feita com 3 e 5 meses e reforço preferencia passa a ser aos 12 meses.

D) A Vacina Inativada contra Poliomielite (VIP) deve ser feita injetável aos 2, 4 e 6 meses e com reforço aos 15 meses e aos 4 anos, também injetável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151974)

Enunciado: Devemos fazer a vacina dTpa (contra Difteria, Tétano e Coqueluche - Pertussis acelular) nas seguintes situações, EXCETO:

A) Profissionais de saúde que atuem em ambulatórios de pediatria, creches e pré-escolas.

B) Crianças que tenham apresentado efeitos adversos após a vacina com componente pertussis de células inteiras.

C) Profissionais de saúde que atuem em maternidades e UTI neonatal.

D) Gestantes após a 27ª semana de gestação até 20 dias antes do parto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129780)

Enunciado: Os pais levam seu filho de 3 anos para consulta de puericultura. Após avaliação detalhada, verifica-se que o escore-Z do peso da criança encontra-se entre +3 < +2; estatura/idade entre +2 < + 1; IMC entre +3 < +2. Segundo os critérios da OMS, 2006, assinale a alternativa com a avaliação do estado nutricional desta criança:

A) Peso e estatura adequados para idade; risco de sobrepeso.

B) Peso adequado para idade; estatura adequada para idade; eutrofia.

C) Peso elevado para idade; estatura adequada para idade; sobrepeso.

D) Peso elevado para idade; estatura adequada para idade; eutrofia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107790)

Enunciado: A tia leva o menor A.S.R., 2 anos, ao PSC Zona Norte com história de 3 dias com diarreia e febre, porém mãe informa que todo mês ela tem diarreia. Eles moram em uma invasão na Zona Leste, a água não é tratada e tem um lixão próximo onde a criança brinca às vezes. Recebeu leite materno só até o segundo mês de vida, pois a mãe achava o leite "fraco". Atualmente recebe 4 mamadeiras de leite (que recebe do programa da prefeitura), com a seguinte composição: 1 medida de leite (obs.: divide o leite com seus outros 5 irmãos), 6 medidas de arrozina para 200 ml de água, não come frutas, nem carne, nem verduras. Ao exame, criança apática, hipocorada, dermatose generalizada, hiperemia perianal importante, presença de edema periorbital e de membros inferiores, hepatomegalia, cabelo de duas cores (sinal da bandeira). Qual o diagnóstico nutricional?

A) Marasmo.

B) Kwashiorkor.

C) Deficiência exclusiva de vitamina C.

D) Deficiência exclusiva de zinco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103848)

Enunciado: O que caracteriza a Síndrome de Turner:

A) Disgenesia ovariana, linfedema, pescoço alado, cariótipo XO.

B) Obesidade, infertilidade, insuficiência adrenal, pescoço alado.

C) Hipocalcemia, calcificações cutâneas, infertilidade, pescoço alado, hipoglicemia.

D) Cariótipo XO, infertilidade, tumor hipotalâmico, pescoço alado, hipocalcemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103851)

Enunciado: A dieta Vegan macrobiótica, adepta de vegetarianos (restrita), leva à deficiência de qual vitamina essencial no metabolismo do folato:

A) Vitamina B6 (piridoxina).

B) Tiamina (vitamina B1).

C) Vitamina B12 (cianocobalamina).

D) Riboflavina (vitamina B2).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87442)

Enunciado: E.R.F., 6 meses, foi levado por sua mãe ao posto. A Sra. S.G.T. informou que não conseguiu amamentar e oferecia mingau de arrozina com 1 medida de leite integral 5 x ao dia. Durante exame o pediatra observou que o peso para o comprimento estava < -2 escore-Z e o comprimento para idade estava < -3 escore-Z. Qual impressão diagnóstica e conduta?

A) Eutrófico. Acalmar a mãe.

B) Baixa estatura. Orientação nutricional e acompanhamento semanal.

C) Apesar de eutrófico. Brigar com a mãe pela negligência.

D) Baixa estatura. Prescrever antibiótico e vitaminas.

E) Baixa estatura. Encaminhar ao endocrinologista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87440)

Enunciado: O crescimento de uma criança depende de vários fatores intrínsecos e extrínsecos.

Quanto às variações normais do crescimento, assinale a assertiva CORRETA.

A) A idade cronológica está compatível com a idade óssea no Atraso Constitucional do Crescimento.

B) Na Baixa Estatura Familiar há história familiar de retardo puberal.

C) O exame físico é normal para idade cronológica no Atraso Constitucional do Crescimento.

D) No Atraso Constitucional do Crescimento a idade óssea é compatível com a estatura.

E) Os exames laboratoriais estão normais para a idade óssea na Baixa Estatura Familiar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81127)

Enunciado: A menor A.L.M., 2 anos, foi atendida no PSC Zona Sul com história de 3 dias com diarreia e febre, porém mãe informa que todo mês ela tem diarreia. Eles moram em uma invasão na Zona Leste, a água não é tratada, tem um lixão próximo onde a criança brinca às vezes. Recebeu leite materno só até o 2º mês de vida, pois a mãe achava o leite "fraco". Atualmente recebe 4 mamadeiras de leite (que recebe do programa da prefeitura), com a seguinte composição 1 medida de leite (obs.: divide o leite com seus outros 5 irmãos), 6 medidas de arrozina para 200 ml de água, não come frutas, nem carne, nem verduras. Ao exame, criança apática, hipocorada, dermatose generalizada, hiperemia perianal importante, presença de edema periorbital e de membros inferiores, hepatomegalia, cabelo de duas cores (sinal da Bandeira). Qual o diagnóstico nutricional?

A) Marasmo.

B) Kwashiorkor.

C) Deficiência exclusiva de vitamina C.

D) Obesidade.

E) Deficiência exclusiva de zinco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60890)

Enunciado: Adolescente de 14 anos procura AAL com queixa de ginecomastia há seis meses e pênis pequeno. Ao exame: ginecomastia, obesidade moderada, pênis embutido, sem outra anormalidade. Estadiamento de Tanner P2 G3. Qual a conduta?

A) Solicitar TAC de crânio.

B) Encaminhar para endocrinologia.

C) Pedir exame de cromatina sexual.

D) Observar a evolução da ginecomastia por mais um ano.

E) Indicar cirurgia para correção da ginecomastia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61496)

Enunciado: Marque a alternativa ERRADA:

A) As dermatoses são comuns em pacientes desnutridos tipo Marasmo.

B) O exame físico de pacientes desnutridos tipo Kwashiorkor é caracterizado pela presença de edema.

C) Lactentes desnutridos tipo Marasmo apresentam diminuição acentuada de tecido adiposo.

D) Na desnutrição tipo Marasmo, o lactente apresenta-se irrequieto, agitado, aceitando todos os alimentos que lhes são oferecidos.

E) Lactentes com Kwashiorkor apresentam graus variados de esteatose hepática, hipoalbuminemia e inapetência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61505)

Enunciado: Considerando as variações normais do crescimento humano é CORRETO afirmar:

A) Atraso constitucional do crescimento não tem relação com o início da puberdade.

B) A idade óssea é compatível com a estatura na baixa estatura constitucional.

C) As duas formas mais frequentes de variação do crescimento estão dissociadas do padrão familiar.

D) No atraso constitucional do crescimento, a idade óssea é compativel com a idade cronológica.

E) Na baixa estatura familiar, o alvo genético é abaixo da média da população geral e a criança está crescendo dentro do esperado para aquele alvo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46662)

Enunciado: A albumina plasmática é um método excelente para a mensuração do estado nutricional. Sua vida média é de:

A) 9 horas.

B) 2 dias.

C) 9 dias.

D) 21 dias.

E) 28 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46672)

Enunciado: Na desnutrição do tipo marasmo somente uma das alternativas é correta:

A) Manutenção da imunocompetência.

B) Manutenção do peso corpóreo.

C) Baixos níveis de proteínas viscerais.

D) Ocorre nas doenças graves e trauma.

E) Manutenção da prega cutânea do tríceps.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49814)

Enunciado: Na alimentação de um lactente saudável, no primeiro ano de vida, está relacionado com o desenvolvimento da obesidade o seguinte fato:

A) Introdução precoce de sólidos

B) Ausência de alimentação ao seio

C) Uso de alimentos pastosos através de mamadeiras

D) Uso de leite de vaca com adição de farinha de 3%

E) Uso de leite artificial associado com leite materno

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46652)

Enunciado: Escolar com sete anos vem ao endocrinologista, pois sua mãe está preocupada com seu crescimento, pois está menor do que seus colegas de escola. Qual dado deverá ser considerado no momento da avaliação?

A) Seguimento pela curva de crescimento.

B) Dosagem do hormônio de crescimento.

C) Dosagem dos hormônios tireoidianos.

D) Estatura dos pais.

E) Idade óssea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46667)

Enunciado: Lactente de quatro meses, com quadro de anemia microcítica, crise convulsiva mioclônica de difícil controle desde o nascimento. O ECG mostra padrão hipsarritmia. Qual a deficiência vitamínica?

A) Biotina.

B) Niacina.

C) Tiamina.

D) Piridoxina.

E) Riboflavina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46636)

Enunciado: A associação que indica um pior diagnóstico para desnutrição protética calórica grave é:

A) Edema e hiperpotassemia.

B) Diarreia e intolerância à lactose.

C) Hipostenúria e intolerância à lactose.

D) Hiponatremia e depleção de potássio.

E) Hipertemia, edema, carência de zinco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9987)

Enunciado: Em ambulatórios pediátricos de países desenvolvidos, qual a deficiência de crescimento mais comumente encontrada:

A) infecção recorrente e distúrbio metabólico.

B) Marasmo e Kwashiorkor.

C) Prematuridade.

D) Erros inatos do metabolismo.

E) Doença do colágeno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9988)

Enunciado: Qual a deficiência vitamínica no lactente caracterizada por neurite periférica, convulsões, dermatite e anemia?

A) Deficiência niacina.

B) Deficiência B1 (Tiamina).

C) Deficiência B12 (Biotina).

D) Deficiência vitamina B6 (Piridoxina).

E) Deficiência vitamina D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9998)

Enunciado: O que caracteriza a síndrome de Prader-Willi?

A) Crânio pequeno com fontanelas abertas, microftalmia, catarata, nistagmo, hipoplasia, micrognatia, dedos cavalgados.

B) Baixa estatura, deficiência mental, fenda palpebral desviada para cima, mãos e pés pequenos, obesidade, hipogenitalismo, diabetes mellitus, hipotonia muscular na primeira infância.

C) Baixa estatura, caquexia, face pequena com orelhas, olhos e nariz normais, desproporcionais a face.

D) Vários graus de deficiência mental, estatura variável, crânio relativamente pequeno, dedos cavalgados.

E) Ataxia-teleangiectasias, infecções repetidas. Associa-se em geral com doenças autoimunes e principalmente com neoplasias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13260)

Enunciado: Você é chamado para investigar um surto de diarreia aguda em uma creche. Qual o agente etiológico mais provável nessa condição?

A) Escherichia coli.

B) Giardia lambia.

C) A. lumbricoides.

D) Rotavirus.

E) Cryptosporidium.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10012)

Enunciado: Criança de 18 meses, apresenta sintomas vagos de irritabilidade, taquipneia, alterações digestivas e inapetência, ainda dor generalizada à palpação nos membros inferiores, principalmente quando colocado no colo ou troca de fralda, assumindo posição do membro típica de rã. Na radiografia é visualizado hemorragia subperiostais, contudo durante a resolução o periósteo elevado se calcifica e o osso afetado assume uma forma de haltere ou clava. Qual a deficiência vitamínica?

A) B

B) C

C) D

D) A

E) E

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13263)

Enunciado: A fim de evitar a desnutrição em lactente com 4 meses de idade, o melhor conselho que você daria a uma mãe nutriz, em um país em desenvolvimento, quando ela descobre que está novamente grávida é:

A) Continuar amamentando o maior tempo possível e começar alimentação complementar após 6 meses de idade.

B) Considerar uma alternativa para o leite humano e suspender o aleitamento o mais rápido possível.

C) Interromper a gravidez e usar planejamento familiar até que a criança tenha 2 anos de idade.

D) Suspender o aleitamento materno o mais rápido possível e introduzir outros alimentos.

E) Manter o aleitamento materno e introduzir leite artificial com mucilagens e outros alimentos complementares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7513)

Enunciado: Considere as seguintes alterações clínicas relacionadas com a desnutrição proteico-energética grave e marque a letra onde estão as características do marasmo na criança. I. hepatomegalia acentuada; II. atrofia muscular; III. edema de membros inferiores; IV. ausência de gordura subcutânea.

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) II e III.

E) I, II e III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

354381)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, residente na zona rural, sem consulta médica há 5 anos; é levada para consulta de rotina em um Centro de Saúde de referência. Sem queixas. Seu cartão de vacinas mostra que usou apenas o esquema vacinal básico, pois relatou alergia a ovo, com urticária, quando ingere a gema ou a clara. Considerando a alergia a ovo descrita no caso, indique que vacina necessita de cuidados especiais para sua administração:

A) Coronavac.

B) Anti-HPV

C) Influenza.

D) DTPa (Dupla tipo adulto).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

354382)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, residente na zona rural, sem consulta médica há 5 anos; é levada para consulta de rotina em um Centro de Saúde de referência. Sem queixas. Seu cartão de vacinas mostra que usou apenas o esquema vacinal básico, pois relatou alergia a ovo, com urticária, quando ingere a gema ou a clara. Sobre a vacinação de adolescentes, de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI-MS), é correto afirmar:

A) A vacina contra Febre Amarela é obrigatória na Região Nordeste.

B) A vacina antimeningocócica conjugada é aplicada em duas doses.

C) A vacinação anti-pertussis não deve ser administrada.

D) A vacina tríplice acelular (têtano, difteria e coqueluche) pode ser usada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

354383)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, residente na zona rural, sem consulta médica há 5 anos; é levada para consulta de rotina em um Centro de Saúde de referência. Sem queixas. Seu cartão de vacinas mostra que usou apenas o esquema vacinal básico, pois relatou alergia a ovo, com urticária, quando ingere a gema ou a clara. Sobre a vacinação para HPV (Papiloma Virus Humano) nessa paciente, de acordo com o Programa Nacional de Imunização pode-se afirmar:

A) Não está indicada, se não iniciou atividade sexual.

B) Não está indicada devido à alergia já apresentada.

C) Poderia ter sido usada desde os nove anos de idade

D) Está indicada com aplicação em dose única, sem reforço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324828)

Enunciado: Menina, dezoito meses de idade, é encaminhada à UBS por Agente Comunitária de Saúde, após verificar a Caderneta de Saúde da Criança. A evolução do peso da menor é a seguinte: nasceu com peso maior ou igual a Escore z -2 e menor que Escore z +2; entre os 4 e 8 meses de idade o peso estava maior ou igual a Escore z -3 e menor que Escore z -2; a partir dos 9 meses o peso tem seguido regularmente a posição menor que Escore z -3. A mãe informa amamentação exclusiva ao seio até os 3 meses de idade, passando a aleitamento misto, com leite em pó integral e, por vezes, mucilagem. Outros alimentos foram oferecidos a partir dos 5 meses, quando apresentou diarreia, sendo internada por 6 dias. Atualmente, toma café com leite e biscoitos ou pão pela manhã; suco ou fruta no lanche da manhã e no da tarde; almoça e janta a mesma refeição da família (feijão, arroz, farinha ou macarrão) e toma leite quando vai dormir. Ao exame: criança ativa, com aspecto emagrecido, dados vitais sem alteração; eupneica, afebril, com mucosas úmidas, descoradas ++/IV; extremidades oxigenadas. Anda sem apoio; fala poucas palavras soltas. Não há edemas, Abdome globoso, timpânico, com fígado palpável a 1 cm do rebordo costal direito, borda romba, superfície lisa, indolor à palpação. Baseado na curva de peso, indique o diagnóstico nutricional dessa criança ao nascer e o diagnóstico nutricional atual:

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324829)

Enunciado: Menina, dezoito meses de idade, é encaminhada à UBS por Agente Comunitária de Saúde, após verificar a Caderneta de Saúde da Criança. A evolução do peso da menor é a seguinte: nasceu com peso maior ou igual a Escore z -2 e menor que Escore z +2; entre os 4 e 8 meses de idade o peso estava maior ou igual a Escore z -3 e menor que Escore z -2; a partir dos 9 meses o peso tem seguido regularmente a posição menor que Escore z -3. A mãe informa amamentação exclusiva ao seio até os 3 meses de idade, passando a aleitamento misto, com leite em pó integral e, por vezes, mucilagem. Outros alimentos foram oferecidos a partir dos 5 meses, quando apresentou diarreia, sendo internada por 6 dias. Atualmente, toma café com leite e biscoitos ou pão pela manhã; suco ou fruta no lanche da manhã e no da tarde; almoça e janta a mesma refeição da família (feijão, arroz, farinha ou macarrão) e toma leite quando vai dormir. Ao exame: criança ativa, com aspecto emagrecido, dados vitais sem alteração; eupneica, afebril, com mucosas úmidas, descoradas ++/IV; extremidades oxigenadas. Anda sem apoio; fala poucas palavras soltas. Não há edemas, Abdome globoso, timpânico, com fígado palpável a 1 cm do rebordo costal direito, borda romba, superfície lisa, indolor à palpação. Considerando o relato do caso, informe duas situações de risco para a desnutrição nessa criança:

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324830)

Enunciado: Menina, dezoito meses de idade, é encaminhada à UBS por Agente Comunitária de Saúde, após verificar a Caderneta de Saúde da Criança. A evolução do peso da menor é a seguinte: nasceu com peso maior ou igual a Escore z -2 e menor que Escore z +2; entre os 4 e 8 meses de idade o peso estava maior ou igual a Escore z -3 e menor que Escore z -2; a partir dos 9 meses o peso tem seguido regularmente a posição menor que Escore z -3. A mãe informa amamentação exclusiva ao seio até os 3 meses de idade, passando a aleitamento misto, com leite em pó integral e, por vezes, mucilagem. Outros alimentos foram oferecidos a partir dos 5 meses, quando apresentou diarreia, sendo internada por 6 dias. Atualmente, toma café com leite e biscoitos ou pão pela manhã; suco ou fruta no lanche da manhã e no da tarde; almoça e janta a mesma refeição da família (feijão, arroz, farinha ou macarrão) e toma leite quando vai dormir. Ao exame: criança ativa, com aspecto emagrecido, dados vitais sem alteração; eupneica, afebril, com mucosas úmidas, descoradas ++/IV; extremidades oxigenadas. Anda sem apoio; fala poucas palavras soltas. Não há edemas, Abdome globoso, timpânico, com fígado palpável a 1 cm do rebordo costal direito, borda romba, superfície lisa, indolor à palpação. Na avaliação dessa criança, indique o exame laboratorial imprescindivel:

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324701)

Enunciado: Criança, 5 anos de idade, iniciou quadro febril agudo seguido de cefaleia e mialgias. Foi levada ao Hospital de Doenças Infecto-contagiosas, onde teve o diagnóstico de meningite viral, tendo alta com três dias por apresentar-se bem na evolução. Já em casa, sete dias após a alta, passa a apresentar perda súbita de força muscular em perna direita, com flacidez muscular. Em três dias não houve progressão, mas também não houve melhora. Os reflexos osteo-tendíneos estão diminuídos e a sensibilidade está preservada. Membro inferior esquerdo e demais dados do exame neurológico atual sem alterações. Quanto ao diagnóstico de poliomielite viral no quadro, pode se dizer que:

A) O quadro clínico é incompatível, pois não houve contactantes com sintomas de poliomielite.

B) O quadro clinico é compatível, embora a paralisia mais comum na poliomielite seja espástica.

C) O quadro clínico é compatível com a Síndrome de Guillan-Barré, com quadro típico dessa condição.

D) O quadro clinico é compatível e deve ser considerado como poliomielite até ser afastada a doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324702)

Enunciado: Criança, 5 anos de idade, iniciou quadro febril agudo seguido de cefaleia e mialgias. Foi levada ao Hospital de Doenças Infecto-contagiosas, onde teve o diagnóstico de meningite viral, tendo alta com três dias por apresentar-se bem na evolução. Já em casa, sete dias após a alta, passa a apresentar perda súbita de força muscular em perna direita, com flacidez muscular. Em três dias não houve progressão, mas também não houve melhora. Os reflexos osteo-tendíneos estão diminuídos e a sensibilidade está preservada. Membro inferior esquerdo e demais dados do exame neurológico atual sem alterações. Quanto à situação da poliomielite viral no Brasil, pode se afirmar que:

A) Encontra-se erradicada, porém com taxas de cobertura vacinal reduzidas, o que pode reintroduzir a doença no país.

B) Encontra-se controlada, com casos apenas episódicos, devido à baixa cobertura vacinal dos últimos anos.

C) Encontra-se erradicada e, considerando os riscos vacinais, não há indicação de vacina.

D) Encontra-se em fase pré-epidêmica, pois casos episódicos já indicam risco de disseminação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324703)

Enunciado: Criança, 5 anos de idade, iniciou quadro febril agudo seguido de cefaleia e mialgias. Foi levada ao Hospital de Doenças Infecto-contagiosas, onde teve o diagnóstico de meningite viral, tendo alta com três dias por apresentar-se bem na evolução. Já em casa, sete dias após a alta, passa a apresentar perda súbita de força muscular em perna direita, com flacidez muscular. Em três dias não houve progressão, mas também não houve melhora. Os reflexos osteo-tendíneos estão diminuídos e a sensibilidade está preservada. Membro inferior esquerdo e demais dados do exame neurológico atual sem alterações. Quanto à vacina mais empregada no Brasil para prevenção da poliomielite, pode-se afirmar que

A) é feita de vírus mortos e pode complicar com a Síndrome de Guillan Barré

B) é feita com vírus vivos, provocando complicações raras por mutação viral

C) é feita com DNA viral isolado e pode desencadear reações autoimunes

D) é feita com RNA viral isolado e pode desencadear reações autoimunes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294481)

Enunciado: Adolescente, 16 anos de idade, chega à UBS com quadro de poliúria há, aproximadamente, 40 dias. Refere fadiga frequente, o que atribui ao aumento de peso, durante a pandemia. Nega febre, disúria e outros sintomas. Ao exame, IMC: 29 kg/m²; acima do 95º percentil; bom estado geral, eupneica, hidratada, afebril, corada. Apresenta eritema macular hiperemiado sob ambas as mamas, pruriginoso. O exame de urina I mostra: pH: 7,2; densidade: de 1,01; ausência de cetonas, bilirrubina, urobilinogênio, sangue e nitrito; presença de glicose ++; raros leucócitos e raras células epiteliais. Glicemia em jejum foi de 100 mg/dl. Diante os dados apresentados, indique a classificação dada a essa adolescente quanto à antropometria.

A) Eutrófica.

B) Sobrepeso.

C) Obesidade.

D) Obesidade mórbida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284607)

Enunciado: Menino, 7 anos de idade, é levado à Unidade de Pronto Atendimento por ter pisado em um prego enferrujado quando se encontrava em um abrigo de animais. O genitor não conseguiu retirar o prego, que permaneceu encravado. Sua carteira de vacinação mostra-se desatualizada desde os 12 meses de idade. Considerando a situação descrita, Identifique a afirmação correta quanto aos cuidados desse paciente.

A) O uso de água oxigenada não evidencia vantagens sobre a lavagem com soro fisiológico comum.

B) A lavagem com clorexedina não mostrou eficácia no combate à infecção local.

C) O desbridamento pode ser evitado, se a retirada do prego ocorrer antes de duas horas do ferimento ter ocorrido.

D) O curativo oclusivo pós-desbridamento está contraindicado, devendo ser feito um curativo permeável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284608)

Enunciado: Menino, 7 anos de idade, é levado à Unidade de Pronto Atendimento por ter pisado em um prego enferrujado quando se encontrava em um abrigo de animais. O genitor não conseguiu retirar o prego, que permaneceu encravado. Sua carteira de vacinação mostra-se desatualizada desde os 12 meses de idade. Considerando a situação descrita, Indique a estratégia de imunização correta para profilaxia de tétano, nesse caso.

A) Usar vacina dupla (DT).

B) Usar vacina tríplice (DPT).

C) Usar vacina toxoide tetânico e imunoglobulina hiperimune antitetânica.

D) Usar vacina dupla (DT) e imunoglobulina hiperimune antitetânica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284609)

Enunciado: Menino, 7 anos de idade, é levado à Unidade de Pronto Atendimento por ter pisado em um prego enferrujado quando se encontrava em um abrigo de animais. O genitor não conseguiu retirar o prego, que permaneceu encravado. Sua carteira de vacinação mostra-se desatualizada desde os 12 meses de idade. Considerando a situação descrita, Quanto à antibioticoterapia profilática é correto afirmar:

A) Não há evidências científicas para a profilaxia com penicilina benzatina.

B) A clindamicina e a doxiciclina estão contraindicadas no caso.

C) A reação cruzada com penicilinas é maior nas cefalosporinas de 3ª geração.

D) Metronidazol não substitui penicilina em casos de tétano já instalado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206077)

Enunciado: Menino, com 9 meses de vida, é levado à consulta na UBS por apresentar obstrução nasal, coriza, tosse seca e febrícula há 48 horas. Ao anotar a consulta na Caderneta da Criança, o médico verifica que há registro de aplicação das seguintes vacinas: BCG e hepatite B, aos 28 dias de vida; Salk e pneumocócia 10 valente, aos 2 anos e 4 meses de vida, DPT aos 2, 4 e 6 meses. Frente ao caso, cite as vacinas que devem ser administradas, no momento, para aproveitar a ida à UBS, conforme o Programa Nacional de Imunizações do Minitério da Saúde, especificando a dose (por exemplo, primeira dose, dose única, reforço etc).

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206078)

Enunciado: Menino, com 9 meses de vida, é levado à consulta na UBS por apresentar obstrução nasal, coriza, tosse seca e febrícula há 48 horas. Ao anotar a consulta na Caderneta da Criança, o médico verifica que há registro de aplicação das seguintes vacinas: BCG e hepatite B, aos 28 dias de vida; Salk e pneumocócia 10 valente, aos 2 anos e 4 meses de vida, DPT aos 2, 4 e 6 meses. Frente ao caso, indique as vacinas que deverão ser administradas, nessa criança, quando completar 12 meses de vida, especificando a dose (por exemplo, primeira dose, dose única, reforço etc).

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206069)

Enunciado: Menino, com 9 meses de vida, é levado à consulta na UBS por apresentar obstrução nasal, coriza, tosse seca e febrícula há 48 horas. Ao anotar a consulta na Caderneta da Criança, o médico verifica que há registro de aplicação das seguintes vacinas: BCG e hepatite B, aos 28 dias de vida; Salk e pneumocócia 10 valente, aos 2 anos e 4 meses de vida, DPT aos 2, 4 e 6 meses. Frente ao caso, cite três contraindicações para a vacina contra febre amarela em crianças.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206072)

Enunciado: Durante visita domiciliar, o médico de Família e Comunidade avalia criança do sexo masculino com 4 anos e 4 meses de idade. O menor queixa-se de fadiga ao jogar futebol na escola e ao correr. Apresenta hiperpigmentação na região posterior do pescoço e nas zonas de flexão das articulações, de aspecto hipertrófico e aveludado. Sem outra queixa. Ao exame, apresenta 24 kg e 110 cm de altura. O médico, ao atender a criança, considerou o gráfico de Índice de Massa Corporal da Organização Mundial da Saúde, adotada pelo Ministério da Saúde, representado a seguir. Tendo em vista o relato e o gráfico adotado pelo MS, classifique o estado ponderal desse menino, considerando as curvas do Índice de Massa Corporal.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176301)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 16 anos e 6 meses de idade, vai ao ambulatório de referência, queixando-se de ser mais baixo que seus irmãos e solicitando "tratamento para crescer". Sem outras queixas. A história pregressa mostra que nasceu com peso de 3.580 g e comprimento de 50 cm. Com 2 anos, pesava 11.500 g e media 87,5 cm; aos 5 anos pesava 17.100 g e media 92 cm; aos 8 anos pesava 27 kg e media 106 cm; aos 10 anos pesava 40 kg e media 111 cm; aos 12 anos pesava 56 kg e media 124 cm; aos 14 anos pesava 60 kg e media 145 cm. Relata que houve leve atraso no início da puberdade. Nega doenças importantes e internamentos. Passou a jogar basquete há, aproximadamente, um ano. O pai mede 184 cm e a mãe mede 163 cm. Irmão de 14 anos mede 170 cm. Ao exame, 16 anos, pesa 68 kg e mede 167 cm. Critérios de Tanner compatíveis com a idade cronológica atual. Sem alterações ao exame segmentar. Considerando as informações sobre o caso e o gráfico apresentado para definir o padrão de crescimento de meninos, indique o diagnóstico específico quanto ao desenvolvimento desse adolescente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176320)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 16 anos e 6 meses de idade, vai ao Ambulatório de Referência, queixando-se de ser mais baixo que seus irmãos e solicitando "tratamento para crescer", sem outras queixas. A história pregressa mostra que nasceu com peso de 3.580 g e comprimento de 50 cm. Com 2 anos, pesava 11500 g e media 87,5 cm; aos 5 anos pesava 17100 g e media 92 cm; aos 8 anos pesava 27 kg e media 106 cm; aos 10 anos pesava 40 kg e media 111 cm; aos 12 anos pesava 56 kg e media 124 cm; aos 14 anos pesava 60 kg e media 145 cm. Relata que houve leve atraso no início da puberdade. Nega doenças importantes e internamentos. Passou a jogar basquete há, aproximadamente, um ano. O pai mede 184 cm e a mãe mede 163 cm. Irmão de 14 anos mede 170 cm. Ao exame, 16 anos, pesa 68 kg e mede 167 cm. Critérios de Tanner compatíveis com a idade cronológica atual. Sem alterações ao exame segmentar. Considerando as informações sobre o caso e o gráfico apresentado para definir o padrão de crescimento de meninos, indique o exame de imagem necessário para esse diagnóstico.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176323)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 16 anos e 6 meses de idade, vai ao Ambulatório de Referência, queixando-se de ser mais baixo que seus irmãos e solicitando "tratamento para crescer" , Sem outras queixas. A história pregressa mostra que nasceu com peso de 3580g e comprimento de 50cm. Com 2 anos, pesava 11500g e media 87,5cm; aos 5 anos pesava 17100g e media 92cm; aos 8 anos pesava 27kg e media 106cm; aos 10 anos pesava 40kg e media 111cm; aos 12 anos pesava 56kg e media 124cm; aos 14 anos pesava 60kg e media 145cm. Relata que houve leve atraso no inicio da puberdade. Nega doenças importantes e internamentos. Passou a jogar basquete há, aproximadamente, um ano. O pai mede 184cm e a mãe mede 163cm. Irmão de 14 anos mede 170cm. Ao exame, 16 anos, pesa 68kg e mede 167cm. Critérios de Tanner compatíveis com a idade cronológica atual. Sem alterações ao exame segmentar. Considerando as informações sobre o caso e o gráfico apresentado para definir o padrão de crescimento de meninos, indique o achado que define o diagnóstico nesse exame de imagem.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152222)

Enunciado: Casos de hidrofobia ou raiva humana são habitualmente raros e com frequência estável. Entretanto, mesmo a notificação de, apenas, um caso em um território já é motivo de preocupação para a Vigilância Epidemiológica. Considerando a ação da Vigilância Epidemiológica, cite o principal vetor dessa zoonose no Brasil.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152256)

Enunciado: Um hospital da Rede SUS detectou que o índice de viragem do PPD entre os funcionários da enfermagem superou 2% no ano anterior. O Hospital Geral atende pacientes de clínica médica regulados pela Rede, entre os quais pacientes com tuberculose em atividade. As atividades profissionais na área de saúde são por vezes consideradas insalubres e, dependendo do grau, a insalubridade determina um acréscimo salarial. Diante dessas informações, indique duas medidas que devem ser adotadas em um enfermeiro, com 36 anos de idade, com viagem tuberculínica nos últimos seis meses, assintomático, sem comorbidades.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34972)

Enunciado: Paciente, portadora da síndrome de Turner, vem à consulta de rotina, quando é observado diminuição da amplitude dos pulsos arteriais nos membros inferiores, associada à presença de pulsos amplos e hipertensão arterial nos membros superiores, hiperfonese da 2ª bulha nas áreas aórtica e mitral; estalido protossistólico aórtico, principalmente na área mitral, sopro ocupando a mesotelessístole e avançando até a protomesodiástole na região do dorso esquerdo.

São características da síndrome de Turner, exceto:

A) apresentar baixa estatura.

B) apresentar linha posterior de implantação dos cabelos baixa (na nuca).

C) ter pescoço alado.

D) apresentar edemas nas mãos e no dorso dos pés, no período neonatal.

E) afetar mais o sexo masculino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281872)

Enunciado: Assinale a alternativa correta sobre a herança genética para a estatura.

A) Unigênica.

B) Cromossômica dominante.

C) Cromossômica ligada ao X.

D) Poligênica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249984)

Enunciado: Está contraindicado nos pacientes com tratamento com anti-TNF quais dos procedimentos citados abaixo?

A) Teste tuberculínico e raio X de tórax.

B) Vacinas de vírus vivo e febre amarela.

C) Coprocultura com pesquisa de agentes enteropatogênicos e detecção de INF-gama.

D) Sorologia para hepatite B e C e para HIV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250011)

Enunciado: Vacina que não pode ser utilizada na gravidez:

A) Hepatite C.

B) Raiva.

C) Dupla adulto.

D) Gripe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181154)

Enunciado: Em relação à Síndrome Metabólica na criança, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Orlistate é aprovado para uso em adolescentes maiores de 12 anos.

B) As medidas preventivas para obesidade infantil devem ter como foco apenas a alimentação saudável.

C) O uso de medicação isolada não amplia a liberdade para consumir açúcares e gordura em excesso.

D) O tratamento cirúrgico não deve ser realizado antes da consolidação das epífises de crescimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139753)

Enunciado: Um recém-nascido com três semanas de vida é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe observou ferida no local da aplicação da BCG. Ao exame físico, observa-se lesão pustulocrostosa no braço direito e presença de gânglio satélite em axila direita, não supurado, medindo 1 cm de diâmetro. Considerando o diagnóstico, assinale a alternativa contendo a conduta ADEQUADA a ser tomada para esse recém-nascido:

A) Iniciar isoniazida por via oral.

B) Manter conduta expectante.

C) Solicitar teste tuberculínico.

D) Realizar punção do gânglio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111921)

Enunciado: Mãe leva criança de 3 anos ao pediatra relatando que seu filho está sem apetite e muito irritado. O histórico alimentar atual da criança é adequado para a idade. A mãe diz que está utilizando polivitamínicos e orexígenos há vários meses em doses elevadas. Ao exame físico, a criança apresenta-se hipoativa, com alopecia e lesões cutâneas seborreicas e ausência de ganho ponderal em relação à última consulta. A hipervitaminose crônica MAIS provável, nesse caso, é por excesso de vitamina:

A) E.

B) D.

C) A.

D) B6.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111898)

Enunciado: Jovem com 14 anos de idade é levado à Unidade Básica de Saúde por ferimento no pé esquerdo por mordida de cão. Refere não conhecer o cão e que este fugiu logo após o ter mordido. Tinha realizado o reforço da vacina dT quando estava com 10 anos de idade. A lesão não era profunda e estava levemente sangrante. Qual deve ser a conduta MAIS adequada do profissional que atendeu esse paciente na UBS?

A) Higiene da lesão, iniciar esquema de vacina antirrábica e observar o jovem por 10 dias.

B) Higiene da lesão, iniciar esquema de vacina antirrábica, observar o jovem por 10 dias e administrar uma dose de vacina antitetânica.

C) Higiene da lesão e observar a criança por 10 dias.

D) Higiene da lesão, iniciar esquema de vacina antirrábica intramuscular em deltoide e administrar imunoglobulina contra a raiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321323)

Enunciado: Um recém-nascido de 35 semanas que nasceu há 7 dias, pesando 1900g, comparece ao posto de saúde para ser imunizado. Qual o melhor esquema a ser orientado neste momento?

A) Vacinar com Anti-hepatite B e BCG.

B) Vacinar anti-hepatite B e orientar BCG quando completar 2000g.

C) Adiar ambas as vacinas (Hepatite B e BCG) para quando criança pesar 2500g.

D) Adiar as vacinas contra a hepatite B e a BCG até criança ter 37 semanas de idade gestacional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292794)

Enunciado: Uma paciente com púrpura trombocitopênica idiopática irá ser submetida a esplenectomia videoparoscópica. O médico orienta a aplicação de uma vacina 20 dias antes da retirada do baço. Qual doença deve ser prevenida através dessa vacina?

A) Tétano.

B) Hepatite.

C) Pneumonia.

D) Coronavirus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292832)

Enunciado: Criança de 8 anos de idade, masculino, com quadro clínico de obesidade com IMC acima de z-score +3, presença de acantose nigricans em região cervical, obesidade central com circunferência abdominal acima de P90 para idade e sexo, estrias claras em abdomen e membros inferiores, pressão sistólica acima de P90 para a idade, exames laboratoriais mostrando resistência à insulina e triglicerídeos acima de 110 mg/dL. Observando o quadro clínico descrito, qual a assertiva correta sobre os fatores associados à fisiopatologia da Síndrome Metabólica?

A) Hipertensão arterial e dislipidemia correlacionam-se melhor com o próprio índice de massa corpórea (IMC) do que com circunferência da cintura.

B) O aumento da circunferência abdominal, indicativa de acúmulo visceral de tecido adiposo, confere um risco independente de doença cardiovascular.

C) Os índices de lesão orgânica subclínica refletem menor risco de doença cardiovascular em adultos e estão relacionados a aumento de IMC em crianças.

D) A resistência insulínica associada à obesidade na infância não exerce influência na fisiopatologia da síndrome metabólica e do diabetes melito tipo 2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292834)

Enunciado: Criança de 1 ano e 4 meses vai iniciar atividades escolares e a creche solicitou à mãe que levasse o cartão de vacina, para verificação. Na avaliação, foi visto que tinha as seguintes vacinas administradas até aquela data: BCG e Hepatite B, 03 doses da poliomelite VIP, 02 doses da rotavírus, 03 doses da DTP+Hib+HB (Penta), 02 doses da Pneumocócica 10 valente, 02 doses da Meningocócica C (conjugada) e 01 dose da Influenza. De acordo com o calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), quais vacinas precisam ser administradas para que o cartão vacinal fique atualizado?

A) Febre Amarela 1ª dose; Pneumocócica conjugada reforço; Meningocócica C conjugada reforço; Tríplice Viral 1ª dose; DTP 1º reforço; Poliomielite 1º reforço (VOP); Hepatite A 1 dose; Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela); Influenza 2ª dose.

B) Febre Amarela 1ª dose; Pneumocócica conjugada 3ª dose e reforço; Meningocócica C conjugada 3ª dose e reforço; Tríplice Viral 1ª dose; Pentavalente 1º reforço; Poliomielite 2º reforço (VOP); Hepatite A 1 dose; Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela); Influenza 2ª dose.

C) Febre Amarela 1ª dose e 2ª dose; Pneumocócica conjugada 3ª dose; Meningocócica C conjugada 3ª dose; Tríplice Viral 1ª dose; Pentavalente 1º reforço; Poliomielite 1º reforço (VOP); Hepatite A 1 dose; Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela); Influenza 3ª dose.

D) Febre Amarela 1ª dose; Pneumocócica conjugada reforço; Meningocócica C conjugada reforço; Tríplice Viral 1ª dose e 2ª dose; DTP 1º reforço; Poliomielite 1º reforço (VOP); Hepatite A 1ª dose e 2ª dose; Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela); Influenza 3ª dose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292836)

Enunciado: Mãe trouxe para avaliação no posto de saúde um lactente com 6 meses de idade, que apresentava, há 3 dias, febre, tosse seca, prostração intensa. Evoluiu com exantema inicialmente na face que se estendeu pelo tronco e membros, coriza abundante e hialina e os olhos hiperemiados. Na orofaringe apresentava-se hiperemiada com manchas branco-azuladas e pequenas. Mãe relata que um tio havia chegado de viagem e estava com sintomas semelhantes com suspeita de sarampo. Como devemos proceder quanto ao bloqueio vacinal?

A) Caracterizando situação de surto, os contactantes gestantes e crianças abaixo dos 6 meses de idade também devem ser vacinados.

B) A aplicação da vacina deve ser realizada no prazo máximo de 5 dias, nos contactantes, apenas no caso confirmado de sarampo.

C) Contatos com idade a partir dos 3 meses até 11 meses e 29 dias devem receber uma dose da vacina tríplice viral válida para a rotina de vacinação.

D) A vacinação de bloqueio deve ser realizada no prazo máximo de até 72 horas após o contato com o caso suspeito ou confirmado de sarampo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259742)

Enunciado: Paciente, 10 anos, sexo feminino, é levada para consulta de rotina em ambulatório de pediatria. Mãe relata que a filha teve ganho ponderal considerável nos últimos 3 meses relacionada a mudança no padrão alimentar. Nega atividade física regular. História de diabetes e hipertensão arterial na família. Ao exame: peso 50 kg (escore-Z entre +2 e +3); E 1,45 m (escore-Z +1); IMC 23,8 (escore-Z entre +2 e +3); circunferência abdominal 80 cm (> percentil 90). Ausculta cardíaca e pulmonar normais. PA: 122 x 85 mmHg. Pele e fâneros: presença de acantose nigricans em região de pescoço. Qual parâmetro do exame físico está mais relacionado ao risco cardiovascular na idade adulta?

A) Circunferência abdominal.

B) Índice de massa corpórea.

C) Pressão arterial.

D) Peso por idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234017)

Enunciado: Uma crianc?a de 5 anos foi trazida a? UPA, vi?tima de mordedura de ca?o, na regia?o malar, ha? 1 hora. Ao ser admitida, foi vista ferida com cerca de 3 cm de extensa?o na regia?o malar esquerda, sem a?reas necro?ticas ou sangramento ativo e de aspecto irregular com extensa?o de 3 cm. A ferida foi lavada com a?gua e saba?o em casa e o ca?o era da fami?lia, passi?vel de observac?a?o e na?o apresentava comportamento anormal ou doenc?a evidente no momento do acidente. O carta?o de vacinas da crianc?a esta? completo. Acerca do manejo desse paciente, pode-se afirmar que:

A) A profilaxia por vacina antirra?bica na?o e? necessa?ria.

B) Deve-se realizar a lavagem da ferida, mas na?o a sutura.

C) Deve-se realizar antibio?ticos e vacina antiteta?nica profila?ticos.

D) Deve-se realizar a limpeza da ferida com substa?ncia viricida (p. ex. PVPI).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234049)

Enunciado: Durante consulta de avaliação de rotina, uma criança de 5 anos apresentava história clínica e familiar preditiva para obesidade. Ao exame físico, apresentava IMC acima do percentil 97, aumento da circunferência abdominal com percentil acima de 90 para sua idade, medidas de dobras cutâneas com elevada porcentagem de gordura corporal e acantose nigricans em região cervical. Dentro do quadro clínico do paciente na infância, quais são os mais fortes preditores de síndrome metabólica na idade adulta?

A) História clínica e familiar preditiva para obesidade.

B) IMC acima do percentil 97 e acantose nigricans em região cervical.

C) História clínica preditiva para obesidade e IMC acima do percentil 97.

D) Circunferência da cintura maior que o percentil 90 e as medidas de dobras cutâneas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234072)

Enunciado: Casal se consulta na Unidade Básica de Saúde procurando aconselhamento vacinal em relação ao sarampo. João tem 32 anos e Maria 28. Ambos são sadios e Maria não está grávida. Afirmam terem recebido todas as vacinas da infância, porém não possuem mais seus cartões vacinais. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, que recomendação deve ser feita em relação à indicação de tríplice viral?

A) Uma dose para Maria e duas para João.

B) Uma dose para João e duas para Maria.

C) Duas doses para ambos.

D) Não vacinar nenhum dos dois.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234074)

Enunciado: Paciente, masculino, 55 anos, acompanhado pelo Consultório de Rua, procura a equipe de saúde. Veio há 02 meses para a capital em busca de melhores condições de vida, não conseguiu emprego, mora com a esposa e filhos. Refere ter parado uso abusivo de álcool há três dias para procurar emprego. No momento, apresenta queixas de tremores, náuseas sem vômitos e diarreia. Não conseguiu dormir nas últimas 24h. Ao exame, encontra-se levemente agitado, orientado no tempo e no espaço, apresenta lesões hipercrômicas, descamativas, pruriginosas e bem delimitadas em áreas de exposição solar. Nega uso de drogas e outras comorbidades. Qual o tratamento indicado para o quadro dermatológico do paciente?

A) Loratadina.

B) Prednisona.

C) Ivermectina.

D) Ácido nicotínico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234077)

Enunciado: Equipe de Saúde da Família, em visita a abrigo em Fortaleza, consulta família composta por pai e mãe, refugiados venezuelanos, e bebê de dois meses, nascido no Brasil. A criança encontra-se bem, e seu cartão vacinal mostra registro de imunização para BCG e hepatite B, ao nascer. Qual das opções abaixo aponta corretamente uma vacina que estaria indicada para esta criança?

A) Tríplice viral.

B) Poliomielite oral.

C) Rotavírus monovalente.

D) Pneumocócica 23-valente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234088)

Enunciado: Paciente primigesta, no curso da 12a semana, comparece a consulta inicial de pré-natal em Unidade Básica de Saúde. Refere estar temerosa com a ocorrência de casos de sarampo na cidade e questiona acerca de quais vacinas ela deve realizar. Quais vacinas devem ser recomendadas a esta paciente durante sua gestação?

A) Deve-se recomendar realização de vacinação para influenza, hepatite B e dTpa.

B) Deve-se recomendar realização de vacinação para hepatite B, dTpa e tríplice viral.

C) Deve-se recomendar realização de vacinação para hepatite B, febre amarela e influenza.

D) Deve-se recomendar realização de vacinação para influenza, febre amarela e tríplice viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199676)

Enunciado: Lactente de seis meses de idade é levado ao ambulatório para consulta de rotina. O exame físico revela ausência de cicatriz vacinal para BCG, sem outras alterações. No cartão da criança, consta registro de vacinação contra tuberculose no período neonatal, realizada na maternidade. Qual a melhor conduta nesse caso?

A) Considerar o lactente imunizado e não revacinar.

B) Revacinar o lactente, sem fazer o teste tuberculínico.

C) Fazer o teste tuberculínico e, se for negativo, revacinar o lactente.

D) Revacinar o lactente e, se não apresentar cicatriz, repetir a dose aos 12 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199692)

Enunciado: Estudante, 17 anos, recém-ingressa no curso de Medicina no estado do Ceará inicia suas atividades no serviço de atenção primária e se verifica que ela não possui registro de imunização contra sarampo. Qual é a indicação adequada para esse caso?

A) Dose única da vacina dupla de adulto.

B) Dose única da vacina contra o sarampo.

C) Duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

D) Uma dose de dupla de adulto acelular a qualquer momento e completar a vacinação básica com dupla adulto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173018)

Enunciado: Chega à Unidade de Saúde um casal que recebeu um lactente de 9 meses para adoção. Informam que o bebê recebeu apenas as vacinas aplicadas na maternidade, e solicitam orientação quanto às outras vacinas. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), quais vacinas deveriam ser CORRETAMENTE indicadas pela equipe de Saúde da Família da UBS?

A) Penta (3 doses), poliomielite Salk ? VIP (3 doses), pneumocócica 10 (2 doses) e meningocócica C (2 doses).

B) Penta (3 doses), rotavírus (2 doses), poliomielite Salk ? VIP (3 doses), pneumocócica 10 (2 doses) e

meningocócica C (2 doses).

C) Penta (3 doses), rotavírus (2 doses), poliomielite Salk ? VIP (3 doses), pneumocócica 10 (2 doses) e

meningocócica C (2 doses).

D) Penta (3 doses), vacina poliomielite 1, 2 e 3 ? VOP (3 doses), pneumocócica 10 (2 doses) e meningocócica C (2 doses).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173037)

Enunciado: Escolar de 7 anos é referido ao Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica por ser o menor aluno de sua turma na escola. Tem boa saúde, é ativo e apresenta bom rendimento escolar. Seu pai mede 1,60 m e sua mãe 1,50 m. O médico mede a criança e constata 112 cm, calcula o alvo genético do paciente, solicita radiografia para determinação da idade óssea, que resulta compatível com idade cronológica de 6 anos e 6 meses. Os exames laboratoriais solicitados vêm normais. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente?

A) Hipotireoidismo.

B) Baixa estatura familiar.

C) Deficiência de hormônio do crescimento.

D) Retardo constitucional do crescimento e puberdade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172950)

Enunciado: Durante uma visita domiciliar à puérpera, em sua área, a equipe de Saúde da Família identifica um lactente de 10 meses apresentando magreza acentuada visível, hipotrofia muscular, principalmente dos glúteos, aspecto envelhecido e circunferência braquial de 10 cm. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, como a equipe classificaria o estado de desnutrição dessa criança?

A) Desnutrição proteicoenergética grave ? kwashiorkor.

B) Criança com Desnutrição proteicoenergética grave ? marasmo.

C) Criança com Desnutrição proteicoenergética moderada ? marasmo.

D) Criança com Desnutrição proteicoenergética moderada ? kwashiorkor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173010)

Enunciado: Estudante de medicina, 22 anos, residente em Fortaleza, iniciando o internato em 2018, realizará viagem em 30 dias para estágio em Minas Gerais e comparece à Unidade Básica de Saúde para atualizar seu cartão vacinal. Questionado sobre seu passado vacinal, apresenta cartão vacinal com as vacinas administradas de acordo com o calendário nacional de vacinação até os 05 anos de idade e vacina contra a febre amarela há 12 anos. Nega outras vacinas na adolescência e idade adulta. De acordo com as atuais recomendações do Programa Nacional de Imunização, que vacinas devem ser administradas?

A) dT e influenza.

B) dT e febre amarela.

C) Hepatite B e influenza.

D) Febre amarela e hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172999)

Enunciado: Mulher com 28 anos, na 9ª semana de gestação, comparece à Unidade Básica de Saúde para realizar sua segunda consulta de pré-natal com seu médico de família. Nega queixas durante o atendimento. Mostra cartão de vacina que comprova uma dose de hepatite B realizada há cerca de 5 anos. Traz resultados de exames solicitados em consulta anterior: HBsAg: não reagente, Anti-HBs: não reagente. Qual a conduta recomendada com relação à hepatite B?

A) Duas doses da vacina, iniciando imediatamente.

B) Duas doses da vacina, iniciando após o 1º trimestre.

C) Três doses da vacina, iniciando no 3º trimestre.

D) Três doses da vacina, iniciando no período puerperal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150820)

Enunciado: Criança de 5 anos, vítima, há 2 dias, de escaldo por água quente que caiu do fogão, em região do tórax, é acompanhada em hospital geral. Ao exame, apresenta queimadura de 2% da superfície corpórea, de coloração amarelo nacarado claro, e outra de 2% da superfície corpórea, de coloração amarelo mais escurecido. Qual é a conduta mais adequada para o caso, neste momento?

A) Curativos abertos, para se evitar infecção, até eventual ressecção e enxertia de pele.

B) Curativos oclusivos, para se evitar infecção, até eventual ressecção e enxertia de pele.

C) Ressecção cirúrgica de toda a lesão, para se evitar infecção e programar enxertia de pele.

D) Ressecção cirúrgica da área mais escura, para se evitar infecção e programar enxertia de pele.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150797)

Enunciado: Lactente saudável, de 6 meses, vem à unidade básica de saúde para consulta de puericultura e é encaminhado para aplicação de vacinas, conforme o Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. A mãe da criança alega que o esquema vacinal está diferente em relação aos anos anteriores. Quais modificações foram introduzidas no Calendário Básico de Vacinação do Ministério da Saúde em 2016 para os bebês até 6 meses de idade?

A) A introdução da vacina contra gripe e antecipação da vacina tríplice viral.

B) Acréscimo da 3ª dose da vacina antimeningocócica C e 3ª dose da vacina para rotavírus.

C) Não houve modificações em relação ao Calendário Básico de Vacinações para os bebês até 6 meses de idade.

D) Redução de uma dose da vacina antipneumocócica 10-valente e a 3° dose da vacina contra poliomielite passa a ser injetável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150882)

Enunciado: Adolescente de 14 anos, em uma viagem pelo interior do Ceará, capturou um soim/sagui para criar em casa. No momento em que o alimentava levou um pequeno corte no antebraço esquerdo provocado pela mordedura do animal. Foi orientado pelo agente de saúde a buscar atendimento em uma unidade de saúde ainda no mesmo dia da agressão. Depois de orientar o adolescente a proceder a lavagem do local com água e sabão, qual a conduta mais adequada nesse caso?

A) Iniciar, imediatamente, o tratamento com soro-vacinação em cinco doses nos dias 0, 3, 7, 14 e 28, independente da gravidade da lesão.

B) Observar o animal por 10 dias, e se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, administrar 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28).

C) Enviar o animal para observação em um centro de controle de zoonoses, por 10 dias, se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer ou se tornar raivoso, administrar 3 doses de vacina (dias 0, 7 e 14).

D) Iniciar, imediatamente, o tratamento com 2 (duas) doses de vacina, sendo uma no dia 0 e outra no dia 3. Observar o animal durante 10 dias após exposição. Se não houver confirmação suspender o tratamento e encerrar o caso. Se confirmado, aplicar a última dose da vacina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150816)

Enunciado: Paciente inicia o pré-natal com gestação de 20 semanas. Cartão vacinal registra três doses de dT (dupla do tipo adulto: difteria e tétano) na gravidez anterior, há seis anos. Considerando a recomendação atual do MS (Ministério da Saúde) de fornecer proteção ao recém-nascido para a coqueluche, além de difteria e tétano (vacina dTpa - tríplice bacteriana acelular). Como deve ser realizado o esquema de vacinação dessa gestante?

A) Uma dose de dTpa imediata e repete com 60 dias.

B) Uma dose de dTpa entre 27 e 36 semanas de gestação.

C) Uma dose de dT imediata e uma dose de dTpa com 60 dias.

D) Duas doses de dT com intervalo de 30 dias e uma de dTpa após 27 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127029)

Enunciado: Maria vem à unidade básica de saúde preocupada com seu filho Tomás, de 3 meses. Relata que em sua família e na do marido existem vários casos de obesidade, e solicita orientação para diminuir os riscos de Tomás também evoluir com excesso de peso. Qual das assertivas contém pelo menos 3 recomendações CORRETAS para prevenção da obesidade que podem ser fornecidas pela equipe?

A) As crianças em aleitamento artificial devem receber mamadeiras acrescidas de farinha, açúcar e achocolatado apenas a partir de 6 meses. Limitar comportamentos sedentários a 4 horas por dia. Suspender as mamadas noturnas a partir de 2 meses de idade. Permitir apenas refrigerantes diet.

B) As crianças em aleitamento artificial devem receber mamadeiras acrescidas de farinha, açúcar e/ou achocolatado a partir do desmame. Alimentos ricos em gorduras, como frituras, bolachas recheadas, sorvetes e embutidos (salsicha, mortadela, linguiça, presunto, toicinhos), não devem ser oferecidos antes de 1 ano. Limitar comportamentos sedentários a 4 horas por dia.

C) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Quanto mais tempo a criança mama no peito, menor a chance de se tornar obesa. Evitar o consumo excessivo de leite de vaca, que está associado à obesidade entre crianças menores de 2 anos. Não oferecer comida para a criança enquanto ela assiste a TV. Nenhuma criança deve ver TV mais que duas horas por dia.

D) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Oferecer açúcar, doces em geral, salgadinhos, refrigerante, refrescos artificiais, achocolatados, gelatinas e outras guloseimas apenas depois de 6 meses de vida. A criança que come arroz, feijão, verdura e carne duas vezes ao dia não tem risco de desenvolver obesidade. O consumo excessivo de leite de vaca está associado à obesidade entre crianças menores de 2 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102175)

Enunciado: Menina vem à Unidade Básica de Saúde, para acompanhamento do crescimento, portando radiografia do punho esquerdo mostrando atraso de 2 anos da idade óssea em relação à idade cronológica. Hemograma e sumário de urina normais. Exibe as seguintes medições: Aos sete anos: 110 cm, aos 8 anos ? 117 cm, aos 9 anos ? 122 cm e aos 10 anos ? 128 cm. Não apresenta telarca ou pubarca e tem peso adequado para a idade. (VER IMAGEM). Após plotar as medidas no gráfico de crescimento, qual a conduta adequada para esse caso?

A) Solicitar curva de hormônio de crescimento.

B) Iniciar tratamento com solução de zinco e arginina.

C) Solicitar dosagens hormonais ? FSH, LH, TSH.

D) Monitorar crescimento, reforçar condições adequadas de nutrição, sono e atividade física.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81266)

Enunciado: Criança de dois anos é trazida à consulta e sua mãe relata que a mesma faz uso de leite de cabra desde o desmame. A família tem fazenda e facilidade de obter esse leite, e pretende manter esse hábito. Qual a suplementação necessária nesse caso?

A) Zinco.

B) Cálcio.

C) Ácido fólico.

D) Vitaminas do complexo B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51294)

Enunciado: Criança de 4 meses de idade, portadora de doença do refluxo gastroesofágico, segue em uso exclusivo de leite materno ao seio desde o nascimento. Apresenta quadro de irritabilidade, hipotonia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e movimentos incoordenados. A mãe da criança faz uma dieta vegetariana estrita e apresenta anemia, fraqueza, glossite e parestesias.

Qual das drogas usadas para tratar o refluxo gastroesofágico pode piorar o quadro da criança?

A) Ranitidina.

B) Omeprazol.

C) Domperidona.

D) Hidróxido de alumínio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51231)

Enunciado: Escolar é trazido à Unidade de Saúde para aferição do crescimento encaminhado pela escola, que o julga muito baixo. Ao ser pesado e medido, em duas oportunidades, constata-se que a criança mantém-se aproximadamente no percentil 25 das curvas da Organização Mundial da Saúde (2007) para peso e altura. Os pais têm altura média normal. Qual a conduta adequada para esse caso?

A) Solicitar dosagens hormonais, já que se trata de baixa estatura.

B) Iniciar polivitamínicos, ferro e cálcio, já que se trata de desnutrição.

C) Acompanhar o crescimento com aferições semestrais, já que a criança está normal.

D) Iniciar uso de hormônio de crescimento, já que a criança é portadora de déficit de estatura.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51233)

Enunciado: Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009 / 2010, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), a classificação de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes pode ser feita utilizando-se o índice de massa corpórea (IMC), sendo que a interpretação difere de acordo com o sexo e a faixa etária. O limite de normalidade é estabelecido por curvas de percentil do IMC. Considerando essa classificação, acima de que percentil, na curva de IMC para a faixa etária, define-se a obesidade em crianças?

A) 95%.

B) 90%.

C) 85%.

D) 80%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30873)

Enunciado: Através do gráfico no painel de fotos (VER IMAGEM), faça o diagnóstico nutricional desta paciente de 6 anos com peso de 29 kg e estatura de 120 cm.

A) Baixo IMC para idade.

B) IMC adequado.

C) Sobrepeso.

D) Obesidade.

E) Não há dados suficientes para o diagnóstico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37041)

Enunciado: Menina de 4 anos, residente em Ouro Preto-MG, apresenta dificuldade de adaptação em condições de pouca iluminação. No exame ocular foi evidenciado, na conjuntiva, mancha branco-acinzentada com aspecto de espuma. Esse quadro clínico pode corresponder, provavelmente, à deficiência de vitamina:

A) A

B) B12

C) C

D) D

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37435)

Enunciado: O raquitismo é uma doença óssea. Possui múltiplas etiopatogenias, dentre as quais podemos citar as doenças gastrointestinais que cursam com má absorção, EXCETO:

A) Doença celíaca.

B) Fibrose cística do pâncreas.

C) Síndrome de Fanconi.

D) Espru.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37438)

Enunciado: A prevalência de obesidade na infância e adolescência vem aumentando a nível mundial constituindo um problema de saúde pública atual pelas consequências que pode acarretar, EXCETO:

A) Hipertensão.

B) Diabetes.

C) Distúrbios do sono.

D) Refluxo gastroesofágico.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29456)

Enunciado: Caio, 14 anos, procurou seu médico de família com queixa de ?ser mais baixo que seus colegas da mesma idade? e, por isso, estar sendo alvo de piadas e exclusão da equipe de vôlei. Relata ser um excelente aluno. Ao examiná-lo, o médico não encontrou alterações clínicas, exceto a idade-altura correspondente a 12 anos e Tanner G1 P1. Solicitou RX de punho que revelou idade óssea de 12 anos. Após a leitura do caso acima, assinale a resposta ERRADA:

A) O diagnóstico mais provável é atraso puberal constitucional;

B) O prognóstico do caso está intimamente relacionado ao início precoce de reposição de hormônio de crescimento;

C) A classificação de Tanner G1 P1 corresponde à fase da pré-adolescência;

D) Caio provavelmente irá atingir o padrão de estatura familiar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24320)

Enunciado: Ritelsa, 11 anos, diabética, possui uma alimentação inadequada, pobre em carne, leite, ovos e vegetais folhosos. Nunca fez uso de vísceras e sua família sempre ingere arroz polido. A garota vem apresentando estomatite angular, glossite, fotofobia e dermatoses, provavelmente por:

A) Hipervitaminose A.

B) Deficiência de Riboflavina.

C) Deficiência de Ácido Ascórbico.

D) Hipovitaminose D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25329)

Enunciado: Criança apresenta vômitos, irritabilidade, dor nos membros, pele seca e descamativa. A radiografia dos membros demonstra hiperostose cortical dos ossos das mãos e dos pés. Esses sinais e sintomas correspondem provavelmente à hipervitaminose:

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9094)

Enunciado: Pedro, 9 meses, nascido de parto cesariana, pesando 2.600 gramas, estatura: 50 cm, compareceu à consulta com seu médico de família. Ao avaliar os dados antropométricos de Pedro, o MFC constatou que a criança estava pesando 5 Kg e medindo 70 cm. Continua em aleitamento materno exclusivo e em livre demanda. As vacinas estão em dia e não ocorreram intercorrências. Quanto ao estado nutricional, qual a classificação de Pedro?

A) Peso normal.

B) Desnutrição/peso muito baixo.

C) Desnutrição/peso baixo.

D) Sobrepeso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9102)

Enunciado: Pedro, 9 meses, nascido de parto cesariana, pesando 2.600 gramas, estatura: 50 cm, compareceu à consulta com seu médico de família. Ao avaliar os dados antropométricos de Pedro, o MFC constatou que a criança estava pesando 5 Kg e medindo 70 cm. Continua em aleitamento materno exclusivo e em livre demanda. As vacinas estão em dia e não ocorreram intercorrências. O médico de família solicitou exames complementares para Pedro. Assinale a correlação entre resultado de exame e interpretação INCORRETA:

A) Glicose < 54 mg/dL indica hipoglicemia.

B) Hb < 4 g/dL ou Hct < 12% indicam anemia grave.

C) Proteínas séricas são úteis para o manejo do caso, mas não auxiliam o prognóstico.

D) Exame e cultura de urina quando alterados indicam infecção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

6943)

Enunciado: De acordo com o gráfico abaixo, qual a classificação nutricional, segundo Gomez, de um menino de 15 meses pesando 7 kg? (VER IMAGEM)

A) Eutrófico.

B) Desnutrição Energeticoproteica grau I.

C) Desnutrição Energeticoproteica grau II.

D) Desnutrição Energeticoproteica grau III.

E) Desnutrição Crônica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8916)

Enunciado: Os pais de um menino de 14 anos de idade estão preocupados por sua baixa estatura e ausência de desenvolvimento de características sexuais secundárias. O menino teve um desenvolvimento normal na infância, apesar de ser sempre menor que as crianças de sua idade. O exame físico é normal. A relação entre o segmento superior e inferior é de 0,98. Uma pequena quantidade de pelos finos pubianos e axilares é evidenciada. Não há pigmentação escrotal; seus testículos medem 4 cm^3, e seu pênis mede 6 cm. O diagnóstico mais provável é:

A) Hipopituitarismo

B) Síndrome de Klinefelter

C) Hipotireoidismo

D) Baixa estatura constitucional com puberdade atrasada

E) Síndrome de Turner masculina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13481)

Enunciado: Criança de 15 meses, internada há 40 dias por desnutrição grave, passou a apresentar progressivamente os seguintes sintomas:

hepatomegalia, distensão abdominal com rede venosa colateral, ascite, fácies de ?lua cheia?, hiper tricose e sudorese abundante. O diagnóstico mais provável é:

A) Cardiopatia congênita descompensada.

B) Esquistossomose mansônica.

C) Tuberculose miliar.

D) Síndrome de recuperação nutricional.

E) Doença linfoproliferativa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13489)

Enunciado: Sabendo que uma gota da solução de sulfato ferroso apresenta 1,25 mg de ferro elementar, quantas gotas por dia estaria mais correto recomendar para o tratamento de uma criança de 10 kg com anemia ferropriva?

A) 10.

B) 20.

C) 40.

D) 60.

E) 80.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349759)

Enunciado: Menina de 11 anos apresenta peso de 39 Kg, altura de 144 cm e seu índice de massa corporal é de 23 Kg/m². Ela passou por consulta com dois médicos que prescreveram medicamentos "para emagrecer". Caso não haja outras complicações associadas, a conduta para esse caso deve ser

A) manter os medicamentos prescritos.

B) encaminhar para academia de ginástica e psicoterapia.

C) colher exames: hemograma, triglicerídeos, colesterol e iniciar ansiolítico.

D) indicar tomografia de crânio para avaliação da sela túrcica e investigar cariótipo.

E) controlar ingesta calórica e oferecer oportunidade de exercícios físicos regulares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349698)

Enunciado: Um menino de cinco anos de idade comparece à consulta com sua mãe, a qual se queixa de que o filho não está crescendo como o irmão mais velho. Qual é o principal indicador para avaliar se existe baixa estatura?

A) Prega cutânea tricipital no percentil 25.

B) Circunferência cefálica abaixo do percentil 10 para a idade.

C) Comprimento abaixo do percentil 3 para a idade.

D) Perímetro torácico abaixo do percentil 10 para a idade.

E) Peso abaixo do percentil 10 para a idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365581)

Enunciado: O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde e vem sendo ampliado ano a ano. De acordo com as recomendações vigentes, assinale a alternativa que apresenta correlação entre a vacina e o período de aplicação.

A) Meningo ACWY - 1 dose entre 11-14 anos de idade

B) Febre amarela - aos 9 meses e reforço a cada 10 anos de idade

C) Hepatite B - ao nascer, 2 meses, 4 meses, 6 meses e reforço aos 15 meses de vida

D) Tríplice viral - aos 2, 4 e 6 meses de vida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365603)

Enunciado: Um paciente de 28 anos de idade procurou a unidade básica de saúde (UBS) referindo que foi mordido na coxa direita, há uma hora, por um cachorro na rua, o qual não conhecia. Foi ajudado por um transeunte e levado UBS, por isso, não soube relatar de quem era o animal. Ao exame físico, notou-se um ferimento profundo de 10 cm em coxa direita. O médico optou por iniciar amoxicilina com clavulanato de forma profilática. Além disso, outras condutas devem ser realizadas. Assinale a alternativa que indica essas condutas.

A) Lavar com água e sabão, sutura de forma hermética e profilaxia apenas com vacina.

B) Lavar com água e sabão, sutura de forma não hermética e profilaxia apenas com vacina.

C) Lavar com água e sabão, sutura de forma hermética e profilaxia com vacina e soro.

D) Lavar com água e sabão, sutura de forma não hermética e profilaxia com vacina e soro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349708)

Enunciado: A imagem a seguir foi publicada em um artigo de 1961, no jornal Americano de Saúde Pública. Nesse estudo histórico, usando a vacina inativada da pólio foi observado um efeito protetor da vacinação além do efeito previsto. Esse efeito é conhecido como

A) imunidade secundária.

B) vacinação secundária.

C) imunidade de rebanho.

D) prevenção primária.

E) prevenção secundária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349704)

Enunciado: A meningite é uma das doenças infectocontagiosas com maior letalidade entre crianças, sendo, portanto, questão de saúde pública. Sua incidência vem diminuindo desde os anos 2000 no Brasil, sendo que, dentro do calendário de imunização, há vacinas responsáveis pela redução da incidência da meningite em crianças. É importante salientar que, nos últimos 20 anos, um dos principais agentes etiológicos da meningite teve uma redução significativa devido aos esforços do programa nacional de imunização. Esse agente, além da meningite, provoca frequentemente infecções de vias aéreas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a vacina que protege contra o agente etiológico citado.

A) Penta (DTP + Hib + HB).

B) Meningo C.

C) Meningo B.

D) DTPa.

E) BCG.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322167)

Enunciado: Em relação à vacina tríplice viral, oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa correta.

A) A dose zero, dada em situação epidemiológica de risco para sarampo ou rubéola, não é considerada válida para a cobertura vacinal de rotina.

B) É contraindicada para gestantes, exceto em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.

C) É contraindicada para crianças abaixo dos 12 meses de idade, mesmo em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.

D) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos 1 ano após a vacinação.

E) Pessoas comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca não podem receber a vacina tríplice viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337541)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. O fato de o paciente estar no escore Z -1, do ponto de vista antropométrico, indica que ele se encontra, no momento, com baixa estatura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337542)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. A avaliação da idade óssea (IO) está mais associada à estatura atual e futura do que à idade cronológica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337543)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. Um paciente com velocidade de crescimento adequada, estatura final dentro do alvo parental e uma IO levemente atrasada em relação à cronológica tem mais tempo para crescer, ocasionando maior ganho estatural.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337544)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. O recurso terapêutico no caso de baixa estatura é o hormônio de crescimento (GH), mas seu uso tem efeitos colaterais como estimular neoplasias.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337597)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. O peso, dentre os parâmetros antropométricos, é o último a ser afetado pelo crescimento inadequado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337599)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. Pela verificação do cartão de vacinação, é possível verificar que Miguel ainda não recebeu nenhuma dose de vacina contra pólio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337607)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. A vacina da raiva não deve ser aplicada no caso exposto, devendo ser observado por 10 dias e, caso assintomático, o caso deve ser encerrado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337608)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. Mesmo que o gato desapareça, por se tratar de área onde a raiva é controlada, não é necessário iniciar esquema profilático.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337609)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. O ferimento descrito pode ser classificado como acidente leve, sendo necessário vacinação em caso de animal suspeito de raiva.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337610)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. A vacina antirrábica pode ser aplicada no glúteo ou no deltoide quando usada na via intramuscular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337611)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. Em casos de acidente com cão ou gato observável, exclusivamente doméstico em seus hábitos, em área de raiva controlada, independentemente da gravidade do ferimento, não é necessário começar o esquema profilático.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337612)

Enunciado: Raquel trouxe sua filha Valentina, de 8 anos, à UBS. Ela conta que, há cinco dias, sua filha foi arranhada pelo gato da vizinha na região do tronco. A vizinha refere que o gato não tem quaisquer sintomas e que ele é vacinado para raiva. Ao examinar o ferimento, o médico da UBS observa arranhadura de 5cm, única, superficial, em região infraclavicular direita. Elas vivem em região onde a raiva é considerada controlada. Considerando seus conhecimentos e as informações expostas, julgue o item a seguir. Em casos em que o soro antirrábico é necessário, deve-se infiltrar a maior quantidade possível no território perilesional e o restante de forma intravenosa.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305314)

Enunciado: A respeito da vacina contra o rotavírus, oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não está indicado repetir a dose.

B) A idade máxima para a administração da primeira dose é de 3 meses e 15 dias.

C) A idade mínima para a administração da segunda dose é de 3 meses e 15 dias.

D) A idade máxima para a administração da segunda dose é de 7 meses e 29 dias.

E) Se a criança regurgitar após a administração, a dose é invalidada e deve ser repetida após 14 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305315)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de vacina inativada oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações.

A) Poliomielite oral.

B) Rotavírus humano.

C) Hepatite A.

D) Tríplice viral.

E) Tetra viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298898)

Enunciado: Um paciente de 2 anos e 3 meses de idade foi levado ao ambulatório de pediatria pela mãe, pois ela está preocupada com um "caroço" no pescoço do filho, que ela notou há cinco meses. Relatou que o filho é bastante ativo, que se alimenta bem, sempre ganhou peso, mas fala pouco e palavras difíceis de compreender. Ademais, há muito tempo apareceram alguns machucados no couro cabeludo dele, que o menino coça bastante e tem algumas crostas. Ao exame físico, constataram-se altura = 90 cm (escore z 0), peso = 12,300 kg (escore z entre 0 e -2), FC = 120 bpm, FR = 26 irpm e SatO2 = 97% em AA. No couro cabeludo, há várias lesões com crostas melicéricas e presença de linfonodo retroauricular medindo 1,5 cm, móvel, fibroelástico, indolor à palpação. Observaram-se oroscopia, dentes em bom estado, sem lesões, sem frênulo lingual, otoscopia, com membrana timpânica translúcida, sem abaulamentos ou retrações e ausculta cardíaca, BNF, RR, 2t, sem sopro. Verificaram-se, ainda, ausculta pulmonar, MVUD, sem RA, abdome, RHA+, depressível, sem megalias, indolor à palpação e genitália com testículos em bolsa escrotal e fimose. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. É importante realizar investigação dos hábitos alimentares dessa criança, visto que o ideal seria estar com peso acima do escore z 0.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274374)

Enunciado: Em relação à desnutrição, é correto afirmar que

A) a aguda é usualmente ligada a situações que ameaçam a vida, como trauma e infecções, e o laboratório é caracteristicamente de albumina e transferrina alta, com leucocitose.

B) na crônica, normalmente, o paciente mantém massa muscular total.

C) a deficiência proteica leva cronicamente à hipertrofia de órgãos linfoides, timo e baço.

D) a resposta hormonal normalmente cursa com atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona normal ou aumentada, com aumento da retenção hídrica e de sódio.

E) a perda de massa cardíaca leva a aumento do volume diastólico, com aumento reflexo do débito cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274379)

Enunciado: A síndrome metabólica é uma condição clínica para a qual o pediatra deve estar atento na sua rotina clínica. Sobre essa condição, é correto afirmar que

A) é composta por anormalidades antropométricas, fisiológicas e bioquímicas que predispõem os indivíduos afetados ao desenvolvimento de obesidade e diabetes tipo 2, mas tem fraca relação com doença cardiovascular.

B) a obesidade é um fator de risco para seu desenvolvimento, mas o sobrepeso não.

C) o estilo de vida saudável, com reeducação alimentar e estímulo à atividade física são ineficientes na prática clínica.

D) a adrenarca precoce está relacionada com a síndrome metabólica.

E) a glicemia de jejum não pode ser usada como critério diagnóstico, devendo ser substituída pela hemoglobina glicada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284350)

Enunciado: As vacinas para HPV disponíveis não são apenas profiláticas, tendo atividade contra indivíduos previamente infectados pelo subtipo específico ou contra lesões cervicais.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261301)

Enunciado: Uma criança de 1 ano e 4 meses de idade, com histórico de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, é levada a atendimento pela mãe que referiu tosse, febre, hiperemia ocular e aparecimento de "manchas" brancas em mucosa oral, com posterior aparecimento de "manchas" vermelhas no corpo. Ao exame, apresenta temperatura axilar de 38 ºC e exantema maculopapular avermelhado, de progressão craniocaudal. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A vacina que contempla essa doença é realizada aos 12, aos 15 e aos 24 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250102)

Enunciado: Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir. Na criança menor de dois anos de idade, a deficiência de vitamina A aumenta o risco de infecções e provoca importantes problemas visuais, enquanto a deficiência de ferro causa anemia, sendo importante avaliar a necessidade de suplementação desses nutrientes a partir dos seis meses de vida, mesmo em crianças que continuam a ser amamentadas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239303)

Enunciado: Um paciente de 5 anos de idade comparece em consulta de puericultura acompanhado pelos pais. Após ser calculado o índice de massa corporal (IMC) do paciente, observa-se que ele se encontra acima do escore Z + 3. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O diagnóstico é de obesidade grave.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239304)

Enunciado: Um paciente de 5 anos de idade comparece em consulta de puericultura acompanhado pelos pais. Após ser calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) do paciente, observa-se que ele se encontra acima do escore-Z +3. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Na presença de comorbidades relacionadas à obesidade, deve-se objetivar a redução gradual do peso da criança.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239305)

Enunciado: Um paciente de 5 anos de idade comparece em consulta de puericultura acompanhado pelos pais. Após ser calculado o índice de massa corporal (IMC) do paciente, observa-se que ele se encontra acima do escore Z + 3. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A hipertensão arterial sistêmica é uma das complicações cardiovasculares que podem estar associadas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239306)

Enunciado: Um paciente de 5 anos de idade comparece em consulta de puericultura acompanhado pelos pais. Após ser calculado o índice de massa corporal (IMC) do paciente, observa-se que ele se encontra acima do escore Z + 3. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Caso esse diagnóstico mantenha-se durante o envelhecimento, esse paciente encontra-se mais suscetível ao desenvolvimento de neoplasias como cólon, próstata e fígado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239307)

Enunciado: Um paciente de 5 anos de idade comparece em consulta de puericultura acompanhado pelos pais. Após ser calculado o índice de massa corporal (IMC) do paciente, observa-se que ele se encontra acima do escore Z + 3. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Não se pode observar manifestações de arteriosclerose na faixa etária pediátrica, em associação com o diagnóstico desse paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239340)

Enunciado: Uma gestante de 26 anos de idade, IG de nove semanas, G2P1A0, retorna à UBS para consulta de pré-natal. Apresenta queixa de azia, constipação e desconforto esporádico em quadrante superior direito do abdome. Ao exame físico, apresenta bom estado geral, abdome indolor, útero impalpável e BCF inaudíveis, Frequência cardíaca = 90 bpm, frequência respiratória = 17 ipm, SatO? = 98% em ar ambiente. Leva calendário vacinal com esquema completo para hepatite B e três doses da dupla adulto (dT), realizadas na última gestação, há três anos. Entre os exames complementares, destacam-se os seguintes resultados: EQU sem particularidades; e urocultura - crescimento de Streptococcus do grupo B > 100.000 UFC/mL. Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Apesar de haver esquema vacinal com três doses da vacina dupla adulto (dT), a gestante deverá receber uma dose da tríplice bacteriana (dTpa) após a vigésima semana da atual gestação.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239351)

Enunciado: Uma paciente de 12 anos de idade vai a consulta agendada em Unidade de Saúde da Família acompanhada pela mãe. A familiar demonstra preocupações quanto ao desenvolvimento da filha, alegando ser esta uma das mais baixas entre as respectivas colegas e que ainda não teve a primeira menstruação, a despeito de estar notando desenvolvimento das mamas há 10 meses, observando-se a presença de broto mamário ao exame físico. Refere-se, também, que a mãe está receosa de a filha vir a ser diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos (SOP), tendo base tal preocupação em leitura de informações da internet em correlação com o fato de a filha apresentar acne facial, de ainda nunca ter menstruado e de possuir histórico familiar de primeiro grau de obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Faz uso de metilfenidato 10 mg/dia por diagnóstico prévio de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade, demonstrando manter atenção apenas para atividades do próprio interesse, sem, no entanto, apresentar histórico de baixo desempenho escolar ou prejuízo da vida social. Em avaliação ponderoestatural, verifica-se IMC de 21 kg/m², considerado adequado para a idade da paciente. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A paciente possui indicação para prevenção primária para infecção por HPV mediante vacinação.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

211939)

Enunciado: Em uma consulta de rotina, a mãe de um menino de 11 anos se queixa de que ele está menor que os colegas da classe escolar. Na avaliação, o médico constatou velocidade de crescimento de 7 cm/ano, com estatura entre os percentis 25 e 50 da curva de crescimento, e critério de Tanner = G1P1. No que concerne a esse caso clínico, em relação à conduta apropriada a ser seguida, assinale a alternativa CORRETA:

A) Solicitar radiografia de punhos e pedir para que a mãe e o paciente retornem dentro de dois meses para nova avaliação estatural.

B) Investigar causa renal para estatura baixa para a idade.

C) Solicitar dosagem do hormônio de crescimento para confirmar a baixa estatura e tratar precocemente.

D) Tranquilizar a mãe de que a velocidade de crescimento está normal, uma vez que o paciente está impúbere e não ainda iniciou o estirão puberal.

E) Solicitar dosagens de hormônios tireoidianos e ultrassonografia de tireoide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214466)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. Um dos diagnósticos atuais é o de obesidade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214471)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. Dosagem de colesterol total e frações, assim como de glicemia de jejum, devem ser solicitados.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214483)

Enunciado: A paciente J.D.R., de 24 anos de idade, é portadora do vírus HIV e está em uso irregular de Tratamento Antirretroviral (TARV). Atualmente, apresenta contagem de CD4 de 150 células/mm^3.

Manifestou, durante a gestação do último filho, coinfecção com tuberculose. A paciente e o respectivo filho moram na mesma residência que a avó da criança. O filho de J.D.R. tem 9 meses de vida e não apresenta características clínicas de imunossupressão. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. O filho de J.D.R. não deve receber vacinação oral contra poliomielite.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179198)

Enunciado: Síndrome devido a uma anormalidade dos cromossomos sexuais, mais comum em crianças do sexo feminino. A constituição cromossômica pode ser ausência de um cromossomo X (cariótipo 45, X), mosaicismo cromossômico (cariótipo 45, X/46, XX) além de outras anomalias estruturais do cromossomo X. As anormalidades típicas incluem baixa estatura, disgenesia gonadal, pescoço alado, linha posterior de implantação dos cabelos baixa, fácies típica, tórax alargado, com aumento da distância entre os mamilos, linfedema, cúbito valgo, tireoidite autoimune, com ou sem hipotireoidismo, anormalidades renais, cardiovasculares e auditivas, além de deficiência cognitiva em algumas atividades, embora a inteligência média seja considerada como normal. Baixa estatura é o achado mais comum. Caracteristicamente há retardo leve do crescimento na fase intrauterina, redução progressiva da velocidade de crescimento durante a infância e marcada ausência de crescimento na fase puberal. Pacientes não tratadas apresentam altura média, na idade adulta, de 136 a 147 cm. Trata-se da Síndrome de:

A) Edwards.

B) Patau.

C) Turner.

D) Down.

E) Klinefelter.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179207)

Enunciado: A respeito da imunização na infância, assinale a alternativa CORRETA.

A) A vacina BCG deverá ser administrada o mais precocemente possível, após o nascimento, mesmo em RN HIV positivo.

B) A vacina contra hepatite B (recombinante) deverá ser administrada nas primeiras doze horas de vida, exceto em prematuros com menos de 36 semanas ou mães portadoras de hepatite B.

C) A vacina contra rotavírus humano deverá ser administrada, em dose única intramuscular, ao se completar um ano de idade.

D) A vacina pneumocócica 10 (conjugada) é indicada aos dois anos de idade somente para asmáticos ou portadores de doenças pulmonares crônicas.

E) A vacina contra hepatite A deverá ser administrada, em dose única, ao nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177670)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfodonos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 mL de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Ainda em relação à situação hipotética mencionada, caso Rafaela encontre-se entre o escore Z 0 e -1, na curva de estatura para sua idade, seu diagnóstico será de baixa estatura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177674)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfodonos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 mL de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Caso a paciente encontre-se entre o escore Z +2 e +3 da curva de peso para estatura e IMC para sua idade, seu diagnóstico nutrológico será de sobrepeso.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177678)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfonodos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 ml de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes podem se relacionar com outras comorbidades, como síndrome metabólica, dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177688)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfodonos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 mL de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A partir dos 2 anos de idade, caso haja presença de comorbidades associadas à obesidade, deve-se estimular uma redução lenta e gradural do peso até a sua normalização.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177650)

Enunciado: J.A.S., sexo feminino, 24 anos de idade, teve diagnóstico de tuberculose durante o 3º trimeste da gestação. Além desse fato, a gestação transcorreu sem intercorrências e o pré-natal ocorreu com acompanhamento e exames normais. Nasceu C.A.S., com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, sem sinais clínicos de patologias. Considerando o caso clínico apresentado e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Para a prevenção de infecção latente no recém-nascido, usa-se, como droga de escolha, a isoniazida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177655)

Enunciado: J.A.S., sexo feminino, 24 anos de idade, teve diagnóstico de tuberculose durante o 3º trimestre da gestação. Além desse fato, a gestação transcorreu sem intercorrências e o pré-natal ocorreu com acompanhamento e exames normais. Nasceu C.A.S., com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, sem sinais clínicos de patologias. Considerando o caso clínico apresentado e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O teste de Mantoux (PPD) deve ser realizado por ocasião do nascimento, podendo-se vacinar a criança com BCG, se o PPD for menor que 5 mm.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177660)

Enunciado: J.A.S., sexo feminino, 24 anos de idade, teve diagnóstico de tuberculose durante o 3º trimeste da gestação. Além desse fato, a gestação transcorreu sem intercorrências e o pré-natal ocorreu com acompanhamento e exames normais. Nasceu C.A.S., com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, sem sinais clínicos de patologias. Considerando o caso clínico apresentado e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O uso de isoniazida deve ser mantida sempre por 6 meses.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177666)

Enunciado: J.A.S., sexo feminino, 24 anos de idade, teve diagnóstico de tuberculose durante o 3º trimeste da gestação. Além desse fato, a gestação transcorreu sem intercorrências e o pré-natal ocorreu com acompanhamento e exames normais. Nasceu C.A.S., com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, sem sinais clínicos de patologias. Considerando o caso clínico apresentado e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Caso haja uma pessoa vivendo com HIV/AIDS na moradia de J.A.S. e não haja disponibilidade de PPD, deve-se realizar o tratamento de infecção latente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177593)

Enunciado: J.A.S., sexo feminino, 24 anos de idade, teve diagnóstico de tuberculose durante o 3º trimestre da gestação. Além desse fato, a gestação transcorreu sem intercorrências e o pré-natal ocorreu com acompanhamento e exames normais. Nasceu C.A.S., com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, sem sinais clínicos e patologias. Considerando o caso clínico apresentado e os conhecimentos médicos correlatados, julgo o item a seguir. Na ausência de PPD, C.A.S. deve receber isoniazida por 12 meses.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154323)

Enunciado: Ao avaliar um caso suspeito de baixa estatura sem outros dados relevantes na anamnese e, após avaliação do peso e da estatura pessoal e familiar, da velocidade de crescimento e de outros dados antropométricos básicos, qual seria o primeiro exame complementar a ser realizado?

A) Exame parasitológico de fezes seriadas.

B) Hemograma.

C) Teste de suor.

D) Raios X de mão e punho esquerdos.

E) Urocultura.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152074)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso = 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O médico, ao conferir a caderneta de vacinação desse paciente, deve encontrar registro das vacinas BCG e contra meningite C, que são as realizadas logo ao nascimento.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152127)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso= 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm, e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Se, ao completar dois meses de vida, esse paciente estivesse apresentando um quadro diarreico agudo febril, estaria justificado um possívell adiamento vacinal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152154)

Enunciado: Paciente de 28 anos de idade, nuligesta, casada, ciclos menstruais regulares, nega uso de métodos anticonceptivos, pois deseja gestar. Foi encaminhada ao serviço de patologia cervical; trouxe resultado de citopatológico apresentando LIEAG e colposcopia com biópsia evidenciando NIC III. A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir: deve-se indicar imunização com vacina contra o HPV bivalente.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134984)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. A síndrome de Cushing causa aumento crônico dos níveis séricos de cortisol, o que implica prejuízos ao processo de crescimento. A principal causa dessa patologia é a iatrogênica, motivada pelo uso de corticosteroides na infância.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134993)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. Em regra, a deficiência na produção dos hormônios tireoidianos durante a infância acarreta retardo do crescimento, atraso na idade óssea e sinais clínicos como obstipação intestinal, apatia e lentidão.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135001)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. A síndrome de Turner é uma das principais causas de baixa estatura em meninos, e tratá-la com base em hormônio de crescimento tem se mostrado pouco eficiente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135006)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. Em se tratando de baixa estatura idiopática, o déficit de crescimento se deve à má absorção de nutrientes, o que propicia quadro de desnutrição e presença de marcadores inflamatórios.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135084)

Enunciado: Com relação ao raquitismo, julgue o seguinte item. A causa primária do raquitismo é o deficit de vitamina D, que pode ser consequência da baixa ingesta ou da baixa exposição à luz solar. Uma das causas secundárias do raquitismo inclui a perda de fósforo pelos rins, assim como ocorre na síndrome de Fanconi.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108193)

Enunciado: No item a seguir, é apresentado um caso clínico a respeito de doenças cardiovasculares na infância e na adolescência, seguido de uma assertiva a ser julgada. O perfil lipídico de uma criança de sete anos de idade mostrou, pela segunda vez, o seguinte resultado: colesterol total = 250 mg/dL; LDL-colesterol = 140 mg/dL; HDL-colesterol = 20 mg/dL e triglicerídeos = 200 mg/dL. Nesse caso, o médico deve, inicialmente, recomendar tratamento dietético, com ingestão diária em relação ao valor calórico requerido para esse paciente de 8% de gordura saturada, 10% de gordura poli-insaturada, 10% de gordura monossaturada, 2% de gordura trans, 50% de carboidratos e 20% de proteínas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108241)

Enunciado: No item abaixo, é apresentado um caso clínico a respeito do crescimento e do desenvolvimento na infância e na adolescência, seguido de uma assertiva que deve ser julgada.

Um pré-escolar de três anos de idade, acompanhado da mãe, foi à consulta ambulatorial porque tinha falta de apetite, e a mãe achava que ele estava desnutrido e com estatura abaixo do normal. No exame físico, o médico observou peso/idade de escore-Z < -3; fontanela anterior presente e ampla; suturas cranianas presentes e alargadas; alargamento dos punhos; hipotonia muscular; abdome em batráquio; baixa estatura para a idade. Nesse caso, o tratamento recomendado para a criança é a administração de 200.000 UI de vitamina A por via oral, com repetição da mesma dosagem vinte e quatro horas depois, e uma terceira dose idêntica às anteriores após quatro semanas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79673)

Enunciado: Criança de 4 anos, com crescimento normal até os 2 anos de idade, com velocidade de crescimento de 3 cm/ano no último ano. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica:

A) Crescimento normal.

B) Deficit de hormônio de crescimento.

C) Gigantismo.

D) Crescimento acelerado por possível hiperalimentação/obesidade.

E) Crescimento tipo "catch-up" em crianças com histórico de prematuridade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88640)

Enunciado: Com relação ao acompanhamento do crescimento e ao desenvolvimento infantil, julgue o item subsecutivo. No raquitismo por resistência à vitamina D, o mecanismo fisiopatológico é uma mutação no gene que codifica a enzima 1-alfa-hidroxilase, o que compromete a conversão da molécula inativa (25-hidroxi-vitamina D) na molécula ativa (1,25-diidroxi-vitamina D).

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82103)

Enunciado: Considerando o auxograma de um menino de dez anos de idade, e IC = Idade Cronológica, IA = Idade Altura, IP = Idade Peso, IO = Idade Óssea e IM = Idade Mental, julgue o item a seguir (VER IMAGEM). O auxograma demonstra um caso de nanismo cuja causa é hipotireoidismo congênito.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64301)

Enunciado: Uma mãe levou seu filho, uma criança de cinco anos de idade, ao consultório médico, relatando obesidade infantil. Ela informou que a criança não aceitava bem comida salgada, gostava de "comer bobagens" e não praticava atividade física. Relatou, ainda, que a criança nascera Pequena para a Idade Gestacional (PIG), sem intercorrências no período neonatal, mamara até cinco meses de idade e iniciara a ingestão de alimentos sólidos com dois meses e meio de idade. O médico verificou que os pais da criança eram obesos, que a criança apresentava desenvolvimento neuropsicomotor normal e que sua vacinação estava atualizada. Ao ser examinada, a criança apresentou P/I > P95, E/I = P75 e Índice de Massa Corporal (IMC) entre o percentil 85 e o percentil 90. O exame físico não detectou nenhuma outra alteração. Considerando as informações clínicas descritas acima, responda ao seguinte questionamento. Com relação ao IMC, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), qual o diagnóstico para o caso em apreço?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64302)

Enunciado: Uma mãe levou seu filho, uma criança de cinco anos de idade, ao consultório médico, relatando obesidade infantil. Ela informou que a criança não aceitava bem comida salgada, gostava de "comer bobagens" e não praticava atividade física. Relatou, ainda, que a criança nascera Pequena para a Idade Gestacional (PIG), sem intercorrências no período neonatal, mamara até cinco meses de idade e iniciara a ingestão de alimentos sólidos com dois meses e meio de idade. O médico verificou que os pais da criança eram obesos, que a criança apresentava desenvolvimento neuropsicomotor normal e que sua vacinação estava atualizada. Ao ser examinada, a criança apresentou P/I > P95, E/I = P75 e Índice de Massa Corporal (IMC) entre o percentil 85 e o percentil 90. O exame físico não detectou nenhuma outra alteração. Considerando as informações clínicas descritas acima, responda ao seguinte questionamento. Quais são os fatores de risco para obesidade que essa criança apresenta?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64303)

Enunciado: Uma mãe levou seu filho, uma criança de cinco anos de idade, ao consultório médico, relatando obesidade infantil. Ela informou que a criança não aceitava bem comida salgada, gostava de "comer bobagens" e não praticava atividade física. Relatou, ainda, que a criança nascera Pequena para a Idade Gestacional (PIG), sem intercorrências no período neonatal, mamara até cinco meses de idade e iniciara a ingestão de alimentos sólidos com dois meses e meio de idade. O médico verificou que os pais da criança eram obesos, que a criança apresentava desenvolvimento neuropsicomotor normal e que sua vacinação estava atualizada. Ao ser examinada, a criança apresentou P/I > P95, E/I = P75 e Índice de Massa Corporal (IMC) entre o percentil 85 e o percentil 90. O exame físico não detectou nenhuma outra alteração. Considerando as informações clínicas descritas acima, responda ao seguinte questionamento. Quais devem ser as orientações alimentares para a referida criança? Cite três recomendações.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

52607)

Enunciado: Julgue o item seguinte, acerca das hipovitaminoses. A desnutrição energético-proteica, a deficiência de zinco, as parasitoses intestinais e as pancreatopatias são fatores associados à carência de vitamina A.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

52609)

Enunciado: Julgue o item seguinte, acerca das hipovitaminoses. A carência de vitamina C pode ocasionar o desenvolvimento de beribéri.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49153)

Enunciado: Com relação ao adolescente, julgue o item que se segue. Um adolescente com treze anos de idade, com quadro de baixa estatura constitucional, terá um prognóstico de altura final menor do que a de um adolescente de mesma idade e altura com diagnóstico de baixa estatura familiar.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49169)

Enunciado: Tendo em vista que a vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de ações básicas na atenção à saúde da criança, estando incluída na estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, da Organização Pan-Americana de Saúde, julgue o item que se segue, relativo à vigilância nutricional da criança. Na avaliação do estado nutricional da criança, os métodos diretos indicam os possíveis determinantes das condições nutricionais e alimentares, enquanto os métodos indiretos expressam as manifestações biológicas do estado nutricional (exame físico, provas bioquímicas e antropometria).

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49182)

Enunciado: Tendo em vista que a vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de ações básicas na atenção à saúde da criança, estando incluída na estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, da Organização Pan-Americana de Saúde, julgue o item que se segue, relativo à vigilância nutricional da criança. Entre as diversas medidas para aferição do estado nutricional de uma criança, a Organização Mundial de Saúde recomenda os índices peso/idade, altura/idade, peso/altura, perímetro braquial (quando não for possível a obtenção de outras medidas) e peso ao nascer para monitorar o progresso da saúde.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49185)

Enunciado: Tendo em vista que a vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de ações básicas na atenção à saúde da criança, estando incluída na estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, da Organização Pan-Americana de Saúde, julgue o item que se segue, relativo à vigilância nutricional da criança. A vigilância nutricional da criança objetiva facilitar a visualização e o acompanhamento do padrão de crescimento da criança, sendo a pesagem e a medição de altura o método utilizado para esse acompanhamento.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49187)

Enunciado: Tendo em vista que a vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de ações básicas na atenção à saúde da criança, estando incluída na estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, da Organização Pan-Americana de Saúde, julgue o item que se segue, relativo à vigilância nutricional da criança. A vigilância nutricional da criança compreende um conjunto de ações: exame clínico, provas bioquímicas, pesagem e medição de altura de forma sistemática, comparação dessas medidas com um padrão e adoção de medidas capazes de resolver ou minimizar problemas que possam comprometer a saúde atual da criança e a sua qualidade de vida futura.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49191)

Enunciado: Tendo em vista que a vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de ações básicas na atenção à saúde da criança, estando incluída na estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, da Organização Pan-Americana de Saúde, julgue o item que se segue, relativo à vigilância nutricional da criança. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a antropometria é o método mais simples, de aplicação universal, facilmente disponível, de baixo custo e não invasivo para a aferição do tamanho, da proporção e da composição do corpo humano.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27537)

Enunciado: A desnutrição energético-proteica grave sob a forma de Marasmo se caracteriza por apresentar:

A) maior frequência na idade pré-escolar.

B) aspecto faminto, fácies senil e choro forte.

C) edema generalizado por falta de albumina, choro fraco e prostração.

D) lesões de pele e cabelo e esteatose.

E) lesões nas comissuras labiais, língua careca ou com hipertrofia das papilas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29720)

Enunciado: Criança de 3 anos de idade apresenta-se com anasarca. Entre os exames complementares realizados verificou-se a existência de hipocolesterolemia. Acerca desse diagnóstico, julgue o próximo item. O kwashiorkor evolui com hipocolesterolemia.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8586)

Enunciado: Marcelo tem 7 anos de idade e é visivelmente o mais baixo na sua sala de aula. Os pais o levaram ao pediatra, que solicitou:

A) Dosagem de hormônios tireoideanos.

B) Radiografia de coluna vertebral.

C) Radiografia de mãos e pés.

D) Radiografia bilateral de mãos e punhos.

E) Dosagem de hormônios estreoidais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334886)

Enunciado: Quanto às vacinas do calendário infantil, assinale a alternativa correta.

A) A vacina contra rotavírus está contraindicada em lactentes com refluxo gastroesofágico.

B) Em caso de PPD negativo, após vacinação com a BCG, indica-se revacinação com a mesma vacina.

C) Caso o lactente vomite a vacina de rotavírus aplicada, a indicação é aplicar nova dose imediatamente.

D) Quem já teve coqueluche não precisa receber a imunização contra essa doença em razão de a doença conferir proteção permanente.

E) A vacina de poliomielite oral bivalente é indicada para o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343418)

Enunciado: Entre as vacinas que uma criança de 12 meses deve tomar, encontra-se a:

A) Meningocócica C (reforço).

B) Hepatite B (segunda dose).

C) Febre amarela (dose única).

D) Tetraviral (primeira dose).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334911)

Enunciado: Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ao nascer, uma criança deverá receber certas vacinas. Assinale a alternativa que indica essas vacinas.

A) Hepatite A e poliomielite.

B) Triplice viral e rotavírus.

C) BCG e hepatite B.

D) Varicela e pneumocócica.

E) Meningocócica B e hepatite A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343477)

Enunciado: As vacinas recomendadas ao nascer são:

A) Febre Amarela e Hepatite A.

B) Meningocócica C e VOP.

C) BCG e Hepatite B recombinante.

D) VIP e Penta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343482)

Enunciado: RFDN, sexo masculino, 81 anos, acamado, foi visitado pela Agente Comunitário de Saúde (ACS) de sua área, que solicitou o cartão de vacina do idoso acamado para a filha de RFDN, cuidadora deste. São vacinas que devem ser recomendadas para o idoso, sendo primeira dose ou reforço, EXCETO:

A) Influenza.

B) Pneumocócica 23.

C) Rotavírus.

D) Tétano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307109)

Enunciado: No que concerne ao tema imunização, assinale a alternativa correta. Alternativas:

A) De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de apenas uma dose para a adequada proteção.

B) A vacina tetraviral é indicada para a vacinação de crianças com 12 meses de idade, sendo necessário reforço após dois meses, com a tríplice viral.

C) Deve-se indicar o uso de paracetamol de rotina, antes ou imediatamente após a vacinação, pois aumenta a imunogenicidade da vacina.

D) No caso de mulheres que estejam amamentando e tenham recebido a vacina da febre amarela, o aleitamento materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação.

E) As gestantes devem receber vacinas vivas para maior proteção do feto, facilitando a passagem dos antígenos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301299)

Enunciado: Considerando o calendário vacinal de crianças e adolescentes, atualmente no Brasil pelo PNI (SUS), julgue o item a seguir. Com relação à vacina BCG - Tuberculose, ela deve ser aplicada, em primeira dose, nas crianças nascidas com até 2 kg, imediatamente após o nascimento. Nessas crianças, a segunda dose deve ser aplicada até aos 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301300)

Enunciado: Considerando o calendário vacinal de crianças e adolescentes, atualmente no Brasil pelo PNI (SUS), julgue o item a seguir. Quanto à vacina inativada contra poliomielite (VIP) e à vacina oral contra a poliomielite atenuada (VOP), as três primeiras doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida, devem ser aplicadas obrigatoriamente com a VOP. A recomendação para as doses subsequentes é que sejam feitas com a VIP. Ambas as vacinas VIP e VOP são também indicadas para as crianças imunocomprometidas e seus contatos domiciliares.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301301)

Enunciado: Considerando o calendário vacinal de crianças e adolescentes, atualmente no Brasil pelo PNI (SUS), julgue o item a seguir. Acerca da vacina pneumocócica conjugada, ela está indicada para todas as crianças de até 5 anos de idade, aos 2 e 4 meses, um reforço aos 12 meses, podendo ser aplicada até os 4 anos e 11 meses de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso da vacina conjugada 13 - valente, pelo seu maior espectro de proteção, com três doses no primeiro ano (2, 4, e 6 meses) e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses de vida. Crianças saudáveis com esquema completo com a vacina 10-valente podem receber dose (s) adicional(is) da vacina 13-valente até os cinco anos de idade, com o intuito de ampliar a proteção para os sorotipos adicionais.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301302)

Enunciado: Considerando o calendário vacinal de crianças e adolescentes, atualmente no Brasil pelo PNI (SUS), julgue o item a seguir. Com relação à vacina HPV tipos 6, 11, 16 e 18 (HPV4), ela é recomendada em duas doses com intervalo de 6 meses entre elas para indivíduos entre 9 e 14 anos de idade, e em três doses (0, 1 a 2 e 6 meses) para maiores de 15 anos de idade. Imunocomprometidos por doença ou tratamento devem receber o esquema de três doses.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301303)

Enunciado: Considerando o calendário vacinal de crianças e adolescentes, atualmente no Brasil pelo PNI (SUS), julgue o item a seguir. Quanto às principais causas do ressurgimento do sarampo ao redor do mundo, é correto afirmar que contribuíram para isso fatores como a migração de indivíduos contaminados para áreas com alto índice de suscetíveis e elevada contagiosidade do vírus, cobertura vacinal para as duas doses inferior a 95% da população, bem como o aparecimento de cepas resistentes à vacina sarampo, caxumba e rubéola atenuada (SCR), que é utilizada atualmente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273320)

Enunciado: Adolescente de 13 anos, masculino, refere ser mais baixo que seus colegas. Nasceu com 3 Kg e 50 cm de comprimento. Seu crescimento foi normal. Apresenta bom desempenho escolar e não tem antecedentes de doenças crônicas. Seu pai tem 1,76 m e sua mãe 1,60 m. Ao exame físico, apresenta Tanner G1P1; seu peso e altura estão nos percentis 3 das curvas respectivas da OMS. Sua velocidade de crescimento atual é de 6 cm ao ano e a idade óssea é de 11 anos. O diagnóstico mais provável é:

A) Hipotireoidismo adquirido.

B) Baixa estatura genética ou familiar.

C) Retardo constitucional do crescimento.

D) Deficiência de GH (hormônio do crescimento).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263348)

Enunciado: Uma mãe leva seu filho com 2 anos de idade para consulta na Unidade de Saúde da Família (USF) relatando que a criança apresenta febre não aferida e lesões vésico-pústulo-crostosas em tronco há 2 dias. Segundo o Programa Nacional de Imunização, o calendário de vacinação esteve completo somente até os 6 meses de idade, pois a mãe disse que deixou de vacinar a criança porque passou a trabalhar em turno integral, não tendo como levá-la à USF. Quais são a vacina que preveniria a atual doença e a idade para a sua administração?

A) Vacina tetraviral; 12 meses.

B) Vacina tetraviral; 15 meses.

C) Vacina tríplice viral; 12 meses.

D) Vacina tríplice viral; 15 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273327)

Enunciado: Qual das vacinas abaixo é CONTRA-INDICADA no período gravídico?

A) DTPa;

B) Tríplice Viral;

C) Hepatite B;

D) Influenza.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291477)

Enunciado: Lactente, com 6 meses de idade, está sendo atendido na Estratégia da Saúde para puericultura. A médica identifica o registro no cartão apenas da vacina Influenza, que foi feita na rede particular de imunização. As demais vacinas a serem administradas até o 5º mês estavam todas registradas na caderneta. Nesse caso, quais as vacinas recomendadas para a idade conforme o Programa Nacional de Imunização?

A) Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) e Vip (Vacina inativada para poliomielite).

B) Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) e Pneumococia 10.

C) Pentavalente (DTP+Hib+Hep B), Pneumococia 10 e Rotavírus.

D) Pentavalente (DTP+Hib+Hep B), VIP (Vacina inativada para poliomielite) e Pneumococia 10.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274611)

Enunciado: Lactente saudável, 2 meses, em consulta de puericultura de rotina, mãe solicita informações quanto aos efeitos adversos da vacina da hepatite B. Nesse caso deverá ser orientada sobre a possível ocorrência de:

A) Febre de até 39,4° em 5% a 15% dos vacinados com duração de 1 a 2 dias.

B) Dor no local da injeção e temperatura maior que 37,7° em 1% a 6% dos vacinados.

C) Trombocitopenia transitória.

D) Exantema discreto maculopapular no local da injeção ou em qualquer outro local.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274613)

Enunciado: Caxumba é uma infecção viral por vírus da família Paramyxoviridae, gênero paramyxovirus, manifestando-se próxima aos ouvidos. O sintoma mais comum característico da caxumba é:

A) Palpitação ou ritmo cardíaco acelerado.

B) Queda de cabelo.

C) Pústulas no corpo.

D) Inchaço e dor nas glândulas salivares, podendo ser em ambos os lados ou em apenas um deles.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263363)

Enunciado: Um menino com 8 anos de idade comparece à Unidade Básica de Saúde, acompanhado de sua mãe, para consulta anual. Quando perguntada sobre a atividade física, a mãe relata que a criança frequenta a escola de manhã e não gosta de realizar as atividades que exigem esforço físico na escola e, em casa, tem o hábito de jogar video game e jogos pelo celular. No recordatório alimentar foi observada alta ingesta de carboidratos. A avaliação antropométrica apresenta estatura de 130 cm e peso de 37 kg. Com base na situação e no quadro apresentados e de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade, qual é a classificação do estado nutricional do menino?

A) Obesidade.

B) Sobrepeso.

C) Obesidade grave.

D) Risco de sobrepeso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274615)

Enunciado: Criança, 18 meses, com deformidade em arco dos membros inferiores, níveis baixo-normais para cálcio e fosfato, e normais para hormônios da paratireóide. Provável diagnóstico de:

A) Síndrome de Fanconi.

B) Absorção deficiente de fosfato.

C) Hipofosfatemia genética primária.

D) Osteodistrofia renal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274618)

Enunciado: A Doença de Heine-Medin é popularmente conhecida como:

A) Rubéola.

B) Sarampo.

C) Catapora.

D) Poliomielite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263376)

Enunciado: Uma menina com 13 anos de idade comparece à Unidade Básica de Saúde acompanhada da mãe para consulta de rotina. A paciente tem um irmão de 11 anos de idade. Ao exame físico, não foram observadas alterações dignas de nota. Ao verificar o cartão de vacinação, constatou-se que a adolescente não havia sido vacinada contra o HPV. Nesse caso, o profissional de saúde deve

A) orientar somente a vacinação do irmão.

B) orientar somente a vacinação da adolescente.

C) orientar a vacinação da adolescente e de seu irmão.

D) orientar que não é recomendada a vacinação da adolescente e de seu irmão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273351)

Enunciado: Qual das seguintes afirmações a respeito das recomendações de vacinação é VERDADEIRA?

A) A vacina contra sarampo está relacionada com o aumento da predisposição para autismo.

B) A vacinação contra o vírus da influenza pode levar ao aparecimento dos sintomas de gripe em alguns casos.

C) A aplicação simultânea de vacinas combinadas é desaconselhada e prejudicial ao sistema imunológico.

D) A vacinação de gestantes à partir da 20ª semana de gravidez com a dTpa está indicada para proteger recém-nascidos e lactentes pequenos da coqueluche grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273360)

Enunciado: As vacinas podem produzir efeitos adversos e dentre as afirmações abaixo, a única que se apresenta CORRETA é:

A) Após vacinação com BCG, está indicado o uso da isoniazida na presença de linfonodo axilar.

B) A vacina DPT (difteria, pertussis e tétano) pode provocar a síndrome hipotônica-hiporresponsiva em crianças.

C) A vacina contra febre amarela pode ser aplicada em gestantes, pois é composta por vírus inativados.

D) A vacina de pólio oral (VPO) foi substituída pela vacina injetável (VPI) no calendário de crianças, pelo risco da VPO causar convulsão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291513)

Enunciado: Quanto ao vírus HPV, suas formas de imunização e diagnóstico, podemos afirmar que

A) a vacina anti-HPV quadrivalente consegue imunizar contra quatro tipos virais de alto grau, o que a torna indicada para pessoas de até 45 anos de idade.

B) a vacina anti-HPV quadrivalente, apesar de proteger contra os tipos não oncogênicos 6 e 11 do HPV, tem a mesma eficácia que a bivalente na prevenção das lesões intraepiteliais do colo uterino.

C) as mulheres vacinadas contra o HPV não têm mais a necessidade de realizar o exame de Papanicolau, pois, mesmo que tenham contato com o vírus, elas não desenvolvem a doença.

D) uma desvantagem da pesquisa do DNA-HPV é a necessidade de profissional treinado na coleta, o que dificultaria o acesso a mulheres com dificuldades geográficas e resistentes à coleta por profissional de saúde.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291517)

Enunciado: Um recém-nascido com 20 dias de vida é levado à consulta de puericultura em Unidade Básica de Saúde. A mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar após o parto e já iniciou tratamento medicamentoso. Ela nega qualquer sintoma na criança. Gestação sem intercorrências. Ao exame, o recém-nascido mostra-se em bom estado geral, corado, hidratado e ativo. Os aparelhos cardiovascular e respiratório apresentam-se normais, assim como o abdome.

Considerando a história acima descrita, assinale a alternativa que contém a conduta indicada para esse recém-nascido em relação ao seu tratamento e aleitamento.

A) Manutenção do aleitamento materno com uso de máscara por parte da mãe e uso profilático de isoniazida até o 3.º mês de vida, quando o teste tuberculínico deverá ser realizado.

B) Interrupção do aleitamento materno por parte da mãe e uso profilático de isoniazida até o 3.º mês de vida, quando o teste tuberculínico deverá ser realizado.

C) Manutenção do aleitamento materno com uso de máscara por parte da mãe e uso profilático de isoniazida até o 6.º mês de vida, quando o teste tuberculínico deverá ser realizado.

D) Interrupção do aleitamento materno por parte da mãe e uso profilático de isoniazida até o 6.º mês de vida, quando o teste tuberculínico deverá ser realizado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263427)

Enunciado: Uma lactente com 10 meses de idade é levada à Unidade Básica de Saúde pela mãe, a qual demonstra preocupação pelo contato da filha com um tio que, no dia anterior, chegou de viagem do exterior com sintomas respiratórios e manchas no corpo. Ele procurou atendimento no pronto-socorro e foi diagnosticado como caso suspeito de sarampo. A conduta médica indicada para a lactente é administrar a vacina

A) tetraviral em até 48 horas após o contato com o caso suspeito, sendo essa a dose 1, seguida da segunda dose aos 12 meses.

B) tetraviral em até 72 horas após o contato com caso suspeito, sendo essa a dose 1, seguida da vacinação habitual aos 12 meses.

C) tríplice viral em até 48 horas após o contato com o caso suspeito, sendo essa a dose zero, seguida da segunda dose aos 12 meses.

D) tríplice viral em até 72 horas após o contato com o caso suspeito, sendo essa a dose zero, seguida da vacinação habitual aos 12 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266504)

Enunciado: Geoffrey Rose discutiu as bases da medicina preventiva em relação à redução dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, classificando as ações preventivas em medidas de amplitude populacional e medidas de alto risco. Essa segunda abordagem refere-se à estratégia de classificar pessoas a partir da seleção do grupo de alto risco para a aplicação de uma medida preventiva. Apesar de parecer intuitivamente racional para pacientes e profissionais, essa abordagem apresenta um pequeno impacto para a saúde pública, visto que um grande número de pessoas submetidas a um risco pequeno produzirá mais casos de doença/evento mórbido do que um pequeno grupo com risco elevado. Com base nos conceitos apresentados no texto precedente, julgue o item seguinte. Para atingir o objetivo de redução global de casos e óbitos por covid-19, a aplicação de uma vacina segura e comprovadamente eficaz em toda a população (vacinação em massa) seria mais efetiva do que vacinar seletivamente a população com alto risco para o desenvolvimento de casos graves da doença. (Armando H. Norman e Charles D. Tesser. Acesso ao cuidado na Estratégia Saúde da Família: equilíbrio entre demanda espontânea e prevenção/promoção da saúde. In: Saúde e Sociedade, São Paulo, v.24, n.º I, p 165-79, 2015 com adaptações).

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263437)

Enunciado: Uma escolar com 7 anos de idade foi levada para atendimento no pronto-socorro após episódio de violência sexual. A criança, no dia anterior, foi deixada aos cuidados do primo com 18 anos de idade para que os pais pudessem trabalhar. No dia seguinte, pela manhã, a mãe notou que a criança estava chorosa e com presença de sangue em roupas íntimas e de ferimento em região anal. Durante o atendimento, a criança informou que o seu primo introduziu o pênis em seu orifício anal e que isso tem acontecido há 1 ano. A caderneta de vacinação da criança encontra-se completa. Durante o exame físico, a criança mostra-se em bom estado geral, mas bastante assustada, com sinais vitais estáveis e presença de laceração em região anal. Após o atendimento inicial, são realizados exames laboratoriais e o resultado do anti-HBs da criança é negativo. O primo da criança encontra-se foragido. Segundo a linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças em situação de violências, para a profilaxia para hepatite B, recomenda-se realizar

A) nova série de vacinação Anti-hepatite B (3 doses).

B) acompanhamento clínico, sem medidas específicas.

C) duas doses de imunoglobulina humana Anti-hepatite B.

D) uma única dose de imunoglobulina humana Anti-hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244486)

Enunciado: Uma menina de 9 anos de idade foi encaminhada pelo professor de educação física para consulta de rotina com pediatra em razão do ganho de peso excessivo recente. Ambos os pais são obesos, e a criança apresenta dificuldade nas atividades esportivas, não gosta de brincadeiras ao ar livre, preferindo sempre jogar no tablet. Antropometria peso = 41 kg, estatura = 140 cm. Foram verificados peso para a idade Z + 1,8 e estatura para a idade Z + 1,2 e IMC para a idade z + 1,9. Com base no exposto, quanto ao diagnóstico antropométrico da criança, conforme a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

A) Eutrófica em peso e estatura.

B) Peso elevado para a idade, estatura elevada para a idade.

C) Peso elevado para a idade, obesidade e estatura adequada.

D) Peso elevado para a idade, obesidade grave.

E) Peso adequado para a idade, sobrepeso e estatura adequada para a idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244506)

Enunciado: Quanto às vacinas previstas no Calendário de Vacinação de 2019 para as crianças de 1 ano de idade, assinale a alternativa correta.

A) Reforço da pneumocócica 10v, reforço da meningocócica C, primeira dose tríplice viral.

B) Reforço penta/DTP, reforço VIP/VOP, dose única hepatite A, dose única tetraviral.

C) 3ª dose penta/DTO, 3ª dose VIP/VOP.

D) Pneumocócica 23V.

E) Febre amarela.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227419)

Enunciado: Considerando esse gráfico, que apresenta os índices de massa corporal (IMC) dos indivíduos A, B e C, julgue o próximo item, com base nas normas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. O indivíduo C tem peso adequado para sua altura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227420)

Enunciado: Considerando esse gráfico, que apresenta os índices de massa corporal (IMC) dos indivíduos A, B e C, julgue o próximo item, com base nas normas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. O indivíduo B tem subnutrição grave.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227421)

Enunciado: Considerando esse gráfico, que apresenta os índices de massa corporal (IMC) dos indivíduos A, B e C, julgue o próximo item, com base nas normas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. O indivíduo A tem obesidade grave.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227422)

Enunciado: A respeito da vacinação contra o HPV, julgue o item seguinte. A vacina contra o HPV, além de ser eficaz na prevenção da infecção por esse vírus na região genital de mulheres com vida sexual ativa, também é indicada para meninas adolescentes impúberes, as quais devem receber 3 doses da vacina, no esquema 0, 1 a 2 e 6 meses.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227449)

Enunciado: Com relação às demandas de saúde na atenção primária à saúde (APS), relacionadas às doenças infecciosas e transmissíveis, julgue o item que se segue. Grávidas devem vacinar-se contra o sarampo apenas em caso de surto vigente no país, pois, nessas circunstâncias, os benefícios superam os riscos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230630)

Enunciado: Considerando que a imunoglobulina humana anti-hepatite B IGHAHB e vacina contra hepatite B são recomendados como profilaxia para pessoas susceptíveis com exposição sexual à pessoa com hepatite B aguda. SOMENTE podemos aceitar como adequado o item:

A) Deve-se buscar identificar a pessoa exposta quanto à hepatite B. Caso essa pessoa seja suscetível, estão indicadas a vacina contra hepatite B, mas não a IGHAHB, aplicadas o mais precocemente possível, no máximo até 14 dias depois da exposição.

B) Deve-se buscar identificar a pessoa exposta quanto à hepatite B. Caso essa pessoa seja suscetível, estão indicadas a vacina contra hepatite B e a IGHAHB, aplicadas o mais precocemente possível, no máximo até 21 dias depois da exposição.

C) Deve-se buscar identificar a pessoa exposta quanto à hepatite B. Caso essa pessoa não seja suscetível, estão indicadas a vacina contra hepatite B e a IGHAHB, aplicadas o mais precocemente possível, no máximo até 14 dias depois da exposição.

D) Deve-se buscar identificar a pessoa exposta quanto à hepatite B. Caso essa pessoa seja suscetível, estão indicadas a vacina contra hepatite B e a IGHAHB, aplicadas o mais precocemente possível, no máximo até 14 dias depois da exposição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206169)

Enunciado: São características que podem ocorrer na Síndrome de Turner, EXCETO:

A) Edema de mãos e pés ao nascimento.

B) Pescoço alado, implantação baixa da linha do cabelo.

C) Coarctação de aorta.

D) Puberdade precoce com menarca antes de 11 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203026)

Enunciado: Uma paciente de 14 anos de idade, que nega início da atividade sexual, procurou o consultório ginecológico para orientações acerca do calendário vacinal. Com relação a esse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, assinale a alternativa correta.

A) A vacinação para HPV não pode ser feita, já que a paciente ainda não iniciou a atividade sexual.

B) A vacinação deve ser feita preferencialmente antes do início da atividade sexual.

C) Para as pacientes que já iniciaram atividade sexual, é necessário colher captura híbrida para avaliação da presença de HPV, pois, se esta for positiva, a vacinação não precisa ser realizada.

D) A vacinação para HPV apresenta ampla cobertura e protege contra todos os tipos de HPV existentes.

E) A indicação de vacinação para HPV é restrita a pacientes que apresentam fator de risco, como múltiplos parceiros sexuais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206144)

Enunciado: A prevalência de desnutrição é alta no ambiente hospitalar e varia de 20 a 50%, mesmo em países desenvolvidos. Sobre isso, é INCORRETO afirmar:

A) Durante a fase inicial da resposta inflamatória está indicado o suporte nutricional.

B) O risco de desnutrição é maior em pacientes com mais de 60 anos, com infecção, câncer ou tempo de internação prolongada.

C) As reservas de carboidratos, na forma de glicogênio hepático e muscular são mínimas.

D) A recuperação da falência nutricional, com retorno à composição corporal normal pode levar de meses a anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212106)

Enunciado: Um menino de 4 anos de idade foi encaminhado ao ambulatório de pediatria porque sua mãe havia sido recém-diagnosticada com tuberculose pulmonar, com tratamento iniciado havia 3 semanas. Na consulta, a criança apresentava sinais gripais com tosse seca e coriza hialina havia 10 dias, sem febre. O cartão vacinal estava completo e, no exame físico, foi constatada apenas a presença de coriza e de cicatriz de Bacilo de Calmette-Guérin (BCG). O pediatra solicitou radiografia de tórax e Derivado Proteico Purificado (PPD). O resultado da radiografia foi normal, ao passo que o do PPD foi de 4 mm. Com relação a esse caso clínico, julgue o item que se segue. A presença de cicatriz oriunda da vacinação com a BCG é um indicativo de que a criança está protegida das formas mais graves da tuberculose.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212043)

Enunciado: Julgue o item, relativo à oncologia ginecológica. Por terem baixa patogenicidade, os vírus HPV 16 e 18 não são alvos para o desenvolvimento de vacinas a serem aplicadas em mulheres adultas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212044)

Enunciado: Julgue o item, relativo à oncologia ginecológica. A vacina contra cepas oncogênicas dos HPVs 6, 11, 16 e 18 foi implementada pelo Ministério da Saúde para administração em meninas de nove a quatorze anos de idade e meninos entre onze e quatorze anos de idade.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212072)

Enunciado: Julgue o item a seguir, relativo ao pré-natal, parto e puerpério. A vacina tríplice viral está contraindicada durante a gestação, embora possa ser administrada durante o puerpério e a amamentação.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206114)

Enunciado: Para prevenção da transmissão da tuberculose nas unidades de saúde, devem ser implementadas nas unidades de saúde as seguintes etapas. Determine qual está INCORRETA:

A) Reconhecer o Sintomático Respiratório SR ou paciente com TB pulmonar ativa é o primeiro passo nas medidas administrativas. Pode ser obtido com a preparação de um profissional de saúde para realizar a busca ativa de SR em todo paciente que chega à unidade, interrogando a presença e duração da tosse.

B) Oferecer ao SR máscara cirúrgica para uso durante sua permanência na unidade e instruí-lo com relação à etiqueta da tosse (levar o braço ou lenço à boca quando tossir).

C) SR ou pacientes com TB de vias aéreas em atividade ainda infectantes devem esperar atendimentos ou procedimentos em áreas fechadas ventiladas.

D) Priorizar o atendimento do paciente no serviço, independentemente do motivo da procura. O paciente deve passar à frente na fila de consultas, exames e/ou dispensa de medicamentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212130)

Enunciado: As infecções pneumocócicas em idosos preocupam os profissionais de saúde devido ao risco de complicações como a pneumonia. Nesse contexto, um ensaio clínico randomizado foi conduzido para avaliar a eficácia de uma nova vacina antipneumocócica, considerando a prevenção da Pneumonia Pneumocócica (PP) como desfecho. Os idosos foram divididos randomicamente em dois grupos: um grupo de 502 idosos foi vacinado, e o segundo grupo, composto por 504 idosos, recebeu placebo. Entre os idosos não vacinados, 37 foram diagnosticados com PP e, entre os vacinados, 488 permaneceram saudáveis. O acompanhamento de ambos os grupos foi realizado por 26 meses. Com relação às informações do estudo anteriormente descrito e à vacina antipneumocócica, julgue o item subsequente. O Ministério da Saúde indica a administração da vacina antipneumocócica para idosos que vivam acamados e(ou) em instituições fechadas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183947)

Enunciado: Com relação ao metabolismo do sistema endócrino e às doenças associadas à desregulação desse metabolismo, julgue o item subsecutivo. De acordo com a 1 Diretriz Brasileira para Síndrome Metabólica e com o National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III, em se tratando de síndrome metabólica, a definição baseia-se no índice de massa corporal (IMC).

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183890)

Enunciado: No que se refere à imunização, julgue o item seguinte. A imunização passiva artificialmente adquirida garante proteção mais duradoura e menores reações de sensibilidade se comparada à imunização ativa artificialmente adquirida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183867)

Enunciado: Com relação às políticas de saúde, julgue o item que se segue. A política de imunizações implantada no Sistema Único de Saúde nos últimos anos tem ampliado as indicações das vacinas e, consequentemente, o acesso da população à prevenção de doenças imunopreveníveis.

A) CORRETO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159565)

Enunciado: Criança de oito anos de idade, proveniente de região rural, deu entrada no pronto-socorro após ter sido mordida por animal silvestre (porco-do-mato), que desapareceu após o ocorrido. O ferimento na criança era profundo e múltiplo, localizado no antebraço esquerdo, sem perda de substância. Foi realizada lavagem exaustiva do ferimento após anestesia local, com debridamento de tecido desvitalizado, hemostasia e realização de pontos distantes para aproximação. A respeito do esquema para profilaxia antirrábica humana pós-exposição no caso clínico apresentado, julgue o item a seguir. Nesse caso, indica-se a administração da vacina antirrábica humana de cultivo celular, em cinco doses, bem como a adminisitração de soro antirrábico, do qual deve ser administrada pelo menos metade da dose local do ferimento no atendimento inicial.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154488)

Enunciado: São exemplos de vacinas compostas de vírus vivos atenuados, EXCETO:

A) Sarampo.

B) Rubéola.

C) Caxumba.

D) Hepatite A.

E) Febre amarela.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159564)

Enunciado: Auxograma é um método gráfico para diagnóstico de distúrbios do crescimento no qual se registram diferentes aspectos do crescimento por meio de um sistema de coordenadas cartesianas que relacionam a idade cronológica com a idade e a altura, e idade e o peso, a idade óssea e a idade mental. (Conforme imagem do caderno de questões). A partir dessas informações, julgue o item seguinte com base nos auxogramas dispostos na figura apresentada. O auxograma do paciente B representa o de uma criança com nanismo primário pré-pubertário.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158059)

Enunciado: Nos últimos anos, há grandes dificuldades na atenção primária à saúde no que tange a abordagem de contactantes de pacientes com tuberculose bacilífera na ausência do teste tuberculínico (PPD). Considerando os conhecimentos de medicina preventiva e a Nota Informativa nº 8/2014, CGPNTC/DEVEP/SVS/MS, assinale a alternativa CORRETA quanto à abordagem de neonatos de mãe bacilífera.

A) Havendo disponibilidade de PPD, indica-se não vacinar com BCG ao nascer, tratar com isoniazida por seis meses e realizar PPD após para avaliar resposta.

B) Havendo disponibilidade de PPD, não se deve vacinar com BCG ao nascer, e sim tratar com isoniazida por três meses e realizar PPD. Caso PPD > 5 mm, iniciar esquema RIP.

C) Na ausênia de PPD, os neonatos devem ser tratados com isoniazida por três meses e apenas após serem vacinados com BCG.

D) Na ausência de PPD, os neonatos devem realizar esquema RIP por três meses e depois devem ser vacinados com BCG, apenas.

E) Na ausência de PPD, os neonatos devem receber tratamento com isoniazida por seis meses e vacinação com BCG apenas após o tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159569)

Enunciado: Auxograma é um método gráfico para diagnóstico de distúrbios do crescimento no qual se registram diferentes aspectos do crescimento por meio de um sistema de coordenadas cartesianas que relacionam a idade cronológica com a idade e a altura, e idade e o peso, a idade óssea e a idade mental. (Conforme imagem do caderno de questões). A partir dessas informações, julgue o item seguinte com base nos auxogramas dispostos na figura apresentada. O auxograma do paciente C é o de uma criança com nanismo hipotiroidiano.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159576)

Enunciado: Auxograma é um método gráfico para diagnóstico de distúrbios do crescimento no qual se registram diferentes aspectos do crescimento por meio de um sistema de coordenadas cartesianas que relacionam a idade cronológica com a idade e a altura, e idade e o peso, a idade óssea e a idade mental. (Conforme imagem do caderno de questões). A partir dessas informações, julgue o item seguinte, com base nos auxogramas dispostos na figura apresentada. O auxograma do paciente D corresponde ao de uma criança com nanismo pituitário.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159579)

Enunciado: Auxograma é um método gráfico para diagnóstico de distúrbios do crescimento no qual se registram diferentes aspectos do crescimento por meio de um sistema de coordenadas cartesianas que relacionam a idade cronológica com a idade e a altura, e idade e o peso, a idade óssea e a idade mental. (Conforme imagem do caderno de questões). A partir dessas informações, julgue o item seguinte com base nos auxogramas dispostos na figura apresentada. O auxograma do paciente E representa o de uma criança com nanismo acondroplásico.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159583)

Enunciado: Auxograma é um método gráfico para diagnóstico de distúrbios do crescimento no qual se registram diferentes aspectos do crescimento por meio de um sistema de coordenadas cartesianas que relacionam a idade cronológica com a idade e a altura, e idade e o peso, a idade óssea e a idade mental. (Conforme imagem do caderno de questões). A partir dessas informações, julgue o item seguinte com base nos auxogramas dispostos na figura apresentada. O auxograma do paciente A corresponde ao de uma criança com crescimento normal.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159592)

Enunciado: Em consulta de uma criança de quatro anos de idade, sedentária, sem histórico familiar de dislipidemia ou aterosclerose, o pediatra constatou que ela estava com o peso para a idade acima do escore-Z + 3, que a pressão arterial em três medidas subsequentes era de 120 x 80 mmHg (percentil 99 da curva de pressão arterial por sexo, idade e estatura) e que o nível do colesterol LDL era de 140 mg/dl e o HDL de 45 mg/dl. (VR = LDL < 100 mg/dl; HDL > 40 mg/dl). Com relação a esse caso clínico, julgue o próximo item, acerca da conduta a ser indicada pelo médico. Deve-se indicar mudança no estilo de vida da família da criança: dieta com baixos níveis de sódio e gordura saturada; atividades ao ar livre.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168480)

Enunciado: A figura abaixo apresenta a distribuição espacial dos casos de febre amarela confirmados e em investigação pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil até o dia 06 de abril de 2017, com início dos sintomas a partir de 1º de dezembro de 2016. (Conforme imagem no caderno de questões) Considerando a situação epidemiológica da febre amarela apresentada nos mapas, no período analisado, assinale a opção correta no que se refere às mudanças nas áreas de recomemdação de vacinação.

A) Intensificação das estratégias de vacinação de forma seletiva nos estados de Minas Gerais e Paraná, anteriormente áreas sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.

B) Determinação do estado de São Paulo como área com recomendação temporária de vacinação, anteriormente uma área sem recomendação de vacinação contra a febre amarela.

C) Intensificação da vacinação em municípios afetados pela febre amarela no estado do Rio de Janeiro, mantido como área com recomendação permanente de vacinação.

D) Determinação da maioria dos municípios do estado do Espírito Santo como áreas indicadas para a recomendação temporária de vacinação contra a febre amarela.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159615)

Enunciado: Uma menina de dez anos de idade, moradora da periferia de uma grande cidade, foi atendida na emergência, apresentando, de acordo com relato da mãe, febre alta havia seis dias. A mãe informou, ainda, que, após quarenta e oito horas do início da febre, esta havia sigo seguida por cefaleia, vômitos , diarreia e urina escura. No exame físico, o médico observou escleróticas ictéricas , dor abdominal e discreta hepatomegalia. A mãe da menina relatou que havia um surto de dengue na região onde moravam. Exames laboratóriais realizados no terceiro dia de evolução do quadro clínico apresentataram os seguintes resultados: TGO = 90 UI; TGP = 280 UI; anti-HVA IgM e IgG não reagentes; Anti-HBs Ag reagente; HBs Ag, HBeAg, anti-HBeAg, anti-HB C IgM e IgG não reagentes; o exame de detecção para antígeno de dengue NS1 foi negativo. Com referência ao caso clínico apresentado, julgue o item que se segue. Com referência ao caso clínico apresentando, julgue o item que se segue. Após a cura clínica, a paciente deverá receber quatro doses da vacina contra o HPV em um intervalo de seis meses, se ainda não tiver sido vacinada.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159589)

Enunciado: Um lactente de dois meses de idade foi levado ao médico por sua mãe para uma consulta de rotina. A mãe referiu que nunca havia amamentado no peito e que atualmente o lactente era alimentado com leite de vaca in natura integral e açúcar, em doses de 150 mL cinco vezes ao dia, e água nos intervalos. O médico observou ainda, no cartão da criança, que o lactente havia recebido a primeira dose da vacina contra hepatite B e o BCG intradérmico. No que se refere a esse caso clínico, julgue o item subsecutivo. Essa criança deverá receber as seguintes vacinas: tetravalente (difteria, tétano, pertussis, hemófilo B), anti-hepatite B, antipoliomielite inativada (Salk ou VIP), antipneumocócica decavalente, antirrotavírus humano.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168470)

Enunciado: Uma criança com 10 anos de idade, vítima de mordedura de seu próprio cão na região da bochecha direita, é conduzida pelos pais à Unidade de Pronto Atendimento apresentando ferida de aproximadamente 3 cm de extensão e 1,5 cm de profundidade, sem comprometimento de músculos ou vasos. Os pais informam que a criança teve ferimento no pé esquerdo há 8 meses, quando fez uso de três doses da vacinação antitetânica. O médico de plantão lavou copiosamente a ferida com água e sabão, e fez limpeza com solução degermante de polivinilpirrolidona. Recomendou, ainda, a observação do cão por 10 dias. Além das providências tomadas acima, quais condutas deverão ser adotadas pelo médico?

A) Fechamento da ferida por segunda intenção, profilaxia contra raiva (14 doses da vacina) e antibioticoprofilaxia por 5 a 7 dias.

B) Sutura primária retardada, profilaxia contra raiva (cinco doses da vacina por 5 dias consecutivos) e antibioticoprofilaxia por 5 a 7 dias.

C) Sutura primária da ferida sob anestesia local, profilaxia contra raiva (duas doses da vacina nos dias 0 e 3) e antibioticoprofilaxia por 5 a 7 dias.

D) Aproximação das bordas da ferida com micropore, profilaxia contra raiva (10 doses da vacina em 10 dias) e antibioticoprofilaxia por 5 a 7 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159609)

Enunciado: Com relação à adequada prática clínica nos cuidados pré-natais, julgue o seguinte item.

O reforço da vacina contra febre amarela, quando necessário, pode ser feito em gestantes, uma vez que essa vacina é composta por vírus inativado e não oferece risco à saúde da mãe ou do feto.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168488)

Enunciado: A mãe de uma menina com 2 anos de idade, hígida, comparece à Unidade Básica de Saúde em busca de orientações quanto à atualização da caderneta de vacinas da criança. Relata que sua filha foi imunizada contra a febre amarela aos 6 meses de idade, por ocasião de surto da doença em sua cidade, e que não recebeu nenhuma outra dose da vacina desde então; a família continua morando em área de risco para febre amarela. Para essa criança, é adequado indicar

A) uma dose de reforço aos 4 anos de idade.

B) uma dose de reforço aos 10 anos de idade.

C) uma dose da vacina hoje e uma segunda dose em 30 dias.

D) uma dose da vacina hoje e uma dose de reforço aos 4 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159581)

Enunciado: Com relação à vigilância em saúde, julgue o próximo item. O objetivo da introdução da vacina tetraviral no calendário vacinal nacional é controlar e eliminar sarampo, caxumba e rubéola bem como evitar formas graves de catapora.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159591)

Enunciado: Com relação à vigilância em saúde, julgue o próximo item. A definição de caso suspeito de parotidite epidêmica, a caxumba, é febre aguda com dor e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133996)

Enunciado: Lactente de 2 anos de idade, residente em região rural da Bahia, é levado ao pronto-socorro em razão de febre há 10 dias e desnutrição grave. Ao exame, apresenta-se com peso de 10 kg, edemaciado, apático e taquicardíaco. Em relação ao Kwashiorkor, apresenta forma grave de desnutrição. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

A) Esse tipo de desnutrição grave apresenta-se com criança em aspecto emagrecido e atrofia muscular.

B) É comum a criança apresentar anorexia, edema, pele despigmentada, com áreas de hiperpigmentação e discromias em cabelos.

C) É classificada como deficiência energético-proteica.

D) A faixa etária mais comum de ocorrência é de crianças menores de 1 ano de idade.

E) Geralmente as crianças apresentam diarreia, anemia e perda extrema de tecido celular subcutâneo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129076)

Enunciado: No que diz respeito ao tema "alimentação saudável", assinale a alternativa CORRETA:

A) Gordura trans e gordura vegetal hidrogenada são semelhantes, pois o fato de não haver gordura trans na tabela nutricional não impede que o produto contenha gordura vegetal hidrogenada.

B) Além de verificar na tabela nutricional, outra maneira de perceber a quantidade de sódio no alimento é o gosto salgado, pois, proporcionalmente à sua quantidade, o produto ficará salgado.

C) A substituição do sal por orégano, salsa e manjericão não deve ser incentivada, pois essas ervas ocasionam outros tipos de danos à saúde, às vezes até piores que os ocasionados pelo sal.

D) A tabela nutricional, obrigatória nos alimentos processados, contém a quantidade de nutrientes em ordem crescente de concentração.

E) Alimento diet e (ou) light é a melhor opção, pois sempre é menos calórico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111336)

Enunciado: A estatura-alvo (tendência de crescimento) de um menino filho de um pai com 168 cm de estatura e de uma mãe com 155 cm é:

A) 155,0 cm.

B) 161,5 cm.

C) 164,5 cm.

D) 168,0 cm.

E) 169,5 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111284)

Enunciado: Criança escolar, 8 anos, com suspeita de Baixa Estatura Familiar (BEF). O que esperar, para esse diagnóstico, da radiografia de punho e mão esquerda para idade óssea (IO)?

A) IO igual à idade altura.

B) IO maior que a idade cronológica.

C) IO igual à idade cronológica.

D) IO menor que a idade cronológica.

E) IO igual à idade peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97778)

Enunciado: Um recém-nascido com três semanas de vida é levado à Unidade Básica de Saúde, pois a mãe observou ferida no local da aplicação da BCG. Ao exame físico observa-se lesão pustulocrostosa no braço direito e presença de gânglio satélite em axila direita, não supurado, medindo 1 cm de diâmetro. Considerando o diagnóstico, a conduta adequada a ser tomada para esse recém-nascido é:

A) iniciar isoniazida por via oral.

B) manter conduta expectante.

C) solicitar teste tuberculínico.

D) realizar punção do gânglio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97806)

Enunciado: Uma criança com 3 anos de idade é levada à consulta na Unidade Básica de Saúde. A mãe queixa-se que o filho não está crescendo, tem apresentado perda do apetite e parece não enxergar bem, principalmente no período da noite. Ao exame físico, o médico observou que o peso da criança se situa entre (-2) e (-3) escore z da curva da Organização Mundial da Saúde, além de xerodermia e xeroftalmia. O quadro clínico apresentado pela criança é de:

A) hipovitaminose A.

B) hipovitaminose D.

C) hipovitaminose C.

D) hipovitaminose B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75503)

Enunciado: Criança com três anos de idade, nascida à termo, não acompanhada regularmente na Puericultura, foi levada pela mãe para uma consulta na Unidade Básica de Saúde após sofrer fratura no antebraço direito há dois meses. Após avaliação médica, foi observado: baixa estatura para a idade, escoliose, desproporção da relação segmento superior e inferior, hipotonia muscular e hérnia umbilical pequena. O médico solicitou radiografia de mão e punho e de membros inferiores, mostradas abaixo (VER IMAGEM). O diagnóstico e a alteração radiológica que o confirma são, respectivamente:

A) Osteopenia e perda da densidade óssea.

B) Hipotireoidismo e atraso da idade óssea.

C) Deficiência de fósforo e osteomalácia.

D) Displasia óssea e displasia metafisária.

E) Raquitismo e alargamento das epífises.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138711)

Enunciado: Adolescente com 15 anos de idade, do sexo masculino, estudante, sofreu ataque por mordedura de cão há duas horas. O cão é da raça Rottweiler, faz parte do meio familiar (pertencente ao pai do garoto) e não apresenta sinais de alteração no comportamento. O paciente apresentava, à admissão, múltiplas e extensas lacerações em face (região frontal, glabelar, nasal e periorbitária esquerda) com descolamento parcial da orelha esquerda, acompanhadas de lesões menos perfurantes em membros superiores. Os demais aspectos do exame físico eram normais. O paciente não tem antecedentes patológicos e desconhece a sua situação vacinal. Sobre o caso, responda a seguinte questão: Qual deve ser a abordagem inicial da ferida?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138712)

Enunciado: Adolescente com 15 anos de idade, do sexo masculino, estudante, sofreu ataque por mordedura de cão há duas horas. O cão é da raça Rottweiler, faz parte do meio familiar (pertencente ao pai do garoto) e não apresenta sinais de alteração no comportamento. O paciente apresentava, à admissão, múltiplas e extensas lacerações em face (região frontal, glabelar, nasal e periorbitária esquerda) com descolamento parcial da orelha esquerda, acompanhadas de lesões menos perfurantes em membros superiores. Os demais aspectos do exame físico eram normais. O paciente não tem antecedentes patológicos e desconhece a sua situação vacinal. Sobre o caso, responda a seguinte questão: O paciente necessita de profilaxia para o tétano? Em caso afirmativo, o que deve ser prescrito?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138713)

Enunciado: Adolescente com 15 anos de idade, do sexo masculino, estudante, sofreu ataque por mordedura de cão há duas horas. O cão é da raça Rottweiler, faz parte do meio familiar (pertencente ao pai do garoto) e não apresenta sinais de alteração no comportamento. O paciente apresentava, à admissão, múltiplas e extensas lacerações em face (região frontal, glabelar, nasal e periorbitária esquerda) com descolamento parcial da orelha esquerda, acompanhadas de lesões menos perfurantes em membros superiores. Os demais aspectos do exame físico eram normais. O paciente não tem antecedentes patológicos e desconhece a sua situação vacinal. Sobre o caso, responda a seguinte questão: O paciente necessita de antibióticoterapia? Em caso afirmativo, como deve ser a prescrição?

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138714)

Enunciado: Adolescente com 15 anos de idade, do sexo masculino, estudante, sofreu ataque por mordedura de cão há duas horas. O cão é da raça Rottweiler, faz parte do meio familiar (pertencente ao pai do garoto) e não apresenta sinais de alteração no comportamento. O paciente apresentava, à admissão, múltiplas e extensas lacerações em face (região frontal, glabelar, nasal e periorbitária esquerda) com descolamento parcial da orelha esquerda, acompanhadas de lesões menos perfurantes em membros superiores. Os demais aspectos do exame físico eram normais. O paciente não tem antecedentes patológicos e desconhece a sua situação vacinal. Sobre o caso, responda a seguinte questão: O paciente necessita de profilaxia para raiva? Em caso afirmativo, como deve ser a prescrição?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75535)

Enunciado: Menina com 7 anos de idade foi levada para consulta em Unidade Básica de Saúde pela mãe. Apresenta queixa de ganho de peso excessivo nos últimos meses. Após a realização do exame físico, foram registrados os seguintes dados: Peso = 35 kg; Altura = 1,25 m; Pressão Arterial (membro superior direito) = 118 x 80 mmHg. Após a análise das curvas de crescimento (peso, altura e índice de massa corporal ? IMC) e da tabela de pressão arterial, é correto afirmar que os diagnósticos e a conduta inicial recomendada nessa situação são, respectivamente: (VER IMAGEM)

A) Obesidade grave e hipertensão; recomenda-se incentivar hábitos de vida saudáveis (atividade física regular e alimentação balanceada) e realizar tratamento farmacológico.

B) Sobrepeso e pressão arterial limítrofe; recomenda-se incentivar hábitos de vida saudáveis (atividade física regular e alimentação balanceada) e rastrear outras comorbidades.

C) Obesidade e hipertensão; recomenda-se seguir plano alimentar com dieta balanceada, atividade física regular e acompanhamento semanal com a equipe de saúde.

D) Sobrepeso e hipertensão; recomenda-se seguir plano alimentar com dieta balanceada, atividade física regular, bem como restrições de tempo na frente da televisão.

E) Obesidade e pressão arterial limítrofe; recomenda-se seguir plano alimentar com dieta balanceada, atividade física regular e rastrear outras comorbidades.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75458)

Enunciado: Lactente com dois meses de idade foi levado pela mãe à Unidade Básica de Saúde com história de estar muito apático nas últimas horas. Ao exame físico o médico observa que a criança está hipotônica, hiporresponsiva, apresentando livedo reticular, palidez e cianose de extremidades. Ao ser questionada pelo médico sobre os últimos acontecimentos na vida da criança, a mãe informa à equipe de saúde que a criança havia recebido a vacina Pentavalente há aproximadamente seis horas. Considerando a suspeita de evento adverso pós-vacinação, as manifestações clínicas desta criança sugerem evento relacionado a qual dos componentes vacinais citados nas alternativas abaixo?

A) Toxoide purificado de tétano.

B) Toxoide purificado de difteria.

C) Suspensão de Bordetella pertussis.

D) Antígenos de superfície de hepatite B.

E) Oligossacarídeos de H. influenzae tipo b.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75506)

Enunciado: Médica com 24 anos de idade, recém-formada em escola do Sudeste brasileiro, foi convocada pelo Exército para servir, durante o próximo ano, na base da segunda maior e mais populosa cidade do Acre, na Região Norte do país. Ela comparece à Unidade Básica de Saúde para se vacinar contra febre amarela. Como o médico deve orientar a paciente?

A) Como a viagem irá durar mais de seis meses, não está indicada a vacinação contra febre amarela, somente a adoção de medidas preventivas contra picadas de insetos, principalmente durante a noite.

B) Orientação sobre o acesso à rede de serviços de diagnóstico e tratamento da malária na área onde ela irá morar, além de procurar os serviços de saúde, tão logo identifique algum sintoma.

C) Não existe indicação de vacinação, e sim de quimioprofilaxia para malária, com doxiciclina, mefloquina e cloroquina. Iniciar um dia antes da viagem e manter até quatro semanas após o retorno.

D) Indicar a vacinação contra febre amarela pelo menos dez dias antes da viagem. Não é necessário tomar a vacina se já foi vacinada nos últimos dez anos. Orientar sobre a importância de portar cartão de vacinação durante a viagem.

E) Como viverá em área endêmica, deverá receber reforço vacinal a cada cinco anos. Orientar sobre a importância de portar cartão de vacinação durante a viagem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75511)

Enunciado: Primigesta com 18 anos de idade, 22 semanas de idade gestacional, comparece à Unidade Básica de Saúde para realização de vacinação antitetânica. Traz consigo carteira de vacinação que registra que a última imunização aplicada foi a vacina dupla para adulto, aos 15 anos de idade. Considerando-se o estado vacinal e a idade gestacional, deve-se:

A) aplicar pelo menos duas doses de vacina antitetânica durante a gestação, com intervalo de dois meses.

B) aplicar a dose de reforço da vacina antitetânica, como feito habitualmente durante a gestação.

C) aplicar uma dose de vacina antitetânica durante a gestação e uma nova dose no puerpério.

D) não aplicar vacina antitetânica, pela cobertura vacinal prévia.

E) aplicar a vacina antitetânica, pois cobrir o risco fetal é a prioridade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75547)

Enunciado: Adolescente, 16 anos de idade, vai à consulta ginecológica buscando orientação. Relata estar namorando há três meses, nunca teve atividade sexual, mas pretende começar a ter relações com o namorado em alguns meses. Considerando a literatura mais recente, qual medida teria maior impacto na prevenção das lesões induzidas pelo papilomavírus humano para a paciente em questão, incluindo o câncer de colo uterino?

A) Realizar vacinação contra o HPV.

B) Realizar captura híbrida anual para HPV.

C) Fazer uso de anticoncepcional combinado oral.

D) Realizar exame citopatológico de colo uterino anual.

E) Recomendar que a paciente oriente o namorado a procurar um urologista para realização de peniscopia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137684)

Enunciado: Criança de 8 anos de idade, do sexo masculino, está em acompanhamento de rotina na Unidade Básica de Saúde (UBS). Não tem passado mórbido significativo. O cartão vacinal está em dia. Atividades de lazer: video game, desenhos na TV e visita a familiares. Padrão alimentar atual: ?come de tudo", mas quando era menor , segundo a mãe "tinha que forçar para comer? . Ao exame: peso = 36 Kg; estatura = 130 cm; P A = 100 x 60 mmHg; presença de máculas hipercrômicas ao redor da região cervical compatível com Acantosis nigricans. Ausência de outros achados patológicos no exame físico. Com base no quadro clínico apresentado, responda a proposição abaixo: Cite a(s) patologia(s) que deve(m) ser investigada(s) neste momento e os exames subsidiários relacionados (VER IMAGEM).

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137685)

Enunciado: Criança de 8 anos de idade, do sexo masculino, está em acompanhamento de rotina na Unidade Básica de Saúde (UBS). Não tem passado mórbido significativo. O cartão vacinal está em dia. Atividades de lazer: video game, desenhos na TV e visita a familiares. Padrão alimentar atual: ?come de tudo", mas quando era menor , segundo a mãe "tinha que forçar para comer? . Ao exame: peso = 36 Kg; estatura = 130 cm; P A = 100 x 60 mmHg; presença de máculas hipercrômicas ao redor da região cervical compatível com Acantosis nigricans. Ausência de outros achados patológicos no exame físico. Com base no quadro clínico apresentado, responda a proposição abaixo: Cite outras medidas antropométricas (pelo menos duas) que poderiam ter sido feitas e descreva a execução de uma delas. (VER IMAGEM)

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137686)

Enunciado: Criança de 8 anos de idade, do sexo masculino, está em acompanhamento de rotina na Unidade Básica de Saúde (UBS). Não tem passado mórbido significativo. O cartão vacinal está em dia. Atividades de lazer: video game, desenhos na TV e visita a familiares. Padrão alimentar atual: ?come de tudo", mas quando era menor , segundo a mãe "tinha que forçar para comer? . Ao exame: peso = 36 Kg; estatura = 130 cm; P A = 100 x 60 mmHg; presença de máculas hipercrômicas ao redor da região cervical compatível com Acantosis nigricans. Ausência de outros achados patológicos no exame físico. Com base no quadro clínico apresentado, responda a proposição abaixo: Faça uma proposta de orientação alimentar (pelo menos três orientações) e comportamental (pelo menos duas proposições) a ser feita para o menor e sua família. (VER IMAGEM)

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137560)

Enunciado: Um lactente de um ano de idade apresenta inapetência, apatia, palidez cutâneo-mucosa acentuada, lesões cutâneas hipocrômicas e hipercrômicas com descamação em membros, facies de lua cheia, hepatomegalia, edema em membros e despigmentação de cabelos. A temperatura axilar é de 35,7°C. Foi identificado pelo agente comunitário de saúde em seu domicílio, onde mora com a mãe e mais cinco irmãos, e encaminhado para avaliação na Unidade Básica de Saúde (UBS). Peso = 7 kg e comprimento = 65 cm. Com essas informações, o diagnóstico nutricional e a conduta médica mais adequados são, respectivamente,

A) desnutrição proteica grave e encaminhamento para internação hospitalar .

B) desnutrição proteico-calórica grave e encaminhamento para internação hospitalar .

C) desnutrição proteica grave e monitoramento de peso na Unidade Básica de Saúde.

D) desnutrição proteico-calórica moderada e encaminhamento para internação hospitalar.

E) desnutrição calórica moderada e monitoramento do peso na Unidade Básica de Saúde.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137564)

Enunciado: Um lactente de 4 meses de idade é levado à Unidade Básica de Saúde apresentando tumoração em axila direita. A criança está em aleitamento materno exclusivo e sua situação vacinal é adequada. Ao exame: peso = 5,5 kg, temperatura axilar = 37,1 ºC, chorosa, lesão tumoral de aproximadamente 3 cm, com ponto de flutuação central em axila direita. A conduta mais adequada no momento para esse lactente é

A) prescrever estreptomicina durante dois meses e notificar o caso.

B) prescrever pirazinamida durante dois meses; drenar , se persistir a flutuação; notificar o caso.

C) prescrever etambutol durante dois meses; não há necessidade de drenagem; notificar o caso.

D) prescrever isoniazida; puncionar, se necessário, sem realizar drenagem cirúrgica; notificar o caso.

E) prescrever rifampicina; fazer compressas mornas e incisão para facilitar a drenagem; notificar o caso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137700)

Enunciado: Um lactente de 2 meses de idade é levado ao Pronto-Socorro com história de febre, recusa alimentar e hipoatividade. Exame físico: hipotônico-hiporresponsivo. A mãe refere que a criança recebeu, na véspera, as vacinas DPT (difteria, pertussis e tétano), OPV (pólio oral) e rotavírus. Nessa situação, que conduta deve ser adotada em relação ao esquema vacinal?

A) Suspender a vacina contra rotavírus.

B) Substituir OPV pela IPV (pólio injetável).

C) Substituir a vacina DPT pela DPT acelular .

D) Manter o esquema vacinal normal, sem alterações.

E) Substituir a vacina DPT pela DPT acelular e a OPV pela IPV (pólio injetável).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138395)

Enunciado: Menina com cinco anos de idade, acometida de leucemia linfóide aguda (LLA), internada em enfermaria pediátrica, está sendo submetida à quimioterapia para tratamento da leucemia. Em outra ala da enfermaria, uma criança apresentou febre e desenvolveu lesões eritemato bolhosas sugestivas de varicela. Nesse contexto, a conduta ideal a ser tomada em relação a criança com leucemia é

A) administrar vacina contra varicela

B) aplicar imunoglobulina específica anti-varicela.

C) administrar aciclovir por 10 dias.

D) administrar a vacina contra varicela e o aciclovir por 10 dias

E) administrar a vacina contra varicela e imunoglobulina específica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138408)

Enunciado: Uma criança que nasceu prematura, com 32 semanas de idade gestacional e peso de 1850g, foi encaminhada à Unidade de Saúde para iniciar as imunizações. Atualmente, com um mês de vida, pesa 1900g e recebe aleitamento materno exclusivo. Para essa situação, qual a alternativa que indica o esquema inicial de vacinação recomendado?

A) Iniciar o esquema vacinal aplicando a vacina BCG e a primeira dose da vacina contra a Hepatite B.

B) Aplicar a primeira dose da vacina contra a Hepatite B e aguardar a criança atingir 2000g para programar a vacina BCG.

C) Aguardar a criança atingir 2500g para aplicar a vacina BCG e contra a Hepatite B (primeira dose).

D) Aguardar a criança atingir 2000g para aplicar a vacina contra a Hepatite B (primeira dose) e 2500g para aplicar a vacina BCG.

E) Aplicar as vacinas BCG e contra a Hepatite B (primeira dose) e programar a segunda dose desta última para 15 dias depois.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138413)

Enunciado: Uma médica, durante plantão em serviço de emergência, atendeu um paciente com múltiplas lesões no antebraço direito, vítima de mordedura de cão que ocorrera há 3 horas. O acidente ocorreu na rua, mas o dono do animal foi identificado. O caso deverá ser conduzido por ela de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda

A) iniciar o esquema de vacinação e observar o animal por 10 dias.

B) aplicar o soro antirábico e a vacina por 10 dias.

C) observar o cão durante 10 dias após a exposição,

para iniciar a vacinação antirábica.

D) aplicar soro antirábico (dose única) no 10º dia de

observação do animal.

E) sacrificar o animal imediatamente para evitar

contaminação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138589)

Enunciado: Criança, com 15 meses de idade, foi à Unidade Básica de Saúde para receber as vacinas do Programa Nacional de Imunização. A mãe da criança perguntou se ele podia tomar todas as vacinas, porque seu filho mais velho, de 10 anos de idade, encontra-se em tratamento quimioterápico para leucose aguda. Qual a conduta recomendada?

A) A criança pode receber todas as vacinas previstas.

B) A criança pode receber todas as vacinas, com exceção da Sabin.

C) A criança deve adiar a vacinação contra difteria, tétano e coqueluche.

D) A criança pode receber somente a tríplice viral.

E) A criança deve adiar a vacinação para o próximo mês.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

31031)

Enunciado: Acerca de alterações glicêmicas na infância, julgue o item a seguir. Considere a seguinte situação hipotética. Um menino com oito anos de idade apresenta índice de massa corporal e circunferência abdominal acima do percentil 95 para a idade e taxa de glicemia de jejum de 111 mg/dl. Nesse caso, a criança apresenta síndrome metabólica e diabetes mellitus do tipo 2.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138737)

Enunciado: Adolescente do sexo masculino, com 14 anos de idade, busca atendimento em Unidade Básica de Saúde por considerar sua estatura muito baixa. O seu peso ao nascer foi de 3 Kg e o comprimento, de 50 cm. Manteve-se com velocidade de crescimento adequada até os dois anos de vida. Depois desse período, o pediatra constatou desaceleração no padrão de crescimento. Atualmente, apresenta velocidade de crescimento e estatura compatíveis com a idade óssea. Estágio de Tanner = 1; idade óssea = 13,5 anos; radiografia de crânio normal. Qual a conduta adequada para essa situação?

A) Encaminhar o paciente para endocrinologista para indução puberal imediata com testosterona.

B) Referenciar o paciente para endocrinologista para indução imediata do crescimento com sulfato de zinco.

C) Acompanhar a evolução e não referenciar o paciente nesse momento, pois trata-se de atraso puberal constitucional.

D) Referenciar o paciente para endocrinologista para investigação imediata de hipogonadismo hipogonadotrófico.

E) Não referenciar o paciente e tranquilizá-lo, pois não há evidência de atraso puberal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138722)

Enunciado: Gestante, primigesta, 18 anos de idade, com dezessete semanas de gestação, traz cartão de vacinação para a consulta de pré-natal, mostrando esquema vacinal completo para tétano aos 10 anos de idade. Em relação à recomendação do esquema vacinal da dupla adulto (difteria e tétano), durante a gravidez, qual a conduta correta para essa gestante?

A) Repetir esquema vacinal completo, composto por três doses.

B) Repetir esquema vacinal modificado, composto por duas doses.

C) Aplicar dose de reforço, pois o esquema vacinal completo foi realizado há mais de cinco anos.

D) Não aplicar dose de reforço, já que o esquema vacinal completo foi realizado há menos de dez anos.

E) Não realizar vacinação, pois a vacina dupla adulto

não faz parte dos cuidados da assistência pré-natal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

22205)

Enunciado: Com relação à alimentação no 1° ano de vida, julgue o item seguinte. Crianças em aleitamento materno exclusivo filhas de mães vegetarianas têm risco de hipovitaminose B.

A) certo.

B) errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

352183)

Enunciado: A pelagra se caracteriza pela deficiência da vitamina B3. Qual característica abaixo não corresponde a esse diagnóstico?

A) Eritema, bolhas e púrpuras no abdome e regiões glúteas.

B) As áreas afetadas da pele se tornam espessadas, descamativas e hiperpigmentadas.

C) Mucosa oral vermelha, seca e lisa.

D) Podem estar presentes náusea, vômito e diarreia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351600)

Enunciado: Considere o quadro clínico a seguir: Paciente de 8 anos, sexo masculino, é levado a unidade básica de saúde pela sua avó, devido a mordedura de cão na região da planta do pé direito e em palma da mão esquerda. Os ferimentos eram superficiais, pouco extensos. O acidente ocorreu, pois, a criança colocou a mão e os pés dentro da grade onde o cão, que pertence ao vizinho, estava. O cão encontra-se aparentemente bem, sem sinais de doenças. Assinale a alternativa que apresenta a MELHOR abordagem neste caso.

A) Lavar com água e sabão e observar o animal durante 10 dias após o acidente, se o animal permanecer sadio, encerrar o caso.

B) Lavar com água e sabão, iniciar esquema profilático com soro e 4 doses de vacina, até completar todo o ciclo.

C) Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com 4 doses de vacina e observar o animal durante 10 dias. Se o animal permanecer sadio, completar o ciclo de vacinas e encerrar o caso.

D) Lavar com água e sabão, iniciar esquema profilático com duas doses de vacina e observar o animal durante 10 dias. Se o animal permanecer sadio, encerrar o caso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334721)

Enunciado: Paciente 30 anos, sexo feminino, sem comorbidades conhecidas, ao fazer trilha na região de Santa Leopoldina foi mordida na mão direita por um macaco, que em seguida fugiu para a mata. Chegou ao Pronto-Socorro cerca de 3 horas após o ocorrido. Observe as afirmativas abaixo e depois responda. I) Em situações conforme a descrita acima, deve prescrever soro e vacina antirrábicos. II) Devido à localização, deve ser abordada como mordedura grave. III) Se a lesão for grande e estiver limpa, deve ser realizado a sutura da ferida para evitar cicatrização por segunda intenção e comprometimento dos movimentos.

A) Somente as alternativas I e II estão corretas.

B) Somente as alternativas II e III estão corretas.

C) Somente as alternativas I e III estão corretas.

D) Todas as alternativas estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334722)

Enunciado: É inegável o impacto da vacinação em massa na saúde e na expectativa de vida em todo mundo, no entanto, o surgimento de grupos antivacina, usando pseudo-argumentos científicos que se disseminam pela internet é fonte de preocupação para as autoridades sanitárias. Cabe ao médico orientar os pacientes de maneira adequada sobre as diferentes vacinas e seus usos. Qual dessas opções pode corretamente ser repassada aos pacientes?

A) A vacina contra influenza é um exemplo de vacina de vírus atenuado e, portanto, tem uso restrito em pacientes submetidos aos regimes intensivos de quimioterapia para leucemia mielóide aguda.

B) A presença de comorbidades não imunossupressoras, como cardiopatias, pode contra-indicar a aplicação de vacinas de vírus atenuado.

C) O profissional de saúde deve receber algumas vacinas para reduzir o risco de adoecimento e óbito entre seus pacientes; preenchem esses critérios as vacinas contra hepatite B, tríplice viral (MMR - sarampo/caxumba/rubéola) e influenza.

D) São vacinas contra-indicadas em pacientes espenectomizados: BCG, rotavírus, febre amarela, varicela, dengue, HPV e tríplice viral (MMR).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321162)

Enunciado: O câncer de colo do útero é um problema de saúde pública, sendo a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Em relação à vacina contra o HPV implementada no calendário vacinal pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O grupo etário alvo da vacina são as meninas com idade entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos.

B) A vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV.

C) Devem ser tomadas duas doses, com intervalo de seis meses.

D) Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 55 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320433)

Enunciado: ?Agência da ONU atualizou lista de imunizantes indicados para mulheres que esperam bebês e confirma eficácia e segurança das vacinas Coronavac, Bharat Biotech e Novavax. Brasil é citado no documento como exemplo positivo por ter vacinado mais de 1 milhão de grávidas sem que fosse identificada nenhuma preocupação de segurança? - 15 Fevereiro 2022, Saúde <https://news.un.org/pt/story/2022/02/1779802>. A vacinação durante a gestação objetiva não somente a proteção da gestante, mas, também, a proteção do feto. Não há evidências de que, em gestantes, a administração de vacinas de vírus inativados, de bactérias mortas, toxoides e de vacinas constituídas por componentes de agentes acarrete qualquer risco para o feto. Assinale a alternativa correta quanto à vacinação durante o pré-natal:

A) Por considerar os riscos da gestante não vacinada de contrair hepatite B e de haver transmissão vertical, recomenda-se que as gestantes não imunizadas recebam a vacina contra hepatite B.

B) A vacina contra raiva humana é contraindicada durante a gestação e mesmo mulheres em situações de pós-exposição não podem recebê-la.

C) A vacina para sarampo é composta por vírus inativados e, portanto, segura para o uso em gestantes.

D) A vacina para rubéola deve ser administrada para as gestantes no primeiro trimestre para prevenir a síndrome da rubéola congênita.

E) A vacina contra a influenza é recomendada apenas para gestantes com idade gestacional superior a 20 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334733)

Enunciado: Paciente vítima de mordedura humana com arrancamento de cerca de 40% do lábio inferior dá entrada no pronto socorro com sangramento importante e com a porção arrancada acondicionada um recipiente com gelo. Conduta a ser adotada:

A) Limpeza adequada, hemostasia e enxertia total.

B) Limpeza adequada, hemostasia, deixar aberto.

C) Limpeza adequada, hemostasia, sutura por planos.

D) Limpeza adequada, hemostasia e enxertia parcial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346854)

Enunciado: Lucas tem 13 anos e foi levado ao posto de saúde para atualizar sua situação vacinal. A última vacina foi aos 10 anos. A carteira vacinal demonstra já ter recebido duas doses da vacina hepatite B, duas doses da vacina tríplice viral e a última dose da tríplice-bacteriana aos seis anos. Para o caso de Lucas, é CORRETO afirmar que se deve indicar as vacinas:

A) Dupla tipo adulto, hepatite B e HPV.

B) Hepatite B, HPV e meningocócica ACWY.

C) HPV, meningocócica C e dupla tipo adulto.

D) Hepatite B, meningocócica C e dupla tipo adulto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346855)

Enunciado: Inês é um bebê saudável de 6 meses de vida. Ao examinar a criança, o pediatra nota a ausência da cicatriz vacinal da BCG. Nesse caso, de acordo com a recomendação proposta pelo Ministério da Saúde, assinale a conduta CORRETA:

A) Deve-se solicitar um PPD.

B) Não há necessidade de repetir a vacina.

C) A ausência de cicatriz vacinal é certeza que a criança não está imunizada.

D) Até o sexto mês de vida, a criança poderá ser revacinada, sem a necessidade de PPD anterior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320442)

Enunciado: A prevenção de doenças infecciosas no neonato pode ser obtida pela transferência de anticorpos maternos através da vacinação da gestante. Essa estratégia é preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil nas seguintes doenças imunopreveníveis:

A) Hepatite B, coqueluche e meningite C.

B) Tétano neonatal, coqueluche e diarreia por rotavírus.

C) Tétano neonatal, coqueluche e meningite B.

D) Influenza, doença pneumocócica e hepatite B.

E) Influenza, coqueluche e tétano neonatal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

335092)

Enunciado: Com relação às vacinas durante a gestação, assinale a alternativa correta.

A) A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações, independentemente de já ter sido realizada em gestações anteriores.

B) A vacinação da gripe (influenza) está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, mas apenas no terceiro trimestre de gestação.

C) As pacientes não imunizadas devem ser orientadas a tomar a vacina da rubéola, da caxumba e do sarampo (tríplice viral) no segundo ou terceiro trimestre da gestação.

D) A vacina contra febre amarela normalmente é indicada na gestação ou no puerpério, em dose única.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336284)

Enunciado: A identificação precoce da dislipidemia, associada a mudança no estilo de vida e ao tratamento medicamentoso pode atenuar o risco cardiovascular na vida adulta. Assim, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, deveremos realizar a triagem lipídica nas crianças e adolescentes :

A) Entre 12-16 anos de idade, independente de fatores de risco, pois há influência de fatores hormonais da puberdade no aparecimento das dislipidemias.

B) Todas as crianças a partir dos 9 anos até 11 anos de idade, se anteriormente não houve identificação de qualquer fator de risco (familiar ou inerente a criança) que possa justificar sua triagem antecipada.

C) A partir de 2 anos de idade quando identificado fator de risco como obesidade e HAS em apenas um ou nos dois progenitores.

D) A partir de 4 anos de idade, pois nesta idade as crianças já ingerem quase todos os tipos de alimentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346871)

Enunciado: São doenças passíveis de serem prevenidas com a vacinação, EXCETO:

A) Poliomielite.

B) Febre amarela.

C) Hepatite C.

D) Coqueluche.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334763)

Enunciado: Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Na vacinação da criança e do adolescente é correto afirmar:

A) Crianças que não apresentarem cicatriz vacinal após receberem a dose da vacina BCG precisam ser revacinadas.

B) A idade mínima para a administração da primeira dose da vacina para rotavírus é de 1 mês e a máxima de 2 anos.

C) A recomendação de vacinação contra a febre amarela é para regiões endêmicas do Brasil. Deve ser administrada 1 (uma) dose única em maiores de 6 meses.

D) A vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de 7 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

306713)

Enunciado: O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) a partir de 2014, ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente essa vacina é aplicada em:

A) Meninas e adolescentes, entre 9 e 12 anos de idade, meninos e adolescentes entre 10 e 13 anos.

B) Meninas e adolescentes, entre 8 e 12 anos de idade, meninos e adolescentes entre 9 e 12 anos.

C) Meninas e adolescentes, entre 10 e 16 anos de idade, meninos e adolescentes entre 12 e 15 anos.

D) Meninas e adolescentes, entre 9 e 14 anos de idade, meninos e adolescentes entre 11 e 14 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291938)

Enunciado: Mãe leva filho de 5 meses para atualização do cartão vacinal. A mãe alega que o filho recebeu as vacinas necessárias quando nasceu, porém, desde então por problemas pessoais não pode levar o filho para realização das demais vacinas. Ao exame físico é observada cicatriz de BCG. É CORRETO afirmar que as vacinas a serem realizadas nesse paciente são:

A) Pentavalente (1a e 2a dose), vacina injetável do poliovírus inativado (1a e 2a dose), vacina oral do rotavírus humano (1a e 2a dose), pneumocócica 10-valente conjugada (1a e 2a dose) e meningocócita C conjugada (1a e 2a dose), com no mínimo 15 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose de todas as vacinas.

B) Pentavalente (1a, 2a e 3a dose), vacina injetável do poliovírus inativado (1a e 2a dose), vacina oral do rotavírus humano (1a e 2a dose), Pneumocócica 10-valente conjugada (1a e 2a dose) e meningocócita C conjugada (1a e 2a dose), com no mínimo 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose de todas as vacinas.

C) Pentavalente (1a, 2a e 3a dose), vacina injetável do poliovírus inativado (1a e 2a dose), vacina oral do rotavírus humano (1a e 2a dose), pneumocócica 10-valente conjugada (1a e 2a dose) e meningocócita C conjugada (1a e 2a dose), com no mínimo 15 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose de todas as vacinas.

D) Pentavalente (1a e 2a dose), vacina injetável do poliovírus inativado (1a e 2a dose), pneumocócica 10-valente conjugada (1a e 2a dose) e meningocócita C conjugada (1a e 2a dose), com no mínimo 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose de todas as vacinas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304877)

Enunciado: Felipe, 8 meses de idade, natural de Lauro de Freitas (BA), mudou-se para Vitória há 1 mês e foi encaminhado para consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde de Maruípe pela agente comunitária. Durante a consulta, ao avaliar o cartão de vacina, observa-se que estão confirmadas as seguintes vacinas: BCG (dose única ao nascimento), hepatite B (dose ao nascimento), pentavalente (1ª e 2ª doses), rotavírus (1ª e 2ª doses), pneumocócica 10 valente (1ª e 2ª doses), meningocócica C (1ª dose), VIP: Poliomielite injetável (1ª e 2ª doses). Quais vacinas estão indicadas para Felipe no momento desta consulta, segundo o Programa Nacional de Imunizações atual?

A) Pneumocócica 10-valente, VIP, Meningocócica C, Influenza.

B) Meningocócica C e Influenza.

C) Pentavalente, VIP e Pneumocócica 10-valente.

D) Pentavalente, VIP, Meningócica C, influenza.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291956)

Enunciado: A tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. São ações de vigilância epidemiológica para a tuberculose, EXCETO:

A) Definição, investigação do caso e notificação.

B) Acompanhamento e encerramento dos casos.

C) Exame e tratamento profilático de todos os contatos.

D) Visita domiciliar a caso novo e convocação de faltosos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

257360)

Enunciado: A imunização é um dos investimentos mais efetivos em saúde pública. O Programa Nacional de Imunização (PNI) é considerado um dos mais eficientes do mundo. Em relação as vacinas, é INCORRETO afirmar que:

A) A BCG é administrada em dose única atualmente no país.

B) A vacina de febre amarela deve ser aplicada após 12 meses de contração da doença.

C) A vacina de pólio oferecida nos primeiros meses (2, 4 e 6 meses) é a forma inativada.

D) A idade máxima para aplicação da última dose de rotavírus é 7 meses e 29 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287349)

Enunciado: Criança de 12 meses, parto normal, a termo, com peso de 2.300g, comprimento 48cm e perímetro cefálico de 34cm, a mãe era primípara e havia ganhado apenas 7Kg durante a gestação, foi atendida na Unidade Básica de Saúde. No exame físico ela estava com 10kg (peso para idade - escore 0 a +2) e 78cm (comprimento para idade - escore 0 a +2), ativo, emitindo palavras (mamâ, papá), ficando de pé com apoio, sem andar. Bom apetite, sono tranquilo (raramente acorda à noite). Sua alimentação é composta de leite materno (3 a 4x/dia), frutas (2 x/dia) e come comida da casa (de tudo com pouco sal, mas variada e balanceada) no almoço e jantar. Como devemos orientar a mãe quanto ao desenvolvimento dessa criança?

A) Informar que a criança está obesa e deve ser reduzida a alimentação.

B) Informar que a criança está com o peso e desenvolvimento normal.

C) Informar que a criança está abaixo do peso e aumentar o uso de óleo na alimentação.

D) Informar que a criança está abaixo do peso e trocar o aleitamento materno da noite por leite de vaca, pois assim terá controle da quantidade que a criança ingeriu de leite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287865)

Enunciado: Considerando-se o Calendário de Vacinação da Criança, sobre as vacinas e as doenças evitadas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: (1) Pentavalente. (2) VIP. (3) VORH. ( ) Poliomielite (paralisia infantil). ( ) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. ( ) Diarreia por Rotavírus.

A) 1 - 2 - 3.

B) 3 - 2 - 1.

C) 2 - 3 - 1.

D) 2 - 1 - 3.

E) 1 - 3 - 2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287866)

Enunciado: Em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinação (PNI) 2020, sobre a vacina febre amarela (atenuada), assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: A vacina febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a maioria das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo, exceto com as vacinas _____ ou _____, em crianças menores de dois anos de idade.

A) tríplice viral | tetra viral

B) BCG | hepatite B

C) penta | poliomielite

D) meningocócica C | dupla adulto

E) papilomavírus humano | influenza

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287900)

Enunciado: De acordo com DUNCAN, et al., a obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de peso. Tem etiologia multifatorial, difícil manejo e costuma ser causada pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Em relação ao excesso de peso em crianças, analisar a sentença abaixo: Alguns fatores têm associação comprovada com excesso de peso de causa exógena na infância. São eles: ausência ou interrupção precoce do aleitamento materno; alimentação complementar inapropriada; uso de fórmulas lácteas com diluição incorreta; ingestão excessiva de proteínas no primeiro ano de vida; distúrbios do comportamento alimentar; e problemas familiares (1ª parte). O excesso de peso (obesidade e sobrepeso) é uma importante preocupação de saúde pública devido à associação com aumento de risco para hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença coronariana, osteoartrite, anormalidades lipídicas, doença da vesícula biliar e alguns tipos de câncer (2ª parte). A criança com excesso de peso, em geral, é sedentária, causando prejuízo para diversos componentes da aptidão física, como potência aeróbica, força muscular, flexibilidade e composição corporal (3ª parte). A sentença está:

A) Totalmente correta.

B) Correta somente em sua 3ª parte.

C) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.

D) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

E) Totalmente incorreta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255624)

Enunciado: Em relação ao calendário vacinal preconizado para crianças e adolescentes hígidos, MARQUE A CORRETA:

A) É recomendada uma dose da vacina contra a febre amarela a partir dos 12 meses, para residentes ou viajantes para áreas com recomendação à vacina.

B) Aos 12 meses, é recomendada a vacinação contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela, e uma segunda dose aos 15 meses.

C) A primeira dose da vacina contra Hepatite B é idealmente aplicada aos 2 meses.

D) É recomendada a revacinação da BCG (Tuberculose) em crianças que não apresentem a cicatriz no local de aplicação após 6 meses da vacinação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232113)

Enunciado: Como se dá a disseminação do vírus rábico no organismo a partir do ponto de inoculação?

A) O vírus penetra no organismo quando atinge as extremidades e, devido à característica da vascularização, facilita sua disseminação hematogênica em direção ao sistema nervoso central.

B) Após a penetração na pele, o vírus se dissemina por via hematogênica, desenvolve-se em até 4 dias e, após atingir as meninges, desenvolve o quadro clássico da encefalite rábica.

C) A doença evolui de forma lenta, considerando a capacidade de replicação viral a partir do ponto de inoculação, por via linfática e hematogênica, assim, podendo o indivíduo eliminar de forma contínua o vírus através das glândulas salivares.

D) O vírus rábico se dissemina, preferentemente por via nervosa e, nos casos de pacientes imunocomprometidos as vias hematogênica e linfática podem auxiliar na disseminação viral.

E) O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central, quando se dissemina para vários órgãos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227095)

Enunciado: A vacinação foi profundamente eficiente na prevenção de doenças graves. Em relação ao calendário de vacinação praticado no SUS, é INCORRETO afirmar que:

A) A vacina contra Haemophilus (Hib) deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida.

B) O recém-nascido de baixo peso, com peso inferior a 2.500 g, não deverá tomar vacina BCG até chegar no peso de 2.500 g.

C) A vacina para varicela é recomendada no calendário após 15 meses de vida.

D) A vacina para HPV está liberada para meninos pelo SUS.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234427)

Enunciado: Em relação ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, é CORRETO afirmar que:

A) A vacina BCG deverá ser aplicada logo após o nascimento nas crianças nascidas saudáveis, com peso acima de 2kg, até a idade de 4 anos 11 meses e 29 dias. Caso após 6 meses da aplicação não se observe cicatriz ou nodulação no local da aplicação, a criança deverá receber uma outra dose.

B) A vacina de Rotavírus Humano G1P1(8), atenuada deverá ser aplicada em duas doses em crianças saudáveis da seguinte forma: 1ª dose: 2 meses de vida. Poderá, se necessário, ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. 2ª dose: 4 meses de vida. Se necessário poderá ser administrada a partir dos 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias.

C) De acordo com o contexto epidemiológico do momento as vacinas tríplice viral e febre amarela poderão ser aplicadas simultaneamente em crianças menores de 2 anos.

D) A vacina Papilovírus Humano (HPV) 6,11,16,18 está indicada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 12 a 13 anos, desde que não apresentem nenhuma imunodeficiência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227271)

Enunciado: A vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa) deve obedecer a seguinte recomendação na gestação:

A) Realizar a cada 05 anos a dTpa em gestantes previamente vacinada com esquema completo de dT (difteria e tétano).

B) Se o esquema de vacina dupla do tipo adulto (dT) estiver completo a gestante deve receber dTpa em todas as gestações à partir de 20 semanas.

C) Gestante vacinada com 1 dose de vacina dT e 2 doses de vacina dTpa na última gestação há menos de 05 anos não precisa receber dTpa na gravidez atual.

D) Se a gestante não for vacinada com dTpa na gestação atual, deve aguardar a próxima gravidez para vacinar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243022)

Enunciado: Escolar portadora de lúpus, em uso de corticoide oral em dose > 2mg/ kg/dia, perdeu o cartão vacinal e precisa atualizá-lo. Não tem cicatriz de BCG visível. Em relação a vacinação dessa criança, é CORRETO afirmar que:

A) não aplicar tetraviral e febre amarela até interromper o tratamento por pelo menos um mês.

B) aplicar vacina BCG pelo risco maior de desenvolver tuberculose.

C) aplicar tríplice bacteriana e tríplice viral a qualquer momento da terapia.

D) aplicar todas as vacinas, pois o uso de corticoide nessa dosagem não é contraindicação.

E) aplicar tetraviral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243030)

Enunciado: São vacinas que podem ser administradas em pacientes que estão recebendo tratamento quimioterápico e, portanto, são imunossuprimidos, EXCETO:

A) DT (difteria e tétano)

B) vacina contra o Pneumococo

C) BCG

D) vacina contra o HPV

E) vacina meningocócica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246394)

Enunciado: Assinale a alternativa que contém uma condição favorável para o aparecimento de surtos de febre amarela em uma região:

A) Intenso deslocamento de pessoas entre diferentes países, principalmente de avião.

B) Clima seco, com baixa pluviosidade, e frio o que estimulam a reprodução do vetor.

C) Presença de primatas infectados que podem transmitir diretamente a doença ao homem.

D) Baixa cobertura vacinal da população residente nas áreas endêmicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246803)

Enunciado: A criança com escorbuto chora ao ser manipulada. Isso se deve à presença de:

A) hemorragia subperióstea

B) periostite

C) fratura óssea espontânea

D) osteogênese imperfeita

E) osteoporose

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199568)

Enunciado: Homem de 51 anos de idade foi vítima de mordedura de gato com feridas corto-contusas em mão esquerda. O animal reside em domicílio do paciente (apartamento), em área urbana e encontra-se com histórico vacinal completo. Em relação à profilaxia da raiva humana com vacina de cultivo celular, assinale a alternativa CORRETA para o caso clínico exposto.

A) Deve ser iniciado esquema profilático com uma dose da vacina, manter o animal em vigilância e, caso manifeste sintomas de raiva, completar as cinco doses da vacina.

B) Deve ser iniciado esquema profilático com cinco doses da vacina independentemente de observação do animal agressor.

C) Paciente não deve ser vacinado e o animal agressor deve ficar sob vigilância por 10 dias para sintomas de raiva.

D) Iniciar profilaxia com soro antirrábico e cinco doses de vacina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202747)

Enunciado: A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. A doença caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Qual o período de transmissibilidade da raiva, considerando a espécie do animal agressor?

A) No morcego a transmissibilidade se dá após o terceiro dia da mordedura, por isso se recomenda a vacinação em todos os casos de agressão.

B) A transmissibilidade é indefinida, o que se avalia é o período de incubação da doença que é de aproximadamente 10 dias, período em que se observa o animal.

C) Nos roedores a transmissibilidade ocorre a partir do momento em que houver a agressão, em especial o rato de esgoto, pela elevada infectividade.

D) Os animais de interesse econômico, principalmente bovídeos e equídeos, não transmitem a doença devido ao sistema imune dos mesmos impedirem a replicação viral a partir do ponto de inoculação.

E) Nos cães e gatos a transmissibilidade se dá após a eliminação de vírus pela saliva do animal, de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, e persiste durante toda a evolução da doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199501)

Enunciado: A raiva é uma zoonose transmitida, principalmente, pela mordedura de animais infectados pelo vírus rábico. Sobre a raiva, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A vacina antirrábica humana induz o aparecimento de anticorpos em 24h atingindo nível máximo em aproximadamente 72 horas.

B) A eliminação de vírus na saliva, no cão e no gato, inicia-se três a cinco dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas.

C) O soro antirrábico é uma solução purificada de imunoglobulina específica e a aplicação, quando indicada, deve ser imediata.

D) Os ferimentos nas mãos são classificados como acidentes graves e o tratamento deve ser iniciado com vacina antirrábica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199502)

Enunciado: Desde 2013, a cobertura de vacinação para doenças como caxumba, sarampo e rubéola vem caindo ano a ano em todo o país e ameaça criar bolsões de pessoas suscetíveis a doenças antigas, mas fatais. O desabastecimento de vacinas essenciais, municípios com menos recursos para gerir programas de imunização e pais que se recusam a vacinar seus filhos são alguns dos fatores que podem estar por trás da drástica queda nas taxas de vacinação do país. Em relação à imunização no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A vacina BCG intradérmica é constituída de bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis.

B) A vacina tríplice viral não deve ser aplicada em pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida.

C) A primeira dose da vacina rotavírus pode ser feita a partir de 6 semanas de vida e não pode ser administrada concomitantemente com a vacina meningocócica C.

D) O intervalo mínimo entre as doses da vacina rotavírus é de 30 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199554)

Enunciado: Qual das vacinas abaixo não tem contraindicação na gravidez?

A) Sarampo.

B) Caxumba.

C) Varicela.

D) Raiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

220300)

Enunciado: A respeito da vacina BCG, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O tempo de evolução da lesão vacinal é de 6 a 12 semanas, mas pode prolongar por até 24 semanas.

B) Para recém-nascidos com peso inferior a 2 quilos, está contraindicada a vacina.

C) Para o aparecimento de enfartamento ganglionar homolateral à aplicação, móvel, indolor e único em região axilar, está indicado o uso da isoniazida.

D) As imunodeficiências congênitas e adquiridas contraindicam a vacinação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212927)

Enunciado: São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de obesidade na infância, exceto:

A) Obesidade materna.

B) Desmame precoce.

C) Introdução inadequada da alimentação complementar.

D) Uso de leite de vaca antes de 1 ano de idade.

E) Sexo feminino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196802)

Enunciado: A obesidade é doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta de balanço energético positivo que está comprometendo a saúde infantil. Analise as proposições em relação ao tratamento da obesidade na infância e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. ( ) Prevenir a obesidade na infância é a maneira mais segura de controlar essa doença crônica, que pode se iniciar já na vida intra-uterina. ( ) Limitar o tempo de laser passivo a no máximo quatro horas por dia, controlando os horários de televisão e computador e videogame. ( )Estimular o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e o aleitamento materno total de preferência até os dois anos de idade. ( ) Alimentos diet e light podem ser usados rotineiramente com o objetivo de redução calórica. ( ) Deve-se estimular o consumo de mais de cinco porções de frutas e hortaliças para adolescentes. Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

A) F ? V ? V ? F ? V

B) V ? F ? V ? V ? F

C) F ? V ? V ? V ? F

D) V ? F ? V ? F ? V

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212931)

Enunciado: O excesso de zinco diminui a biodisponibilidade de qual nutriente?

A) Ferro.

B) Cobre.

C) Manganês.

D) Magnésio.

E) Selênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212945)

Enunciado: Sobre a vacinação em prematuros, é correto afirmar, exceto:

A) Com exceção da vacina BCG, o calendário proposto para recém-nascido pré-termo deve ser seguido de acordo com a idade cronológica da criança.

B) As vacinas que contém vírus vivos (pólio oral e rotavírus) são contraindicadas em ambiente hospitalar, pelo risco teórico de disseminação do vírus vacinal no ambiente.

C) Prematuros apresentam, ao nascer, níveis séricos de anticorpos semelhantes ao de bebês nascidos a termo.

D) Preferencialmente os prematuros devem receber vacinas acelulares contra a coqueluche, pelo menor risco de eventos adversos.

E) A vacinação deve ser adiada se o recém-nascido apresentar condições hemodinâmicas instáveis, sepse, distúrbios infecciosos ou metabólicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199617)

Enunciado: Um lactente de 13 meses, foi atendido ambulatorialmente há 2 dias, e está recebendo salbutamol com inalador dosimetrado e prednisona 1 mg/kg/dia, devido a broncoespasmo. Seu esquema de vacinações foi atualizado há um mês, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Seu primo, com quem brincou durante várias horas, há um dia, na casa da avó, apresentou vesículas de varicela hoje. Além de não ter contato com o primo, até que a última vesícula se transforme em crosta, o lactente deve receber o mais rapidamente possível:

A) Vacina e imunoglobulina hiperimune contra varicela.

B) Imunoglobulina hiperimune contra varicela.

C) Vacina contra varicela.

D) Aciclovir oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196765)

Enunciado: Gestante apresentando quadro de tosse crônica há cerca de 2 meses, tendo sido diagnosticada com tuberculose pulmonar logo após entrar em trabalho de parto, iniciando a terapia adequada imediatamente após o parto. Diante do exposto, qual a melhor conduta a ser tomada em relação ao recém-nascido:

A) investigar tuberculose congênita, tratar se positivo; caso contrário, não vacinar, administrar isoniazida por 3 meses, quando deve-se realizar o teste tuberculínico

B) investigar tuberculose congênita, tratar se positivo; caso contrário, administrar a vacina BCG e realizar o teste tuberculínico aos 3 meses de idade

C) administrar isoniazida por 6 meses e, em seguida, realizar o teste tuberculínico

D) administrar isoniazida apenas de houver sintomas no recém-nascido; caso contrário acompanhar no ambulatório de pediatria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199582)

Enunciado: Com relação à obesidade na infância e adolescência, podemos afirmar que:

A) Durante a infância e adolescência define-se obesidade quando o IMC (Índice de Massa Corporal) é igual ou maior do que 25.

B) A obesidade em humanos é determinada por fatores genéticos que influenciam no apetite, na ingestão calórica e no gasto energético.

C) As síndromes de Prader-Willi e Williams-Beuren têm como componente a obesidade.

D) Crianças com 2 anos ou mais atingem o critério de obesidade quando o IMC é igual ou maior do que o 95º percentil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215144)

Enunciado: Lactente de 7 meses, saudável, comparece em consulta pediátrica de rotina e seu cartão de vacinação indicava a administração das seguintes vacinas: BCG; hepatite B, 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; VOP (antipoliomielite oral), 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; DPT + hemófilos B 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; VORH (antirrotavírus), 1.a dose. Conforme o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil. Pode-se afirmar que:

A) Essa criança deveria receber nessa ocasião a segunda dose da VORH e a primeira dose da vacina antipneumocócica 23 valente.

B) A imunização do lactente está em dia e não necessita de novas vacina até os 2 anos de idade.

C) O lactente deve receber as 4ª doses das vacinas de hepatite B e DPT + hemófilos B.

D) Antes de programar continuação das imunizações, aos 7 meses o lactente deve ser testado para reações alérgicas aos componentes das vacinas.

E) Essa criança deveria receber nessa ocasião a primeira dose da vacina de hepatite C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174381)

Enunciado: As vacinas podem produzir efeitos adversos e, dentre as afirmações abaixo, a única que se apresenta correta é:

A) A vacina DPT (difteria, pertussis e tétano) pode provocar a síndrome hipotônica-hiporresponsiva.

B) Na vacinação com BCG, está indicado o uso da isoniazida na presença de linfonodo axilar.

C) A vacina contra febre amarela pode ser aplicada em gestantes, pois é composta por vírus inativados.

D) A vacina de pólio oral (VPO) está sendo substituída pela vacina injetável (VPI), pelo risco de convulsão.

E) A vacina de pólio oral (VOP) está sendo substituída pela vacina injetável (VPI), para diminuir custo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

188016)

Enunciado: Lactente de 1 ano de idade é levado ao Pronto Socorro Infantil com relato de hematomas e sangramento gengival, além de importante dor à manipulação de membros inferiores. Alimenta-se exclusivamente de leite de vaca com engrossante. Além das alterações descritas anteriormente, ao exame físico a criança evita movimentar-se e apresenta palidez cutânea importante e petéquias perifoliculares. Qual é o distúrbio nutricional?

A) Raquitismo.

B) Pelagra.

C) Beribéri.

D) Escorbuto.

E) Kwashiorkor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187452)

Enunciado: De acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, uma criança do sexo masculino, com 6 anos e 5 meses de idade, com índice de massa corpórea (IMC) entre o escore Z + 1 e + 2 é classificada como:

A) Risco de sobrepeso.

B) Eutrofia.

C) Sobrepeso.

D) Obesa.

E) Magreza.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187478)

Enunciado: Uma criança de 3 anos sofreu um acidente e apresenta ferimentos extensos, profundos e sujos em membros inferiores. Seu calendário vacinal está em dia. Além da limpeza das lesões, qual a conduta profilática correta?

A) Uma dose de reforço de vacina antitetânica e uma dose de soro antitetânico.

B) Uma dose de reforço de vacina antitetânica e uma dose de gamaglobulina antitetânica.

C) Reforço com a vacina DTP imediato.

D) Reforço com a vacina DTP entre 4 e 6 anos.

E) Uma dose de gamaglobulina antitetânica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172538)

Enunciado: Mulher de 24 anos, GIP0A0, 38 semanas pela data da ultima menstruação, da entrada na maternidade com dor abdominal e saída de secreção mucossanguinolenta. Ao exame obstétrico observou se inicio de trabalho de parto (bolsa integra, colo uterino com 4 cm de dilatação). Nos exames do primeiro trimestre pré natal, paciente apresenta sorologias negativas, sorologias do terceiro trimestre mantém se negativas, exceto HBsAg positivo, Anti-HBcAg IgM positivo, HBeAg positivo e Anti-HBs negativo. Podemos afirmar:

A) Neste caso, há indicação, imediatamente pós parto, de iniciar Lamivudina (3TC) para o RN;

B) O aleitamento materno é contra indicado, devido a presença do vírus no leite materno;

C) Trata se de um RN com risco aumentado de infecção, indicado Vacina contra Hepatite B, nas primeiras 12 h de vida e Imunoglobulina Humana anti-Hepatite B;

D) Mãe HBsAg positivo e Anti HBs negativo evidencia proteção para a mãe e para o RN, não sendo necessário nenhum cuidado alem da vacina contra Hepatite B nas primeiras 12 h de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172560)

Enunciado: Pela OMS, obesidade é definida como ?doença na qual existe uma acumulação excessiva de massa gorda, de tal forma que a saúde pode ser adversamente afetada?. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2015) mostrou que 25,1% dos adolescentes de 13 a 15 anos e 21,4% de 16 a 17 anos apresentam excesso de peso. Sobre essa doença podemos afirmar, exceto:

A) Excesso de ganho de peso na gestação e diabetes implicam em maior peso no nascimento, rápido ganho de peso pós-natal e maior adiposidade com risco de obesidade na infância e adolescência (PROGRAMAÇÃO FETAL);

B) Crianças que apresentam restrição de crescimento intra-uterino, que nascem pequenas para a idade gestacional e apresentam rápido ganho de peso pós-natal, tem maior risco de desenvolver obesidade e síndrome metabólica (TEORIA DO FENOTIPO POUPADOR);

C) O excesso de peso na infância e adolescência é considerado uma variável preditora de sobrepeso no adulto;

D) Aleitamento materno exclusivo ate 4 meses diminui o risco de obesidade em até 50%, e essa proteção é dose dependente, ou seja, quanto maior o tempo de aleitamento, menor o risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172768)

Enunciado: "A obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta de balanço energético positivo. O seu desenvolvimento ocorre, na maioria dos casos, pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais". "Os exames subsidiários podem ser utilizados para obtenção de dados mais precisos sobre a composição corporal, para investigação de possíveis causas da obesidade e para diagnóstico das repercussões metabólicas mais comuns da obesidade" (Obesidade na infância e adolescência - Manual de Orientação / Sociedade Brasileira de Pediatria). Assinale a alternativa correta com relação aos exames subsidiários sugeridos na avaliação inicial de crianças e adolescentes obesos, sem comorbidades:

A) Glicemia de jejum, perfil sérico lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos) e aminotransferases.

B) Glicemia de jejum, insulinemia, perfil sérico lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos) e aminotransferases.

C) Glicemia de jejum, perfil sérico lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos), aminotransferases, fosfatase alcalina e gama-GT.

D) Glicemia de jejum, insulinemia, perfil sérico lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155399)

Enunciado: Homem foi admitido no hospital com tétano acidental generalizado. Neste caso, é CORRETO afirmar que:

A) Os tempos de incubação e de progressão têm valor apenas epidemiológico.

B) O sulfato de magnésio deve ser usado com objetivo de reduzir as doses de benzodiazepínicos e bloqueadores neuromusculares.

C) A sedação deve ser guiada apenas pelo nível de consciência, de modo a evitar intubação precoce em paciente sem pneumonia.

D) A disautonomia usualmente instala-se nos dois primeiros dias de progressão, e a morfina é droga de escolha no controle.

E) No tétano generalizado não há necessidade de tratamento antibiótico específico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162597)

Enunciado: Qual vacina é contraindicada a pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA)?

A) Influenza.

B) Pneumococo.

C) Tétano/Difteria.

D) Varicela.

E) Hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162526)

Enunciado: Considere um paciente com ferimentos superficiais, limpos, sem corpos estranhos ou tecidos desvitalizados e as seguintes histórias de vacinação prévia contra tétano: I. 3 ou mais doses, sendo a última dose há menos de 5 anos; II. 3 ou mais doses, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos; III. 3 ou mais doses, sendo a última dose há 10 anos ou mais. É CORRETO afirmar que a vacinação antitetânica está indicada em:

A) I, II e III.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) III, apenas.

E) nenhuma delas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155469)

Enunciado: Lactente desnutrido de 16 meses, pesando 9,0 kg e medindo 69 cm, é atendido no setor de emergência. Ao exame apresenta prostração, gemência, letargia, taquipnéia, edema moderado de membros inferiores, boa perfusão periférica e estertores crepitantes finos na base pulmonar direita. Exames laboratoriais: Na: 125 mEq/L; K: 3 mEq/L; albumina: 2,9 g/dL e Hb: 9,7 g/dL. A prioridade para o tratamento é:

A) Infundir 20 ml/kg de concentrado de hemácias lavadas.

B) Corrigir o sódio sérico para 130 mEq/L com cloreto de sódio a 3%.

C) Corrigir a hipoalbuminemia para 3,5 g/dL com infusão de 2 unidades de albumina.

D) Iniciar nutrição parenteral total em veia profunda corrigindo as carências encontradas.

E) Iniciar antibioticoterapia parenteral com associação de amplo espectro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162551)

Enunciado: Gestante HBsAg positiva e HBeAg positiva está em pródromos de trabalho de parto. Visando evitar a transmissão vertical do vírus, o que deve ser feito, em relação à vacina para Hepatite B?

A) Vacinar imediatamente a gestante.

B) Vacinar a criança preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto.

C) Vacinar a mãe 6 horas antes do parto e a criança preferencialmente até 24 horas após o parto.

D) Nada, pois com esse resultado de sorologia não há risco para a criança.

E) Vacinar a mãe 10 horas antes do parto e a criança preferencialmente na primeira semana de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148556)

Enunciado: A prescrição da vacina anti-tetânica no pré-natal de uma gestante submetida ao esquema completo de vacinação contra o tétano há 7 anos deve ser:

A) Administrar de 3 doses com intervalo de 8 semanas.

B) Administrar, pelo menos, 2 doses antes do nascimento.

C) Administrar uma dose de reforço antes do nascimento.

D) Administrar o soro anti-tetânico após o nascimento.

E) Considerar a paciente protegida e nada fazer.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131664)

Enunciado: Diante de uma lactente com raquitismo por deficiência de vitamina D, comumente as dosagens séricas de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina, mostrarão:

A) Hipercalcemia, hipofosfatemia e fosfatase alcalina elevada.

B) Hipocalcemia, hiperfosfatemia e fosfatase alcalina normal.

C) Normocalcemia, hipofosfatemia e fosfatase alcalina elevada.

D) Normocalcemia, hipofosfatemia e fosfatase alcalina normal.

E) Hipocalcemia, hiperfosfatemia e fosfatase alcalina elevada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127207)

Enunciado: Nas deficiências de vitaminas, é CORRETO afirmar:

A) A deficiência de vitamina A pode causar manifestações hemorrágicas.

B) A deficiência de vitamina D pode levar a ceratomalácia levando a cegueira.

C) A deficiência de vitamina K pode causar raquitismo.

D) A deficiência de vitamina E pode levar a polineurite, a insuficiência cardíaca e manifestações hemorrágicas.

E) A deficiência de vitamina B1 pode levar ao beribéri.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131689)

Enunciado: Hipovitaminoses são comuns na população pediátrica. Dentre as vitaminas citadas abaixo, qual não é considerada lipossolúvel?

A) Vitamina A.

B) Vitamina C.

C) Vitamina D.

D) Vitamina E.

E) Vitamina K.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106410)

Enunciado: Assinale a alternativa correta. O craneotabes é um sinal precoce de:

A) pelagra.

B) beribéri.

C) escorbuto.

D) raquitismo.

E) Kwashiorkor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

77331)

Enunciado: Marque a alternativa errada:

A) No Brasil, estima-se que até 50% dos lactentes têm anemia ferropriva.

B) A deficiência de vitamina A é responsável por 1 milhão de mortes por ano e afeta 40 - 60% dos pré-escolares em países em desenvolvimento.

C) O ferro ajuda na defesa contra infecções e no desenvolvimento motor e cognitivo.

D) A deficiência de zinco pode causar infecções, perda de peso e cegueira noturna.

E) O consumo de sal de iodado isoladamente não supre as necessidades diárias recomendadas deste elemento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88927)

Enunciado: Segundo o método de Waterlow, modificado por Batista, o estado nutricional de um pré-escolar com peso/altura atual = 89% do peso/altura desejados e altura/idade = 92% da ideal para pré-escolares do mesmo gênero e idade, classifica-se como:

A) Desnutrição aguda.

B) Subnutrição.

C) Desnutrição pregressa.

D) Desnutrição crônica.

E) Eutrofia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

43976)

Enunciado: Em relação à obesidade na infância e adolescência, observe as assertivas abaixo e depois responda o correto: I. Embora a obesidade da infância não seja obrigatoriamente acompanhada de obesidade na vida adulta, os fatores determinantes costumam estar, também, presentes ao término do crescimento, o que justifica a vigilância e intervenção feitas pelo pediatra. II. Diante de uma criança em idade escolar ou adolescente, cujo Índice de Massa Corpórea (IMC) esteja no P97, é importante verificar a história familiar, a rotina e hábitos de vida, que incluem a rotina alimentar da família, sem nos esquecermos do perfil lipídico e da glicemia de jejum. III. O IMC, por ser prático, suprime a necessidade de exame físico detalhado, sendo a balança e o antropômetro os instrumentos necessários para acompanhamento de um indivíduo obeso na faixa de atenção pediátrica. IV. Mesmo considerando o aumento da obesidade nas faixas etárias abrangidas pela pediatria, a resistência insulínica nunca está presente nestes pacientes.

A) Todas as assertivas estão corretas.

B) Somente as assertivas I e II estão corretas.

C) Somente as assertivas II e IV estão corretas.

D) Somente as assertivas I e III estão corretas.

E) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32497)

Enunciado: É expressivo o aumento da prevalência de obesidade na faixa etária pediátrica, concomitante ao incremento significativo de morbidades associadas à doença nesta idade, tais como:

A) Síndrome metabólica, Hipertensão arterial e Síndrome da apneia do sono.

B) Dislipidemia, Genu varum, Esteatose hepática.

C) Diabetes Mellitus tipo 1, Insuficiência venosa, Dislipidemia.

D) Acanthosis nigrians, Infarto agudo do miocárdio, Síndrome do ovário policístico.

E) Acidente Vascular Cerebral, Refluxo gastroesofágico, Estrias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

23084)

Enunciado: A causa mais comum de obesidade na infância e adolescência é:

A) Hipotireoidismo.

B) Síndrome de Cushing.

C) Síndrome de Prader-Willi.

D) Obesidade exógena.

E) Síndrome de Sotos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9424)

Enunciado: NÃO é uma característica da desnutrição na forma de Kwashiorkor:

A) Albumina sérica baixa.

B) Gordura subcutânea ausente.

C) Esteatose hepática e hepatomegalia.

D) Anasarca.

E) Diminuição acentuada do apetite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9428)

Enunciado: NÃO está associada à obesidade na infância e adolescência:

A) Proteinúria.

B) Discriminação na vida social.

C) Infertilidade.

D) Atraso na puberdade.

E) Maior risco de diabetes tipo 2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8091)

Enunciado: A respeito da desnutrição energético-proteica, é correto afirmar:

A) O baixo peso ao nascer não é um bom indicador de risco de desnutrição materno-fetal, pois sofre a influência de fatores genéticos.

B) O Índice de Massa Corporal não deve ser utilizado como indicador em adultos porque sofre influência do perfil de estatura da população.

C) A mortalidade na faixa etária escolar é considerada um indicador desprovido de fatores de confusão.

D) O peso, mas não a altura, de crianças que atingem a idade escolar configura-se como um indicador adequado de seu estado nutricional.

E) Houve um declínio acentuado na prevalência de desnutrição energético-proteica no Brasil nas últimas 3 décadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8095)

Enunciado: Pode se desenvolver na recuperação nutricional do desnutrido grave, exceto:

A) Edema.

B) Hepatomegalia - glicogênese hepática.

C) Eosinofilia.

D) Hiperpotassemia.

E) Sudorese pós-prandial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

363890)

Enunciado: Paciente com 20 semanas de gestação, com informação de imunização completa para tétano em gestação passada, que ocorreu há um ano. Essa gestante deve receber

A) nenhuma dose de imunizante contra tétano.

B) uma dose de DTPa a partir da 20ª semana de gestação.

C) uma dose de DT no primeiro trimestre e uma de DTPa.

D) três doses de DT na primeira metade da gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330087)

Enunciado: Considerando a classificação da hipertensão arterial em relação aos percentis, é CORRETO afirmar:

A) PA normal: PAS e PAD ?menor que? p70.

B) PA elevada: PAS e/ou PAD ?maior ou igual a? p70 e ?menor que? 90, ou entre 100x80 mmHg e ?menor que?? p90.

C) Hipertensão estágio 1: PAS e/ou PAD ?maior ou igual a? 95 e ?menor que? 12 mmHG acima do p95, ou entre 130x80 mmHg a 139x89 mmHg.

D) Hipertensão estágio 2: PAS e/ou PAD ?maior ou igual a? 15 mmHg acima do p90, ou ?maior ou igual a? 140x90.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334805)

Enunciado: Analise a figura a seguir que mostra o gráfico de peso para idade de 0 a 2 anos para o sexo masculino. Marcar as medidas nos gráficos promove a saúde da criança, pela fácil identificação de desvios do crescimento. Fonte: MS (2021). Considerando um lactente de 11 meses, sexo masculino, com peso de 6.100 gramas, ao plotar estes parâmetros no gráfico apresentado, observa-se que, de acordo com o desenvolvimento, esta criança classifica-se como:

A) desnutrição grave.

B) muito baixo peso para a idade.

C) pequeno para idade.

D) peso adequado para idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334806)

Enunciado: O Ministério da Saúde, em 2021, ampliou temporariamente o grupo de pessoas que podem recorrer ao SUS (Sistema Único de Saúde) para tomar vacina pneumocócica conjugada. Ainda em relação às vacinas pneumocócicas:

A) a pneumo23V (PPSV23) proporciona cobertura para o maior número de sorotipos do pneumococo. Tem uso reduzido em pediatria por ser recomendada a partir dos 10 anos de vida.

B) a VPC13 é composta de 13 sorotipos de Streptococcus pneumoniae (pneumococo) conjugados com a proteína CRM197. Previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite, otite) em crianças.

C) a 10-valente (VPC10) deve ser realizada em dose única, pela rede privada, em crianças que tenham entre 12 e 23 meses de idade.

D) a pneumocócica conjugada 13-valente (VPC13) inclui 13 polissacarídios capsulares purificados de S. pneumoniae; contém mais sorotipos que a 10-valente (VPC10), mas é inferior por faltar alguns sorotipos fundamentais em crianças.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334807)

Enunciado: O Ministério da Saúde lançou, em novembro de 2022, o Plano Nacional de Resposta a um Evento de Detecção de Poliovírus e um Surto de Poliomielite: Estratégia do Brasil. Em relação à vacina contra a poliomielite:

A) a VOP (vacina oral contra poliomielite) é composta por três pólio vírus (polio1, 2 e 3 inativados) sendo necessárias várias doses para desencadear imunidade para os três vírus.

B) a VOP (vacina oral contra poliomielite) deve ser feita em contatos de imunossuprimidos, por ser doença de extrema gravidade para protegê-los indiretamente pela imunidade de rebanho.

C) a vacina Salk (VIP) determina melhor soroconversão e menor custo que a vacina Sabin (VOP), sendo indicada pela OMS em países em que a poliomielite foi eliminada.

D) o esquema para pólio é composto por três doses de VIP aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP aos 15 meses e aos 4 anos de idade, pelo Calendário Nacional de Vacinação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

332003)

Enunciado: Criança de 12 meses apresenta coriza hialina ao ser levada ao Posto de Vacinação. Com base no Programa Nacional de Imunizações, indique o esquema de vacinação a ser administrado em relação a tríplice viral e a tetra viral:

A) Adiar a vacinação.

B) Agendar somente a tetra viral para os 15 meses.

C) Aguardar um mês e fazer duas doses do tríplice viral com intervalo de um mês.

D) Administrar a tríplice viral e agendar a tetra viral para os 15 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334813)

Enunciado: Uma criança de 4 anos de idade é identificada na curva de ICM (OMS) entre os escores Z+2 e Z+3. Qual é a classificação que está adotada no Cartão da Criança do Ministério da Saúde e que será adotada como diagnóstico nutricional?

A) Obesidade.

B) Risco de Sobrepeso.

C) Sobrepeso.

D) Peso elevado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334820)

Enunciado: A desnutrição voltou? Dados divulgados pelos pesquisadores do "Observar infância" da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostraram que em 2021 houve a maior taxa de hospitalização de crianças menores de um ano de idade com desnutrição (113 hospitalizações/100 mil nascidos vivos). (Nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria - Departamento de Nutrologia - em 28/10/2022). Em relação à desnutrição sabe-se que:

A) o Marasmo é caracterizado por fraqueza intensa, parestesia em membros inferiores e carência de micronutrientes.

B) o Kwashiorkor é caracterizado por edema, alteração na cor dos cabelos, lesões de pele, esteatose hepática e hipoalbuminemia.

C) entre as carências de micronutrientes, as mais prevalentes são as deficiências de zinco, cálcio e de vitamina D.

D) na avaliação do paciente pela curva de IMC, ele estará desnutrido se estiver abaixo de Z=-3. Acima desse valor, sem desnutrição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334821)

Enunciado: Leia o relato do caso clínico a seguir. De acordo com as recomendações vacinais do Programa Nacional de Imunização (PNI), tem-se que a vacina:

A) a vacina BCG deverá ser aplicada o mais precocemente possível após o nascimento e um reforço realizado aos dez anos de idade.

B) a vacina pólio inativada (vip), obrigatoriamente, nas 3 primeiras doses (2, 4 e 6 meses), podendo ser seguida por 2 doses (15 meses e 4 anos) via oral atenuada (vop).

C) a vacina contra a febre amarela é indicada para indivíduos que moram em zona endêmica para a doença ou viajantes para tais locais.

D) todas as crianças ao nascer, independente da idade gestacional e peso, devem receber 3 doses de vacina contra hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334822)

Enunciado: M e P trazem seu filho V., de 13 anos de idade, para avaliação. Os pais estão preocupados com o seu desenvolvimento e crescimento. Ao exame, apresenta estágio puberal em G1P1, peso=45 kg, estatura=1,40m, IMC=22,1(z entre +1 e +2). Estatura do pai=1,70 m e da mãe=1,57 m. Trouxeram exame de idade óssea = 11 anos de idade. Analisando os dados clínicos relatados e as curvas de IMC e estatura, classifique a puberdade, o estado nutricional e a estatura deste adolescente, respectivamente.

A) Puberdade normal; eutrófico; baixa estatura familiar.

B) Puberdade normal; sobrepeso; baixa estatura constitucional.

C) Puberdade atrasada; sobrepeso; baixa estatura patológica.

D) Puberdade atrasada, eutrófico; muito baixa estatura.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339815)

Enunciado: Em consulta de puericultura, a mãe de um pré-escolar masculino de 4 anos questiona ao pediatra sobre o peso atual do seu filho, pois acredita que ele está "magro" e necessita de um suplemento alimentar. Após exame clínico, o pediatra plota os dados antropométricos na curva da OMS para IMC, apropriada para sexo e idade do menor, estando este entre os percentis 85 e 97. Podemos afirmar que, de acordo com o estado nutricional, como este pré-escolar é classificado de acordo com os dados acima, sabendo que, na avaliação da altura, ele encontra-se no percentil 50?

A) Estrófico

B) Peso adequado para a idade

C) Risco de sobrepeso

D) Sobrepeso

E) Obesidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321598)

Enunciado: De acordo com o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) de 2021, a vacina pneumocócica conjugada deve ser aplicada nas crianças:

A) a partir de 9 meses e a cada 3 meses, até 18 meses de idade.

B) com 3, 6, 9 e 12 meses de vida.

C) a partir de 1 ano e a cada 2 meses, até 2 anos de idade.

D) com 2, 4, 6 e 12 meses de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321599)

Enunciado: A vacina BCG, de acordo com o calendário vacinal de 2021 da SBP.

A) deve ser administrada em dose única.

B) deve ser aplicada a partir de 30 dias de vida.

C) pode ser celular ou acelular.

D) pode ser proscrita aos filhos de mães com tuberculose prévia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321600)

Enunciado: Ao ser discutido sobre o uso correto da tecnologia em prol de um desenvolvimento neuropsicomotor satisfatório na infância e na adolescência, a SBP preconiza que o tempo de exposição a mídias deve ser

A) entre 1 a 2 horas ao dia para crianças entre 2 e 3 anos completos.

B) tempo zero para crianças até 2 anos de idade.

C) de até 3 horas diárias para crianças entre 3 e 6 anos.

D) no máximo de 4 horas ao dia (com intervalos) para crianças maiores de 6 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339833)

Enunciado: De acordo com o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) de 2021, a vacina pneumocócica conjugada deve ser aplicada nas crianças:

A) a partir de 9 meses e a cada 3 meses, até 18 meses de idade.

B) com 3, 6, 9 e 12 meses de vida.

C) a partir de 1 ano e a cada 2 meses, até 2 anos de idade.

D) com 2, 4, 6 e 12 meses de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339834)

Enunciado: A vacina BCG, de acordo com o calendário vacinal de 2021 da SBP.

A) deve ser administrada em dose única.

B) deve ser aplicada a partir de 30 dias de vida.

C) pode ser celular ou acelular.

D) pode ser proscrita aos filhos de mães com tuberculose previa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300815)

Enunciado: Criança de 12 meses com aparência de ser pequena para a idade cronológica. Peso abaixo do percentil 5 na curva padronizada de crescimento (percentil 50 para 8 meses); o comprimento está no percentil 25 e o perímetro encefálico no percentil 50. Sinais vitais ao exame físico normais. Diagnóstico mais provável de:

A) Raquitismo certamente de etiologia orgânica.

B) Retardo de crescimento FTT certamente de etiologia orgânica.

C) Raquitismo provavelmente de etiologia não orgânica.

D) Retardo de crescimento FTT provavelmente de etiologia não orgânica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300824)

Enunciado: Considerando o crescimento do lactente, quantos aos principais índices antropométricos utilizados na avaliação do crescimento e às principais alterações com relação à Estatura/Idade (E/I), é CORRETO afirmar:

A) Avalia principalmente a situação global da criança.

B) Reflete crescimento neural, principalmente nos 6 primeiros meses.

C) Está comprometido nos casos agudos.

D) Está afetado nos processos crônicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

317168)

Enunciado: Sra. ABC, mulher, 62 anos, vem à consulta médica em UBS com sensação de cansaço, fraqueza e mal estar. Refere dispneia aos pequenos esforços, cansando para atividades de vida diário (tomar banho e vestir a roupa). É tabagista de cigarro branco desde os 12 anos, em média 20 cigarros ao dia. Na infância já trabalhou na lavoura, e tinha fogão e lenha em casa. Desconhece comorbidades, mas diz que raramente vai ao médico. Não lembra quando foi a última vacina que tomou, pois os locais de vacinação são sempre longe de casa e a paciente não tem quem a leve para a vacinação. Baixa aceitação alimentar, comendo mais sopas e alimentos batidos, alega que comidas secas e em pedaços maiores tem dificuldade para deglutição. Tem perda ponderal de 7kg nos últimos 2 meses. Nunca fez cirurgias, desconhece doenças de infância. É etilista ativa, em média 7 latinhas de cerveja ao dia. Nega queixas alérgicas, nega vômitos, nega diarreia. Refere que a urina está mais escura e em menor volume nos últimos meses. Ao exame físico: Peso 42 kg. A 1,65; SpO2 90%, FR 18irpm; FC 103bpm; PA 170x120mmHg; Tax: 37,2ºC; Descorada +/4, desidratada 2+/4, eupneica em arambiente, lúcida e orientada no tempo e espaço, contactuante com o examinador. Ausculta respiratória: murmúrio vesicular redizido difusamente, sem estertores crepitantes. Expansibilidade pulmonar preservada. Ausculta cardíaca: ritmo regular, em 2 tempo, bulhas normofonéticas, sem sopros. Abdome escavado, doloroso a palpação profunda em eigastro, descombressão brusca negativa. Extremidades sem edema de membros inferiores, pulso periféricos palpáveis e simétricos, tempo de enchimento capilar normal. Neurológico: sem sinais focais, verbaliza sem dificuldade, movimenta os quatro membros, sem paresias ou paralisias. Sobre essa paciente analise as afirmativas abaixo: I) Paciente tabagista ativa, alta carga tabágica, tem indicação para realizar rastreio precoce de neoplasia pulmonar, por isso deve ser pedido radiografia de tórax. II) Paciente com perda ponderal, disfagia progressiva, atualmente par sólidos, etilista e tabagista, deve fazer investigação para lesão neoplástica de trato gastro-intestinal com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. III) A paciente não tem fatores de risco para osteoporose, já que é magra, por isso não há indicação para realização de densitometria óssea. IV) A paciente tem indicação para atualizar cartão vacina, e nesse momento são indicadas as vacinas COVID-19 (3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

doses); Influenza (1 dose); Anti-pneumocócica (pneumo 10 valente). Das informações acima, podemos dizer que são corretas:

A) I, II, II, IV

B) I, III

C) II apenas

D) I, II, IV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314123)

Enunciado: A síndrome de Wernick-Korsakoff é a forma aguda da deficiência de qual vitamina?

A) A.

B) B1.

C) B12.

D) C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314124)

Enunciado: Criança com quadro progressivo e insidioso de irritabilidade e choro à manipulação apresenta hematomas em joelhos e tornozelos e inicia quadro febril. Nesse Caso, o diagnóstico deve ser de deficiência de vitamina

A) A.

B) B1.

C) B12.

D) C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

302865)

Enunciado: A tuberculose na criança permanece ainda negligenciada e com alta mortalidade no mundo. Considere o caso de uma puérpera, em tratamento para tuberculose pulmonar há 1 semana. A respeito do caso, considere as seguintes condutas: 1. Vacinar o RN com BCG. 2. Contraindicar a amamentação. 3. Iniciar quimioprofilaxia com isoniazida. 4. Realizar prova tuberculínica. É/São conduta(s) adequada(s) a ser realizada(s) no período neo natal com o recém-nascido, que se encontra assintomático, conforme as diretrizes atuais do Ministério da Saúde:

A) A 3 apenas.

B) 1 e 3 apenas.

C) 2 e 4 apenas.

D) 1, 2 e 4 apenas.

E) 1,2,3 e 4.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308243)

Enunciado: A vacinação contra o HPV é preconizada pelo Ministério da Saúde do Brasil em meninas de e meninos, respectivamente:

A) 9 a 14 anos e 11 a 14 anos.

B) 8 a 13 anos e 8 a 14 anos.

C) 11 a 14 anos para ambos

D) 9 a 14 anos para ambos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314127)

Enunciado: No calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) de 2021 é preconizada a administração da vacina:

A) BCG logo após o nascimento e com 10 anos de idade.

B) contra rotavírus com 2, 4 e 6 meses de vida.

C) Hib com 2, 4, 6 e 15 meses de vida.

D) contra varicela aos 9 e 12 meses de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294288)

Enunciado: Uma paciente que irá completar 15 anos em três semanas comparece à Unidade de Saúde e é atendida pelo médico da Estratégia de Saúde da Família. Ela deseja receber a segunda dose da vacina contra HPV. Ao consultar o sistema, o médico confirma que ela recebeu a primeira dose dessa vacina no dia em que completou 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, ela deve

A) receber uma segunda dose da vacina.

B) ser orientada a ir para casa sem a segunda dose da vacina, pois já se passaram seis meses após a primeira dose.

C) receber mais duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre a segunda e a terceira dose.

D) terminar o esquema vacinal com uma segunda dose somente se estiver vivendo com HIV/Aids, ou ser transplantada de órgãos sólidos ou de medula óssea, ou ser paciente oncológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313222)

Enunciado: Com relação à interpretação de gráficos de crescimento infantil, assinale a alternativa incorreta:

A) em prematuros, poderá ser evitado o diagnóstico de insuficiência de crescimento quando, ao inscrever os parâmetros de crescimento, subtrair da idade pós-natal as semanas da prematuridade

B) os neonatos de muito baixo peso (menor que 1.500g) poderão continuar a mostrar a retomada do crescimento através de toda a idade escolar

C) o único bom indicador isolado de uma desnutrição aguda continua sendo o peso para altura abaixo do 5° percentil

D) somente após os 5 anos podemos perceber a influência dos genes no crescimento da criança, correlacionando o tamanho da mesma com a média da altura dos pais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313223)

Enunciado: Um recém-nascido de parto normal, a termo, com 48 horas de vida, está sugando bem o seio materno, não apresenta alterações ao exame físico e recebe alta da maternidade. Três dias depois, em casa, a mãe apresenta lesões cutâneas disseminadas e procura a Unidade Básica de Saúde, recebendo o diagnóstico de varicela. A melhor conduta imediata, com relação ao recém-nascido, é:

A) aciclovir

B) observação clínica

C) vacina contra varicela

D) imunoglobulina contra varicela-zóster

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316344)

Enunciado: Qual das vacinas abaixo não deve ser administrada na paciente durante o pré-natal?

A) Antitetânica.

B) Hepatite B.

C) Antirrábica.

D) Sarampo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294299)

Enunciado: Um adolescente que foi mordido no antebraço direito por um Rattus norvegicus comparece na unidade de saúde e é atendido pelo Médico da Estratégia de Saúde da Família. Neste caso, de acordo com o Ministério da Saúde, com relação ao esquema profilático para a raiva humana, esse adolescente

A) não deve receber o esquema profilático.

B) deve receber esquema profilático com 2 doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.

C) deve receber esquema profilático com soro e 5 doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

D) deve receber o esquema profilático com 5 doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316358)

Enunciado: Laura Maria, 12 anos, chega à unidade acompanhada pela mãe, Estela. A adolescente está chorando muito e com a mão ensanguentada. A agente comunitária de saúde, Aline, que está hoje no "POSSO AJUDAR" as conduz para a sala do curativo e chama a enfermeira para ajudar. Logo em seguida, a médica de família da equipe Amparo chega na sala para entender o que é toda essa gritaria. A mãe relata que Laura Maria ama os animais e estava brincando na praça do lado da unidade com os cachorros quando um deles mordeu a mão da filha e elas vieram correndo para unidade. A melhor conduta clínica a ser adotada é:

A) Tranquilizar a mãe e a adolescente, orientar vacinação antirrábica, lavar com soro fisiológico e realizar sutura.

B) Tranquilizar a mãe e a adolescente, fazer antissepsia e orientar sacrificar o animal.

C) Orientar internação da adolescente, realizar vacinação antirrábica e observar sinais e sintomas de raiva humana.

D) Tranquilizar mãe e adolescente, fazer antissepsia e orientar vacinação antirrábica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313248)

Enunciado: Uma adolescente de 16 anos, com idade gestacional de 20 semanas, inicia pré-natal. Refere ter perdido a carteira de vacinação e não sabe referir imunizações prévias. A orientação de vacinas na gestação é:

A) realização de vacina para influenza e da tríplice bacteriana acelular, independentemente de vacinação prévia para tétano

B) pela idade materna, não há necessidade de realizar qualquer imunização além da vacina de influenza

C) nessa idade gestacional, não deve ser realizada qualquer imunização, pelo risco de embriopatia

D) administração de dupla tetânica e da vacina de hepatite B, independentemente do status sorológico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311968)

Enunciado: Sobre o calendário atual de vacinação, a um lactente de 11 meses deverão ter sido administradas:

A) BCG, pentavalente, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, rotavírus, febre amarela, tríplice viral.

B) BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, pneumocócica, rotavírus, meningocócica, influenza, febre amarela.

C) BCG, pentavalente, poliomielite, pneumocócica, rotavírus, influenza, meningocócica, febre amarela.

D) BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, pneumocócica, rotavírus, meningocócica, influenza, febre amarela, tríplice viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313258)

Enunciado: Uma criança de 5 anos foi vítima de mordedura profunda na superfície palmar do dedo indicador direito. O acidente foi causado por um cão de propriedade de um vizinho, que não refere qualquer alteração no comportamento do animal nos últimos dias. A criança nunca havia recebido esquema profilático para raiva. A conduta profilática inicial para raiva a ser adotada neste caso, recomendada pelo Ministério da Saúde, deve incluir lavagem cuidadosa da lesão e observação do animal, acompanhada de:

A) Aplicação de 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28), sem soro.

B) Aplicação de 2 doses de vacina (dias 0 e 3), sem soro.

C) Aplicação de 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28) e soro.

D) Aplicação de 3 doses da vacina antirrábica (dias 0, 3 e 7), sem soro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316375)

Enunciado: Criança de 2 anos de idade está apresentando um quadro compatível com varicela. A família tem dúvidas quanto ao tempo de precaução, às medidas de precaução a serem adotadas e quando a criança poderá retornar à escola. Assinale a alternativa correta:

A) Precaução de contato e aerossóis e retornar às atividades quando se apresentar assintomático do ponto de vista clínico, independente do estado das lesões cutâneas.

B) Precaução de contato e gotículas e retornar à escola somente após 15 dias do início da sintomatologia.

C) Precaução de contato e retornar às atividades após 10 dias do início do quadro quando as lesões cutâneas se tornarem vesiculosas.

D) Precaução de contato e aerossóis e retorno às atividades quando todas as lesões cutâneas tiverem se transformado em lesões crostosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

318001)

Enunciado: Em 1973, foi formulado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura. Em relação às vacinas contempladas no PNI, sabe-se que:

A) Existem 5 vacinas no PNI que previnem meningite bacteriana, sendo elas: vacina contra Haemophillus Influenzae b (Hib); vacina pneumocócica conjugada; vacina meningocócica C conjugada; vacina meningocócica ACWY conjugada e vacina BCG.

B) A vacina BCG é composta pelo bacilo Calmette-Guérin e produzida com bacilos vivos, atenuados de cepa de Mycobacterium bovis. Previne principalmente a tuberculose em sua forma pulmonar, porém também confere certa proteção contra as formas meningea e miliar.

C) A vacina tríplice bacteriana acelular (DTPa) está indicada se, após o uso da vacina tríplice bacteriana de células inteiras (DTPw), ocorrer convulsão, episódio hipotônico hiporresponsivo ou encefalopatia.

D) A vacina rotavírus previne doença diarreica causada por este vírus. É uma vacina oral inativada. É contraindicada para bebês com doença do aparelho gastrointestinal ou história prévia de invaginação intestinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294330)

Enunciado: A faixa etária de maior risco para hipovitaminose A é:

A) recém-nascidos.

B) lactantes.

C) pré-escolares.

D) adolescentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

295418)

Enunciado: O Programa Nacional de Imunizações (PNI) representa uma das intervenções em saúde pública mais importantes no cenário de saúde brasileiro. As ações de vacinação e vigilância apresentam impacto positivo na prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, refletindo positiva e diretamente na qualidade e expectativa de vida da população. Neste contexto, para imunização conforme o PNI de Maria Clara, que nasceu prematura com 36 semanas e seis dias, apresentando peso de 1,9 kg e atresia jejunal corrigida cirurgicamente, deverá ser:

A) receber a vacina contra hepatite B, dose zero, ao completar uma semana de vida, por se tratar de vacina de vírus atenuado.

B) receber BCG após 2,5 kg.

C) receber a vacina injetável contra rotavírus ao completar quatro meses de idade cronológica.

D) receber vacina pentavalente aos dois, quatro e seis meses de idade, caso não apresente evento adverso grave como episódio hipotônico hiporresponsivo e convulsões.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294331)

Enunciado: Criança, filha de pais vegetarianos estritos, é levada ao pediatra com quadro de irritabilidade, glossite, diarreia e sinais de parestesias. Ela apresenta deficiência de vitamina:

A) A.

B) B1.

C) B12.

D) C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308296)

Enunciado: Manuela, 3 anos de idade apresenta peso de 18 Kg e altura de 100 cm. Utilizando o gráfico abaixo, conforme as recomendações da Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, classificamos essa criança como apresentando:

A) Desnutrição.

B) Eutrofia.

C) Sobrepeso.

D) Obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294337)

Enunciado: Atualmente já existe uma vacina contra a dengue, autorizada no mundo e já inclusa em nosso calendário vacinal. Porém, ela só pode ser administrada em pessoas que sejam soropositivas para dengue e a partir de

A) seis anos.

B) nove anos.

C) doze anos.

D) dezoito anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316386)

Enunciado: Criança de 2 anos, hígida, sem comorbidades, em consulta de rotina com o pediatra, os pais solicitam revacinação de BCG, uma vez que a criança não tem a cicatriz desta vacina. Calendário vacinal atualizado. A alternativa correta neste caso é:

A) O pediatra deve orientar a mãe que não é necessário revacinar; esta é a recomendação da OMS e SBP, pois a ausência da cicatriz de BCG após a vacinação não é indicativo de ausência de proteção.

B) O pediatra deve indicar a revacinação imediatamente, pois há grande risco de adquirir tuberculose ao entrar na escola.

C) O pediatra deve contraindicar revacinação e investigar, pois a ausência de cicatriz é indicativo de imunodeficiência primária.

D) O pediatra deve indicar a revacinação, pois a BCG é importante para proteção contra todas as formas de tuberculose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

318015)

Enunciado: Crianças e adolescentes com desnutrição, na fase do acompanhamento ambulatorial, devem:

A) ser orientados para uma alimentação rica em ferro, zinco e selênio, e ter suspensas as suplementações medicamentosas.

B) receber suplementação endovenosa, uma vez por semana, de minerais e orientação de alimentação saudável rigorosa.

C) receber suplementação medicamentosa de vitaminas e minerais e orientação de alimentação saudável.

D) evitar ingestão de suplementos vitamínicos industrializados e utilizar alimentação natural balanceada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311984)

Enunciado: Ao avaliar um escolar de 9 anos, sexo masculino, qual das alternativas abaixo indica provavelmente patologia?

A) Estatura, um desvio padrão abaixo da estatura alvo.

B) Aumento dos testículos e aparecimento de pelos finos.

C) Desenvolvimento Tunner no estágio pré-púbere.

D) Estatura, três desvios padrões abaixo do Z score -1.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265846)

Enunciado: Na gravidez, a imunização contra rubéola está CONTRAINDICADA pelo fato da vacina ser composta por vírus vivos atenuados. Outra vacina que também não deve ser aplicada durante a gravidez pelo mesmo motivo, é:

A) Salk.

B) Sarampo.

C) Hepatite B.

D) Difteria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

285089)

Enunciado: Menino de 13 anos é levado por sua mãe para Unidade Básica de Saúde. Eles procuram orientação médica sobre a vacina ção para HPV. Qual alternativa reflete as recomen dações atuais do Ministério da Saúde?

A) Ele não pode receber a vacina, pois é disponibilizada apenas para meninas.

B) Ele só pode receber a vacina ser for transplantado, portador de câncer ou HIV.

C) Ele não pode receber a vacina, pois ela é indicada aos 11 anos ou menos.

D) Ele pode receber duas doses da vacina, com in tervalo de 6 meses entre as doses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281832)

Enunciado: A vacinação contra rotavírus, em lactentes, pode ter papel patogênico no desencadeamento da

A) estenose hipertrófica de piloro.

B) hérnia inguinal encarcerada.

C) apendicite.

D) intussuscepção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273155)

Enunciado: A caxumba ocorre usualmente sob a forma de surtos, que acometem mais as crianças, sendo mais severa nos adultos. É uma doença que ocorre mais no período do inverno e primavera. Quanto à sua transmissão, é CORRETO afirmar:

A) Ocorre por meio do contato direto com as secreções, como saliva e espirro.

B) Ocorre por meio da picada de um mosquito.

C) Ocorre por meio do contato com o sangue de um infectado.

D) Ocorre por meio do contato com o sangue e secreções.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

285092)

Enunciado: Menino de 6 anos foi mordido, na mão esquerda, pelo cão de vizinha pego na rua há 2 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a conduta a ser tomada deve ser:

A) Vacina antirrábica 2 doses (0 e 3 dias após exposição) + observação do cão por 10 dias, encerrar o caso, se nada ocorrer com o animal.

B) Observar o cão por 10 dias.

C) Vacina antirrábica 3 doses (0, 3 e 7 dias após exposição).

D) Vacina antirrábica 5 doses.

E) Vacina antirrábica 5 doses (0, 3, 7, 14 e 28 dias após exposição) + soro antirrábico por tratar-se de lesão grave (mãos).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

277459)

Enunciado: Na avaliação clínica de criança com desnutrição grave, aponte a alternativa correta:

A) é muito comum a ocorrência de infecção, que geralmente se manifesta com sinais clínicos evidentes, como crise convulsiva, febre e insuficiência respiratória

B) presume-se que todas as crianças com esse quadro tenham infecção, devendo receber antibioticoterapia desde o início do tratamento

C) sinais de hipertensão intracraniana e irritação meníngea são muito frequentes

D) o esquema antimicrobiano preconizado à admissão nesse tipo de paciente se constitui de vancomicina e cefepima

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274511)

Enunciado: O uso de dispositivos móveis, como smartphones e tablets por lactentes e pré-escolares aumentou dramaticamente nos últimos anos. As evidências de pesquisas científicas sugerem que os dispositivos tecnológicos de telas e as mídias oferecem tanto benefícios quanto riscos para a saúde das crianças e adolescentes, tornando-se necessário o planejamento dos cuidadores. Em relação ao uso da tecnologia na população pediátrica, marque a alternativa correta.

A) Estudos mostram a associação entre excesso de exposição a telas na primeira infância e atraso no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, atrasos sociais, além de comportamentos agressivos e alterações no sono.

B) Estudos mostraram que crianças que excedem 2 horas por dia de uso de mídia sedentária têm 100 vezes mais chances de desenvolver obesidade em comparação com aqueles que não excedem 2 horas por dia de uso de mídia sedentária.

C) A recomendação de exposição a mídias para crianças menores de dois anos é de 2 horas, pois este período mostra eficácia para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, da interação social e das habilidades motoras através dos jogos.

D) Entre a idade de 2 anos completos e 5 anos a recomendação é de 5 horas por dia ao todo, somando-se o período diário que a criança permanece na TV, celular, tablets e videogames.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265905)

Enunciado: Ideal imunizar todas as pessoas expostas não previamente vacinadas, ou sem conhecimento de vacinação prévia, e sem indícios de infecção por HBV (HBSAg não reagente), independentemente da idade. Podemos apenas ACEITAR que:

A) Duas doses de vacina contra a hepatite B induzem títulos protetores de anticorpos (anti-HBs maior ou igual a 10UI/mL) em mais de 90% dos adultos e dos jovens sadios, e em mais de 95% dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

B) Três doses de vacina contra a hepatite B induzem títulos protetores de anticorpos (anti-HBs maior ou igual a 10UI/mL) em menos de 90% dos adultos e dos jovens sadios, e em mais de 5% dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

C) Três doses de vacina contra a hepatite B induzem títulos protetores de anticorpos (anti-HBs maior ou igual a 10UI/mL) em mais de 90% dos adultos e dos jovens sadios, e em mais de 95% dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

D) Três doses de vacina contra a hepatite B não induzem títulos protetores de anticorpos (anti-HBs maior ou igual a 10UI/mL) em mais de 60% dos adultos e dos jovens sadios, e em mais de 95% dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274826)

Enunciado: Lactente de 6 meses de vida é conduzido para consulta de puericultura. Está em aleitamento materno exclusivo, sem queixas. Não faz uso de nenhuma medicação. Refere gestação e parto sem intercorrências. Em relação às vacinas pelo calendário do Ministério da Saúde, qual alternativa contempla calendário vacinal completo com 6 meses de vida?

A) BCG uma dose. Hepatite B 3 doses. DTP 3 doses. Rotavirus 3 doses. VOP (pólio oral) 3 doses. Meningite C 3 doses. Pneumo 10 3 doses.

B) BCG uma dose. Hepatite B uma dose. Pentavalente 3 doses (DTP, hepatite B, hemofilus B). VIP (pólio intramuscular) 3 doses. Rotavirus 2 doses. Meningite C 2 doses. Pneumo 10 2 doses.

C) BCG uma dose. Pentavalente 3 doses (DTP, hepatite B, hemofilus B), VIP (pólio intramuscular) 3 doses. Rotavirus 2 doses. Meningite C 2 doses. Pneumo 10 2 doses. Febre amarela 1 dose.

D) BCG uma dose. Pentavalente 3 doses (DTP, hepatite B, hemofilus B), VIP (pólio intramuscular) 3 doses. Rotavirus 2 doses. Meningite C 2 doses. Pneumo 10 2 doses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

282051)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 14 anos, é levado ao pediatra, pois apresenta desinteresse escolar e está incomodado com o fato de ser o mais baixo da sua turma da escola. Os pais também são pequenos. Apresenta aparência de 11 anos, altura e peso encontram-se entre os escores z-2 e z-3, Tanner G1P2. Altura alvo entre os escores z-2 e z-3. Idade óssea compatível com 10 anos e meio. A principal hipótese diagnóstica é:

A) Hipotireoidismo.

B) Baixa estatura genética.

C) Baixa estatura constitucional.

D) Baixa estatura genética e constitucional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

282056)

Enunciado: Sobre as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização 2020, assinale a alternativa correta:

A) A vacina de febre amarela, que anteriormente era ofertada apenas com 9 meses de vida, passa a ser indicada com 9 meses e um reforço com 15 meses.

B) A vacina meningocócica ACWY passa a ser ofertada para adolescentes de 11 a 12 anos.

C) A vacina BCG passa a ser refeita quando não se observa reação inflamatória conhecida como cicatriz vacinal no músculo deltoide em membro superior direito.

D) É recomendado repetir a dose da vacina oral de poliomielite aos 6 meses se o bebê apresentar regurgitação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231936)

Enunciado: Uma gestante com 9 semanas deseja saber se pode tomar a vacina para gripe H1N1.

Assinale a orientação correta para essa situação:

A) pode tomar a vacina imediatamente

B) pode tomar a vacina a partir de 12 semanas

C) pode tomar a vacina a partir de 20 semanas

D) não está recomendada a vacina para gestantes

E) não é necessário tomar a vacina se já for imunizada contra gripe comum

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229819)

Enunciado: As tendências temporais da nutrição e da obesidade definem uma das características marcantes do processo de transição nutricional do País. Ao mesmo tempo em que a ocorrência da desnutrição em crianças e adultos declina em ritmo acelerado, aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade. Dessa forma, considere a alternativa que contém a RECOMENDAÇÃO para a promoção da alimentação saudável da criança e, consequentemente, a prevenção da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis:

A) Promoção, apoio e estímulo ao aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de idade e complementado até aos doze meses de idade.

B) Orientação da alimentação da criança baseada nos 10 passos da alimentação para lactentes.

C) Orientação para o consumo de ovo com gema e derivados do glúten a partir do segundo ano de vida.

D) Incentivo ao consumo de alimentos fontes de zinco e ferro a partir dos quatro meses de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229821)

Enunciado: O Ministério da Saúde do Brasil em 2019 recomendou que todas as crianças com uma determinada faixa etária tomem uma "dose zero" de vacinação contra o sarampo. Além dessa dose zero, as crianças ainda deverão receber as vacinas previstas no calendário de vacinação. Os bebês devem tomar a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e, aos 15 meses, tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varícela, que é considerada a segunda dose. Assinale a alternativa que apresenta essa faixa etária indicada para a "Dose Zero".

A) Entre 9 meses e 1 ano incompleto (11 meses e 29 dias).

B) Entre 6 meses e 9 meses incompletos (8 meses e 29 dias).

C) Entre 6 meses e 1 ano incompleto (11 meses e 29 dias)

D) Entre 4 meses e 1 ano incompleto (11 meses e 29 dias).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246529)

Enunciado: Sobre a raiva humana, julgue os itens seguintes. I. O período de incubação é de 20 a 90 dias. II. Na manifestação encefalítica ocorre paralisia flácida nos membros que evolui para tetraparesia com paralisia facial. III. A recuperação é rara. Pode-se afirmar que:

A) todos os itens estão certos.

B) nenhum item está certo.

C) apenas os itens I e II estão certos.

D) apenas os itens I e III estão certos.

E) apenas os itens II e III estão certos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

241704)

Enunciado: Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde a respeito do manejo da infecção pelo HIV em adultos, pode-se afirmar sobre o esquema vacinal para pacientes infectados pelo HIV, acima de 13 anos, que:

A) Imunização para hepatite B é recomendada em concentração dobrada pelo fabricante em 4 doses.

B) Imunização para febre amarela pode ser considerada em áreas de risco, apenas se CD4 > 350.

C) Imunização para varicela é contraindicada nos pacientes susceptíveis e em gestantes.

D) Vacina contra o HPV é indicada até os 26 anos, administrada em somente 2 doses.

E) Vacina inativada contra o vírus da influenza é desaconselhada nesse grupo de pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

254232)

Enunciado: Joana comparece ao posto de saúde com seu filho Roberto de 5 meses. Relata que acabou de se mudar do Maranhão para Goiânia e que na mudança perdeu o cartão de vacina de Roberto, porém sabe que suas vacinas estavam desatualizadas. No exame físico você observa cicatriz vacinal em membro superior direito. Sem outras alterações. Quais vacinas devem ser realizadas neste momento?

A) BCG, hepatite B, Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10 V.

B) Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10V, Menigocócica C.

C) BCG, Penta, VIP, Pneumocócica 10V, Menigocócica C, Rotavírus humano.

D) Penta, VIP, Pneumocócica 10V, Menigocócica C, Rotavírus humano.

Gabarito

345457.

Comentário: Para decidirmos qual será a profilaxia correta para tétano a ser utilizada diante de um acidente, devemos primeiro avaliar o risco do ferimento. Os ferimentos de baixo risco são aqueles superficiais, que não possuem corpos estranhos ou tecidos desvitalizados. Já os de alto risco, são os ferimentos profundos ou os superficiais sujos, com corpos estranhos, por queimaduras ou congelamentos, puntiformes, por armas brancas ou de fogo, mordeduras, esmagamentos ou fraturas expostas. Portanto, o ferimento descrito na questão é considerado como de alto risco. Dentre as lesões deste tipo, a conduta dependerá da situação vacinal do paciente. Para pessoas que possuem a última dose de vacina anti-tetânica documentada há mais de cinco anos, mas há menos de dez, a recomendação é uma dose de reforço da vacina, sem necessidade e aplicação de soro ou imunoglobulina. Resposta letra B.

343778.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso de tela na infância. A letra A está incorreta crianças com idades entre 2 e 5 anos, devemos limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora dia , sempre com supervisão de pais cuidadores responsáveis. A letra B está correta é recomendado em todas as idades nada de telas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

durante as refeições e desconectar 1-2 horas antes de dormir. A letra C está incorreta adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, é orientado limitar o tempo de telas e jogos de videogames a 2-3 horas dia , e nunca deixar virar a noite jogando. E, por fim, a letra D também está incorreta em crianças com idades entre 6 e 10 anos, devemos limitar o tempo de telas ao máximo de 1-2 horas dia , sempre com supervisão de pais responsáveis. Resposta letra B.

343785.

Comentário: Questão clássica de prova, que aborda o atraso do cartão vacinal. Não tem jeito, tem que ir para a prova com o calendário vacinal decorado. Ao nascimento são indicadas as vacinas BCG e contra a Hepatite B. Aos dois meses Poliomielite (VIP - inativada) Rotavírus humano Pentavalente e Pneumocócica 10-valente. Aos três meses apenas a meningocócica C. Aos quatro meses, são indicadas as mesmas vacinas realizadas aos dois meses. Portanto, essa criança deverá receber a vacina dos três meses (meningocócica C) e as vacinas dos quatro meses (VIP Rotavírus humano Pentavalente e Pneumocócica 10-valente). Resposta letra D.

343794.

Comentário: Segundo o Ministério da Saúde e a SBP, em relação ao IMC, as crianças de 5-19 anos podem ser classificadas na seguinte forma magreza acentuada (se Z escore -3), magreza (se Z escore -3 e -2), eutrofia (se Z -2 e 1), sobrepeso (se Z escore 1 e 2), obesidade (se Z escore 2 e 3), obesidade grave (se Z escore 3). Ao colocarmos o paciente no gráfico, percebemos que seu IMC encontra-se entres os escores 1 e 2. Portando, a criança é classificada como tendo sobrepeso. Resposta letra A.

345478.

Comentário: Essa questão descreve uma gestante com 16 semanas de idade gestacional que apresenta esquema vacinal incompleto para o HPV (recebeu duas doses da vacina antes da gestação). devemos lembrar que, embora não contenha vírus vivo, a vacina contra o HPV não deve ser administrada em gestantes, devido aos dados limitados sobre sua segurança na gestação. Entretanto, a imunização é segura para lactantes e, por isso, pode ser administrada no período de lactação. Portanto, a orientação mais adequada é postergar a terceira dose da vacina para depois

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do parto, não sendo necessário repetir todo o esquema vacinal. Resposta letra B.

343809.

Comentário: O percentil 50, também chamado mediada, é definido como o valor que divide os dados ordenados ao meio. Metade dos dados têm valores maiores do que a mediana, a outra metade tem valores menores do que a mediana. Sendo assim, uma criança (independentemente da idade) que apresenta-se no percentil 50 para o peso, significa que tem o peso igual à mediana para a idade que ela apresenta no momento da avaliação. Resposta letra A.

345501.

Comentário: Questão clássica de prova, que aborda o atraso do cartão vacinal. Não tem jeito, tem que ir para a prova com o calendário vacinal decorado. Ao nascimento são indicadas as vacinas BCG e contra a Hepatite B. Aos dois meses Poliomielite (VIP - inativada) Rotavírus humano Pentavalente e Pneumocócica 10-valente. Aos três meses apenas a meningocócica C. Portanto, percebemos que o cartão vacinal foi atualizado até essa idade. Aos quatro meses, são indicadas as mesmas vacinas realizadas aos dois meses aos cinco meses, mais uma dose da meningocócica C e aos seis meses, mais uma dose da VIP e da Penta. Sendo assim, a melhor resposta para a questão é a letra B, mas a banca liberou como resposta correta a letra D. Foi solicitado recurso, e acreditamos que a questão será anulada. Gabarito oficial letra D. Gabarito Medgrupo letra B.

281144.

Comentário: Estamos diante de um escolar de 6 anos que foi mordido na mão pelo cão do vizinho. Sabemos que a conduta para a profilaxia antirrábica depende de dois pontos o tipo de acidente (acidente leve ou acidente grave) e a situação do animal agressor (cão desconhecido ou conhecido). Perceba que o cão é conhecido, mas a mordida foi não mão, por isso temos que considerar um acidente grave. A orientação inicial para esses casos é lavar o ferimento com água e sabão e iniciar esquema profilático com duas doses da vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3. Em seguida, iremos observar o animal durante 10 dias. Caso o animal permaneça saudável, encerramos o caso caso desapareça ou fique doente, completamos o esquema com mais duas doses da vacina. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281149.

Comentário: Vamos analisar cada uma das alternativas Opção A incorreta. Depende. Em algumas cromossomopatias, o paciente apresenta peso e comprimento normais ao nascer e no decorrer no desenvolvimento pode apresentar déficit pôndero-estatural (p.ex Síndrome de Prader-Willi) Opção B incorreta. Com frequência, os pacientes portadores da Síndrome de Prader-Willi cursam com deficiência do hormônio de crescimento, explicando a baixa estatura. Opção C incorreta. A acondroplasia ou nanismo é caracterizada como um distúrbio genético autossômico dominante que afeta a ossificação endocondral. A alteração está localizada no braço curto do cromossomo quatro, devido mutação do gene localizada no receptor do fator de crescimento do fibroblasto tipo 3 (FGFR3). Portanto o problema não está relacionado com o hormônio de crescimento. Opção D incorreta. Os mecanismos que determinam baixa estatura nas pacientes com síndrome de Turner ainda não foram completamente elucidados, visto não haver deficiência de hormônio do crescimento. Provavelmente o que ocorre é uma falha na resposta à ação deste hormônio combinada com displasia esquelética. Opção E correta. Frequentemente os pacientes portadores de Síndrome de Down e Turner cursam com hipotireoidismo, sendo este um achado comum às duas síndromes. Resposta letra E.

283333.

Comentário: Quando discutimos vacinação durante a gestação devemos lembrar que vacinas compostas por partículas ou vírus inativados podem ser administradas com segurança, enquanto vírus atenuados (vivos) não devem ser administrados. A vacina da febre amarela é composta por vírus vivo atenuado e, portanto, deve ser evitada durante a gestação. Porém, no caso da vacina da febre amarela, em caso de viagem de gestante para áreas endêmicas deve ser realizada a vacinação uma vez que o risco de infecção é grande. Assim, a vacina da febre amarela não está rotineiramente indicada, mas, deve ser aplicada caso a gestante viaje para áreas endêmicas. Resposta Letra C.

281183.

Comentário: A vacina da hepatite A é administrada por via intramuscular e pode ser aplicada a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

partir de um ano de idade. Desde janeiro de 2016, passou a ser recomendado que a dose seja feita aos 15 meses, podendo ser realizada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Resposta letra C.

281185.

Comentário: A única vacina que não faz parte do calendário dao Ministério da Saúde é descrita na letra D vacina contra meningococo do tipo B. A vacina tríplice viral é feita aos 12 meses (sarampo, rubéola e caumba) a hepatite B é feita após o nascimento e aos 2, 4 e 6 meses na forma de penatavelente (DTP Hib hep B) a meningocócica C é feita aos 3 e 5 meses reforço aos 12 meses e HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Resposta letra D.

251919.

Comentário: Questão objetiva sobre imunização. A vacina contra o HPV está disponível no Programa Nacional de Imunização para meninas 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, em duas doses (0 e 6 meses). Há previsão de ampliar a cobertura para meninos mais jovens em 2020, mas até o momento está vigente a faixa etária descrita. Resposta da questão letra D.

251920.

Comentário: A desnutrição em crianças, como bem lembrado no enunciado, ainda é frequentemente encontrada em nosso país. Lembre-se de que os quadros de desnutrição grave se apresentam através de duas formas clínicas o marasmo e o kwashiorkor. A criança com marasmo apresenta emagrecimento acentuado, pobreza de subcutâneo, atrofia muscular, fácies senil, eventualmente alterações no cabelo. Já os pacientes com kwashiorkor podem apresentar hepatomegalia, face de lua cheia ou até anasarca (opção A incorreta). Para tratar os desnutridos graves que necessitam de internação, o primeiro passo é a estabilização. Na primeira semana, deve-se corrigir possível hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, hipotermia e iniciar antibioticoterapia. Apenas depois desta fase deve-se iniciar a recuperação nutricional e reposição de ferro (opção D incorreta). O uso de dietas hiperproteicas e hipercalóricas na fase de estabilização pode predispor à ocorrência da síndrome de realimentação (opção B incorreta). Um dos cuidados importantes relacionados com a hidratação diz respeito à dificuldade na avaliação do estado de desidratação da criança muitos parâmetros encontrados na criança com desidratação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

grave podem estar presentes pela própria desnutrição e, por isso, dados objetivos como diurese e frequência cardíaca devem ser usados (opção C correta). Resposta letra C.

251932.

Comentário: A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e cada vez mais prevalente na pediatria (opção A correta). Para o tratamento da obesidade infantil é fundamental uma abordagem multidisciplinar, com profissionais da medicina, nutrição, psicologia e educação física a fim de avaliar possíveis doenças associadas (como apneia do sono, hipertensão arterial, resistência periférica a insulina) e também compreender a dinâmica familiar e estabelecer estratégias para melhor adesão ao tratamento (opção C correta). Em casos selecionados, após avaliação médica, é possível a introdução de medicamentos como sibutramina (sacietógeno, liberado a partir dos 14 anos) e orlistat (reduz em até 30% a absorção de gordura) em adolescentes (opção B correta). Deve-se sempre buscar uma reeducação alimentar, com redução do consumo energético e atividades regulares, porém dietas muito restritas não se mostram eficazes em longo prazo (letra D incorreta). Resposta letra D

251934.

Comentário: O Kwashiorkor e o marasmo se manifestam clinicamente de forma distinta. As principais características do Kwashiorkor são retardo no crescimento, perda de gordura subcutânea e muscular menos intensa que no marasmo, edema depressível que se localiza principalmente nas pernas, mas pode ser generalizado (incluindo ascite), nas crianças que caminham, mas que pode atingir todo o corpo, hepatomegalia acentuada devido a esteatose hepática, e alterações mentais e de humor. Podem ocorrer lesões de cabelos (textura, cor, sem brilho, queda) generalizadas ou localizadas (sinal da bandeira), e também lesões de pele (despigmentação, dermatose de áreas de fricção, descamação). A criança com marasmo avançado tem um aspecto inconfundível. É muito magra, com evidente perda de massa muscular, extremidades muito delgadas e abdomen às vezes proeminente. A face tem uma aparência de velho ou simiesca devido à perda da bola gordurosa de Bichat. Resposta letra C.

217700.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação profilática de 400 UI dia a partir da primeira semana de vida até os 12 meses, e de 600 UI dia dos 12 aos 24 meses, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo, independentemente da região do país. Para os recém-nascidos pré-termo, a suplementação oral de vitamina D (400 UI dia) deve ser iniciada quando o peso for superior a 1500 g e houver tolerância plena à nutrição enteral. Nos grupos de risco, descritos no tópico avaliação do estado nutricional relativo à vitamina D, recomenda-se a dose mínima diária de 600 UI, monitorando as concentrações séricas de 25-OH-D, sempre que possível, e, se necessário, reajustando a dose. Em relação à duração da exposição ao sol, recomenda-se 30 minutos de exposição solar semanal (ou 6 a 8 minutos por dia, três vezes por semana) para lactentes apenas com fraldas, no primeiro ano de vida, ou de 2 horas semanais (17 minutos por dia) em lactentes com vestimentas (apenas face e mãos expostas). Resposta letra D.

182618.

Comentário: I. Correta. Os sinais clássicos de hipoglicemia como palidez, hipotermia, sudorese e perda da consciência nem sempre estão presentes. II. Incorreta. São distúrbios hidroeletrolíticos frequentes no desnutrido hipopotassemia, hiponatremia, hipomagnesemia (e não hiper). III. Correta. São 3 etapas de tratamento da DEP grave fase de estabilização ou inicial, fase de reabilitação ou de crescimento rápido e fase de seguimento ou acompanhamento. Sendo assim, as afirmativas corretas são I e III. Resposta letra D.

182665.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) INCORRETA. Atualmente, além da vacina contra o HPV ser disponibilizada para as meninas entre 9 e 14 anos, esta também pode ser feita para os meninos com idade entre 11 e 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), com esquema vacinal de 2 (duas) doses (0 e 6 meses). B) INCORRETA. Sabemos que a vacina BCG é administrada em dose única ao nascer. C) CORRETA. Desde de abril de 2017, o Ministério da Saúde adotou a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é a aplicação de uma dose única da vacina contra febre amarela para toda a vida, a partir dos 9 meses. D) CORRETA. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vacinação contra hepatite B é recomendada aos 15 meses de idade em dose única. Como vimos, temos 2 alternativas incorretas, mas gabarito divulgado letra B.

183214.

Comentário: A vacina anti-hemófilos tipo B protege contra a doença invasiva pela bactéria, ou seja, epiglotite, meningite, entre outras. Infecções associadas com cepas de hemófilos não tipável, como as infecções respiratórias agudas, não tem a sua incidência modificada pela utilização dessa vacina. Sendo assim, as crianças não apresentarão proteção para otite com a aplicação desta vacina. Resposta letra B.

159090.

Comentário: A vacina BCG é administrada por via intradérmica e, no local de inoculação, podemos observar a formação de uma cicatriz vacinal. A formação dessa cicatriz demora semanas e , no local, podemos acompanhar a evolução de uma lesão. Até o final de 2018, o Ministério da Saúde recomendava que quando não ocorresse a formação de cicatriz seis meses após a dose inicial, uma segunda dose fosse feita. Não havia a necessidade de se realizar uma prova tuberculínica antes disso. A partir de janeiro de 2019, esta revacinação deixou de ser recomendada, pois dados da OMS apontam que a falta de cicatriz não indica a falta de proteção. Resposta (na época do concurso) letra C.

135951.

Comentário: Questão decoreba mas bem objetiva. A classificação de Gomez avalia a adequação do peso da criança em relação ao peso do percentil 50 para a idade e o sexo...ou seja, é uma regrinha de 3. Se o peso desse paciente em relação ao P50 for superior a 90%, classificamos como normalidade se estiver entre 76-90%, desnutrição grau 1 (leve) se entre 61-75%, desnutrição grau 2 (moderada) e se menor que 60%, grau 3 (grave). Resposta correta Letra C.

108791.

Comentário: Mesmo sem colocarmos o paciente no gráfico ou sem o IMC, sabemos que a criança apresenta obesidade. Além disso, há dislipidemia (colesterol total 150, LDL 100, TG 100, HDL 45), há provável intolerância à glicose (glicemia de jejum entre 100-126 mg dl), além de hipertensão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

arterial provável (não temos o percentil de altura para classificar o grau de HAS). O tratamento de todas essas alterações deve ser iniciado de forma conservadora, sem uso de medicações com a adoção de mudanças alimentares, prática de atividade física e suporte psicossocial que deve abranger a família e contar com o apoio de equipe multidisciplinar. O uso de medicações é controverso e com indicações discutíveis, assim como a cirurgia bariátrica, mas sempre só são avaliados após período inicial de mudanças de hábitos (letra C correta).

84474.

Comentário: A doença celíaca é uma doença autoimune, sendo causada pela intolerância permanente ao glúten, principal fração proteica presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia (primeira, segunda e quinta afirmativas falsas), se expressa por enteropatia mediada por linfócitos T em indivíduos geneticamente predispostos (terceira afirmativa verdadeira). A forma clássica da doença caracteriza-se por diarreia crônica com fezes volumosas, pálidas e gordurosas podendo ter evolução grave (quarta afirmativa verdadeira). Seu tratamento consiste em dieta sem glúten, devendo-se, portanto, excluir da alimentação tudo o que contenha trigo, centeio, cevada e aveia por toda a vida. Com a instituição de dieta totalmente sem glúten, há normalização da mucosa intestinal e das manifestações clínicas. É importante que se mantenha dieta isenta de glúten por toda vida nesses doentes, pois, mesmo quando assintomáticos, o dano à mucosa está presente. Complicações malignas (como o linfoma e o carcinoma de esôfago) e não malignas (como osteoporose e esterilidade) estão associadas a não obediência da dieta restrita, o que justifica a necessidade de manutenção da dieta por toda vida. Resposta letra A.

84494.

Comentário: Analisando as assertivas A CORRETA. Esse é o cálculo básico para se determinar o IMC. B CORRETA. Os estudos comprovam que, dentre os inúmeros benefícios da amamentação, se encontra a redução de distúrbios nutricionais na fase adulta, especialmente nos casos de amamentação exclusiva e sob livre demanda até os 4 a 6 meses de idade. C INCORRETA. O Departamento de Nutrologia da SBP adota o consenso proposto pela Federação Internacional de Diabetes que define síndrome metabólica em adolescentes entre 10 e 16 anos como aumento da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

circunferência abdominal (P90, segundo sexo e idade), associado a pelo menos duas das quatro anormalidades hipertrigliceridemia 150 mg dl, HDL 40 mg dl, HAS (sistólica 130 e diastólica 85 mmHg), intolerância à glicose (glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg dl ou presença de DM II). D CORRETA. O CDC define para os maiores de 2 anos sobrepeso e obesidade desta forma P85-P94 sobrepeso, P95 obesidade. E CORRETA. A principal causa é exógena, ou seja, elevado aporte energético e baixo gasto de calorias, responsável por mais de 90% dos casos. Resposta letra C.

84470.

Comentário: Crianças aos 10 anos de idade devem ser submetidas à análise do perfil lipídico. Ou antes, a partir dos 2 anos de idade, nas seguintes situações quando houver história familiar de doença aterosclerótica prematura e ou de dislipidemia ou se a própria criança apresentar xantomas ou arco corneano, fatores de risco (hipertensão arterial, diabete melito, obesidade) ou doença aterosclerótica. Em relação aos valores desejáveis, pela Sociedade Brasileira de Pediatria Colesterol total 150 mg dL, LDL colesterol 100 mg dL, HDL colesterol 45 mg dL, triglicerídeos 100 mg dL. Questão anulada, pois não foi digitado o sinal entre o HDL colesterol e 45 mg dL.

50100.

Comentário: Toda criança ou adolescente com níveis pressóricos acima do percentil 90 (para a faixa etária, sexo e altura) deve receber tratamento não medicamentoso. No caso em tela, seriam importantes algumas mudanças no estilo de vida , como dieta atividades físicas, a fim de reduzir o sobrepeso. Se a PA continuar elevada, devemos iniciar uma investigação para causas secundárias (lembrando que a principal etiologia da HAS secundária é renal) e considerar o pronto início de tratamento farmacológico anti-hipertensivo. Não há estudos suficientes a respeito do uso de anti-hipertensivos na infância adolescência, e a escolha dessas drogas segue os mesmos preceitos dos adultos. Contudo, é interessante citar uma exceção à regra adolescentes do sexo feminino possuem contraindicação relativa aos IECA e BRA, devido à possibilidade de gravidez indesejada e os consideráveis riscos dessas drogas para o feto. Perceba, então, que não há uma resposta adequada aqui (nenhuma fala das MEV). O gabarito da banca foi a letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37129.

Comentário: A síndrome metabólica também ocorre em crianças, mas sua definição não é tão consensual quanto em adultos. O principal critério é aquele proposto pela NCEP ATP III e semelhantes aos do adulto, com algumas modificações para a idade, sendo necessária a presença de pelo menos 3 de 5 parâmetros níveis de triglicérides 110 mg dL HDL 40 mg dL (independente de sexo) circunferência abdominal 90º percentil segundo sexo e idade glicemia 110 mg dL e pressão sistólica ou diastólica 90º percentil segundo sexo, idade e estatura. A prevalência da síndrome situa-se entre 0,4 e 26,3% segundo a amostra avaliada. Resposta C.

29391.

Comentário: O diagnóstico nutricional das crianças pode ser feito através da análise e da combinação de uma série de curvas. Quando utilizamos a curva peso idade da OMS, consideramos que a criança que se encontra abaixo do percentil 3 apresenta peso baixo para idade. Isso basta para minimamente nos sugerir um quadro de desnutrição.

307027.

Comentário: Todos os animais silvestres, como morcego de qualquer espécie, micos (sagui ou soim), macaco, raposa, guaxinim, quati, gambá, roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e ou domesticados, haja vista que, nesses animais, a patogenia da raiva não é bem conhecida. Assim, acidentes com esses animais são considerados graves. Também são considerados acidentes graves, independente do animal envolvido - Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e ou planta do pé - ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo - lambeduras de mucosas - lambeduras de pele onde já existe lesão grave - ferimentos profundos causados por unhas de animais Resposta opção B.

307028.

Comentário: Todos os animais silvestres, como morcego de qualquer espécie, micos (sagui ou soim), macaco, raposa, guaxinim, quati, gambá, roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ou domesticados, haja vista que, nesses animais, a patogenia da raiva não é bem conhecida. Assim, acidentes com esses animais são considerados graves. Segundo o Guia de Vigilância em Saúde, 3a edição, após acidentes com animais silvestres, a conduta é Lavar com água e sabão. Iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 4 (quatro) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via ID. Não é permitido suspender a profilaxia após observação do animal por 10 dias (isso é possível apenas no caso de acidente por cão ou gato doméstico). Resposta A.

307029.

Comentário: A assertiva A é CORRETA e foi relatada recentemente na literatura. Recentemente, foram observados micos infectados pelo vírus Herpes simiae, que pode causar doença grave em humanos e é transmissível pela mordedura. A assertiva B é incorreta. O ferimento deve ser sempre lavado com água e sabão. A assertiva C é incorreta. Não há indicação de vacinação antirrábica de rotina para estudantes, a não ser na seguinte situação estudantes de medicina veterinária e estudantes que atuem em captura e manejo de mamíferos silvestres potencialmente transmissores da raiva A assertiva D é incorreta. É necessária notificação de qualquer Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva . Resposta letra A.

315209.

Comentário: A deficiência nutricional que tipicamente cursa com a tríade dos três Ds é o pelagra, causado pela deficiência de NIACINA (vitamina B3). - Dermatite pode se desenvolver abrupta ou insidiosamente, mas geralmente é desencadeada pela exposição solar. Inicia-se como uma queimadura de sol, com eritema de superfícies expostas. Podem aparecer vesículas e bolhas. Essas lesões cicatrizam, descamam e deixam a pele subjacente hiperpigmentada. É também muito comum a localização em botas , em luvas e ao redor do pescoço. Podem estar associadas à glossite e à estomatite. - Diarreia existe espessamento e inflamação da parede do cólon a mucosa está atrofiada e recoberta por uma pseudomembrana. - Demência depressão, desorientação, insônia e delirium . Nos países em que a base da alimentação é o milho, pode ocorrer a deficiência dessa vitamina, haja vista o baixo teor de triptofano neste alimento. Além disso, a isoniazida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

também interfere no seu metabolismo. Os pacientes com doença de Hartnup, em que há um defeito congênito no transportador de triptofano a nível intestinal e túbulos renais, manifestam sintomas típicos da pelagra (LETRA C CORRETA). O escorbuto leva a manifestações hemorrágicas por deficiência de vitamina C (LETRA A INCORRETA). O beribéri é caracterizado por sintomas neurológicos e cardiovasculares por deficiência de vitamina B1 (LETRA B INCORRETA). A anemia ocorre por baixa quantidade de hemoglobina e tem múltiplas etiologias, inclusive a deficiência de fator intrínseco, responsável pela absorção de vitamina B12 (LETRA D INCORRETA). As porfirias são um grupo de desordem metabólica que levam à dificuldade no metabolismo do heme (LETRA E INCORRETA). Resposta letra C.

275988.

Comentário: Não há muita dúvida em relação ao diagnóstico de Rafael o quadro apresentado é clássico de sarampo. Vamos então relembrar os conceitos da profilaxia pós exposição ela está recomendada para todos os comunicantes suscetíveis, podendo ser feita com a aplicação da vacinação de bloqueio em até 72 horas ou da imunoglobulina em até 6 dias. A vacina está recomendada para as pessoas suscetíveis (ou seja, não vacinadas e que nunca tiveram a doença) do mesmo domicílio, vizinhos próximos, contactantes da creche, sala de aula, alojamento ou sala de trabalho. A vacina deve ser aplicada em pessoas entre 1 e 49 anos conforme as orientações do PNI. Para pessoas com mais de 50 anos que nunca receberam nenhuma dose, está recomendada dose única da tríplice viral. Para fins de bloqueio, crianças acima de 6 meses devem receber também uma dose, mas esta não é considerada como parte do calendário da criança. A imunoglobulina está indicada para pessoas que tenham contraindicação à vacina menores de 6 meses, gestantes e imunocomprometidos. Analisando então o caso, consideramos que todas as crianças são suscetíveis, logo precisam receber algum tipo de profilaxia. Jorge, por ser menor de 6 meses, não poderá receber a vacina, assim como Ana, que está gestante. Maria e Bernardo não apresentam contraindicação para a vacinação, portanto deverão recebê-la o quanto antes. Apenas um detalhe é impossível Ana estar gestante de 25 semanas, já que tem um filho de 4 meses O autor quis fazer tanta graça na questão que acabou fazendo confusão. Como isso não impede de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

chegarmos à resposta correta, não há muito o que discutir (vai que Jorge foi adotado, né).

Resposta letra E.

275991.

Comentário: Questão simples e direta Segundo o atual calendário de imunizações do Ministério da Saúde (MS), aos 12 meses de idade a criança recebe a primeira dose da tríplice viral, sendo a segunda dose aplicada aos 15 meses em conjunto com a varicela (tetraviral) reforço da pneumocócica 10V, visto que a criança recebeu duas doses prévias dessa vacina, aos 2 e 4 meses por fim, o reforço da meningocócoca C, após as duas doses aos 3 e 5 meses. Vale ressaltar que em 2020, o MS atualizou o seu calendário de imunizações incluindo a vacina ACWY (conjugada), que passa a ser aplicada em adolescentes de 11 e 12 anos. Resposta letra B.

283745.

Comentário: Em relação ao peso, consideramos como adequado para idade crianças entre 0 e 10 anos situadas entre os escores Z - 2 e Z 2. Acima do escore Z 2 a criança apresenta peso elevado para idade entre Z - e Z -3, baixo peso para idade e abaixo do Z -3, muito baixo peso para a idade. Portanto, o ganho de peso desta criança está adequado. Em relação à estatura, consideramos como adequadas todas as crianças acima do escore Z - 2. Entre z - 2 e Z -3, consideramos baixa estatura e abaixo de Z - 3, muito baixa estatura. Portanto, o crescimento também está adequado. Resposta letra A.

231365.

Comentário: Questão sobre vacinas na gravidez. Importante lembrar da regra sobre vacinas na gestação não devem ser utilizadas vacinas de microrganismos atenuados, como sabin, caxumba, sarampo, rubéola, varicela, febre amarela... Por outro lado, são permitidas as vacinas de microrganismos mortos e fragmentos virais, como vacina contra hepatite A, hepatite B, dT, dTpa, H1N1, gripe, raiva e meningococo. Atenção porque algumas vacinas permitidas, como a vacina contra hepatite A, apesar de liberadas não são recomendadas de rotina pelo Ministério da Saúde. Resposta letra A.

249204.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas a letra A está incorreta uma nutrição inadequada terá maiores repercussões no ganho ponderal, não no crescimento do perímetro cefálico. A letra B está correta atraso no desenvolvimento global pode cursar com incoordenação de sucção-deglutição-respiração, podendo haver prejuízo da alimentação da criança. A letra C está Incorreta não raramente os bebês nascidos prematuros apresentam alterações sensitivas como aversão ao contato oral. A letra D está incorreta muitos são os fatores responsáveis pela causa do déficit de crescimento em prematuros. Esses bebês são privados de um período crítico de crescimento intrauterino acelerado (o terceiro trimestre de gestação). Acrescido a este fato, estes prematuros apresentam elevada morbidade neonatal, o que implica aumento dos gastos energéticos e das necessidades nutricionais, e ainda enfrentam sérias restrições na oferta e ou aproveitamento dos nutrientes. Resposta letra B.

252918.

Comentário: Ao nascimento, todas as crianças devem ser vacinadas com as vacinas BCG e hepatite B. Ambas podem ser administradas o mais precocemente possível, sendo que o Ministério da Saúde recomenda a hepatite B nas primeiras 12 horas de vida e a BCG antes da alta do recém-nascido da maternidade, que geralmente ocorre com 48 horas de vida. Resposta letra C.

252919.

Comentário: Ao nascimento, todas as crianças devem ser vacinadas com as vacinas BCG e hepatite B. Ambas podem ser administradas o mais precocemente possível, sendo que o Ministério da Saúde recomenda a hepatite B nas primeiras 12 horas de vida e a BCG antes da alta do recém-nascido da maternidade, que geralmente ocorre com 48 horas de vida. Resposta letra B.

252920.

Comentário: A vacina BCG é aplicada em dose única logo após o nascimento. No entanto, caso o peso ao nascimento seja inferior a 2.000 gramas, a vacinação é adiada até que a criança atingir este peso. Resposta letra B.

252927.

Comentário: Questão objetiva sobre classificação de peso e comprimento ao nascer. Vamos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

relembrar a classificação - Peso adequado para a idade gestacional entre p10 e p90 - Baixo peso para idade gestacional (PIG) - Grande para a idade gestacional (GIG) p90 Olhando a curva percebemos que se trata de um paciente entre o P10 e p90, loogo, adequado para a idade gestacional. Gabarito letra A

252928.

Comentário: Questão de puericultura recorrente nas provas de Residência Médica. Observamos um lactente cujo peso está abaixo do escore Z (EZ -3), portanto, inferior ao esperado (faixa de normalidade entre EZ -2 e 2). Sobre a estatura, observa-se criança acima do EZ -2, portanto, com estatura adequada. Gabarito letra D

252929.

Comentário: TOdo o caso clínico foi desnecessário para a questão o autor quer saber apenas a partir de que idade usamos o IMC como parâmetro confiável na avaliação nutricional da criança. Entre 0 e 5 anos, o parâmetro para indicar magreza, eutrofia ou obesidade é a relação do peso estatura, enquanto que a partir dos 5 anos, usamos o valor do IMC idade. Crianças abaixo do z -3 são classificadas como magreza acentuda. Entre Z - 3 e Z - 2, magreza. Crianças eutróficas são aquelas entre o score Z - 2 e Z 1. Entre Z 1 e Z 2, crianças de 0 a 5 anos têm risco de sobrepeso, mas a partir dos 5 anos já são consideradas como sobrepeso. Entre z 2 e Z 3, crianças de 0 a 5 anos têm sobrepeso, enquanto a partir de 5 anos são obesos. Acima do score Z 3, crianças de até 5 anos são consideradas obesas, enquanto maiores de 5 anos têm obesidade grave. Resposta letra C.

252933.

Comentário: Questão sobre vacinação contra o HPV. Vamos, então, relembrar que esta vacina é disponibilizada pelo SUS para Meninas de 9 a 14 anos e Meninos de 11 a 14 anos. Resposta letra C.

201773.

Comentário: A questão pede as vacinas dentre as alternativas que podem ser feitas na gestação. As vacinas tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola), a contra varicela e a pólio oral são

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

compostas por vírus vivo atenuado e são contraindicadas na gravidez. A vacina contra febre amarela geralmente é contraindicada na gravidez, por também ser composta por vírus vivo atenuado, mas pode ser liberada em situações de surto para gestante que resida em área endêmica ou em caso de viagem inevitável para essas áreas, devido à alta morbidade da doença na gestação. As vacinas contra hepatite A e B, bem como a vacina contra influenza, são compostas por vírus inativado e são consideradas seguras na gravidez. Resposta letra A.

219913.

Comentário: Até janeiro de 2019, tinhamos a recomendação de revacinar todas as crianças que não desenvolveram cicatriz vacinal após 6 meses da vacinação com BCG, sem necessidade de realização de exame laboratorial. A prova foi elaborada antes dessa recomendação, mas mesmo assim a banca anulou a questão para não prejudicar ninguém. Segundo o conteúdo da nota técnica de 01 02 2019 do Ministério da Saúde, temos a recomendação de não revacinar crianças que receberam a BCG e não desenvolveram a cicatriz vacinal, independentemente do tempo transcorrido após a vacinação.

219897.

Comentário: A questão pergunta qual é a afirmativa incorreta. Logo de início já vemos que é a alternativa A, pois a criança maior de 5 anos que se encontra no gráfico de IMC para idade entre Z escore 2 e 3 é classificada como obesa, e não como sobrepeso. Paciente apresenta possível quadro de esteatose hepática e, por isso, devemos solicitar uma USG de abdome, além de exames laboratoriais como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e lipidograma. O exame físico deve incluir a aferição da pressão arterial OBRIGATORIAMENTE em todas as crianças maiores de 3 anos de idade, independente da presença de sobrepeso ou obesidade. A orientação nutricional e de hábitos saudáveis (como atividade física) também é fundamental. Resposta letra A.

212186.

Comentário: Questão simples e conceitual Dentre as doenças citadas apenas a RAIVA é transmitida pela presença do vírus na saliva de ANIMAIS INFECTADOS. Sífilis, gonorreia, hepatite B e tuberculose não são transmitidas pela saliva. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212156.

Comentário: Para o momento, temos que analisar as possíveis pendências penta (DPT Hib hepatite B) falta 1 dose (o total seriam 3doses) VIP falta 1 dose (o total seriam 3 doses) pneumocócica-10 valente falta a 2ª dose (total de 2 doses mais um reforço) rotavírus fez 1 dose, mas lembre-se que a segunda só pode ser aplicada até 7 meses e 29 dias de vida. Resposta letra D.

216290.

Comentário: Questão baseada no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde de 2017. Vamos ao trecho do documento que responde a questão na parte cujo título é Vigilância dos eventos adversos pós-vacinação . Manifestações neurológicas - raramente algumas vacinas de vírus vivos atenuados ou mortos podem anteceder a síndrome de Guillain-Barré (SGB), (letra A - CORRETA) que se manifesta clinicamente como polirradiculoneurite inflamatória com lesão de desmielinização, parestesias e deficit motor ascendente de intensidade variável . (letra B - INCORRETA) Geralmente, os sintomas aparecem entre 7 e 21 dias, no máximo até 42 dias (6 semanas) após a exposição ao possível agente desencadeante. (letra C - CORRETA) Até o momento, há poucas evidências se a vacina influenza pode aumentar o risco de recorrência da SGB em indivíduos com história pregressa desta patologia. (letra D - CORRETA) Recomenda-se precaução na vacinação dos indivíduos com história pregressa da SGB, mesmo sabendo ser bastante rara. Os riscos e benefícios devem ser discutidos com o médico. Resposta letra B.

182774.

Comentário: Existem mais de 40 definições de SÍNDROME METABÓLICA na infância e adolescência, todas com adaptações dos critérios para adultos. Os critérios diagnósticos mais importantes levam em consideração 1) cintura abdominal igual ou maior que o percentil 90 para idade e sexo 2) PA sistólica ou diastólica maior que o percentil 90 para idade e sexo 3) parâmetros laboratoriais glicemia de jejum 110 mg dl triglicerídeos 110 mg dl e HDL 40 mg dl. O tratamento consiste no controle dos componentes da síndrome e envolvem perda de peso, mudança de hábitos de vida, atividade física e uso de medicações (ex metformina, orlistat, sibutramina, etc). A opção A traz o parâmetro aceito da OMS. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182779.

Comentário: Sobre o tratamento da síndrome metabólica A- Incorreta. A metformina é a medicação de escolha para os casos em que é necessário uso de medicamentos. B- Incorreta. Em raros casos selecionados, o tratamento medicamentoso está indicado em idades inferiores. C- Correta. O tratamento nunca deve ser iniciado com medicamentos, optando-se sempre inicialmente as medidas conservadoras. D- Incorreta. Jovens entre 16-18 anos podem ter o tratamento cirúrgico indicado, mas estarão aptos a recebê-lo no caso de um IMC maior que 3 (obesidade grave). Resposta letra C.

187797.

Comentário: A recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à vacinação de prematuros com a vacina contra a Hepatite B é de obrigatoriamente quatro doses (esquema 0 - 2 - 4 - 6 meses), em RN nascidos com peso inferior a 2.000 g ou idade gestacional menor que 33 semanas, sendo a primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. Por isso, a opção B encontra-se incorreta. A BCG, de fato, deve ser adiada até que o peso esteja igual ou maior que 2kg. A vacina contra rotavírus, por ser composta de vírus vivo atenuado, não deve ser aplicada em ambiente hospitalar, e deve-se utilizar a vacina acelular contra a coqueluche, se possível (DTPa). Resposta letra B.

182800.

Comentário: Paciente diabéticos possuem indicação de vacinação para influenza, pneumococo (pneumo 23 e 13) e hepatite B, para prevenção de internação hospitalar, sendo as medidas higiênicas e de imunização as mais efetivas para este objetivo (alternativa A correta). Não há contraindicação pelo diabetes ou por níveis glicêmicos de nenhuma imunização específica (alternativas C e D corretas). No entanto, para recomendação de vacinação deve-se considerar os riscos da doença e os benefícios da vacinação (alternativa B incorreta). Gabarito Alternativa B.

182811.

Comentário: A vacina contra o herpes zoster é recomendada como rotina para maiores de 60 anos de idade. São contraindicações pessoas imunodeprimidas, anafilaxia a algum componente da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vacina, pacientes com tuberculose ativa não tratada e gestantes. Resposta letra D.

181365.

Comentário: A medida da circunferência abdominal deve ser realizada na altura da crista ilíaca (LETRA A INCORRETA). Mais badalados nas academias para quem deseja perder gordura, a medida das pregas cutâneas pode estimar a adiposidade (LETRA B INCORRETA). A circunferência abdominal tem relação direta com comorbidades como hipertensão, doença coronariana, diabetes e síndrome metabólica, sendo inclusive critério para essa última (LETRA C INCORRETA). A importância do incremento na curva de IMC depende de idade e padrão familiar. Mudanças nos percentis de altura e peso são relativamente comuns, porém mudanças importantes (por exemplo, acima da linha de dois percentis principais) não são comuns, principalmente acima dos quatro anos de idade, e devem chamar atenção pois aumentam o risco de obesidade (LETRA D INCORRETA). Finalmente, a relação da circunferência abdominal e estatura, nem sempre usada no dia a dia, pode estimar risco de doenças como o DM2 quando superior a 0,5 (LETRA E CORRETA). Gabarito, portanto, letra E.

152639.

Comentário: Questão simples Dentre as doenças relatadas, quais são aquelas que são imunopreveníveis, ou seja, que tem vacina contra a doença Tétano, difteria e coqueluche com a DTP sarampo e rubéola, ambas em conjunto com a caxumba, são preveníveis com a tríplice viral e, em conjunto com a varicela, com a tetra viral febre amarela com a vacina contra a própria doença. Escarlatina, calazar e malária não apresentam vacina contra a doença. No que se refere à malária, a vacina está sendo produzida e atualmente encontra-se na fase final de testes em humanos. No entanto, ainda não encontra-se disponível no mercado. Resposta letra D.

161354.

Comentário: As vacinas contraindicadas na gestação são as que apresentam agentes vivos atenuados, que são a vacina contra a Febre amarela, HPV, dengue, varicela e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Logo, a resposta é a letra B.

158798.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas feitas sobre a vacina BCG. A primeira afirmativa é verdadeira de fato, os eventos adversos associados com a vacina BCG não são comuns e podem ser eventos adversos locais, regionais ou sistêmicos. Tais eventos podem ser decorrentes do tipo de cepa utilizada, da quantidade de bacilos atenuados administrada, da técnica de aplicação e da presença de imunodeficiência primária ou adquirida. A segunda afirmativa também é verdadeira o principal objetivo desta vacina é a prevenção das formas graves de tuberculose, como a tuberculose miliar e a meningoencefalite tuberculosa. Ainda que exista uma proteção para as formas pulmonares, essa proteção não é considerada significativa e não consegue interromper a cadeia de transmissão. A terceira afirmativa é falsa não há tal distinção. E, por fim, a quarta afirmativa é falsa a revacinação é feita apenas uma única vez, porém deve-se aguardar um prazo de seis meses após a vacinação antes de se indicar a revacinação. Resposta letra B.

158758.

Comentário: Esta criança recebeu quase todas as vacinas indicadas no primeiro ano de vida. A única vacina que não foi feita no primeiro ano de vida foi a a segunda dose da vacina oral contra o rotavírus humano, feita aos quatro meses. Porém, essa vacina não poderá mais ser feita, pois a idade limite para a sua administração é de sete meses e 29 dias. Assim, o que essa criança deverá receber agora são algumas vacinas que deveriam ter sido feitas aos 12 e aos 15 meses. Aos 12 meses, recomendam-se três vacinas a vacina tríplice viral, o reforço da vacina pneumocócica e o reforço da vacina meningocócica (este foi feito). Aos 15 meses, deveria ter recebido a vacina contra hepatite A, o reforço da vacina DTP (lembre-se de que não há reforço de pentavelente, apenas de DTP), o reforço da vacina contra poliomielite, feito com a vacina oral, e a vacina tetraviral (feita apenas após a criança já ter recebido a vacina tríplice viral anteriormente). Assim, todas essas vacinas deverão ser feitas agora, exceto a tetraviral que será feita após 30 dias. Resposta letra C.

134870.

Comentário: O Kwashiorkor representa uma desnutrição grave, sendo que essa condição já é o suficiente para indicar o tratamento desta criança sob internação hospitalar. A primeira fase do tratamento da desnutrição grave é a fase de estabilização, que apresenta o objetivo de evitar o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

óbito. No caso em questão, a criança apresenta infecção, devendo ser realizada antibioticoterapia endovenosa e encarada como sepse. Lembrar que nesta fase não tem o intuito de realizar a recuperação nutricional da criança, mas sim de estabilizá-la para evitar descompensações metabólica, hidroeletrolítica, infecciosa, entre outras.

134050.

Comentário: A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) tem por finalidade promover uma rápida e significativa redução da mortalidade na infância. Trata-se de uma abordagem da atenção à saúde na infância, desenvolvida originalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência (UNICEF), caracterizando-se pela consideração simultânea e integrada do conjunto de doenças de maior prevalência na infância desnutrição, doenças diarreicas, infecções respiratórias agudas, malária e afecções perinatais. Resposta letra B.

134054.

Comentário: Nas consultas de puericultura o sobrepeso e a obesidade devem ser combatidos através de diversas medidas profiláticas que precisam ser devidamente orientadas a pais e responsáveis hábitos de vida saudáveis (prática regular de exercícios físicos, horário de sono adequado) e alimentação adequada (aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, alimentação balanceada e variada, redução do consumo de sódio e alimentos industrializados processados, intervalos e quantidade de refeições corretos). O uso de medicamentos como medida preventiva não está indicado, devendo estar reservados apenas para tratamento da obesidade sintomática e associada a comorbidades graves. Resposta letra C.

134317.

Comentário: A vacina contra o Haemophilus influenzae do tipo B integra a vacina penta. É recomendada em três doses no primeiro ano de vida aos 2, 4 e 6 meses. Depois disso, são feitos dois reforços apenas com a DTP, aos 15 meses e 4 anos. Resposta letra C.

134260.

Comentário: A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, em que ocorre uma sobreposição de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fatores genéticos e ambientais. A obesidade exógena (acarretada por ingestão alimentar excessiva) consiste no tipo mais comum, responsável por 95 a 98% dos casos. Resposta letra D.

134262.

Comentário: Em relação a obesidade temos as alternativas Letra A) A obesidade exógena é a principal causa de obesidade em crianças. Porém, muitas alterações genéticas cursam com obesidade como as síndromes de Turner, Prader-Willi e outras. CORRETA Letra B) Na abordagem da obesidade em crianças, o tratamento se baseia na mudança dos hábitos de vida. Porém, nos casos associados a comorbidades importantes, o tratamento medicamentoso pode ser necessário. INCORRETA Letra C) A obesidade é uma importantíssima causa de resistência à insulina nas crianças, estando também associada à dislipidemia, diabetes melittus tipo II (que pode, muitas vezes, ter início ainda na adolescência) e complicações cardiovasculares a longo prazo. CORRETA Letra D) O tecido adiposo atua como órgão secretório ativo, liberando peptídeos e citocinas na circulação. A obesidade exógena está associada a um processo mais rápido de maturação com aceleração do crescimento e desencadeamento da puberdade mais precocemente. CORRETA Resposta letra B.

134819.

Comentário: O raquitismo é um defeito da mineralização óssea, caracterizado por anormalidades na formação na placa epifisária de crescimento, com áreas não mineralizadas, devido a baixa concentração extracelular de cálcio e fósforo, causado pela deficiência da vitamina D. Os primeiros sinais e sintomas podem surgir nos primeiros meses de vida e progredir com a idade, principalmente nas regiões de desenvolvimento mais rápido. Há atraso no fechamento das fontanelas cranianas, no crescimento e desenvolvimento motor fronte olímpica, craniotabes e retardo na erupção dos dentes. O abaulamento da junção costo-condral determina o aparecimento do sinal conhecido como rosário raquítico. Os ossos longos apresentam extremidades alargadas, encurvamentos, genu varo ou valgo, coxa vara. Sendo assim, o único achado incompatível entre as alternativas listadas é a letra C

134265.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A obesidade está relacionada a várias complicações, como também a uma maior taxa de mortalidade. Entre as complicações frequentes e que podem ser notadas em curto prazo estão os problemas ortopédicos, respiratórios, transtornos psicossociais, dificuldade de relacionamentos e isolamento social e além de comprometer a postura e causar alterações no aparelho locomotor, e trazer incômodos no convívio social na vida adulta. O excesso de gordura na região abdominal e o excesso de gordura visceral são aspectos da composição corporal associados à ocorrência de doenças crônico-degenerativas o aumento do colesterol sérico é um fator de risco para doença coronariana, e esse risco é ainda maior quando associado à obesidade. As consequências da obesidade têm início ainda na infância, como a formação das placas ateroscleróticas que causam problemas cardiovasculares, e atualmente 60% das crianças com excesso de peso apresentam dislipidemia e hipertensão arterial. A aterosclerose tem início na infância, com o depósito de colesterol na íntima das artérias musculares, formando estrias gordurosas. Essas estrias nas artérias coronarianas de crianças podem, em alguns indivíduos, progredir para lesões ateroscleróticas avançadas em poucas décadas. Este processo é reversível no início do seu desenvolvimento, sendo o ritmo de progressão variável. Uma das causas frequentes de pseudotumor cerebral é a trombose venosa cerebral, doença onde ocorre uma trombose focal em alguma veia do cérebro, o que causa falha na reabsorção do líquor cerebral, ocasionando o pseudotumor. Trombos de maneira geral podem ocorrer na obesidade como relatado a cima. A esofagite eosinofílica não está relacionada a obesidade na criança. A esofagite eosinofílica acomete geralmente adultos jovens, principalmente homens, com uma prevalência variável nos estudos entre 0,002 a 6%. Seu sintoma mais importante é a disfagia para alimentos sólidos (sensação de parada de progressão do bolo alimentar). Gabarito letra A.

110553.

Comentário: As comorbidades mais associadas à obesidade são 1) Dermatológicos acantose nigricans , candidíase, furunculose, estrias, celulite, acne e hirsutismo 2) Ortopédicos genu valgum , epifisiólise da cabeça do fêmur, osteocondrites, artrites degenerativas, pé plano 3) Cardiovasculares hipertensão arterial 4) Respiratório síndrome da apneia obstrutiva do sono e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

asma 5) Hepáticos colelitíase, esteatose hepática não alcoólica 6) Gastrointestinais refluxo gastroesofágico e constipação intestinal 7) Geniturinários síndrome dos ovários policísticos, pubarca precoce, incontinência urinária 8) Sistema nervoso pseudotumor cerebral, problemas psicossociais. Gabarito letra C.

110559.

Comentário: O enunciado nos apresenta um pré-escolar de 3 anos com óbvio deficit ponderal. Basta nos lembrarmos de que, por volta de 1 ano, a criança triplica seu peso de nascimento, e este paciente não alcançou o triplo de seu peso de nascimento aos 3 anos de idade. Porém a questão solicita a classificação do estado nutricional. A classificação de Gomez calcula o percentual de adequação entre o peso medido e o peso esperado para a idade, de acordo com o gênero, e classifica o paciente em eutrófico, desnutrido de 1 grau, desnutrido de 2 grau e desnutrido de 3 grau. Se utilizarmos a fórmula de peso, na qual P Idade x 2 9, teríamos que esta criança deveria ter, em média, 15 kg. Portanto, apresenta um deficit de 6.100 g, isto é, um deficit de 40% em relação ao ideal. Logo, pela classificação de Gomez, esta criança tem uma desnutrição de III grau ou grave. De acordo com a análise do Medgrupo, a resposta correta é a letra E.

110566.

Comentário: Uma criança no percentil 98 no gráfico de peso pode ser classificado como peso elevado para idade (no gráfico peso x idade) e sobrepeso (no gráfico peso x estatura). Para esta criança apresentando distúrbio nutricional, é importante que sejam pesquisadas as comorbidades que podem acompanhar o sobrepeso obesidade, como a dislipidemia e o diabetes. Assim, devem ser solicitadas a glicemia de jejum, colesterol total e dosagem de triglicerídeos. Gabarito letra D.

110571.

Comentário: A forma ideal de acompanharmos o crescimento na infância (peso e estatura) é através da construção de sua curva de crescimento e da comparação dos dados obtidos com os referenciais populacionais. Mas, também devemos memorizar o incremento esperado na estatura de uma criança, pois ajuda quando não temos os gráficos disponíveis, como nesse caso para aquelas entre 2 - 12 anos altura idade (anos) x 6 77. Nesse caso, a criança tem 6 anos e seis

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

meses 6,5 x 6 77 116 cm seria a altura média esperada para idade. Essa criança apresenta exatamente 116 cm, possuindo, portanto, altura adequada. Em relação ao peso esperado para crianças de 1-6 anos Peso (kg) idade (anos) x 2 8 20 kg. Ou seja, a criança da questão está com o peso adequado e estatura adequada. Portanto, devemos tranquilizar a família e reavaliar o crescimento em 6 a 12 meses para cálculo da velocidade de crescimento. Gabarito letra A.

49640.

Comentário: Na criança desnutrida, ocorre atrofia da mucosa do trato gastrointestinal e diminuição da atividade enzimática (a ação das dissacaridades, lipases, e amilase está diminuída), o que leva a um processo de má absorção, com aparecimento de diarreia crônica. Ocorre, também, diminuição importante da atividade das dissacaridades como a sacarase, maltase e lactase, e a redução da função desta última enzima é responsável pela intolerância à lactose existente nesses pacientes. Além disso, a depressão da secreção pancreática, inclusive da lipase, e o metabolismo anormal dos sais biliares, contribuem para a má digestão e absorção dos lipídios da alimentação e, consequentemente, para a piora do estado nutricional. O fígado pode ser considerado como o órgão mais afetado pela desnutrição, sendo a esteatose a lesão mais importante, observada principalmente no Kwashiorkor . Essa lesão é reversível, e pode estar também acompanhada de fibrose perilobular, com evolução desfavorável para cirrose. Visto isso, temos como resposta correta a letra C.

49575.

Comentário: Sabemos que a obesidade é uma realidade no atendimento a crianças e adolescentes, em número cada vez maior, tanto em países pobres, quanto em países ricos, e tornou-se um importante problema de saúde no Brasil. Fatores genéticos, perinatais, alimentares, ambientais e endocrinometabólicos estão envolvidos na patogênese dessa doença. É importante termos em mente que a grande maioria dos casos de obesidade (mais de 90%) é decorrente da reunião entre predisposição genética, alto consumo calórico e baixo gasto energético o que configura obesidade primária, não havendo condição patológica associada, e a base do tratamento envolve reeducação alimentar e atividade física, com reforço para a redução de atividades sedentárias, como televisão,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

computador e videogame. Resposta letra D.

298263.

Comentário: Este lactente de oito meses apresenta um atraso vacinal e pela idade, não poderá mais receber a vacina oral contra rotavírus (a segunda dose só pode ser realizada até 7 meses e 29 dias). Por isso, já eliminamos as alternativas A e C. Mesmo que o paciente não apresente cicatriz da BCG, como há comprovação de que recebeu esta vacina, não há recomendação de realizá-la novamente - por isso, também eliminamos a alternativa D. O paciente só recebeu duas doses de vacina contra hepatite B, então deverá receber mais uma neste momento, além de mais uma dose da tetravalente (DTP Hib). De forma inadequada, esta criança recebeu a vacina oral contra poliomielite, quando deveria ter recebido a vacina inativada, mas não existe contra-indicação de seguir neste momento com o esquema adequado, por isso iremos realizar a VIP. Até poderíamos questionar a resposta, já que a alternativa está incompleta (a criança também deveria receber vacina antipneumocócica e antimeningocócica), mas a resposta liberada pela banca não está incorreta, pois contempla todas as vacinas que a criança deve receber neste momento. Resposta letra B.

286745.

Comentário: Gestante com passado vacinal desconhecido deve ser vacinada com todas as vacinas recomendadas no período gravídico. São elas hepatite B, dT e dTpa (sendo a dTpa administrada após as 20 semanas) e influenza. A tríplice viral, por conter vírus vivo atenuado, é contraindicada durante a gestação. Resposta letra A.

286761.

Comentário: Vamos analisar cada uma das alternativas a) INCORRETA. As principais fontes de vitaminas do complexo B (riboflavina, piridoxina, cobalamina) são as fontes animais, como carnes, leite e ovos. b) INCORRETA. A vitamina K realmente tem importância na síntese dos fatores de coagulação , mas é uma vitamina lipossolúvel. c) INCORRETA. As principais fontes alimentares da vitamina A pré-formada são fígado, rim, gema de ovo e manteiga. A provitamina A (beta-caroteno) é encontrada principalmente em vegetais de folhas verdes, batata-doce e cenoura. d) CORRETA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Poucos alimentos contêm vitamina D naturalmente (os fígados de peixes gordurosos são a exceção) a síntese dérmica é a principal fonte natural da vitamina e a síntese pode sofrer influência dos fatores descritos, por causa do aumento ou redução da exposição ao sol. A suplementação está recomendada para todas as crianças a partir do final da primeira semana de vida até os 2 anos. Resposta letra D.

286773.

Comentário: Uma das principais causas de baixa estatura patológica no sexo feminino é a síndrome de Turner, principalmente encontrarmos atraso puberal associado. Na síndrome podemos ter a presença de várias alterações fenotípicas, porém, em um percentual dos casos a única alteração observada na infância pode ser alteração do crescimento. Estas pacientes apresentam disgenesia gonadal e, por isso, não produzem os esteroides sexuais, apesar da presença de gonadotrofinas é uma forma de hipogonadismo hipergonadotrófico. Deverá seja feita a solicitação do cariótipo para confirmação do diagnóstico. Resposta letra C.

286776.

Comentário: Recém-nascidos contactantes de um paciente com tuberculose ainda bacilífero podem ser infectados pelo M. tuberculosis e desenvolver formas graves da doença. Nessas situações, recomenda-se a prevenção da infecção latente. O RN não deverá ser vacinado com a BCG ao nascer. Recomenda-se utilizar a isoniazida por três meses e, após esse período, faz-se a Prova Tuberculínica (PT). Se o resultado da PT for 5 mm, a isoniazida deve ser mantida por mais três meses, completando seis meses de tratamento, e o RN não deverá ser vacinado para BCG, uma vez que já apresenta resposta imune ao bacilo da tuberculose. Caso o resultado da PT seja inferior a 5 mm, a medicação deve ser interrompida e a vacinação para BCG efetuada. Resposta letra B.

256604.

Comentário: A toxicidade aguda pela vitamina A se manifesta por pressão intracraniana aumentada, vertigem, diplopia, abaulamento da fontanela (em crianças), convulsões e dermatite esfoliante, podendo até levar ao óbito. Entre crianças que estão sendo tratadas para a deficiência de vitamina A, ocorre edema transitório das fontanelas em 2% dos bebês, e náuseas, vômitos e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dores de cabeça transitórios em 5% das crianças em idade pré-escolar. A intoxicação crônica por vitamina A é uma grande preocupação nos países industrializados e tem sido vista em adultos saudáveis em outros aspectos que ingerem 15 mg dia e em crianças que ingerem 6 mg dia por um período de vários meses. As manifestações são pele seca, queilose, glossite, vômitos, alopecia, desmineralização e dor óssea, hipercalcemia, aumento de linfonodos, hiperlipidemia, amenorreia e características de pseudotumor cerebral com aumento da pressão intracraniana e papiledema. A intoxicação crônica por vitamina A pode levar à fibrose hepática com hipertensão portal e desmineralização óssea. Cuidado para não confundir a deficiência de vitamina A causa xeroftalmia, que inclui estágios brandos de cegueira noturna e xerose conjuntiva (secura) com manchas de Bitot (placas brancas de epitélio queratinizado evidenciadas na esclera), assim como a rara ulceração da córnea, que leva potencialmente à cegueira e à necrose. A ceratomalacia (amolecimento da córnea) também é encontrada em estados de deficiência desta vitamina e leva a uma escarificação da córnea, causando cegueira. Qualquer estágio da deficiência de vitamina A leva a um risco aumentado de morte por diarreia, disenteria, sarampo, malária ou insuficiência respiratória (a deficiência de vitamina A pode comprometer as defesas de barreiras, imunológicas inatas e adquirida contra infecções). Resposta letra A.

252284.

Comentário: A hipervitaminose A pode se manifestar com quadro clínico muito característico e por este motivo acaba eventualmente sendo solicitado nas provas de Residência. Pacientes que fazem uso crônico da vitamina A, podem evoluir com um quadro agudo semlhante a um pseudotumor cerebral (cefaleia, vômitos, papiledema, abaulamento de fontanelas) e quadro crônico, com queda de cabelo, descamação, anorexia. O uso crônico de polivitamínicos, com consumo acima de 6000 mcg de vitamina A é a principal causa desta condição. Gabarito letra C

208404.

Comentário: São contraindicações à vacina da febre amarela - Crianças menores de 6 meses de idade - Pessoas com história de eventos adversos graves em doses anteriores - Pessoas com história de anafilaxia comprovada em doses anteriores ou relacionada a substâncias presentes na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou a outras) - Pacientes com imunossupressão grave de qualquer natureza Imunodeficiência devido a câncer ou imunossupressão terapêutica Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com a contagem de células CD4 200 células mm3 ou menor de 15% do total de linfócitos para crianças menores de 13 anos Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) - Pacientes submetidos a transplante de órgãos - Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica) - Pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico tendo em vista a possibilidade de imunossupressão - Gestantes. A administração deve ser analisada caso a caso na vigência de surtos. Gabarito MEDGRUPO Alternativa C.

208351.

Comentário: Vamos relembrar Durante a gestação as vacinas contendo vírus ou bactérias vivas atenuadas não são indicadas como é o caso das vacinas contra o Sarampo, contra a rubéola e a vacina BCG. A vacina meningocóccica ACWY é INATIVADA, ou seja, não é capaz de causar a doença e portanto pode ser usada na gestação caso tenha indicação. Portanto, o nosso gabarito é a letra C.

208332.

Comentário: A recomendação da profilaxia contra o tétano acidental é determinada com base na avaliação de 3 parâmetros 1) tipo de ferimento 2) situação vacinal e 3) presença de comorbidades (ex. paciente desnutrido, imunodeprimidos e idosos). Na questão, estamos diante de um adolescente com ferimento de alto risco. A conduta nestes casos varia de acordo com a situação vacinal, da seguinte forma três ou mais doses da vacina e última dose há menos de cinco anos (é o que faremos nesse caso, pois a criança recebeu a terceira dose com 15 meses de idade e o próximo reforço será feito somente aos 4 anos) cuidados com o ferimento três ou mais doses da vacina e última dose entre cinco e dez anos reforço da vacina (obs. pacientes idosos, imunodeprimidos e desnutridos, poderão receber, além da vacina, a profilaxia passiva com SAT ou IGHAT) três ou mais doses da vacina e última dose há mais de dez anos reforço da vacina menos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de três doses ou vacinação incerta (como no caso) vacina e imunização passiva (SAT IGHAT). Resposta letra C.

208341.

Comentário: A questão traz um adolescente de 12 anos com o calendário vacinal incompleto. Quais vacinas estão faltando A vacina contra a febre amarela é feita em apenas uma dose e já foi feita, não havendo necessidade de repetí-la. Porém, repare que este adolescente está com esquema incompleto para hepatite B (tem apenas 1 dose), portanto, devemos fazer a segunda dose da hepatite B neste momento. A dupla do tipo adulto (dT) deve ter seu reforço feito a cada 10 anos como o paciente fez o 2º reforço dessa vacina aos 5 anos de idade, somente aos 15 anos a dT está indicada, a não ser que haja história de ferimento cutâneo grave, pois neste caso a dose seria adiantada para um intervalo de 5 anos. A tríplice viral também está com esquema incompleto (duas doses da vacina tríplice viral entre um e 29 anos) e, por isso, também deve ser feita uma segunda dose desta vacina. Além disso, faltam o reforço da meningocócica C (11 a 14 anos) e a vacina contra o HPV (para meninos entre 11 e 14 anos). Por não haver resposta correta, a questão foi anulada.

208384.

Comentário: O zinco é um micronutriente fundamental para várias funções no organismo. A falta desse micromineral pode comprometer o crescimento, a função imune e o desenvolvimento neuropsicomotor. A deficiência de zinco pode ocorrer na doença de Crohn, síndrome do intestino curto (cursa com má absorção de nutrientes), anemia falciforme e na acrodermatite enteropática. Clinicamente, ela se manifesta com manifestações em epitélios, como alopécia, dermatite de distribuição simétrica em regiões perioral, perineal, bochechas, cotovelos, joelhos e tornozelos. Essas lesões de pele causam infecção bacteriana na maioria dos casos. Além disso, podem surgir alterações oculares como conjuntivite, fotofobia e blefarite. Resposta letra B.

208322.

Comentário: Vamos relembrar qual a vacina contra o sarampo e como deve ser a forma de aplicação Nome Tríplice viral (inclui a prevenção contra SARAMPO, caxumba e rubéola). Mas qual

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é o esquema vacinal para não vacinados - Crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade uma dose aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses de idade (tetra viral). (letra B - INCORRETA) - Crianças de 5 anos a 9 anos de idade que perderam a oportunidade de serem vacinadas anteriormente duas doses da vacina tríplice viral. (letra A - CORRETA) - Adolescentes e adultos até 49 anos Pessoas de 10 a 29 anos - duas doses das vacina tríplice Pessoas de 30 a 49 anos - uma dose da vacina tríplice viral Letra C e D Ambas estão CORRETAS. Resposta letra B. Fique atento que este item gerou bastante polêmica, mas está errado A recomendação do Ministério da Saúde é de 2 doses para crianças entre 12 meses e menores que 5 anos de idade.

208337.

Comentário: Essa questão foi devidamente anulada após recurso feito pela equipe Medgrupo. Vamos entender o motivo Segundo a PORTARIA 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, a POLIOMIELITE é doença de notificação IMEDIATA e não semanal conforme descrito na letra C. Perceba que a banca se equivocou ao considerar poliomielite doença de notificação semanal

208385.

Comentário: E aí A lesão que essa criança apresentou é uma reação vacinal normal ou podemos considerá-la um evento adverso da BCG Sem dúvidas, estamos diante de uma reação esperada após a administração da vacina BCG. Lembre-se que a evolução da lesão ocorre da seguinte forma entre 3 e 4 semanas surge um nódulo no local da aplicação, que evolui para pústula em até 5 semanas, exatamente como no caso Em seguida, essa pústula se transforma em uma úlcera de 4 a 10 mm de diâmetro que se converte para uma crosta entre 6 e 12 semanas após a aplicação. Em alguns casos, essa cicatrização é mais demorada, podendo prolongar-se até o quarto mês e, raramente, além do sexto mês de vida. Nossa conduta é apenas orientar os responsáveis sobre a benignidade da lesão vacinal e a importância da limpeza com água e sabão. Resposta letra A.

208440.

Comentário: Como sabemos, toda gestante deve tomar a vacina antitetânica fornecida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

gratuitamente pelo SUS do seguinte modo 1 dose de dTPA entre a 20ª e a 36ª semana de gestação se o esquema estiver atualizado ou 2 doses se a última vacina já tiver mais de 10 anos sendo uma da dT ou da simples antitetânica e outra da dTPA, com intervalo mínimo de 30 dias. Logo, no caso apresentado na questão, onde a gestante fez o esquema completo há menos de 10 anos, a alternativa correta é a letra D.

176101.

Comentário: Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a faixa etária da vacina contra o HPV para meninas. A recomendação é vacinar todas as meninas entre 9 e 14 anos com 2 doses. Além disso, a vacina agora também é feita nos meninos entre 11 a 14 anos na rotina do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, gabarito letra A.

176015.

Comentário: No meio do ano passado, houve surtos de parotidite em escolas de Manaus. Normalmente, esta não é uma doença de notificação compulsória. É necessária a notificação da doença apenas durante surtos, mas ela não passou a integrar à lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. A complicação mais comum da doença é o envolvimento gonadal. Meningite com ou sem meningoencefalite podem ocorrer, pelo tropismo pelo SNC, mas como já foi dito, não é a principal complicação da caxumba. Diante de surtos, devemos fazer o diagnóstico baseado nos achados clínicos e na presença de história epidemiológica. Portanto, não vamos complicar uma questão fácil. Resposta letra D.

176091.

Comentário: Uma criança de 8 meses que apresenta dieta estritamente láctea, apresenta grande fator de risco para deficiências nutricionais, em especial a hipovitaminose C. A sua deficiência causa o escorbuto, cujas manifestações clínicas são mais evidentes entre 6 meses e 2 anos de idade que, além de sintomas inespecíficos como anorexia, irritabilidade, febre e taquipneia, pode ocasionar outras alterações específicas como petéquias perifoliculares, edema esponjoso gengival com pontos hemorrágicos e a posição de rã , caracterizada por joelhos e quadris fletidos com coxa rodada externamente, simulando uma pseudoparalisia. A vitamina B apresenta clínica diversificada,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pois depende do seu subtipo específico a deficiência de vitamina E desenvolve quadros de anemia, trombocitose, edema e sintomas neurológicos (ataxia, perda sensitiva, alterações visuais) e vitamina K é característica pelos distúrbios de coagulação. Resposta letra B.

176026.

Comentário: A questão foi anulada por um motivo bastante simples as alternativas não apresentam sintomas, mas os critérios diagnósticos da síndrome metabólica. Mas vamos aproveitar e recordar as comorbidades associadas à obesidade na síndrome metabólica em crianças e adolescentes entre 10 a 16 anos de idade cardiovasculares hipertensão arterial, aterosclerose endocrinometabólicos aumento dos triglicerídeos e LDL, redução do HDL, resistência insulínica, intolerância à glicose e diabetes síndrome dos ovários policísticos dermatológicas acantose nigricans , candidíase cutânea, estrias, celulite, acne, hirsutismo, furunculose ortopédicas joelho valgo (genu valgum), epifisiólise de cabeça do fêmur, tíbia vara (doença de Blount) respiratórias síndrome da apnéia obstrutiva do sono hepáticos esteatose hepática gastrointestinais refluxo gastroesofágico, constipação intestinal genitourinários pubarca precoce, incontinência urinária neurológicos pseudotumor cerebral, problemas psicossociais.

176116.

Comentário: A equipe Medgrupo discorda do gabarito liberado pela banca avaliadora para essa questão. Vamos entender o motivo Vamos retirar um trecho da Nota Informativa 384 do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a vacina HPV quadrivalente para a população masculina de 12 a 13 anos de idade. A faixa etária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 anos até 13 anos de idade. Os homens de 14 a 26 anos de idade vivendo com HIV Aids também passarão a ser contemplados nas ações de vacinação contra o HPV, bem como as meninas de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) que ainda não tiveram a oportunidade de serem vacinadas. Dito isso, vamos analisar as assertivas A) Incorreta. O intervalo vacinal é de 6 meses (são duas doses) para homens e mulheres na faixa etária correta. B) Incorreta. Mulheres homens convivendo com HIV AIDS recebem 3 doses. C) Incorreta. Perceba que a faixa etária para meninos é de 12-13 anos e não entre 11 e 13 anos. D)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Incorreta. A faixa etária é de 9 a 26 anos. Dessa forma, não há um gabarito correto apesar de a banca avaliadora não ter anulado a questão.

176110.

Comentário: Vamos analisar as assertivas e comentar as mudanças propostas no Calendário Nacional de Vacinação do Brasil para 2017 A) Incorreta. A mudança para essa vacina é que o reforço, que anteriormente era aplicado aos 15 meses, passa a ser aplicado aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras doses da meningocócica continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses. Ou seja, permanecem 3 doses. B) Correta. O Ministério da Saúde incluiu a vacina meningocócica C para a faixa etária de 12-13 anos para ambos os sexos. C) Incorreta. A vacina para febre amarela é dada aos 9 meses, com reforço aos 4 anos e, após, 1 dose a cada 10 anos. D) Incorreta. Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com a contagem de células CD4 200 céls mm^3 ou menor que 15% do total de linfócitos para crianças menores de 6 anos. Gestantes que residam em local próximo de casos recentes devem ser vacinadas. Dessa forma, percebemos que a única assertiva correta é a letra B, nosso gabarito.

176118.

Comentário: Torna-se cada vez mais evidente que a vacina é o único meio para interromper a cadeia de transmissão de algumas doenças imunopreveníveis. O controle das doenças só será obtido se as coberturas alcançarem índices homogêneos para todos os subgrupos da população e em níveis considerados suficientes para reduzir a morbimortalidade por essas doenças. Essa é a síntese do Programa Nacional de Imunizações (PNI). No PNI, a recomendação é que Profissionais de saúde devem ser vacinados no esquema de 3 doses em virtude do risco de contaminação em 0, 1 e 6 meses. Se não houver resposta, realiza-se outro esquema de vacinação com 3 doses. Gabarito letra C.

151923.

Comentário: Questão que trata da saúde dos adolescentes e as recomendações do Ministério da Saúde (MS) para essa faixa etária. O MS disponibiliza duas cadernetas, uma para os meninos e outra para as meninas, contendo informações sobre como evitar doenças, mudanças no corpo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(através do acompanhamento pelo IMC), saúde sexual, reprodutiva e bucal, além da alimentação. Todos esses temas são relevantes para a faixa etária em tela, bem como a questão da violência nas escolas (e estratégias para minimizá-las) e o uso de métodos contraceptivos. Em relação à vacina contra o vírus HPV, a recomendação é que sejam vacinadas meninas com IDADES ENTRE 9 E 13 ANOS. São necessárias duas doses, sendo a segunda dose dada após o intervalo de 6 meses em relação à primeira dose. Resposta A.

151955.

Comentário: Em 2016, houve as seguintes mudanças no calendário de vacinação Poliomielite passou a ser 3 doses injetáveis (2, 4 e 6 meses). Reforço continua sendo aos 15 meses e aos 4 anos com gotinha. HPV passou a ser 2 doses em meninas de 9 a 13 anos, sendo a 2ª dose 6 meses após a 1ª. Meningite o reforço passou a ser aos 12 meses. Mantiveram-se as 2 doses, aos 3 e aos 5 meses. Pneumonia 2 doses (2 e 4 meses). Reforço continua aos 12 meses. Resposta C.

151974.

Comentário: Vamos relembrar os trechos do Informe Técnico do Ministério da Saúde sobre esta vacina, de acordo com a letra correspondente Letra A 5.2.2 Profissionais de Saúde Indicação médico anestesista, ginecologista, neonatologista, obstetra, pediatra, enfermeiro e técnico de enfermagem que atendam recém-nascidos nas maternidades e UTIs neonatais. - INCORRETA Letra B Nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) está disponibilizada a vacina DTPa difteria, tétano e pertussis (acelular) para crianças que apresentaram eventos adversos após o recebimento de quais quer vacinas com componente pertussis de células inteiras, como convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após vacinação, síndrome hipotônica hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após vacinação - CORRETA Letra C Como dito na letra A, INCORRETA. Letra D A vacina tipo adulto-dTpa será disponibilizada para gestantes a partir da 27ª semana de gestação e poderá ser administrada até 20 dias antes da data provável do parto. CORRETA Resposta letra A.

129780.

Comentário: De acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de peso e estatura, adotados pelo Ministério da Saúde, podemos classificar esta criança como Z-score acima de 2 para Peso x Idade peso elevado para a idade Z- score entre 1 e 2 para Estatura x Idade estatura adequada para a idade Z- score entre 2 e 3 para IMC sobrepeso. Resposta letra C.

107790.

Comentário: O enunciado apresenta um pré-escolar de 2 anos, que recebeu aleitamento materno até os 2 meses quando foi interrompida a amamentação. A partir de então, começou a receber dieta em quantidades insuficientes, já que a tia informou que o leite era diluído acrescentado de arrozina. Além disso, a dieta era pobre de frutas, carne, verduras. Ao exame, criança apática, hipocorada, dermatose generalizada, hiperemia perianal importante, presença de edema periorbital e de membros inferiores, hepatomegalia, cabelo de duas cores (sinal da bandeira). Diante desse quadro, nossa primeira hipótese para o diagnóstico nutricional desta criança é desnutrição grave. As formas clínicas da desnutrição grave podem ser - kwashiorkor edema, hipoalbuminemia, alterações de pele e cabelos, hepatomegalia estes achados clássicos foram descritos no enunciado - marasmo ausência de edema e hepatomegalia, emagrecimento acentuado, lesões cutâneas raras. Gabarito letra B.

103848.

Comentário: A síndrome de Turner é uma doença de natureza genético-cromossômica caracterizada pela monossomia do cromossoma sexual X e, portanto, cariótipo 45, X0. Dentre as características clínicas principais destacam-se baixa estatura (100%) com média de estatura final em torno de 143,3 cm 6 cm hipogonadismo hipergonadotrófico (96%) por disgenesia ovariana (90%), tireoidite de Hashimoto (44%) e anormalidades glicêmicas e lipídicas linfedema ao nascimento implantação baixa de cabelos, pescoço curto, pterigium coli, mandíbula pequena, tórax em escudo, hipertelorismo mamilar rins em ferradura valva aórtica bicúspide (30%) e coarctação de aorta (10%). Portanto, gabarito letra A.

103851.

Comentário: A dieta de vegetarianos restritos, aqueles que não ingerem carne de origem animal e nem seus derivados, é pobre em vitamina B12 ou cianocobalamina. Esta vitamina está presente em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

carnes em geral, leite e ovos. Metabolicamente, participa da conversão da homocisteína em metionina e da conversão do metiltetrahidrofolato em tetrahidrofolato influenciando, assim, toda a síntese de DNA celular. A sua deficiência também prejudica o metabolismo do ácido fólico, pois, como vimos, a B12 é fundamental para a conversão do folato ativo (tetrahidrofolato). Dentre as principais manifestações clínicas, destacam-se anemia macrocítica, alterações neurológicas (síndrome cordonal posterior) e osteoporose. Gabarito letra C.

87442.

Comentário: Vamos fazer a avaliação nutricional desta criança em relação ao P E, podemos afirmar que estamos diante de um caso de MAGREZA, já que se encontra escore-Z -3 e escore-Z -2. Quanto à E I, temos aqui uma MUITO BAIXA ESTATURA PARA IDADE. Nosso lactente de 6 meses tem uma justificativa importante para essas alterações uma alimentação inadequada para idade, baseada na oferta de leite de vaca integral acrescido de farinha. A SBP, o MS e a OMS recomendam que, até os 6 meses, a criança receba exclusivamente leite materno, e na impossibilidade do mesmo, fórmula infantil, não estando recomendado o uso do leite de vaca ao longo de todo primeiro ano de vida. Estamos aqui diante de uma provável desnutrição crônica (com comprometimento da estatura), e sua etiologia está muito provavelmente associada ao grave erro alimentar. Assim, a conduta envolve a correção dos erros alimentares e acompanhamento semanal do peso e possíveis alterações clínicas. Resposta letra B.

87440.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre as variações normais do crescimento A Incorreta. No atraso constitucional do crescimento a idade óssea está geralmente atrasada em relação à idade cronológica, evidenciando um potencial de crescimento. Estas crianças apresentam crescimento mais lento, porém mais prolongado, adquirindo a estatura final normal. B Incorreta. Na baixa estatura familiar, as crianças apresentam crescimento compatível com seu alvo genético. Geralmente, uma história de retardo puberal parental é encontrada nos casos de retardo constitucional do crescimento, e não na variante familiar da baixa estatura. C Incorreta. O exame físico no atraso constitucional do crescimento é normal para a idade óssea que, nesses casos, é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

menor que a cronológica. D Correta. No atraso constitucional do desenvolvimento, a idade óssea é atrasada em relação à idade cronológica, mas está compatível com a idade estatural do paciente. E Incorreta. Na baixa estatura familiar, não há alterações laboratoriais tanto para a idade cronológica quanto para a idade óssea. Resposta letra D.

81127.

Comentário: O enunciado descreve uma criança vivendo em lugar sem saneamento básico com graves erros na história alimentar, como interrupção precoce do aleitamento materno e uma dieta pobre em fonte de proteínas e micronutrientes. Além disso, a dieta é também deficiente na quantidade, uma vez que as mamadeiras de leite engrossado são divididas com seus outros 5 irmãos. Essa história tão cheia de fatores de risco já nos aponta para a possibilidade de um distúrbio nutricional e o exame clínico não nos deixa dúvidas trata-se de uma criança com um quadro de desnutrição grave na forma de kwashiorkor . O quadro de kwashiorko r se instala, classicamente, nas crianças que mantêm algum aporte energético alimentar, mas que têm uma grave deficiência proteica. Há, ainda, um componente inflamatório sistêmico que permite o estabelecimento dessa condição. A manifestação clínica mais importante, que permite a imediata diferenciação dessa condição com o marasmo, é a presença de edema. Outras alterações que podem ser encontradas incluem alterações cutânea e de fâneros (como o sinal da bandeira) e hepatomegalia. A deficiência de micronutrientes, como o zinco, pode ser encontrada (mas essa criança tem muito mais do que uma deficiência isolada desse elemento). Resposta letra B.

60890.

Comentário: A ginecomastia é o desenvolvimento uni ou bilateral das mamas presente em adolescentes do sexo masculino no início da maturação sexual e do estirão puberal, mais frequente em obesos e com história familiar positiva. Na maioria dos casos, é um processo fisiológico que faz parte do desenvolvimento puberal normal, principalmente nas fases de maturação G3 e G4 de Tanner. O pênis embutido é um pênis normalmente desenvolvido que se encontra encoberto pela gordura suprapúbica comum em crianças obesas. Em ambos os casos, como o do nosso paciente, o acompanhamento clínico e psicológico estão indicados, sendo a reafirmação de que a puberdade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

está seguindo seu curso normal, uma base importante da conduta. Nos casos de ginecomastia intensa e prolongada, sem remissão após dois anos e com desenvolvimento puberal completo, pode-se considerar a cirurgia como a melhor opção terapêutica. Nosso paciente apresenta o problema há 6 meses, sem desenvolvimento completo e, portanto, ainda não há indicação cirúrgica. Resposta, portanto, opção D.

61496.

Comentário: Analisando as opções A - ERRADA. As alterações cutâneas do desnutrido grave geralmente são do tipo pelagroide, ou seja, se assemelham às lesões da pelagra, diferenciando-se dessa por acometer áreas expostas ao sol. Essas dermatoses são praticamente restritas ao paciente portador de kwashiorkor . B - CORRETA. A Desnutrição Energeticoproteica (DEP) grave pode ser dividida em duas grandes síndromes a DEP grave edematosa e a não edematosa. Ou seja, é justamente a presença de edema que diferencia, de maneira didática, o kwashiorkor (com edema) e o Marasmo (sem edema). C - CORRETA. No Marasmo, os pacientes lançam mão de todas as suas reservas energéticas, incluindo o tecido adiposo. D - CORRETA. Ao contrário do kwashiorkor , o paciente marasmático está inquieto, irritadiço e faminto isso remete ao conceito de que esse paciente tem uma desnutrição energética global, ao contrário do primeiro, em que a baixa ingesta se restringe às proteínas (o que inibe o apetite voraz e evidencia a hipoalbuminemia desses pacientes). E - CORRETA. Além da inapetência e da hipoalbuminemia já explicados, a esteatose hepática é uma marca do kwashiorkor . Isso decorre do baixo nível de proteínas plasmáticas que eles apresentam, impedindo a produção adequada de lipoproteínas, fazendo com que a gordura se acumule nos hepatócitos. Resposta letra A.

61505.

Comentário: Vamos ver o que dizem as opções A errada. O atraso constitucional do crescimento se reflete diretamente na entrada da puberdade. Geralmente há um atraso também nesse fenômeno, dando ao distúrbio apresentado, inclusive, o nome completo de atraso constitucional do crescimento e da puberdade. B errada, e confusa. Não ficou muito claro o que o autor da questão quis dizer, mas vamos lembrar na baixa estatura constitucional, a idade óssea é tipicamente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

atrasada em relação à idade cronológica. C errada. As mais importantes variações do crescimento (atraso constitucional e baixa estatura genética) normalmente seguem a história padrão familiar, isto é, pais baixos geralmente tem filhos baixos e pais com retardo de crescimento geralmente tem filhos com a mesma evolução. D errada. Nesses casos, a idade óssea está atrasada em relação à idade cronológica, configurando um bom prognóstico estatural para esses pacientes. E correta. A criança com baixa estatura familiar geralmente cresce numa curva abaixo do p3 (por isso, baixa estatura), porém com um crescimento dentro do esperado para aquele alvo. A resposta liberada inicialmente foi a opção E. Contudo, a questão foi ANULADA provavelmente pela confusão da opção B.

46662.

Comentário: A avaliação das proteínas plasmáticas é uma forma interessante de se acompanhar a recuperação nutricional de um paciente desnutrido. A meia-vida da albumina situa-se entre 18 a 21 dias. Embora o enunciado cite sua validade em avaliações nutricionais, um parâmetro bem superior é a pré-albumina (meia-vida de 2 a 3 dias), que nos indica com maior exatidão de carências nutricionais de desenvolvimento recente. Resposta letra D.

46672.

Comentário: O marasmo é uma das formas clínicas dos quadros de desnutrição grave. As crianças com marasmo apresentam um quadro de emagrecimento acentuado, com grande redução de panículo adiposo, distrofia muscular de ombros, braços, nádegas e pernas (opções B e D erradas). O emagrecimento é tamanho que o contorno das costelas fica visível. Há escassez de gorduras nas nádegas e coxas, formando numerosas pregas na pele. Nos quadros de marasmo temos uma instalação tipicamente insidiosa, por uma carência global de nutrientes, geralmente ao longo do primeiro ano de vida (opção D errada). Ao contrário do que classicamente se dizia, sabemos hoje que as crianças com marasmo podem apresentar níveis baixos de proteínas plasmáticas, mas ainda assim não apresentam edema, como fazem as crianças com Kwashiorkor (de todo modo, a banca considerou a opção C como errada). A única descrição mais correta está na letra A o desnutrido tem basicamente um comprometimento da imunidade celular, mas sua imunidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

humoral está preservada. Resposta A.

49814.

Comentário: É consenso que a obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e que ela determina várias complicações na infância e na idade adulta. Na infância, o manejo pode ser ainda mais difícil do que na fase adulta, pois está relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta de entendimento da criança quanto aos danos da obesidade. Diversos fatores estão implicados em um maior risco para o desenvolvimento da obesidade exógena na infância, como interrupção precoce do aleitamento materno com introdução de alimentos complementares inapropriados, emprego de fórmulas lácteas diluídas de modo incorreto, distúrbios do comportamento alimentar e a inadequada relação ou dinâmica familiar. Curiosamente, a banca do concurso não considerou a opção B como sendo um fator de risco. Alguns dados mostram que a cada 3,7 meses no tempo de aleitamento materno total reduz em 6% o risco de desenvolvimento de obesidade. A resposta A está correta e foi a gabarito oficial, mas em nosso entendimento a resposta B também está certa.

46652.

Comentário: O primeiro passo na avaliação de uma queixa relacionada ao crescimento estatural é a verificação da estatura atual e da velocidade de crescimento, isto é, o padrão apresentado pela curva de crescimento. Via de regra, as crianças que apresentam baixa estatura por algum quadro patológico possuem uma velocidade de crescimento baixa sua curva é horizontal ou pouco inclinada. Já as crianças com variantes normais do crescimento possuem velocidade de crescimento normal. Assim, a opção A traz o primeiro dado a ser avaliado na consulta atual.

46667.

Comentário: A associação de quadros convulsivos com deficiência vitamínica deve sempre nos remeter à deficiência de piridoxina, vitamina B6. O quadro clínico desta deficiência é caracterizado por queilite, glossite, dermatite seborreica, anemia hipocrômica e microcítica, linfopenia, neuropatia periférica (incomum em crianças) e convulsões. O risco de deficiência de piridoxina é aumentado nos pacientes que recebem terapias que inibem a atividade da vitamina B6, como isoniazida,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

penicilamina, corticoides e alguns anticonvulsivantes. Resposta letra D.

46636.

Comentário: As alterações eletrolíticas tipicamente encontradas no paciente com desnutrição grave são a hiponatremia e a hipocalemia. Vale lembrar que esta hiponatremia é dilucional, ou seja, o conteúdo total de sódio do organismo está aumentado, em parte, devido ao aumento do sódio intracelular por deficiência da bomba de sódio. Os pacientes desnutridos graves, em geral, apresentam hipocalemia acentuada que pode se associar à fraqueza muscular, íleo paralítico e alterações da repolarização ventricular. Além disso, a depleção grave de potássio pode levar a prolongamento do PR e alargamento e redução da voltagem do QRS, bem como aumentar o risco de arritmias ventriculares. Assim, a letra D traz a resposta correta. Nas outras opções até encontramos algumas outras alterações encontradas no desnutrido grave, como o edema, presente nas formas de desnutrição edematosa e a hipostenúria (incapacidade para concentração urinária). Porém, estas não estão diretamente relacionadas ao pior prognóstico como as alterações eletrolíticas descritas.

9987.

Comentário: A falência de crescimento e desenvolvimento apresenta múltiplas causas, sendo mais frequente nos primeiros 5 anos de vida. As etiologias desta condição nosológica são diferentes no grupo dos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. Leia abaixo Nos países desenvolvidos, as principais causas de déficit de crescimento desenvolvimento são, de acordo com a faixa etária NEONATAL Desmame precoce Erro nas preparações das fórmulas lácteas Privação psicossocial Anomalias congênitas Infecções Substâncias teratogênicas LACTÂNCIA Privação psicossocial Depressão materna Cardiopatia congênita Fibrose cística Doença celíaca Encefalopatia. PRÉ-ESCOLA Doenças crônicas Nos países em desenvolvimento as duas principais causas de falha de crescimento e desenvolvimento são a desnutrição calórico-proteica grave e a infecção pelo HIV. A OMS estima que mais de 20 milhões de crianças nasçam com baixo peso a cada ano, cerca de 150 milhões de crianças menores de 5 anos têm baixo peso para a sua idade e 182 milhões (32,5%) têm baixa estatura. Alguns autores referem, no entanto, que esses valores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

podem estar subestimados devido a dificuldades para o cálculo de cifras exatas sobre a prevalência mundial de desnutrição. Cerca de 20 a 30% das crianças gravemente desnutridas vão a óbito durante o tratamento em serviços de saúde de países em desenvolvimento. Essas cifras têm se mantido inalteradas nas últimas 5 décadas e correspondem a um percentual 4 a 6 vezes mais alto que a taxa de 5%, reconhecida como aceitável pela OMS. Além da elevada prevalência, a DEP torna-se, direta ou indiretamente, a principal causa de morbidade e mortalidade nas crianças abaixo de cinco anos, período de maior vulnerabilidade. Isso pode ser explicado pela elevada velocidade de crescimento observada nesta faixa etária, com maiores necessidades energéticas e também pela perda paulatina da imunidade passiva ao longo do primeiro ano de vida. A desnutrição ainda é, infelizmente, um dos grandes problemas do Brasil. A incidência varia de acordo com o desenvolvimento regional. Dados recentes da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS-1996) mostram que a prevalência de desnutrição vem apresentando uma queda nos últimos anos, mas de acordo com o indicador antropométrico utilizado, ainda acomete cerca de 5,7% da população abaixo de dois anos, de acordo com o indicador peso idade, e 10,5% de acordo com o indicador estatura idade indicando um tipo de desnutrição, já citada como desnutrição invisível, na qual esta entidade mórbida passe quase desapercebida contribuindo significativamente para a baixa estatura na idade adulta, particularmente em algumas regiões do Brasil. A redução na taxa de prevalência de desnutrição pode estar relacionada com a diferença na metodologia da avaliação das crianças (os desnutridos leves, que se encontram entre um e dois desvios padrões abaixo da média foram excluídos da definição do PNDS). O número de crianças no Brasil em 1995, segundo o IBGE, era da ordem de 65 milhões estimava-se que seis milhões com idade inferior a cinco anos apresentavam algum grau de desnutrição, sendo que 300.000 apresentavam desnutrição grave. Esta questão foi anulada pela banca, por ser o gabarito B fornecido INCORRETO.

9988.

Comentário: Vamos rever as principais características clínicas de cada uma das deficiências vitamínicas NIACINA (B3) - PELAGRA Dermatite inicia-se como uma queimadura de sol, com eritema de superfícies expostas. Podem aparecer vesículas e bolhas. Estas lesões cicatrizam,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

descamam e deixam a pele subjacente hiperpigmentada. Diarreia existe um espessamento e inflamação da parede do cólon a mucosa está atrofiada e recoberta por uma pseudomembrana. Demência depressão, desorientação, insônia e delirium . A anatomia patológica mostra degeneração e desmielinização celular. TIAMINA (B1) - BERIBÉRI A neurite periférica é causada por degeneração da mielina. Há parestesias e disestesias em extremidades Inferiores, perda da sensibilidade vibratória, diminuição dos reflexos profundos, cãibras e dor nas panturrilhas. As manifestações cardiovasculares são secundárias a uma síndrome de insuficiência cardíaca de alto débito. Encefalopatia de Wernicke caracterizada por confusão mental, sonolência, irritabilidade, sinais oculares e ataxia. É rara em crianças. BIOTINA (B12) Anemia macrocítica, neutropenia e plaquetopenia Degeneração combinada na medula nervosa Osteoporose. PIRIDOXINA (B6) A deficiência isolada de vitamina B6 é bastante rara, estando geralmente associada a outros distúrbios vitamínicos. Alterações de cavidade oral queilose, glossite Alterações de pele dermatite seborreica Alterações hematológicas anemia hipocrômica e microcítica, linfopenia com prejuízo na diferenciação dos linfócitos e redução da produção de anticorpos Alterações em nervos periféricos neuropatia periférica Convulsões neonatais. COLECALCIFEROL (D) - RAQUITISMO Craniotabes Rosário Costal Peito de Pombo Sulco de Harrison Alargamento de punho Arqueamento da tíbia Baixa estatura.

9998.

Comentário: Cerca de 75% dos indivíduos com a síndrome de Prader-Willi apresentam deleção do braço longo do cromossoma 15. A prevalência estimada é de um em cada 15.000 crianças. As principais características fenotípicas são baixa estatura, obesidade iniciada aos seis meses, falta de saciedade, obsessão alimentar, diâmetro bifrontal estreito, cabelos, pele e olhos claros, retardo mental, hipotonia na fase de lactente, pés e mãos pequenos, micropênis e hipogonadismo.

13260.

Comentário: As gastroenterites agudas na infância formam, junto com as infecções respiratórias, as doenças mais prevalentes entre as crianças abaixo de 5 anos, respondendo inclusive por grande parte do percentual de óbitos nesta faixa etária. As diarreias agudas são de natureza infecciosa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(vírus, bactérias e parasitas) na maioria das vezes, e o agente mais frequentemente envolvido é o rotavírus, motivo este que fomentou a inclusão da vacina antirrotavírus humano para crianças menores de 5 meses no calendário vacinal do Ministério da Saúde. As doenças diarreicas agudas causadas por rotavírus são as principais causas de morbidade e mortalidade por diarreia em crianças em todo o mundo nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Estimativas apontam que 111.000.000 episódios de diarreia são registrados por ano em menores de cinco anos atribuídos ao rotavírus. A diarreia causada por rotavírus que geralmente ocorre na faixa etária entre seis meses a dois anos, é auto limitada. A sintomatologia da doença é diarreia, vômito e febre alta. A diarreia geralmente é profusa, que pode evoluir para a desidratação grave do tipo isotônica. Caso a reidratação não seja instituída de forma precoce e adequada poderá ocorrer o óbito. É indubitável que o maior causador das diarreias em lactentes no mundo é o rotavírus e não o Cryptosporidium como sugere a banca.

10012.

Comentário: O escorbuto é a doença provocada pela carência de ácido ascórbico, e as manifestações clínicas são mais evidentes no período de 6-24 meses. Os sintomas iniciais são gerais e inespecíficos anorexia, irritabilidade, febre baixa, taquipneia e hipersensibilidade dolorosa nos membros inferior, especialmente verificada durante a troca de fraldas. Os principais sinais observados são ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS. A dor nos membros inferiores resulta em uma postura antálgica, e lembra uma pseudoparalisia joelhos e quadris fletidos com a coxa rodada externamente. Esta postura é semiolgicamente conhecida como posição de rã . Pode haver um edema tenso nos membros e hemorragia subperióstea, que é comum principalmente nas extremidades. Há também formação de um rosário nas junções costocondrais e depressão esternal, a semelhança do que ocorre no raquitismo. Entretanto, a angulação do rosário no escorbuto é mais aguda que na carência de vitamina D. ALTERAÇÕES CUTANEOMUCOSAS. Nas gengivas há formação de um edema esponjoso com pontos hemorrágicos, principalmente localizados acima dos incisivos centrais superiores. Púrpura e equimoses cutâneas também podem ser verificadas. Na pele são identificadas petéquias perifoliculares de aspecto típico. Há um prejuízo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

na cicatrização de feridas e na consolidação de fraturas ósseas.. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS. A irritabilidade pode ser expressão do metabolismo deficiente de neurotransmissores. ALTERAÇÕES HEMATOPOIÉTICAS. Pode ocorrer anemia por carência de ferro e folato, pois como vimos a vitamina C participa da facilitação da absorção intestinal de ferro e da conversão do ácido fólico em sua forma ativa. A radiografia de ossos longos mostra várias alterações no escorbuto, que são osteopenia, adelgaçamento da cortical da diáfise, linha branca espessa na metáfise (linha de Fraenkel) que corresponde a uma zona de cartilagem bem calcificada, núcleo epifisário com centro rarefeito e periferia densa (Sinal do Anel de Wimberger), e em estágios bem avançados da doença verificamos zonas de destruição logo abaixo da linha de Fraenkel. A hemorragia subperióstea não aparece na sua fase aguda, sendo apenas demonstrável quando calcifica, produzindo a clássica imagem em halteres ou clavas .

13263.

Comentário: A OMS SBP MS recomenda que o aleitamento materno seja mantido de forma exclusiva PARA TODAS AS CRIANÇAS (independente do nível de desenvolvimento do país) até os 6 meses, e a partir de então seja introduzida a alimentação complementar. A gravidez não contraindica o aleitamento, embora alguns autores sugiram que a ocitocina liberada com o reflexo da ejeção do leite possa induzir contrações uterinas precoces e facilitar o abortamento. De qualquer forma, a orientação adequada a esta mãe é continuar em aleitamento materno exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos, seguida da introdução de alimentos complementares depois do primeiro semestre de vida do bebê.

7513.

Comentário: Uma questão que objetiva estabelecer as principais diferenças clínicas entre as principais formas de desnutrição grave marasmo e kwashiorkor. Vamos a elas NO MARASMO...Observam-se déficit de peso e estatura, atrofia muscular extrema, emagrecimento acentuado com pobreza de tecido celular subcutâneo e pele enrugada, principalmente nas nádegas e coxas. Pela perda de tecido subcutâneo ocorre desaparecimento da bola gordurosa de Bichat. Em geral o apetite está preservado, ao contrário do kwashiorkor onde há uma inapetência grave. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anemia e a diarreia são comuns e com frequência as crianças apresentam o abdome volumoso. Não há edema, nem lesões cutâneas. Os cabelos podem, eventualmente, estar alterados. As proteínas séricas e as enzimas hepáticas são normais. NO KWASHIORKOR...A criança geralmente se apresenta com estatura e peso menores do que os esperados para a idade, aspecto consumido, fato este observado principalmente nos músculos dos membros superiores e inferiores. Este fato pode ser mascarado pelo edema. O edema é muito frequente e considerado a manifestação clínica mais importante desta síndrome. Alterações mentais comportamentais estão invariavelmente presentes. A criança se apresenta apática, hipoativa, anoréxica e desinteressada pelos fatos que ocorrem ao seu redor ela geralmente não sorri, mesmo quando estimulada, e está permanentemente irritada, sem apetite. Diferente da criança marasmática, a criança com kwashiorkor tem tecido celular subcutâneo. O grau de gordura subcutânea dá uma indicação do grau de deficiência calórica. A pele da face está frequentemente despigmentada, desenvolvendo-se dermatoses em áreas de atrito, como, por exemplo, na região inguinal e no períneo. Surgem áreas de hiperpigmentação que, eventualmente, descamam. Os cabelos apresentam alteração de textura, cor (discromias) e são quebradiços. Os cabelos pretos tornam-se castanhos ou avermelhados. Pode estar presente o sinal da bandeira , que consiste na alteração segmentar (em faixas) da cor dos cabelos, traduzindo períodos alternados de pior e melhor nutrição. As fezes podem estar liquefeitas, com sangue e alimentos não digeridos. Anemia está presente na maioria dos casos. É, em parte, devido à deficiência proteica para síntese de eritrócitos, deficiência de ferro e de ácido fólico, parasitoses intestinais e infecções frequentes. Hipoalbuminemia e redução da proteína sérica total, relação com a intensidade do edema, são observadas em praticamente todos os pacientes. Geralmente as crianças com esta síndrome têm hepatomegalia (esteatose).

354381.

Comentário: A vacina contra o vírus influenza tinha restrições quanto à aplicação em indivíduos com alergia ao ovo, porém informe técnico publicado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2023 libera seu uso, mesmo em situações de anafilaxia, desde que em ambiente controlado. Por isso, não concordamos com o gabarito liberado pela banca e entramos com recurso. Segundo o informe,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pessoas que após a ingestão de ovo apresentaram apenas urticária podem ter a vacina influenza aplicada, sem a necessidade de cuidados especiais. A Sociedade Brasileira de Imunizações orienta que não há necessidade de qualquer precaução adicional, mesmo nos casos de anafilaxia, diferente do MS que estabelece a necessidade de aplicação da vacina em ambiente controlado nesses casos, de preferência sob supervisão médica. As outras alternativas citam vacinas que não tem restrições quanto ao uso em indivíduos com alergia ao ovo. Resposta letra C, mas não concordamos.

354382.

Comentário: Questão sobre o calendário vacinal de adolescentes, porém com vários problemas de redação. Há duas respostas corretas e a questão foi anulada após recurso. Vamos avaliar as alternativas. Letra A correta. Desde 2020, o Ministério da Saúde estabeleceu a imunização contra febre amarela para todo território nacional, inclusive para região Nordeste. Talvez a banca quisesse dizer que deve ser feita apenas na região Nordeste . Mas da forma como a frase está escrita, confunde o aluno. Por causa da redação, a opção está correta. Letra B incorreta. Para adolescentes, a vacina contra a meningite indicada é a ACWY, que cobre estes sorotipos. Pode ser feita dos 11 aos 14 anos, em dose única. Letra C correta. Segundo o PNI, a vacinação contra Bordetella pertussis não faz parte do calendário vacinal do adolescente. Porém, a Sociedade Brasileira de Imunizações refere que os adolescentes com esquema primário de DTP ou DTPa completo devem receber um reforço com dT ou dTpa, preferencialmente com a formulação tríplice acelular entre 9 e 11 anos, com novos reforços a cada 10 anos. Letra D incorreta. Esse foi o gabarito da banca. Mas como dissemos na alternativa anterior, a vacinação com dTpa não faz parte do calendário vacinal de adolescentes recomendado pelo Ministério da Saúde. Resposta questão anulada.

354383.

Comentário: A vacinação contra o HPV é indicada para ambos os sexos, dos 9 aos 14 anos de idade, em esquema de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. A vacina disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece proteção para quatro tipos de HPV (6, 11, 16 e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

18). É interessante lembrar que é uma vacina composta apenas por VLPs (partículas semelhantes aos vírus - vírus-like particle), o que permite sua aplicação em pacientes imunodeprimidos. Para este grupo, o esquema deve ser de três doses da vacina. Vamos às alternativas. Letra A incorreta. A indicação da vacona contra o HPV independe do início da atividade sexual. Letra B incorreta. Não há contraindicação em caso de alergia ao ovo. Letra C correta. Como dito, a vacina é indicada para ambos os sexos, a partir dos 9 anos de idade. Letra D incorreta. Quando o esquema é iniciado até os 14 anos, são feitas duas doses. Após esta idade, são necessárias três doses. Resposta letra C.

324828.

Comentário: O enunciado descreve uma lactente de dezoito meses, com história de diversos erros alimentares, apresentando-se emagrecida e descorada. Para indicar o diagnóstico nutricional, vamos relembrar as possíveis classificações de peso para idade para crianças entre zero e dez anos muito baixo peso para idade (abaixo do percentil 0,1 ou escore-Z -3) baixo peso para idade (maior ou igual ao escore-Z -3 e menor que o -2 ou percentil 3) peso adequado para a idade (maior ou igual ao escore-Z -2 e menor ou igual ao 2 ou percentil 97) e peso elevado para idade (acima do escore-Z 2). A classificação em eutrofia, magreza, sobrepeso ou obesidade entre zero e cinco anos é feita com o gráfico de peso para estatura, dado que não foi fornecido. Sabemos que a paciente nasceu com peso maior ou igual a escore-Z -2 e menor que o 2, ou seja, com peso normal e atualmente tem peso abaixo do escore-Z -3, ou seja, muito baixo peso para idade. O gabarito inicial da banca estava incorreto (Nasceu eutrófica OU normal ao nascer E Peso baixo para a idade OU desnutrida para a idade OU baixo peso OU desnutrida) e foi modificado após recurso Nasceu eutrófica OU normal ao nascer E Muito baixo peso para a idade .

324829.

Comentário: O enunciado descreve uma lactente de dezoito meses, apresentando-se emagrecida e descorada, em cuja história podem ser identificados diversas fatores de risco para desnutrição interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (antes dos seis meses) e interrupção da lactação, com introdução de leite de vaca e mucilagem antes de um ano de vida história de diarreia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e diversos erros alimentares, como carência de fontes proteicas, excesso de sucos e de farináceos (pão, biscoito, farinha). Resposta Indicar duas das seguintes desmame precoce OU Interrupção da lactação alimentação inadequada nutricionalmente OU Dieta inadequada doença gastrointestinal OU Diarreia OU Gastroenterite.

324830.

Comentário: O enunciado descreve uma lactente de dezoito meses, com história de diversos erros alimentares, apresentando-se emagrecida e descorada, com muito baixo peso para a idade. O diagnóstico de desnutrição é feito a partir da avaliação antropométrica e do exame clínico, mas alguns exames laboratoriais são importantes, em especial nas crianças com desnutrição grave e indicação de internação hospitalar (o que não pode ser estabelecido com os dados deste caso). Estes exames incluem hemograma, que avalia a presença de anemia ou processo infeccioso glicose sanguínea, para detecção de hipoglicemia, uma importante causa de morte nos primeiros dias de internação das crianças com desnutrição grave EAS e cultura de urina, para rastreio de infecção urinária parasitológico de fezes, para a pesquisa de parasitoses intestinais cultura de sangue, fezes e nasofaringe, que devem ser realizadas, sempre que possível, em todos os pacientes e antes do início do tratamento com antibiótico e dosagens de albumina e eletrólitos. A questão foi mal formulada, mas, neste caso, a banca considerou como imprescindível a solicitação do hemograma, visto que a criança apresentava uma alteração clínica (estava descorada 2 4) que sugeria anemia, além do muito baixo peso e de diversos fatores de risco para anemia ferropriva. Resposta Dosagem de hemoglobina OU Hemograma OU Hemograma completo.

324701.

Comentário: Cerca de 90% dos indivíduos infectados pelo poliovírus selvagem não desenvolvem qualquer tipo de sintoma. O restante se apresenta com manifestações inespecíficas, como meningite asséptica e sintomas gripais comuns somente 1-1,6% cursa com a forma paralítica da doença. Aliás, esta é a única forma clínica que possui características típicas, que permitem sugerir o diagnóstico da doença. Dentre elas, podemos citar instalação súbita da deficiência motora, acompanhada de febre assimetria, acometendo, sobretudo, a musculatura dos membros, com mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

frequência os inferiores flacidez muscular (por isso, é bem comum usarmos o termo paralisia flácida aguda para se referir à clínica da doença) , com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área paralisada sensibilidade preservada persistência de alguma paralisia residual (sequela) após 60 dias do início da doença. Perceba, portanto, que o quadro clínico apresentado é compatível com a doença Agora, vamos analisar as alternativas Letra A incorreta. A ausência de contactantes sabidamente sintomáticos não exclui a possibilidade do indivíduo adquirir a doença, embora o risco se torne menor, já que a transmissão se dá de pessoa para pessoa, através da via fecal-oral, mais frequentemente. Letra B incorreta. Como vimos, a paralisia flácida é a mais comum. Letra C incorreta. Em Guillain-Barré, temos uma paralisia flácida de caráter ascendente e simétrica. Letra D correta. De forma geral, diante da suspeita de poliomielite, exames confirmatórios, como isolamento viral e sequenciamento genético, devem ser solicitados. A princípio, encaramos como um caso (pelo menos, suspeito) de poliomielite e, naturalmente, a suspeita se mantém até sua exclusão (ou confirmação). A redação da alternativa não está perfeita, mas é a que melhor se encaixa como resposta. Resposta letra D.

324702.

Comentário: A poliomielite encontra-se erradicada do território nacional. O último caso confirmado da doença no Brasil ocorreu em 1989, conforme nota divulgada pelo Ministério da Saúde em outubro de 2022. Desde então, nenhum outro caso foi registrado. Cabe ressaltar que, em meados de 2022, uma criança de três anos desenvolveu quadro de paralisia flácida aguda (PFA) dois dias após a vacinação com a vacina VOP. Segundo o Ministério, a polio doença foi excluída e a principal hipótese diagnóstica foi de evento adverso pós-imunização. Talvez, esse caso tenha servido de inspiração para a Banca confeccionar a questão De qualquer forma, a cobertura vacinal vem diminuindo ano após ano. Em 2015, ela alcançou a excelente marca de 98,29% das crianças imunizadas. De lá para cá, vimos o número cair e chegar a marca de, aproximadamente, 70% em 2021. Para você ter ideia, a meta é de 95% Obviamente, a queda da cobertura acarreta risco de a doença voltar a ser transmitida no país. Resposta letra A.

324703.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A grande dúvida relacionada a essa questão é qual é a vacina contra poliomielite mais empregada no Brasil Bom, como sabemos, o PNI indica a administração de 3 doses da VIP (aos 2, 4 e 6 meses de idade) e 2 doses da VOP (aos 15 meses e aos 4 anos). Isso leva à falsa impressão de que a VIP é a resposta da pergunta. Isso porque a VOP é a vacina utilizada nas campanhas de imunização organizadas pelo Ministério da Saúde. O público-alvo dessas campanhas é composto por crianças de 1 a 5 anos incompletos - mesmo aquelas que já tomaram uma ou duas doses da VOP são convocadas Como as campanhas acontecem com frequência, quase todo ano, a quantidade de doses aplicadas da VOP supera a da VIP. Então, vamos lá A VOP é um imunobiológico composto por vírus vivos atenuados. Em raros casos, pode haver paralisia aguda flácida após a administração da vacina nas crianças vacinadas ou nos indivíduos que tenham tido contato com uma criança que recebeu VOP. Este fenômeno deve-se à mutação para neurovirulência que o patógeno pode sofrer. A taxa de paralisia é maior na primeira dose de VOP, sendo o risco substancialmente maior que nas doses subsequentes. Nos imunocomprometidos, este risco é mais elevado, cerca de 3.200 vezes maior que em imunocompetentes. A poliomielite vacinal está associada mais comumente aos sorotipos 2 e 3. Para definição do caso de poliomielite associado à vacina é condição fundamental o achado do vírus vacinal nas fezes dos pacientes acometidos. Resposta letra B.

294481.

Comentário: Esta questão certamente suscitou dúvidas... Lembre-se de que, pelo Ministério da Saúde, a classificação do sobrepeso e da obesidade é feita da seguinte forma IMC acima do percentil 99,9 (escore-Z 3) indica obesidade grave IMC maior que o percentil 97 (escore-Z 2) e menor ou igual ao 99,9 indica obesidade e IMC maior que o percentil 85 (escore-Z 1) e menor ou igual ao percentil 97 indica sobrepeso. A banca citou que o IMC deste adolescente está acima do percentil 95. E agora Calma... Aqui certamente não foi usada a classificação do Ministério da Saúde, mas sim a classificação usada nos livros norte-americanos, como o Nelson. Por esta referência, há sobrepeso quando o IMC está entre o percentil 85 e o 94 e há obesidade quando é maior ou igual ao percentil 95. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284607.

Comentário: Estamos diante de uma criança que pisou em um prego enferrujado e com carteira de vacinação atrasada. Quanto aos cuidados com esse paciente, vamos analisar as afirmativas apresentadas. A água oxigenada evidencia vantagens sobre a lavagem com soro fisiológico comum, visto que a bactéria do tétano é mais susceptível ao oxigênio - quando coloca o oxigênio ela tende a morrer. A lavagem com clorexidina tem eficácia no combate à infecção local. E, por fim, o desbridamento deve ser feito para diminuir o risco de tétano e, após ele, devemos realizar um curativo permeável, que permite que entre oxigênio, que é ruim para a bactéria.

284608.

Comentário: A indicação da necessidade de profilaxia específica para o tétano depende da avaliação de dois parâmetros principais a situação vacinal do paciente e o risco de tétano associado ao ferimento. Em relação ao risco para tétano, os ferimentos podem ser considerados de alto risco ou de risco mínimo. Os ferimentos com risco mínimo são ferimentos superficiais, limpos, sem corpos estranhos ou tecidos desvitalizados. Já os ferimentos com alto risco são ferimentos profundos ou superficiais sujos com corpos estranhos ou tecidos desvitalizados queimaduras feridas puntiformes ou por armas brancas e de fogo mordeduras politraumatismos e fraturas expostas. No caso descrito, temos um escolar com ferimento de alto risco. A conduta nestes casos varia de acordo com a situação vacinal, da seguinte forma - três ou mais doses da vacina e última dose há menos de cinco ano apenas cuidados com o ferimento. - três ou mais doses da vacina e última dose entre cinco e dez anos reforço da vacina. Nosso paciente se enquadra nesta categoria, pois se recebeu todas as vacinas até 12 meses, recebeu três doses de vacina com componente temático (penta). - três ou mais doses da vacina e última dose há mais de dez anos reforço da vacina. - menos de três doses ou vacinação incerta vacina e imunização passiva (SAT IGHAT). O reforço poderá ser considerado para os imunodeprimidos, idosos e desnutridos que já tenham recebido três ou mais doses da vacina caso o tempo transcorrido desde a última dose seja maior do que cinco anos. O gabarito original da questão havia sido a letra D, completamente equivocado após recurso, foi trocado pela letra A. Cabe, contudo, indicar que em uma criança e sete anos a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vacina feita é a vacina dupla do tipo adulto (dT), não a vacina dupla infantil (DT). Resposta letra A.

284609.

Comentário: Questão um tanto quanto confusa, como foram tantas questões deste concurso neste ano. O enunciado descreve um escolar de sete anos que apresenta um ferimento considerado de alto risco para o tétano acidental e solicita a análise de afirmativas feitas sobre o tema. Vejamos cada uma delas. A opção A está correta a afirmativa parece ter sido extraída na íntegra do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério a Saúde. Não há indicação para a profilaxia do tétano acidental com a penicilina benzatina. A opção B foi considerada incorreta pela banca, mas suscitou dívidas não há indicação para o uso de clindamicina ou doxiciclina para a profilaxia. Quando falamos em tratamento do tétano, a escolha é o uso de penicilina cristalina ou de metronidazol, mas a clindamicina e a doxiciclina podem ser encontradas como alternativas na literatura. De todo modo, esta afirmativa B nos pareceu correta, uma vez que não há indicação (ainda que isso seja diferente de dizer que há contraindicação). A opção c está incorreta o risco é maior com a cefalosporinas de primeira geração. E, por fim, a opção D está incorreta como já dito, o metronidazol e a penicilina são alternativas. Resposta letra A.

206077.

Comentário: O primeiro passo é relembrar as vacinas que deveriam ter sido feita até noive meses. Ao nascer BCG e hepatite B com 2 e 4 meses penta, vacina inativada contra poliomielite, pneumocócica conjugada, vacina de rotavírus com 3 e meses meningocócica C com 6 meses penta e vacina inativada contra a poliomielite aos 9 meses vacina de febre amarela. É curioso que a banca não citou a vacina penta, mas sim a vacina DTP, não mencionando a vacina contra hemófilo e nem contra hepatite B em seu gabarito. Isso está errado... de todo modo, é importante lembrar de que de todas essas vacinas a que não poderá mais ser feita é a vacina contra rotavírus a primeira dose é feita apenas até 3 meses e 15 dias e a segunda dose até 7 meses e 29 dias. O gabarito oficial foi Vacina meningocócica C (primeira dose) OU Vacina para meningococos (primeira dose) E Vacina Salk (terceira dose) OU VIP (terceira dose) OU Vacina inativada contra Poliomielite (terceira dose) E Vacina contra febre Amarela (dose única).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206078.

Comentário: Aos 12 meses são feitas três vacinas tríplice viral (1ª dose a segunda dose é feita na forma de tetraviral aos 15 meses) pneumocócica conjugada 10-valente (reforço as primeira e a segunda dose são feitas aos 2 e 4 meses) e vacina meningocócica C (reforço a primeira e a segunda dose são feitas aos 3 e 5 meses).

206069.

Comentário: A banca nos trouxe um caso clínico, mas a resposta para a questão independia da análise do mesmo. Foi indagada, de forma objetiva, quais seriam as contraindicações para a vacina de febre amarela. A primeira contraindicação citada no gabarito foi a idade inferior a seis meses, o que está correto. Não confunda os conceitos A vacina é habitualmente feita a partir dos nove meses, mas a contraindicação, de fato, é uma idade inferior a seis meses, pelo maior risco de eventos adversos. A história de alergia ou hipersensibilidade ao ovo também foi citada lembre-se de que nas situações de risco epidemiológico muito alto, a vacina pode ser feita mesmo nos pacientes com este relato (principalmente quando há relato de anafilaxia ao ovo), mas isso irá ocorrer em ambientes especiais e com protocolos específicos. A história de doença infecciosa febril também foi citada como contraindicação e isso está contemplado em materiais do Ministério da Saúde na verdade, nestes casos, não há uma contraindicação permanente, mas sim a necessidade de adiamento. E, por fim, a banca também indicou quadros de imunodeficiências isso é válido para a vacina de febre amarela e também para as demais vacinas de agentes vivos.

206072.

Comentário: Para determinação dos quadros de sobrepeso e obesidade na infância devemos plotar os valores de índice de massa corporal (IMC) nos gráficos de escore-Z o percentil. Lembre-se de que abaixo de cinco anos, o IMC maior que escore-Z 1 (percentil 85) e menor ou igual a 2 (percentil 97) indica risco de sobrepeso maior que 2 e menor ou igual a 3 (percentil 99,9) indica sobrepeso maior que 3 indica obesidade. Lembre-se de que, a partir dos cinco anos, as mesmas faixas indicam, respectivamente, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Fazendo o cálculo do IMC com os dados fornecidos encontraríamos um valor de 19,8 kg m 2 . Plotando este dado no gráfico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fornecido, vemos que o mesmo está acima do percentil 97. Com base nisso não sabemos se esta criança tem sobrepeso ou obesidade... A banca aceitou sobrepeso como resposta ou peso acima do normal. Lembre-se, contudo, de que a determinação de que o peso está elevado para a idade deveria ser feita com o gráfico de peso por idade. Resposta oficial Sobrepeso OU Peso acima do normal para a idade.

176301.

Comentário: Esta questão é um tanto quanto curiosa, pois já nos revelou o final da história , o que não é comum nas questões que abordam este tema. Temos um adolescente que se queixa de baixa estatura. Ao colocarmos a sua estatura atual no gráfico, observamos que não há, de fato, comprometimento estatural. O ponto atual está situado pouco entre os percentis 15 e 50, indicando uma estatura adequada para idade e, além disso, se fizermos o cálculo do alvo-genético e marcarmos o valor obtido no gráfico iremos verificar que o jovem parece estar dentro do seu canal fisiológico de crescimento. Porém, não foi sempre assim... ao construirmos a curva de crescimento com os dados fornecidos, iremos verificar que durante muitos anos houve, de fato, baixa estatura. Diante desta queixa, o primeiro passo é determinarmos a velocidade de crescimento. Basta olharmos a representação gráfica, que iremos perceber que após uma desaceleração nos primeiros anos de vida, a curva de crescimento sempre se mostrou ascendente, indicando uma velocidade adequada. Diante disso, devemos considerar a possibilidade de baixa estatura familiar ou de atraso constitucional do crescimento e da puberdade. Na primeira situação, os pais são baixos e mesmo na adolescência e vida adulta o paciente continua sendo baixo na segunda situação, o provável diagnóstico deste jovem, temos exatamente o descrito. Ocorre uma maturação mais lenta, com início mais tardio da puberdade, porém, após o estirão puberal, a estatura final alcançada é normal, dentro do alvo genético. O gabarito oficial foi Atraso constitucional do crescimento OU Atraso fisiológico do crescimento OU Retardo constitucional de crescimento OU Baixa estatura constitucional.

176320.

Comentário: O caso apresentado foi compatível com o diagnóstico de atraso constitucional do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crescimento havia baixa estatura com velocidade de crescimento normal e, após um retardo no início da puberdade, a estatura final encontra-se normal, dentro do alvo-genético. O exame habitualmente é indicado na avaliação é a radiografia de mão e punho esquerdos para avaliação da idade óssea. No atraso constitucional, como há uma maturação biológica lenta, encontramos uma idade óssea atrasada em relação à idade cronológica. Cabe, contudo, indicar que, neste momento, não esperamos mais encontrar um atraso significativo nesta idade óssea. O gabarito oficial foi Avaliação radiológica da idade óssea OU Avaliação da idade óssea.

176323.

Comentário: O caso apresentado foi compatível com o diagnóstico de atraso constitucional do crescimento havia baixa estatura com velocidade de crescimento normal e, após um retardo no início da puberdade, a estatura final encontra-se normal, dentro do alvo-genético. Lembre-se de que diante da queixa de baixa estatura, a presença de uma velocidade de crescimento normal aponta para uma provável variante da normalidade, ou seja, um quadro de baixa estatura familiar ou de atraso constitucional do crescimento e da puberdade. A avaliação da idade óssea é algo que nos ajuda nesta avaliação na baixa estatura familiar, é compatível com a idade cronológica no atraso constitucional é inferior à idade cronológica, indicando o atraso na maturação biológica. O gabarito oficial foi Idade óssea inferior à cronológica OU Retardo na idade óssea.

152222.

Comentário: Questão polêmica Vamos devagar, no Brasil, caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas, ou seja, são reservatórios e não vetores. Já os morcegos, são os responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre (vetores), entretanto, outros mamíferos, como canídeos (raposas e cachorro do mato), felídeos (gatos do mato), outros carnívoros silvestres (jaritatacas, mão pelada), marsupiais (gambás e saruês) e primatas (saguis), também apresentam importância epidemiológica nos ciclos enzoóticos da raiva. Portanto, resposta morcego. RESPOSTA OFICIAL Morcegos RESPOSTAS EQUIVALENTES Morcegos GABARITO PÓS Resposta Oficial Morcegos Resposta Equivalente O morcego.

152256.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Todos os indivíduos são susceptíveis a infecção pelo bacilo de Koch e os profissionais de saúde, certamente, representam um grupo de risco. É sabido, no entanto, que a maioria das pessoas bloqueia a infecção e não manifesta a doença, sendo considerados portadores de infecção latente por tuberculose. Todavia, a infecção pode ser posteriormente reativada, gerando adoecimento. O tratamento da infecção latente reduz a chance de doença manifesta em 60-90% das pessoas. E a forma de avaliar a infecção é por meio da prova tuberculínica. Profissionais de saúde com viragem tuberculínica, isto é, aumento da PPD maior ou igual a 10 mm, entre a primeira e a segunda avaliação, devem ser avaliados quanto a presença de doença manifesta por meio de radiografia de tórax. Em casos sem doença manifesta (assintomático) a profilaxia com isoniazida deve ser instituída. A forma mais atual de denominar a quimioprofilaxia secundária é tratamento da infecção latente. Logo, gabarito oficial correto. GABARITO OFICIAL Deve fazer Raios X de tórax e receber profilaxia com isoniazida RESPOSTAS EQUIVALENTES Rx de tórax e quimioprofilaxia com isoniazida Fazer RX de tórax e isoniazida oral Radiografar o tórax e administrar isoniazida oral GABARITO PÓS Resposta Oficial Deve fazer Raios X de tórax e receber profilaxia com isoniazida Respostas Equivalentes Rx de tórax e quimioprofilaxia com isoniazida Fazer RX de tórax e isoniazida oral Radiografar o tórax e administrar isoniazida oral.

34972.

Comentário: Sabidamente, por ser uma síndrome cromossômica caracterizada pela deleção de um cromossoma sexual, configurando um cariótipo 45, X0, afeta exclusivamente meninas, e por isso, a opção E é a incorreta. A síndrome de Turner é definida pela presença de um cromossomo X e deleção total ou parcial do segundo cromossomo sexual em paciente com fenótipo feminino, com uma ou mais características clínicas atribuídas à síndrome. Ainda que tradicionalmente se considere o cariótipo 45,X como o mais prevalente, em torno de 50% dos casos, o aumento do número de células contadas em cariótipos ou a avaliação de outros tecidos demonstra uma frequência maior de indivíduos com mosaicismo. Os principais achados físicos divididos por segmentos são nos olhos e região periocular ptose palpebral, estrabismo, pregas epicanticas, hipertelorismo ocular e sobrancelhas espessas orelhas implantação baixa, orelhas rodadas boca

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

boca de peixe, palato em ogiva, alterações dentárias cabelos implantação baix micrognatia tórax em escudo, tórax escavado, hipertelorismo mamário, escoliose e cifose cúbito e geno valgo quarto metacarpo curto linfedema em mãos e pés ao nascer displasias ungueais nevus pigmentares baixa estatura (na imensa maioria dos casos) cardiopatia congênita e malformações genitourinárias.

281872.

Comentário: Herança poligênica é um tipo de herança, na qual participam dois ou mais pares de genes com segregação independente, resultando em um efeito cumulativo de vários genes envolvidos, cada um contribuindo com uma parcela para a formação da característica.A altura humana é um exemplo perfeito de herança poligênica, onde o efeito aditivo de dezenas de genes produz uma distribuição normal. Resposta letra D.

249984.

Comentário: Os antagonistas do fator de necrose tumoral são agentes biológicos utilizados nos casos de ausência de resposta ou resposta parcial às drogas convencionais no tratamento da artrite reumatóide e das espondiloartrites. Por se tratarem de drogas biológicas, está contraindicado aos pacientes as vacinas de vírus vivo, que inclui também a da febre amarela. Resposta letra B.

250011.

Comentário: Essa questão pede a vacina que não pode ser utilizada durante a gravidez e o gabarito oficial liberado pela banca foi a vacina contra raiva. Entretanto, a vacina contra a raiva humana é feita com vírus morto e pode ser aplicada durante a gestação, caso a grávida venha a apresentar algum fator de risco, como ser mordida por cão ou morcego. A gestante pode tomar tanto a vacina como a imunoglobulina contra a raiva caso o médico ache necessário. Por outro lado, uma das alternativas cita vacina contra hepatite C, que ainda não existe a vacina que deve ser oferecida às gestantes para evitar sua contaminação e prevenir a transmissão vertical é a vacina contra hepatite B e não hepatite C. Já as vacinas dupla adulto e influenza também podem ser utilizadas na gestação. Portanto, essa questão está incorreta e deveria ter sido anulada.

181154.

Comentário: As medidas preventivas da obesidade infantil devem ter como foco não apenas a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alimentação saudável, como também hábitos de vida saudável, como a prática de atividade física regular, e devem ser iniciadas desde o início da vida, não apenas na adolescência. Resposta letra B.

139753.

Comentário: A alteração descrita faz tão somente parte da evolução natural da formação da cicatriz de BCG. A reação local da lesão costuma evoluir entre seis e 12 semanas da seguinte forma após a administração de três a quatro semanas surge nódulo no local entre quatro e cinco semanas o nódulo evolui para uma pústula em seguida, evolui para uma úlcera de 4 a 10 mm de diâmetro entre 6 a 12 semanas finalmente, forma-se uma crosta. Durante a evolução dessa lesão, pode ocorrer o enfartamento ganglionar axilar (também supra ou infraclavicular), não supurado, que desaparece espontaneamente e não necessita de tratamento medicamentoso e ou cirúrgico. Esse gânglio é homolateral ao local da aplicação, firme, móvel, clinicamente bem perceptível, frio, indolor, medindo até 3 cm de diâmetro, e não é acompanhado de sintomatologia geral. Desaparece espontaneamente, sem necessidade de tratamento. Resposta letra B.

111921.

Comentário: Como regra geral, o excesso de vitaminas não costuma ser um problema. A exceção é o excesso de vitamina que este paciente parece apresentar vitamina A. A hipervitaminose A só ocorre quando há a ingestão de altas doses de vitamina A por várias semanas ou meses. As manifestações agudas incluem anorexia, irritabilidade, vômitos, sonolência e abaulamento de fontanela (pseudotumor cerebral). Já as manifestações crônicas incluem anorexia, limitação dos movimentos, dores ósseas, craniotabes, eritema e descamação da pele, queilose, alopecia, hepatomegalia, função hepática anormal. Resposta letra C.

111898.

Comentário: No relato da questão temos um caso de mordedura por cão situada no pé, o que caracteriza um ferimento grave, independente de não ser profundo. O cão não é conhecido do indivíduo e não pode ser observado durante 10 dias para avaliação da infecção por raiva. Desta forma, este paciente deve ter seu ferimento lavado com água e sabão, deve receber o soro

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

antirrábico aplicado na região da lesão e também iniciar esquema vacinal com 5 doses nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. Resposta correta D.

321323.

Comentário: De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), duas vacinas devem ser aplicadas ao nascimento a BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, e a vacina contra hepatite B. A BCG está indicada para todos os recém-nascidos com mais de 2000g, independente da idade gestacional. A primeira dose da vacina contra hepatite B (monovalente) deve ser feita o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida da criança, até 30 dias após o nascimento. A aplicação da vacina contra hepatite B ao nascimento independe da idade gestacional e do peso, mas aqueles com peso inferior a 2000 gramas ou com menos que 33 semanas de idade gestacional devem, obrigatoriamente, receber esquema com quatro doses deste imunizante. Atualmente, com a introdução no PNI da pentavalente (tríplice bacteriana ou DTP, Haemophilus influenzae tipo B e hepatite B) aos dois, quatro e seis meses de vida, todas as crianças vacinadas no sistema público recebem um total de quatro doses. Resposta letra B.

292794.

Comentário: Os pacientes submetidos à esplenectomia apresentam maior risco de quadros infecciosos pelos germes encapsulados (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Neisseria meningitidis. Deste modo, recomenda-se vacinação contra estes agentes. Nos pacientes que serão submetidos à esplenectomia eletiva, a vacinação deverá preceder o procedimento cirúrgico pelo período mínimo de 14 dias. Os pacientes já esplenectomizados apresentam resposta melhor à vacinação a partir de 14 dias do ato cirúrgico, mas se deve considerar a oportunidade de vacinar como prioritária na decisão de quando vacinar. Dentre as condições listadas, a que pode ser prevenida por estas vacinas é apenas a pneumonia. Resposta letra C.

292832.

Comentário: A síndrome metabólica consiste na associação de uma série de fatores de risco metabólicos para doença cardiovascular e diabetes tipo 2. A opção A está incorreta a obesidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

central é o principal fator de risco encontrado nestes pacientes e é melhor definida pelo aumento da circunferência abdominal do que. Pelo índice de massa corporal. A opção B está correta independentemente da presença de outros fatores, o acúmulo visceral de gordura aumenta o risco de doença cardiovascular. A opção C está incorreta os índices refletem maior risco, não menor. E, por fim, a opção D está incorreta o desenvolvimento de obesidade na infância pode sim desempenhar papel o desenvolvimento da síndrome metabólica. Resposta letra B.

292834.

Comentário: Esta criança recebeu, na verdade, todas as vacinas recomendadas no primeiro semestre. Lembre-se do calendário proposto nos primeiros seis meses de vida da criança ao nascer, é feita a vacina BCG e a vacina contra hepatite B aos dois e quatro meses são feitas a vacina penta, a vacina contra rotavírus, a vacina pneumocócica 10-valente e a vacina inativada contra poliomielite aos três e cinco meses é feita a vacina meningocócica C aos seis meses são feitas a terceira dose da penta e da vacina inativada contra poliomielite. Além disso, após seis meses, as crianças devem receber a vacina contra influenza durante as campanhas nacionais de vacinação. Além disso, quando vacinadas pela primeira vez, estas crianças devem receber duas doses da vacina. Assim, esta criança tem a indicação de fazer as vacinas recomendadas aos nove meses (1a dose da febre amarela), 12 meses (1a dose da tríplice viral, reforço da vacina pneumocócica e reforço da vacina meningocócica) e aos 15 meses (dose única da hepatite A, reforço de poliomielite com a VOP, reforço com DTP e tetra viral, que representa a segunda dose da tríplice viral e a primeira dose da varicela a tetra viral será feita apenas 30 dias após a tríplice viral). A vacina de febre amarela e a tríplice viral não podem ser feitas simultaneamente, sendo indicado um intervalo de 30 dias entre ambas. A vacina contra influenza não será necessariamente feita, pois é feita apenas durante as campanhas, mas como estava indicada em todas as opções, não nos impediria de chegar à resposta correta. Resposta letra A. Aproveitando para aprender um pouco mais... Uma dúvida comum é a diferença entre as doses do esquema básico e as doses de reforço. Por que falamos em primeira, segunda ou terceira doses e doses de reforço Quais as diferenças As vacinas aplicadas são rigorosamente as mesmas. As respostas imunes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desencadeadas é que serão distintas. Para que ocorra proteção, é necessária a produção de uma quantidade mínima de anticorpos. Algumas vacinas conseguem isso com apenas uma dose, enquanto outras precisam de duas ou mais doses. Por isso, para algumas situações, é necessário mais do que uma dose no esquema básico. Em alguns casos, com o passar o tempo, mesmo o indivíduo que chegou a produzir anticorpos em título protetores pode perder esta proteção. Nesta situação, podemos indicar as doses de reforço. De forma bem simples dose do esquema básico - mínimo para estar protegido dose de reforço - voltar a proteger quem já esteve protegido, mas pode ter perdido esta proteção.

292836.

Comentário: O primeiro passo neste caso é definirmos o diagnóstico desta criança a associação dos pródromos catarrais com um exantema craniocaudal nos indica o diagnóstico de sarampo. Se houvesse ainda qualquer dúvida, a descrição das manchas de Koplik faz com que esta dúvida desapareça. A profilaxia pós-exposição pode ser feita de duas formas com a administração da vacina até três dias após a exposição (opção B incorreta e opção D correta) ou com o uso da imunoglobulina, até seis dias após o contato. Lembre-se de que a profilaxia é necessária apenas para os suscetíveis, ou seja, indivíduos que nunca tiveram a doença ou nunca foram vacinados. A vacina, para fins de bloqueio, pode ser feita a partir dos seis meses (opção A e C incorretas), sendo que as doses feitas em menores de um ano não são consideradas como doses válidas para fins de rotina. Lembre-se de que esta é uma vacina de vírus vivo atenuado e, deste modo, não é feita em grávidas nem em imunodeprimidos. Nestas situações, e também para as grávidas e os menores de seis meses, a imunoglobulina está indicada. Resposta letra D.

259742.

Comentário: O termo síndrome metabólica define uma série de alterações que são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica na vida adulta. De acordo com a International Diabetes Federation o diagnóstico de síndrome metabólica pode ser estabelecido entre 10 e 16 anos da seguinte forma (1) Aumento da circunferência abdominal (maior ou igual ao percentil 90) e mais 2 dos seguintes critérios a) triglicerídeos maior ou igual a 150 mg dl b) HDL

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

menor que 40 mg dl c) pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg e diastólica maior ou igual a 85 mmHg e d) glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg dl (recomendado o teste de tolerância oral a glicose) ou presença de DM tipo 2. Logo, o parâmetro que mais se relaciona é o aumento da circunferência abdominal descrito no enunciado (é o critério obrigatório para a caracterização do quadro). Resposta letra A.

234017.

Comentário: No manejo de uma criança vítima de mordedura, precisamos avaliar as recomendações referentes a duas profilaxias tétano e raiva. Em relação à profilaxia para tétano, precisamos avaliar o risco do ferimento para tétano acidental e a situação vacinal do paciente. Em relação ao risco, qualquer mordedura será considerada um ferimento de alto risco. Entretanto, nesse caso, não há necessidade de profilaxia específica. O paciente com situação atualizada para tétano é aquele que já recebeu três ou mais doses da vacina para tétano. Se a última dose realizada foi há menos de cinco anos, mesmo sendo um ferimento de alto risco, não há necessidade de recomendar nenhuma profilaxia específica (letra C incorreta). Em relação à profilaxia para raiva, quando há uma vítima mordedura, precisamos avaliar o tipo de acidente (leve ou grave) e a situação do animal agressor (se era suspeito para raiva, se é doméstico, se há possibilidade de acompanhamento do animal). A criança apresentou um acidente grave, já que foi uma mordedura na face diante de um acidente grave, segundo o Ministério da Saúde, causado por um animal sem suspeita de raiva no momento da agressão, como é o caso apresentado, deve-se iniciar o esquema vacinal e acompanhar o animal por 10 dias. Se nesse período o animal permanecer saudável, bastam as duas doses de vacina recebidas nos 10 dias. Esse conceito vem sendo questionado se você está diante de um acidente causado por um animal que não tem possibilidade de ter raiva, não é obrigatório iniciar o esquema profilático. Porém, a banca entende que precisa começar o esquema vacinal (letra A incorreta). Em relação à sutura, quando há mordedura, o ideal é não realizar o fechamento da lesão pelo risco de infecção. Porém, alguns tipos de mordedura, como lesão de face, a sutura deve ser considerada - o prejuízo estético é elevado na face (letra B incorreta). E, por fim, a letra D é a afirmativa correta na hora da limpeza da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ferida, deve ser realizado substância viricida (p. ex. PVPI). Resposta letra D.

234049.

Comentário: A Síndrome Metabólica (SM) é a associação de obesidade visceral, resistência insulínica, intolerância à glicose, hipertensão e dislipidemia. Antes dos dez anos de idade, não se recomenda fazer o diagnóstico de SM, mas na presença de obesidade abdominal deve-se enfatizar a importância de redução de peso e reeducação alimentar, com ênfase em mudança de comportamento. Em crianças acima de dez anos, a SM pode ser diagnosticada pela presença de obesidade abdominal e de duas ou mais manifestações clínicas, entre elas triglicérides aumentados, HDL (lipoproteínas de alta densidade) baixas, hipertensão arterial ou hiperglicemia. O grande marcador da SM é a presença da adiposidade central indicada pela circunferência da cintura acima do percentil 90. Logo, a melhor resposta para a questão é a letra D. Resposta letra D.

234072.

Comentário: Pouco importa o que o casal afirma... Se não há comprovação, assumimos que as vacinas não foram feitas e seguimos as orientações do Ministério da Saúde. A partir de 2020, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina tríplice viral para toda a população de até 59 anos. Entre 1 e 29 anos são necessárias duas doses da vacina entre 30 e 59, basta uma dose. Deste modo, Maria irá receber duas doses, com intervalo de 30 dias João receberá apenas uma. Resposta letra B.

234074.

Comentário: Questão bem difícil aqui e que nos apresenta um paciente com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool que pode ter gerado deficiência de algumas vitaminas e nutrientes, como a vitamina B3 E, muito provavelmente, essa deficiência de niacina (termo que engloba tanto a deficiência de nicotinamida quanto de ácido nicotínico) levou ao quadro de pelagra Esta é considerada um déficit de nicotinamida no interior da célula. Seja por causa primária (déficit nutricional) ou secundária (doença subjacente). Manifesta-se por evolução crônica, com períodos de exacerbação e remissão. Apresenta-se sob a forma de demência, diarréia e dermatite três Ds . A forma de apresentação mais comum é com sintomas incompletos e não a tríade clássica. O

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quadro cutâneo consiste em eritema simétrico nas superfícies expostas ao sol, nas extremidades, face (eritema em asa de borboleta) e ao redor do pescoço (colar de casal). A manifestação inicial consiste em eritema e prurido no dorso das mãos. A pele a seguir torna-se edematosa e em alguns doentes se desenvolvem vesículas ou bolhas, cuja ruptura causa erosão (pelagra úmida). Progressivamente há espessamento e hiperpigmentação. Fissuras dolorosas às vezes se desenvolvem nas palmas e plantas. Os distúrbios gastrintestinais mais importantes são diarréia e vômitos. As alterações neuropsiquiátricas variam desde sintomas leves como astenia, dores variadas, insônia, depressão até total instabilidade emocional e manias. A pelagra clássica responde dramaticamente à administração oral de nicotinamida ou ácido nicotínico na dose de 100-300 mg dia três vezes ao dia. Niacinamida é preferida, uma vez que não causa distúrbios vasomotores como a niacina. As alterações mentais desaparecem em 24h-48h, mas as lesões de pele podem demorar até 3 a 4 semanas. Resposta letra D.

234077.

Comentário: Vamos relembrar quais vacinas a criança deve tomar aos 2 meses de vida Pentavalente (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B) 1ª dose Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (previne a poliomielite) - 1ª dose Pneumocócica 10 Valente (conjugada) (previne a pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) - 1ª dose Rotavírus humano (previne diarreia por rotavírus) 1ª dose. Ou seja, dentre as opções somente a letra C encontra-se correta.

234088.

Comentário: Questão sobre vacinas na gravidez. Importante lembrar da regra sobre vacinas na gestação não devem ser utilizadas vacinas de microrganismos atenuados, como sabin, caxumba, sarampo, rubéola... Por outro lado, são permitidas as vacinas de microrganismos mortos e fragmentos virais, como vacina contra hepatite A, hepatite B, dT, dTpa, H1N1, influenza, gripe, raiva e meningococo. As vacinas recomendadas de rotina durante o pré-natal são influenza, hepatite B e dTpa. Atenção porque algumas vacinas permitidas, como a vacina contra hepatite A, apesar de liberadas não são recomendadas de rotina pelo Ministério da Saúde. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199676.

Comentário: A vacina BCG oferece proteção contra as formas graves de tuberculose e recomenda-se que seja administrada logo após o nascimento. A sua administração é feita por via intradérmica e é indicado que seja feita na inserção inferior do músculo deltoide direito. Uma das razões para o local de administração ser padronizado é a possibilidade de acompanharmos a evolução da lesão vacinal. Até janeiro de 2019, a recomendação do Ministério da Saúde era a seguinte quando a cicatriz não era identificada após seis meses, uma segunda dose era feita, não havendo necessidade de teste tuberculínico prévio. Contudo, desde o início de 2019, tal recomendação desapareceu. Com base em orientações da própria OMS, o Ministério da Saúde passou a indicar que a ausência de cicatriz não significa falta de proteção, sem mais necessidade de revacinar. Resposta (na ocasião do concurso) letra B.

199692.

Comentário: Quando estamos diante de um indivíduo que não apresenta registro de uma vacina, devemos presumir que ela não foi feita. Toda a população de até 29 anos deve ter duas doses da vacina contra sarampo a partir de um ano de idade, com intervalo de 30 dias entre as doses. Além disso, os profissionais de saúde também devem ter sempre duas doses desta vacina, independentemente da idade. Resposta letra C.

173018.

Comentário: Relembrando, aos nove meses a criança já deveria ter recebido as seguintes vacinas BCG (uma dose, ao nascer) hepatite B (uma dose, ao nascer) pentavalente (três doses, aos 2, 4 e 6 meses) poliomielite inativada (três doses, aos 2, 4 e 6 meses) pneumocócica conjugada (duas doses, aos 2 e 4 meses) rotavírus (duas doses, aos 2 e 4 meses) e meningocócica (duas doses, aos 3 e 5 meses). Todas as vacinas que deveriam ter sido feitas até então estarão recomendadas para esta criança, exceto uma a vacina contra rotavírus. Lembre-se de que a primeira dose é feita apenas até três meses e 15 dias e a segunda dose até sete meses e 29 dias. Resposta letra A.

173037.

Comentário: O primeiro passo é definir se a criança apresenta baixa estatura. Utilizando o gráfico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anexo para classificação, podemos observar que o escolar está com altura inferior ao percentil 3 para a idade, que define a sua baixa estatura. Sabemos que a melhor medida para avaliação do crescimento linear é a Velocidade de Crescimento (VC), mas, infelizmente, não foram fornecidos dados das estaturas anteriores do paciente, o que impossibilita a sua determinação. O segundo parâmetro a ser avaliado é o alvo genético e, para tal avaliação, vamos utilizar as alturas dos pais que foram fornecidas, utilizando a seguinte fórmula para cálculo (altura do pai em cm altura da mãe em cm) 13 2 (- 8,5 cm). Ao substituir os valores, obtemos um alvo genético de 161,5 cm, com desvio de - 8,5 cm (153 170 cm). Logo, o paciente encontra-se dentro do alvo genético da família, considerando que apresente uma VC normal (cerca de 5 cm ano até a puberdade). Vamos avaliar o próximo dado fornecido a Idade Óssea (IO), que é de suma importância na avaliação do retardo constitucional do crescimento. Lembre-se de que nesta situação a idade óssea estará atrasada em comparação à cronológica. No entanto, uma IO de 6 anos e 6 meses não é um atraso importante, considerando que a criança tem 7 anos, pois aceita-se desvios de atraso ou adiantamento da idade óssea em comparação à cronológica, o que confere um exame normal (logo, a opção D não pode ser a resposta). Por fim, os exames laboratoriais estão normais (apesar de não ter sido informado que exames seriam estes...). Ainda assim, com esse dado, é improvável que as duas causas endócrinas apontadas nas alternativas A e C sejam a resposta correta da questão. Logo, considerando-se o alvo genético baixo e a descrição da normalidade de exames, o diagnóstico mais PROVÁVEL deste caso clínico parece ser a baixa estatura familiar. Resposta letra B.

172950.

Comentário: Um dos parâmetros usados pela Organização Mundial de Saúde para identificar os quadros de desnutrição grave é a circunferência braquial. As crianças com idade entre seis e 59 meses que tenham uma circunferência menor que 115 mm são consideradas com desnutrição grave. Esta é uma forma bastante simples para identificar essas crianças e a avaliação pode ser feita com auxílio de fitas coloridas padronizadas para este fim que são distribuídas nas comunidades. Avaliando a descrição das características do exame físico, não encontramos o principal marcador clínico dos quadros de kwashiorkor, que é a presença do edema. Pelo contrário,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é dito que há magreza acentuada visível e face envelhecida, aspectos encontrados na criança com marasmo, crianças que têm ausência de tecido subcutâneo. Resposta letra B.

173010.

Comentário: Sabemos que, além de todas as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações, o profissional de saúde recebe algumas outras vacinas, como a vacina contra a influenza, administrada anualmente nas campanhas. Se este estudante recebeu todas as vacinas até os cinco anos de idade, já recebeu três doses da vacina contra a hepatite B, não havendo indicação de novas doses (é verdade que a sorologia deverá ser feita, por ser um profissional de saúde, mas a vacina não é rotineiramente indicada porque não há o relato de sorologia), já recebeu uma dose de febre amarela (desde abril de 2017 a recomendação é de dose única), e também já recebeu três doses da vacina contra tétano, mas havendo a recomendação de um reforço agora (os reforços são feitos a cada dez anos). Resposta letra A.

172999.

Comentário: A questão pergunta sobre a vacinação contra hepatite B em uma paciente que possui sorologia HBsAg e Anti-HBs não reagentes, ou seja, a paciente não tem a doença e não possui imunidade, apesar de ela já ter recebido uma dose da vacina. Ela deve completar o esquema de vacinação contra hepatite B com duas doses na gravidez e o problema que houve no momento da prova é que a resposta da banca foi a letra B, após o primeiro trimestre. Esta era a recomendação do Caderno de Atenção Básica Pré-natal de baixo risco, porém o protocolo mais novo do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão vertical de hepatite B, de 2016, recomenda que a vacina pode ser realizada em qualquer momento da gestação. Isto ocorre porque ela é totalmente segura e não há complicações em qualquer fase da gestação. Assim, após recurso, a banca mudou seu gabarito inicial de letra B para letra A. Resposta letra A.

150820.

Comentário: Como a lesão foi descrita como de coloração amarelo nacarado, concluímos se tratar de uma queimadura de 3º grau. Isso porque o tal amarelo representa a gordura do tecido celular subcutâneo. Nesses casos, daremos preferência a curativos fechados para diminuir a exposição de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tecidos nobres (abaixo da derme), diminuindo a taxa de infecção. Passada a fase inicial da lesão, retira-se o curativo e programa-se a abordagem final com enxerto ou retalho. A ressecção cirúrgica de toda a lesão só estará indicada em casos de escara associada a síndrome compartimental ou restrição respiratória. Gabarito letra B.

150797.

Comentário: Esta questão abordou especificamente as mudanças ocorridas em janeiro de 2016 no calendário de imunizações do Ministério da Saúde. As principais mudanças ocorridas foram as seguintes 1) a terceira dose da vacina contra poliomielite passou a ser feita com a vacina inativada. Assim, as crianças passaram a receber três doses com a vacina inativada (aos 2, 4 e 6 meses) e dois reforços com a vacina oral (aos 15 meses e 4 anos). 2) a terceira dose da vacina conjugada pneumocócica passou a não ser mais recomendada (opção D correta). Assim, as crianças passaram a receber apenas duas doses da vacina (aos 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses). 3) algumas vacinas tiveram suas faixas etárias ampliadas (as vacinas pneumocócica e meningocócica passaram a ser feitas até 4 anos 11 meses e 29 dias). 4) a vacina contra hepatite A passou a ser feita aos 15 meses. 5) a vacina contra o HPV passou a ser feita em apenas duas doses, com intervalo de 6 meses (as três doses foram mantidas apenas para grupos especiais, como pacientes com HIV Aids e imunodeprimidos). Resposta letra D.

150882.

Comentário: Um adolescente apresentou mordedura em braço esquerdo por um sagui, devendo então ser avaliada quanto a profilaxia por possível exposição a raiva. Para tal, será necessário a avaliação da gravidade da lesão e do animal. Se tratando de animal silvestre, além da lavagem da lesão com água e sabão, o paciente deverá iniciar imediatamente o tratamento com cinco doses da vacina, administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28 pós-exposição. No entanto, se o ferimento foi considerado grave (profundo, extenso ou múltiplo), o adolescente será submetido a vacinação e também a aplicaçao do soro na porta de entrada e, na impossibilidade de infiltrar toda a dose, aplicar o restante por via intramuscular na região glútea. Inicialmente, o gabarito da questão foi a letra A. No entanto, por não contemplar este detalhe com relação ao soro, a questão foi anulada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150816.

Comentário: A vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) é vacina inativada, portanto, sem evidências de riscos teóricos para a gestante e o feto. Desde 2014, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação em todas as gestantes de uma dose entre 27 e 36 semanas de gestaçã, no intuito de conferir uma proteção inicial contra a coqueluche para o feto. No entanto, caso a gestante apresente esquema incompleto ou nunca tenha realizado a vacinação, poderá ser submetida a uma ou duas doses da vacina dT (dupla adulto), além da dTpa. Resposta letra B.

127029.

Comentário: Nas últimas décadas estamos testemunhando um alarmante aumento da obesidade na população infantil, com todas as consequências em longo prazo que essa condição acarreta. Por conta disso, mesmo quando não questionado pela família, o pediatra deve, em todas as consultas, tentar dar orientações no sentido de evitar o estabelecimento desta condição. A única afirmativa que traz orientações corretas é a letra C. Não se esqueça das várias orientações que são preconizadas nos dez passos para uma alimentação saudável em menores de dois anos doces guloseimas não devem ser oferecidos para menores de dois anos o aleitamento deve ser exclusivo por seis meses. E, em relação às atividades físicas, deve ser estimulada a prática diária de alguma forma de atividade e devem ser dadas orientações para redução do tempo gasto com atividades sedentárias. Resposta letra C.

102175.

Comentário: Temos uma menina de 10 anos de idade que mede 128 cm. A primeira pergunta é ela tem baixa estatura Para respondermos esta pergunta, a banca nos forneceu um gráfico. Ao plotarmos a altura atual e a pregressa, observamos que essa paciente vem crescendo entre os percentis 3 e 15 e com velocidade de crescimento normal. Por qual razão foi solicitada uma radiografia para avaliação de idade óssea é um mistério. Será que ela está muito abaixo de seu alvo genético Além disso, essa menina é impúbere e ainda irá passar pela aceleração do crescimento puberal. Logo, iremos tão somente acompanhá-la clinicamente. Resposta letra D.

81266.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O leite de cabra in natura apresenta apenas traços de folato e por isso é deficiente nesta vitamina. A suplementação de ácido fólico é obrigatória se o leite de cabra for a alimentação principal. Imaginamos que esta criança de 2 anos já receba alimentação complementar, mas o fato da fonte proteica principal dela derivar majoritariamente do leite de cabra a torna suscetível à carência de ácido fólico, apesar da ingestão de vegetais e frutas. Além disso, condições de rápido crescimento tecidual fazem aumentar as exigências dessa vitamina, e a lactância é um período com estas características. Resposta letra C.

51294.

Comentário: Antes de mais nada, é fundamental salientarmos que o omeprazol não tem seu uso liberado para crianças menores de 1 ano de idade seguindo nosso raciocínio, parece que o autor estabelece uma relação entre o quadro neurológico do bebê e a dieta materna, parecendo evidente (pela clínica e pela história) estarmos diante de uma condição de hipovitaminose B12. A partir daí, podemos concluir que a droga contraindicada no caso é o omeprazol, o qual acentuaria a deficiência vitamínica em questão na medida em que inibe sua absorção pela elevação do pH gástrico.

51231.

Comentário: Qual o diagnóstico nutricional desta criança Ao que tudo indica, trata-se de uma criança eutrófica (seu peso parece estar adequado para sua estatura, pois ambos estão no mesmo percentil) com altura normal (acima do percentil 3). Qual a conduta neste momento Simplesmente seguir o acompanhamento regular nas consultas de puericultura, com a vigilância do crescimento e do desenvolvimento. Resposta letra C.

51233.

Comentário: As diretrizes da ABESO publicadas em 2009 2010 adotam a definição da International Obesity Task Force , em que a condição de sobrepeso seria representada por um índice situado na curva de percentil de IMC entre os valores de 85% e 95% para a faixa etária, enquanto que a classificação de obesidade corresponderia ao valor acima de 95%. Alternativa A correta.

30873.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Primeiro passo calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Lembrem-se de que o IMC é obtido dividindo o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). Assim, temos que o IMC dessa paciente é de 20,13 kg m². Chegando-se a esse valor, o passo seguinte é colocarmos o ponto no gráfico e vermos a relação entre esse ponto e as curvas de percentil. Vemos que o IMC por idade dessa menina encontra-se acima do percentil 97. Segundo as atuais recomendações do Ministério da Saúde, para os indivíduos com idade entre 5 e 19 anos, o IMC por idade acima do percentil 85 e menor ou igual ao percentil 97 significa sobrepeso quando acima do percentil 97 e menor ou igual ao percentil 99,9, significa obesidade já o IMC por idade acima do percentil 99,9 significa obesidade grave. Não está representada no gráfico apresentado a curva do percentil 99,9. De todo modo, podemos dizer que essa paciente apresenta obesidade. O gabarito correto é a letra D.

37041.

Comentário: Questão bastante simples. Sempre que falamos de deficiência vitamínica e alteração ocular devemos nos remeter à deficiência de vitamina A. O sintoma mais precoce é a diminuição da visão no escuro, até a completa cegueira noturna (nictalopia ou hemeralopia). A queratinização do epitélio da córnea também é precoce e predispõe a infecções. Em estágios mais avançados, com a infecção e o infiltrado de linfócitos, a córnea torna-se enrugada, mole e se degenera irreversivelmente (ceratomalácia). Em casos muito graves, a córnea se rompe e permite o extravasamento do cristalino e humor vítreo. A conjuntiva bulbar também sofre queratinização e desenvolve placas as manchas de Bitot, outra lesão de surgimento precoce, descritas no enunciado. Assim, a resposta correta é a opção A.

37435.

Comentário: Todas as alternativas, exceto as letras C e E, apresentam doenças do trato gastrointestinal que cursam com má absorção de gorduras e, por conseguinte, de vitaminas lipossolúveis (ADEK), as quais são perdidas nas fezes esteatorreicas. A carência de vitamina D promove raquitismo (deficiência de mineralização) nos esqueletos em crescimento (criança). Em adultos a doença se chama osteomalacia . Pois bem, a síndrome de Fanconi é um distúrbio tubular

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

renal, caracterizado pela perda de todas as funções do túbulo proximal (bicarbonatúria, com ATR tipo II aumento da fração excretória de sódio, com hipocalemia por secreção distal e hipercalciúria hiperfosfatúria e hipofosfatemia, glicosúria renal e aminoacidúria). A hiperfosfatúria, ao espoliar o organismo de fosfato, afeta o processo normal de mineralização óssea, e por isso, quando presente em crianças, pode levar ao raquitismo. Resposta certa C.

37438.

Comentário: A obesidade infantil configura distúrbio que assume prevalência crescente na população, gerando limitações significativas do direito à saúde nas distintas faixas etárias, além de custos orçamentários relevantes para tratamento das comorbidades correlatas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em uma publicação que trata especificamente deste assunto, elenca uma série de condições associadas ao sobrepeso e à obesidade. Aí encontramos a associação com o refluxo gastroesofágico, que foi o gabarito da questão. Desta forma, a melhor resposta seria a letra E, pois todas as condições estão associadas. De toda forma, apenas uma referência foi indicada pela banca deste concurso e, por esta fonte, a resposta seria a letra D, que foi o gabarito.

29456.

Comentário: Estamos diante de um adolescente que apresenta baixa estatura. Não dispomos de uma importante informação sua velocidade de crescimento. Porém, com os dados fornecidos e as opções disponíveis podemos chegar ao gabarito correto. O jovem apresenta-se na idade limite para o diagnóstico de traso puberal, que é definido, em meninos, como a ausência de sinais puberais após os 14 anos. Sua idade óssea é compatível com sua idade estatural, e ambas apresentam-se atrasadas em relação à sua idade cronológica. Tudo isso nos leva a pensar no atraso constitucional do crescimento e puberdade. Nesta condição, o crescimento e a puberdade têm início mais tardio, porém não há qualquer comprometimento da estatura final o padrão de estatura familiar será atingido. Não existe qualquer indicação para o uso de hormônio de crescimento nessa situação. Logo, a opção B está incorreta.

24320.

Comentário: Estamos diante de um quadro clínico marcado por estomatite angular, glossite,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fotofobia e dermatoses, provavelmente secundário a uma disvitaminose. Vamos ver o que causa cada uma das opções listadas. Opção A Errada. A hipervitaminose A ocorre quando crianças ingerem diariamente e de forma crônica mais de 6000 mcg. As principais manifestações clínicas agudas são síndrome de pseudotumor cerebral, fontanela abaulada em crianças pequenas, anorexia, dificuldade de ganhar peso, dermatite seborreica e aumento de fígado e baço. Na forma crônica pode haver causa de dor óssea, queda de cabelo, descamação cutânea, anorexia, hepatomegalia e hiperostose cortical. Opção C Errada. A deficiência de ácido ascórbico, vitamina C, chama-se escorbuto. Apresenta manifestações musculoesqueléticas, hematológicas, cutaneomucosas e comportamentais. O ácido ascórbico está presente de forma abundante em frutas ácidas, e o enunciado não menciona ingestão pobre desta classe de alimentos. Opção D Errada. A hipovitaminose D leva ao quadro de raquitismo em lactentes e crianças maiores. As alterações gerais incluem diminuição do crescimento ponderoestatural, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, palidez, irritabilidade, sudorese, hipotonia muscular, distensão abdominal e hérnias, aumento do baço e gânglios linfáticos (principalmente cervicais), estridor laríngeo e laringoespasmo. As alterações ósseas são simétricas e indolores, acometendo a cartilagem de crescimento e levando a alterações em todos os segmentos corporais (alguns sinais clássicos incluem o craniotabes, o sulco de Harrison, a presença de genu varum ou genu valgum). E a opção B Está correta. A riboflavina, vitamina B2, é encontrada principalmente em vísceras, leite e alguns vegetais de folhas verdes. Os achados clínicos mais frequentes da carência de riboflavina são queilose, queilite angular, glossite, palidez de mucosas e manifestações oculares, como fotofobia. O uso do arroz polido está associado com a deficiência de ribloflavina, corroborando a nossa hipótese.

25329.

Comentário: Temos aí a descrição de várias manifestações associadas com o excesso de vitamina A no organismo. A hipervitaminose A pode ocorrer quando crianças ingerem diariamente e de forma crônica mais de 6.000 mcg de vitamina A. As principais manifestações clínicas agudas são síndrome de pseudotumor cerebral (cefaleia, vômitos, papiledema, diplopia, paresia de pares

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cranianos) fontanela abaulada em crianças pequenas anorexia dificuldade de ganhar peso dermatite seborreica, e aumento de fígado e baço. Na forma crônica, pode causar dor óssea queda de cabelo descamação cutânea anorexia hepatomegalia e hiperostose. A hiperostose acomete principalmente ossos longos e pode ser evidenciada em exames radiográficos, como no caso enunciado.

9094.

Comentário: Considerando-se que o ganho mensal de peso no primeiro trimestre de vida é 700g mês, no segundo trimestre, 600g mês e no terceiro trimestre 500g mês, Pedro aos nove meses deveria estar pesando aproximadamente 8 kg. Outra forma de estimarmos o peso médio para a idade é verificar que o percentil 50 do gráfico peso x idade para meninos do NCHS ou OMS corresponde a 9,250 e 9 kg, respectivamente. Ao colocarmos o peso de Pedro no gráfico peso x idade do NCHS CDC (2000) ou OMS (2007) verificamos que se encontra muito abaixo do último percentil. De acordo com a última classificação antropométrica do Ministério da Saúde, quando o peso encontra-se abaixo do percentil 0,1, a criança é classificada como portadora de MUITO BAIXO PESO, e se o peso estiver entre o percentil 0,1 e o percentil 3, é categorizada como BAIXO PESO. Uma crítica a esta questão onde está o gráfico de peso x idade para que o aluno possa responder à questão com segurança Sem ele, a questão adquire um alto grau de dificuldade.

9102.

Comentário: Trata-se de uma criança com magreza acentuada, um quadro de desnutrição grave, pois seu IMC situa-se abaixo do escore Z -3. As assertivas A e B trazem corretamente os mais aceitos pontos de corte para considerarmos o diagnóstico de hipoglicemia e anemia grave no lactente, apesar de não haver consenso definitivo sobre tais valores. A opção D, embora não muito clara, também está correta. A positividade da urinocultura, que deve sempre ser interpretada de acordo com o método de coleta empregado, confirma o diagnóstico de infecção do trato urinário (lembrem-se sempre de que um desnutrido grave apresenta, a priori, uma infecção). Embora o exame (supomos que o autor se refira ao exame simples de urina) não confirme o diagnóstico de infecção urinária, pode indicar a presença de infecção nesse sítio. A opção C, por sua vez, está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incorreta. Os desnutridos graves possuem alterações nas proteínas séricas e a presença de hipoproteinemia é um importante marcador de mau prognóstico.

6943.

Comentário: O peso ideal para um menino de 15 meses, considerando o percentil 50, é de 11,125 kg, segundo o gráfico Peso x Idade fornecido pela banca do concurso. Como seu peso real é de 7 kg, podemos dizer que o menino apresenta um déficit ponderal de 37% em relação ao ideal Déficit ponderal (Peso Ideal Peso Real) x 100 Peso Ideal . De acordo com a classificação da desnutrição energeticoproteica de Gómez, a criança do caso é portadora de desnutrição de 2º grau. Veja a classificação completa abaixo Déficit de 10-24% em relação ao p50 Leve ou Primeiro Grau Déficit de 25-39% em relação ao p50 Moderado ou Segundo Grau Déficit de 40% em relação ao p50 Grave ou Terceiro Grau.

8916.

Comentário: A questão nos traz um menino de 14 anos, sem doença pregressa, sem anormalidade ao exame físico e que acabou de iniciar a puberdade, pois apresenta um testículo com volume de 4 cm^3. Sabemos que, nos meninos, o primeiro sinal de puberdade é o aumento testicular aos 9 ½ anos em média, definindo assim o estágio G2 de Tanner. Este fenômeno é resultado do aumento de tamanho dos túbulos seminíferos. O crescimento testicular é importante na puberdade. Antes de seu início, o volume encontra-se em torno de 1 a 3 ml. Um volume de 4 ml ou mais é indicativo de puberdade. Além de ter iniciado a puberdade no limite máximo de idade ainda considerado fisiológico (a ausência de aumento testicular após 14 anos é considerado atraso puberal nos meninos), o adolescente é baixo e sempre foi o menor da turma, dizem os pais. Diante de um adolescente saudável, trófico, com baixa estatura proporcionada (a relação SS SI nesta idade varia de 0,9 a 1) e retardo puberal, devemos pensar em alguma condição benigna, ou seja, variante da normalidade. As duas principais causas de baixa estatura benigna são a baixa estatura familiar e o atraso constitucional do crescimento. Vejamos cada uma delas Baixa Estatura Familiar as crianças com baixa estatura familiar apresentam-se com peso e estatura normais ao nascimento, e após os 2-3 anos apresentam um desvio para baixo na sua curva de estatura, entrando no seu canal de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crescimento genético . Esta curva geralmente é paralela e está abaixo do percentil 3, e assim permanece através da puberdade. A velocidade de crescimento é normal e a idade óssea é compatível com a idade cronológica. Ao final, o indivíduo alcançará uma estatura final compatível com seu alvo genético. Para que pudéssemos pensar neste diagnóstico, necessariamente o caso deveria trazer a estatura do adolescente e seus pais. Atraso Constitucional do Crescimento e Puberdade no atraso constitucional, temos uma criança que também, após os 2-3 anos, sofre uma desaceleração do crescimento, produzindo uma curva paralela e abaixo do percentil 3, com velocidade de crescimento normal até a puberdade, de modo semelhante à da baixa estatura familiar. A grande diferença é que a idade óssea, neste caso, é atrasada em média 3 anos em relação à idade cronológica. Quando chegam à adolescência, estas crianças sofrem nova desaceleração do crescimento (velocidade de crescimento média de 4 cm ano) e atraso na maturação sexual. Em outras palavras, há um retardo para desencadear a puberdade e o estirão do crescimento. São crianças com crescimento e desenvolvimento mais lento, porém por um período mais prolongado, de modo a não haver prejuízo da estatura final. Tipicamente a criança com ACCP é saudável e não apresenta anormalidade fenotípica. Existe sempre uma história familiar positiva, com o pai tendo sido baixo quando criança e apresentado um estirão pubertário um pouco mais tardio. Agora, vejamos as outras opções A) o hipopituitarismo geralmente cursa com obesidade, pés e mãos pequenos, fácies de boneca, alterações fenotípicas ausentes neste paciente B) a síndrome de Klinefelter apresenta aspecto eunucoide (com grande redução da relação SS SI) e geralmente é causa de alta estatura C) o hipotireoidismo pode desencadear baixa estatura e puberdade precoce, o que não é o caso. Além disso, faltam outros sintomas clínicos que nos façam suspeitar do diagnóstico E) o cariótipo da síndrome de Turner é 45, X0, portanto, é impossível um homem com a síndrome.

13481.

Comentário: A síndrome de recuperação nutricional ocorre durante o tratamento correto dos casos de desnutrição grave, sendo mais exuberante nos casos de kwashiorkor, observado entre o 20º e 40º dias de tratamento. Estas alterações costumam regredir por volta da 10ª a 12ª semana após o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

início do tratamento. Não se sabe ao certo a etiologia dessas alterações. As manifestações clínicas observadas nessa síndrome clínica variam de intensidade e as mais comumente encontradas são 1) Hepatomegalia à custa do lobo esquerdo, com maior aumento sendo encontrado por volta da quinta semana após o início do tratamento 2) Distensão abdominal com circulação venosa colateral e ascite 3) Fácies de lua cheia 4) Alterações de pele e fâneros sudorese intensa em região cefálica, hipertricose, unhas com desnível transversal, cabelos com pontas mais claras 5) Telangiectasias mais visíveis em face. Dentre as alterações bioquímicas mais freqüentes encontramos 1) Hipergamaglobulinemia 2) Eosinofilia 3) Aumento da volemia. Resposta letra D.

13489.

Comentário: O primeiro passo para acertar a questão é determinar a dose diária de ferro que essa criança deve receber para tratar a anemia ferropriva. Para tratamento a dose recomendada é de 4 a 6 mg kg dia. Utilizando-se dose de 5 mg kg dia, chegamos a uma dose total de 50 mg dia. Basta agora dividir 50 (dose diária) por 1,25 (dose por gota), o que totaliza 40 gotas. Resposta letra C.

349759.

Comentário: Há alguns problemas com essa questão, que foi anulada após recurso. Mas vamos aproveitá-la para aprender. Pela classificação nutricional a partir dos gráficos da Organização Mundial de Saúde (OMS), crianças e adolescentes de 5 anos até 19 anos incompletos são consideradas com sobrepeso se os valores do IMC para idade e sexo estiverem entre o escore Z 1 e 2 obesas entre os escores Z 2 e 3 e com obesidade grave se valores acima do escore Z 3. Além disso, sabemos que o IMC deve ser calculado por meio da fórmula IMC peso (kg) (altura(m) ao quadrado). Entretanto, a banca não apresentou o gráfico da OMS e errou o cálculo do IMC, que seria de 18 kg m2 pelas medidas fornecidas (e não 23 kg m2 como informado). Para o IMC de 18, a adolescente seria classificada como sobrepeso e para o de 23, como obesidade. Letra A incorreta. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tratamento farmacológico da obesidade infantil é controverso e não é recomendado para menores de 16 anos de idade. Letra B incorreta. A prática esportiva é fundamental para tratamento e prevenção da obesidade, sendo recomendado que crianças e adolescentes realizem entre 30 e 60 minutos de atividade física vigorosa diariamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Entende-se portanto que o foco não deve ser apenas na musculação e sim em atividades aeróbicas, que até podem ser feitas em academias de ginástica. O acompanhamento psicoterápico pode servir de apoio no tratamento, em conjunto com a mudança do estilo de vida (hábitos alimentares e atividade física). Letra C incorreta. A realização de exames complementares ao diagnóstico de obesidade é fundamental para investigação da síndrome metabólica e presença de comorbidades. O diagnóstico de síndrome metabólica é estabelecido da seguinte forma 1) aumento da circunferência abdominal (maior ou igual ao percentil 90) e mais 2 dos seguintes critérios a) triglicerídeos maior ou igual a 150 mg dL b) HDL menor que 40 mg dL c) pressão arterial maior ou igual a 130x85 mmHg d) glicemia de jejum 100 mg dL. Dosagem da função renal e de enzimas hepáticas são recomendadas para o diagnóstico de comorbidades como nefropatia diabética e esteatose hepática, respectivamente. Por outro lado, não há indicação de tratamento com ansiolítico a não ser que seja feito diagnóstico de transtorno de ansiedade com necessidade de uso de medicação. Letra D incorreta. A investigação diagnóstica de possíveis tumores cerebrais ou doenças genéticas está indicada na associação da obesidade com baixa estatura ou diminuição na velocidade de crescimento, o que não é o caso apresentado pela questão. São causas de obesidade com déficit estatural deficiência ou resistência ao GH, hipotireoidismo, excesso de glicocorticoides e pseudo-hipoparatireoidismo. Letra E correta. Se considerarmos que a classificação nutricional é de obesidade, essa seria a resposta mais próxima de estar correta. O tratamento da obesidade deve ter uma abordagem ampla e, para todas as idades, recomenda-se mudanças de estilo de vida, que compreendem a educação nutricional do paciente e da sua família e as orientações quanto à prática da alimentação saudável e atividade física. A orientação alimentar deve ser individualizada e de acordo com a condição socioeconômica da criança. Programas de modificação do estilo de vida são eficazes no controle do peso do paciente pediátrico, tanto no curto quanto no longo prazo, quando acompanhados em equipe multidisciplinar e com o apoio da família. Lembre-se também que o tempo de tela deve ser reduzido, para um total máximo diário de 2 horas para crianças maiores de 2 anos. Resposta questão anulada.

349698.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão objetiva sobre o indicador de baixa estatura. Vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. As pregas cutâneas são utilizadas como medidas adicionais na avaliação nutricional, em geral em ambulatórios especializados. No entanto, não são indicadores de baixa estatura, e sim formas de avaliar a gordura corporal. Letra B incorreta. O perímetro cefálico é um dos índices antropométricos medidos rotineiramente na consulta pediátrica, principalmente nos três primeiros anos de vida, e reflete o crescimento cerebral. Circunferência cefálica abaixo do percentil 10 é indicador de microcefalia, e não de baixa estatura. Letra C correta. A baixa estatura é definida como estatura para idade abaixo de -2 desvios-padrão ou abaixo do percentil 3 para idade e sexo. Aqui, no entanto, a banca cometeu um erro conceitual o termo estatura é usado para caracterizar tanto o comprimento (medido na posição horizontal) quanto a altura (medida na posição de pé) de um indivíduo. Habitualmente, fazemos a aferição do comprimento até os dois anos (alguns orientam que seja até os três anos) e da altura a partir de então. O paciente da questão, portanto, teria sua altura aferida, e não o comprimento. Ainda assim, esta é a melhor alternativa. Letra D incorreta. O perímetro torácico é medido com uma fita métrica passando so bre os mamilos com o tórax entre a inspiração e expiração e é uma das medidas antropomé tricas adicionais que podem auxiliar a compreender o que está ocorrendo com uma criança ou adolescente com alteração do crescimento, mas não indica baixa estatura. Letra E incorreta. O baixo peso pode ser um indicador inicial de um distúrbio que comprometerá a estatura, mas isoladamente não é indicativo desta. O peso abaixo do percentil 3 define baixo peso para idade. Resposta letra C.

365581.

Comentário: Questão direta sobre o calendário vacinal. Vamos às alternativas. Letra A correta. Para adolescentes, a vacina contra a meningite indicada é a ACWY, que cobre estes sorotipos, sendo recomendada uma dose dos 11 aos 14 anos. Para as crianças, a vacina feita é a que protege apenas contra o meningococo C, aplicada aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Letra B incorreta. A vacina da febre amarela é composta por vírus vivos atenuados e é recomendada para todo território nacional, independente do perfil epidemiológico da região. A primeira dose deve ser aplicada aos nove meses e o reforço aos 4 anos (e não reforço a cada 10

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anos isso já foi uma recomendação, mas não há mais esta indicação há vários anos). Letra C incorreta. Além da dose da vacina contra hepatite B ao nascer, o esquema vacinal recomendado para hepatite B inclui a aplicação da vacina penta (com a DTP e a H. influenzae tipo B) aos dois, quatro e seis meses de idade. Aos 15 meses, é feito ainda um reforço da DTP. Ou seja, após a primeira dose ao nascer, a vacina contra hepatite B não é aplicada de forma isolada. Letra D incorreta. A vacina tríplice viral (SCR) está indicada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) aos 12 meses de idade e também aos 15 meses, associada à vacina contra varicela (tetraviral). Resposta letra A.

365603.

Comentário: Estamos diante de um caso de acidente com animal potencialmente transmissor de raiva (condição, inclusive, passível de notificação imediata). Sendo assim, devemos seguir a nossa receita de bolo clássica para a profilaxia de raiva 1º Identificar o animal causador, lembrando que, acidentes por mamíferos silvestres e morcegos, são sempre considerados graves e 2º Classificar o tipo de acidente CONTATO INDIRETO Tocar ou dar de comer para animais. Lambedura em pele íntegra. Contato em pele íntegra com secreções ou excreções de animal, ainda que raivoso ou de caso humano. ACIDENTE LEVE mordedura ou arranhadura superficial no tronco ou nos membros, exceto mãos e pés. lambedura de lesões superficiais. ACIDENTE GRAVE mordedura ou arranhadura nas mucosas, no segmento cefálico, nas mãos ou nos pés. mordedura ou arranhadura múltiplas ou extensas, em qualquer região do corpo. mordedura ou arranhadura profunda, mesmo que puntiforme. lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo que intactas. mordedura ou arranhadura causado por mamífero silvestre. Voltando ao caso, temos um acidente grave provocado por cão não passível de observação por 10 dias. Logo, a conduta é lavar com água e sabão e iniciar a profilaxia completa com vacina - 4 doses (0, 3, 7 e 14) - e soro antirrábico. Lebre-se que, casos que necessitem da realização de sutura (lesões muito extensas e ou em que o resultado final ficará muito inestético), pode-se aproximar as bordas o mínimo suficiente para permitir uma cicatrização por 2ª intenção (sutura não hermética). O que nunca pode-se fazer é uma sutura hermética. Letra A incorreta. A sutura deve ser feita de forma não hermética e a profilaxia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

deve incluir o soro. Letra B incorreta. A profilaxia deve incluir o soro. Letra C incorreta. A sutura deve ser feita de forma não hermética. Letra D correta. Resposta letra D. Por fim, relembre que casos de mordedura, também nos autorizam a avaliar a profilaxia de tétano, pois trata-se de um ferimento com alto risco de tétano . Nestes casos avaliaríamos a história de vacinação prévia contra tétano.

349708.

Comentário: A questão traz um gráfico interessante a linha vermelha mostra a redução progressiva no número de casos esperados de poliomielite ao longo dos anos, após a introdução da vacina inativada contra a doença, considerando o efeito da vacina como limitado às pessoas vacinadas. A linha azul, por sua vez, mostra o efeito observado uma queda muito mais expressiva do que o esperado. Vamos analisar as alternativas quanto a este efeito. Letra A incorreta. Relembre alguns conceitos a imunidade inata é aquela que já nasce com o próprio organismo e está presente antes de qualquer exposição aos agentes estranhos, representada pelas barreiras físicas e químicas, fagócitos, sistema complemento, células Natural Killer (NK) e proteínas de fase aguda. Já a imunidade adaptativa (também chamada de imunidade específica ou adquirida) é aquela que se desenvolve depois do contato com o antígeno, na qual os principais atores são os linfócitos B e T. A imunidade adaptativa engloba uma resposta primária, mais demorada, até o reconhecimento do antígeno por linfócito B específico e início da produção de anticorpos. A primeira classe de imunoglobulina a ser produzida é a IgM e, posteriormente, a IgG. Após o segundo encontro com o mesmo antígeno, a resposta ocorre de maneira mais rápida e mais intensa, pois na resposta primária ocorreu a estimulação dos linfócitos T de memória esta é a imunidade ou resposta secundária. Este conceito, portanto, se refere à resposta imune individual e não explica o efeito observado no gráfico. Letra B incorreta. Na verdade, este não é um conceito definido na literatura... Poderíamos imaginar que a banca se refere à uma segunda dose ou revacinação, mas isso também não explicaria a diferença observada no gráfico. Letra C correta. A imunidade de rebanho ocorre quando uma porção significativa da população se torna imune a uma doença infecciosa, e consequentemente o risco de disseminação de pessoa para pessoa diminui. As pessoas que não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estão imunes ou neste caso, que não foram vacinadas são indiretamente protegidas, porque a transmissão ativa da doença na população se torna muito pequena. É exatamente o que vemos no gráfico o impacto da vacinação na população vai além da proteção (e da redução do número de casos) dos indivíduos vacinados. Letra D incorreta. A prevenção primária é definida como intervir antes que efeitos à saúde ocorram, através de medidas como vacinação e mudanças em comportamentos de risco (hábitos alimentares, tabagismo, etc). Apesar de relacionado à vacinação, esse conceito não explica a diferença observada no gráfico. Letra E incorreta. A prevenção secundária é a identificação de doenças em estágios precoces, antes do início de sinais e sintomas, como com a realização de mamografia de rotina e aferição regular de pressão arterial. Resposta letra C.

349704.

Comentário: Essa questão gerou muita discussão na época do concurso, mas não há como questionar o gabarito. Precisamos entender sobre qual agente o enunciado está falando, para então chegarmos na resposta correta e, para isso, seria preciso relembrar um pouco da cronologia das vacinas. Perceba que o enunciado se refere a um agente que era causa importante de meningite, mas que teve sua incidência reduzida nos últimos 20 anos (e esse dado faz toda a diferença para chegarmos na resposta correta) a vacina contra Haemophilus influenza B , aplicada na forma da penta, foi introduzida no calendário vacinal em 1999 e após isso, houve redução significativa dos casos de meningite (e de infecções de vias aéreas) por esse agente. Muitos questionaram a respeito da vacina BCG, já que é aplicada com objetivo de reduzir tuberculose meníngea - esta vacina faz parte do calendário vacinal há mais de 40 anos Ela é sim capaz de prevenir casos de meningite, mas não houve redução neste número nos últimos 20 anos. A vacina meningocócica C foi incorporada no calendário vacinal em 2010, portanto a redução significativa de casos ocorreu na última década, não nos últimos 20 anos. A vacina meningocócica B não faz parte do calendário do PNI. Resposta letra A.

322167.

Comentário: A vacina tríplice viral é composta por vírus vivos atenuados do sarampo, caxumba e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

rubéola. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), devem ser administradas duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses (na tetra viral). Desde 2019, o Ministério da Saúde passou a recomendar a dose zero em crianças entre seis e 12 meses atualmente, esta recomendação está mantida nas regiões que mantém circulação do vírus do sarampo. Esta dose tem como objetivo proteger as crianças nessa faixa etária de risco para complicações do sarampo, mas não deve ser considerada válida para a vacinação de rotina e não substitui nenhuma das doses subsequentes, pois a eficácia nessa idade é incerta (alternativa A correta e C incorreta). Sendo uma vacina composta por vírus vivos atenuados, a tríplice viral é contraindicada na gestação, pelo risco teórico de danos ao feto não há exceção em situação de surto (alternativa B incorreta). Recomenda-se também evitar a gravidez por 30 dias após vacinação contra rubéola (alternativa D incorreta). A vacina tríplice viral é contraindicada em pessoas com história de alergia grave (anafilaxia) em dose anterior do imunizante as dúvidas quanto à administração em crianças com alergia ao ovo e à proteína do leite de vaca são frequentes. No caso da alergia a ovo, mesmo grave, não há contraindicação à vacinação. No PNI, são administradas vacinas tríplices virais de três produtores Fiocruz Biomanguinhos, GSK e Serum Institute of India apenas a última está contraindicada em crianças com alergia grave à proteína do leite de vaca, pois contém traços de lactoalbumina. As vacinas dos outros dois produtores podem ser administradas (alternativa E incorreta). Resposta letra A.

337541.

Comentário: Questão objetiva. A baixa estatura é definida como uma estatura por idade abaixo do percentil 3 para idade e sexo ou abaixo do escore-Z -2 (dois desvios-padrão abaixo da média da população). Essa criança, com estatura no escore-Z -1, portanto, não apresenta baixa estatura (afirmativa errada). No entanto, lembre-se que outras avaliações são importantes ao analisarmos o crescimento de uma criança. Podemos detectar um crescimento deficitário, por exemplo, quando, mesmo sem baixa estatura, o paciente está abaixo do seu alvo genético familiar ou apresenta alteração na velocidade de crescimento. Resposta letra B.

337542.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A avaliação da idade óssea é uma ferramenta bastante útil na abordagem das crianças com baixa estatura, pois nos permite avaliar o índice de maturação endócrina global de um indivíduo. Existem alguns métodos disponíveis para essa avaliação, sendo o método de Greulich-Pyle um dos mais utilizados, através de radiografia de mão e punho esquerdos. O desenvolvimento ósseo acontece em uma determinada sequência de maturação, ou seja, ocorre um aumento progressivo dos núcleos de ossificação desde o nascimento até o término do crescimento no final da puberdade. A idade óssea é determinada pela maturação óssea epifisária, indicada pela presença e tamanho dos núcleos de ossificação. Assim, o desenvolvimento do corpo relaciona-se mais com a idade óssea do que com a idade cronológica. O crescimento linear no sexo feminino costuma ocorrer até que seja alcançada uma idade óssea de 15-16 anos. Já no sexo masculino, isso ocorre até uma idade óssea de 17-18 anos. A estatura final é atingida quando ocorre a fusão completa da cartilagem de crescimento, independentemente da idade cronológica na qual isso tenha ocorrido. Assim, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

337543.

Comentário: A avaliação da idade óssea é uma ferramenta bastante útil na abordagem das crianças com baixa estatura, pois nos permite avaliar o índice de maturação endócrina global de um indivíduo. O desenvolvimento ósseo se processa por uma determinada sequência de maturação, ou seja, ocorre um aumento progressivo dos núcleos de ossificação desde o nascimento até o término do crescimento no final da puberdade. A idade óssea é determinada pela maturação óssea epifisária, indicada pela presença e tamanho dos núcleos de ossificação. O desenvolvimento do corpo relaciona-se mais com a idade óssea do que com a idade cronológica. A estatura final é atingida quando ocorre a fusão completa da cartilagem de crescimento, independentemente da idade cronológica na qual isso tenha ocorrido. Assim, a afirmativa está correta as crianças com idade óssea atrasada e velocidade de crescimento normal crescerão por mais tempo. Mas é preciso fazer uma ressalva isto não significa uma estatura final maior. É o que ocorre, por exemplo, no atraso constitucional do crescimento. Estas crianças apresentam-se em percentis de estatura abaixo da população geral e também abaixo de seu alvo genético, que é normal a velocidade de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crescimento costuma ser normal ou nos limites inferiores da normalidade. O que acontece é uma lentificação do processo de crescimento, com duração mais prolongada do mesmo. Caracteristicamente, a idade óssea é atrasada em relação à idade cronológica e isso possibilita uma previsão de estatura final compatível com o padrão familiar. Resposta letra A.

337544.

Comentário: O tratamento com hormônio de crescimento (GH) está indicado em apenas alguns casos de baixa estatura, como na deficiência deste hormônio, na síndrome de Turner e em crianças pequenas para idade gestacional que não recuperam o padrão de estatura familiar. Além disso, os efeitos colaterais graves são raros, devendo-se atentar para o desenvolvimento de cefaleia, intolerância à glicose e hipertensão intracraniana benigna. Apesar de haver preocupação de um possível papel do GHrh no aumento do risco de câncer, essa associação não é comprovada, principalmente em pacientes sem história de doença neoplásica ou de fatores de risco. Pacientes com doença neoplásica prévia devem ser conjuntamente acompanhados por oncologista ou neurocirurgião. Em uma grande série de casos, não houve aumento da recorrência de neoplasia ou da incidência de novos casos em pacientes em uso de somatropina. A afirmativa, está, portanto, incorreta o gabarito inicial da banca foi a letra A, mas após recurso foi corretamente modificado para alternativa B. Resposta letra B.

337597.

Comentário: A afirmativa não tem relação com o caso clínico, mas vamos analisá-la. Diversos fatores, como genéticos e ambientais, podem afetar o crescimento e torná-lo inadequado. Em geral, quando há um fator prejudicando o crescimento como estados de doença ou desnutrição energético-proteica , o comprometimento ponderal é o primeiro a acontecer, para depois haver impacto em estatura. Assim, o peso é o parâmetro antropométrico mais sensível e o primeiro a ser afetado. Resposta letra B.

337599.

Comentário: A afirmativa está errada. A vacina VIP, indicada no cartão de Miguel, nada mais é do que a vacina inativada contra a poliomielite. Temos duas vacinas contra poliomielite em nosso

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

calendário a VOP (vacina oral contra a poliomielite) e a VIP. As três primeiras doses do esquema (aos 2, 4 e 6 meses) são feitas apenas com a VIP. Os reforços (aos 15 meses e 4 anos) e as doses em campanhas são feitos com a VOP. Lembre-se de que o esquema sempre deve ser iniciado com VIP, pois quando a VOP é feita no início do esquema há maior risco ainda que raro de poliomielite vacinal. Resposta letra B.

337607.

Comentário: Em meados de 2022, o Ministério da Saúde mudou algumas recomendações acerca da profilaxia pós-exposição da raiva. Em anexo, colocamos uma tabela que reúne a conduta a ser tomada nos mais diferentes tipos de situações. Levando em consideração o caso descrito, note que se trata de um ferimento leve a arranhadura foi superficial e no tronco. Além disso, o animal é passível de observação e não tem sinais sugestivos de raiva. Portanto, a conduta a ser tomada deve ser a seguinte lavagem da ferida com água e sabão não iniciar a profilaxia no momento observar o animal por dez dias permanecendo vivo e saudável, suspender a observação e encerrar o caso se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar a vacina nos dias 0, 3, 7 e 14. Resposta letra A.

337608.

Comentário: Perceba que estamos lidando com uma exposição do tipo leve para raiva, já que a arranhadura foi superficial e no tronco. Além disso, o animal é passível de observação e não tem sinais sugestivos de raiva. Portanto, a conduta a ser tomada deve ser a seguinte lavagem da ferida com água e sabão não iniciar a profilaxia no momento observar o animal por dez dias permanecendo vivo e saudável, suspender a observação e encerrar o caso se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva , indicar a vacina nos dias 0, 3, 7 e 14. Resposta letra B.

337609.

Comentário: Perceba que estamos lidando com uma exposição do tipo leve para raiva, já que a arranhadura foi superficial e no tronco. Além disso, o animal é passível de observação e não tem sinais sugestivos de raiva. Por isso, a profilaxia com vacina antirrábica não é indicada em um primeiro momento (o animal deve ser observado por dez dias). Porém, se o animal não fosse

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

passível de observação por dez dias ou apresentasse sinais sugestivos de raiva, a vacinação (nos dias 0, 3, 7 e 14) já deveria ser iniciada nesse atendimento. Resposta letra A.

337610.

Comentário: Por se tratar de um acidente leve e o animal ser passível de observação e não apresentar sinais sugestivos de raiva, a vacina não está indicada nesse momento (vide tabela). Porém, a Banca nos faz uma pergunta acerca do imunizante. Sem problemas Quando indicada, a vacina antirrábica pode ser aplicada pelas vias intradérmica ou intramuscular. Quando optado por esta, o local de aplicação deve ser o músculo deltoide ou o vasto lateral da coxa (em menores de dois anos). A aplicação glútea NÃO É recomendada, pois resulta em menores títulos de anticorpos. Resposta letra B.

337611.

Comentário: O que é afirmado pela Banca está correto Aliás, essa foi a grande mudança da profilaxia da raiva proposta pelo Ministério da Saúde na atualização de 2022. Caso o animal seja passível de observação por dez dias e não apresente sinais sugestivos de raiva, o paciente não deve receber vacina ou imunoglobulina no primeiro momento, mesmo que o acidente seja grave. A profilaxia com o uso de imunizantes só deve ser indicada caso o animal morra, desapareça ou passe a apresentar sinais da doença durante o período de observação. Cabe ressaltar que a nota técnica do Ministério não menciona o fato de a raiva estar controlada naquela área ou não, ou seja, a princípio, a conduta é a mesma independentemente da região em que o paciente sofreu o ferimento. Resposta letra A.

337612.

Comentário: Caso seja necessário infundir a imunoglobulina antirrábica, o ideal é que isso seja feito o mais rápido possível (tempo limite até o sétimo dia após a aplicação da primeira dose de vacina). Existindo clara identificação do local ferido, deve-se infiltrar o volume, total ou máximo possível, dentro ou ao redor desta região. Caso não seja possível, o restante da dose deve ser aplicado pela via intramuscular . Cabe ressaltar que a dose preconizada imunoglobulina antirrábica é de 20 UI Kg. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305314.

Comentário: A questão foi anulada após recurso, ainda que nos pareça estar correta. A vacina oral contra o rotavírus humano faz parte do Programa Nacional de Imunizações e é indicada para as crianças aos 2 e 4 meses. A primeira dose pode ser feita entre 1 mês e 15 dias e 3 meses e 15 dias a segunda dose pode ser feita entre 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. É importante que sempre seja respeitado um intervalo de quatro semanas entre as doses. Assim, as opções B, C e D estão corretas. A vacina é administrada pela via oral e quando a criança cospe, vomita ou regurgita a vacina, não há indicação para que a dose seja repetida, devendo ser considerada válida. Logo, a opção A está correta e a E incorreta. A opção E havia sido o gabarito oficial, mas a questão foi anulada.

305315.

Comentário: As vacinas de agentes vivos atenuados encontradas no Programa Nacional de Imunizações são BCG vacina oral contra a poliomielite vacina oral de rotavírus humano vacina de febre amarela vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) vacina tetra viral (vacina tríplice viral e vacina de varicela) e vacina contra varicela. Assim, dentre as citadas, apenas a vacina contra hepatite A é constituída por vírus inativados. Resposta letra C.

298898.

Comentário: A afirmativa está errada. Ainda que a avaliação dos hábitos alimentares deva ser parte integrante de qualquer atendimento de puericultura, não há razão para acreditarmos que o peso desta criança esteja insuficiente com base nos dados fornecidos consideramos que uma criança tem peso adequado para a idade quando seu peso é maior ou igual ao escore-Z -2 e menor ou igual ao escore-Z 2. É bem verdade que sempre deve ser feita a avaliação do IMC, pois mesmo uma criança com peso adequado poderá ter magreza, basta que seja uma criança mais alta . Ainda assim, a análise isolada do peso não é motivo de preocupação neste caso. Resposta letra B

274374.

Comentário: Vamos analisar as alternativas Letra A Incorreta. O laboratório de pacientes com desnutrição aguda costuma apresentar valores reduzidos de albumina e transferrina. Esta última,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inclusive, pode estar aumentada em quadros de desnutrição crônica devido à carência de ferro, mas, no contexto de situações de estresse metabólico (ex trauma, infecções), esperamos que ela esteja baixa pela menor produção hepática. Letra B Incorreta. Pelo contrário, na desnutrição crônica é esperado que o paciente perca massa muscular. Letra C Incorreta. A desnutrição afeta a resposta imune frente a infecções e, entre as diferentes formas de desnutrição, a carência de proteínas na dieta é uma das formas mais prejudiciais. Sendo assim, alguns trabalhos têm mostrado que a deficiência crônica de proteínas pode cursar com redução no tamanho do timo - o que provavelmente se relaciona com maiores dificuldades na resposta imune. Letra D Correta A hipoproteinemia leva à uma redução da pressão coloidosmótica e edema intersticial, com saída do líquido para o meio extracelular. Consequentemente, há uma redução da volemia e o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado. Letra E Incorreta. A desnutrição pode causar atrofia da musculatura cardíaca. Do ponto de vista hemodinâmico, ocorre diminuição do débito cardíaco, da pressão do enchimento diastólico, aumento da pressão atrial e aumento da pressão venosa central. A tolerância à sobrecarga de volume é muito reduzida devido ao déficit na função contrátil miocárdica. Resposta letra D.

274379.

Comentário: Sobre a síndrome metabólica, vamos avaliar as alternativas A letra A está incorreta a presença de obesidade em crianças e adolescentes está associada com alterações cardiovasculares que, por sua vez, estão associadas com maior risco de doença cardiovascular na fase adulta de vida. A letra B está incorreta o sobrepeso também é considerado fator de risco para desenvolvimento de síndrome metabólica. A letra C está incorreta essas mudanças comportamentais e dietéticas no tratamento da obesidade. A letra D está correta os principais fatores de risco são sobrepeso e a obesidade (principalmente se há o acúmulo de gordura predominantemente abdominal ou ectópica), dislipidemias, hipertensão arterial sistêmica, história pessoal de intolerância à glicose ou diabetes gestacional, história familiar de DM2, de doença cardiovascular ou hipertensão arterial, presença de acantose nigrans, adrenarca precoce e síndrome de ovários policísticos. A letra E está incorreta entre 10 e 16 anos, o diagnóstico de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

síndrome metabólica deve ser estabelecido da seguinte forma 1) aumento da circunferência abdominal (maior ou igual ao percentil 90) e mais 2 dos seguintes critérios a) triglicerídeos maior ou igual a 150 mg dl b) HDL menor que 40 mg dl c) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130x85 mmHg d) Glicemia de jejum 100 mg dl (recomendado o teste de tolerância oral a glicose) ou presença de DM tipo 2. Resposta letra D.

284350.

Comentário: Afirmativa incorreta. A vacina contra o HPV protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, mas esta proteção ocorre apenas nos indivíduos que ainda não foram infectados - por isso, o ideal é que seja realizada antes do início da atividade sexual, para que a proteção ocorra contra os 4 subtipos. Mesmo assim, se a paciente já tiver apresentado infecção ou mesmo já tiver lesão cervical, a vacina ainda está recomendada, para proteção para os outros subtipos. A vacina é composta por partículas virais e não tem capacidade de promover regressão da lesão Apenas para relembrar está recomendada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, em duas doses com intervalo de 6 meses entre elas. Para pacientes portadores do vírus HIV, transplantados (órgãos sólidos ou medula) e pacientes oncológicos, está recomendada dos 9 aos 26 anos, em três doses (0 - 2 - 6 meses). Resposta letra B.

261301.

Comentário: Primeira pergunta Qual o diagnóstico mais provável da criança em questão Sarampo E qual é a vacina que previne o sarampo e quando esta deve ser aplicada de acordo com o Calendário Vacinal do MS Tríplice viral, que é feita aos 12 meses e tetra viral, que é realizada aos 15 meses. Logo, alternativa errada. Resposta letra B.

250102.

Comentário: Crianças entre 6 meses e 2 anos de idade podem precisar receber suplementos de ferro e de vitamina A, que são nutrientes especialmente importantes para a criança. A deficiência de ferro causa anemia, que prejudica o desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem. A deficiência de vitamina A aumenta o risco de infecções e provoca importantes problemas visuais, podendo até mesmo levar à cegueira. Por terem maior risco de desenvolver deficiências de ferro e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vitamina A, as crianças entre 6 meses e 2 anos de idade podem precisar receber suplementos desses nutrientes. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças de 6 a 24 meses devem receber 1 mg de ferro elementar kg por dia. Em relação à vitamina A, alguns municípios são contemplados pelo programa de suplementação de vitamina A, que é realizada a partir dos seis meses de idade. Sendo assim, a afirmativa apresentada está correta. Resposta letra A.

239303.

Comentário: Acompanhe pela tabela. Pacientes entre 5 e 19 anos (o caso do enunciado) que possuem um IMC entre o escore Z 1 e 2, são classificados como sobrepeso . Já aqueles entre o escore Z 2 e 3, são considerados obesos. Finalmente, acima do escore Z 3, classificamos o paciente como obesidade grave . Resposta A.

239304.

Comentário: A afirmativa está certa. Em seu manual sobre o tratamento de obesidade, a Sociedade Brasileira de Pediatria propõe algumas metas terapêuticas com o objetivo de sistematizar o atendimento às crianças. As metas de tratamento do sobrepeso e obesidade são direcionadas de acordo com a presença ou não de comorbidades e com a idade da criança. Nas crianças com obesidade (neste manual é citado que o ponto de corte seria o IMC maior que o p95) sem comorbidades, objetiva-se manutenção do peso para os menores de 7 anos e redução do peso para os acima desta idade. Já na presença de comorbidades, o objetivo é a redução gradual do peso. Resposta letra A.

239305.

Comentário: Crianças obesas possuem risco cardiovascular elevado, o que inclui hipertensão arterial, mas também ateroesclerose, aumento do débito cardíaco e hipervolemia. Especificamente em relação à hipertensão, esse risco é proporcional à gravidade da obesidade, chegando a 4% em indivíduos com obesidade moderada e 9% naqueles como obesidade grave. Não só isso, mas a presença de hipertensão na infância eleva consideravelmente o risco de hipertensão e síndrome metabólica na fase adulta, problema que pode ser resolvido se o paciente perder peso (isso é, ele não está fadado a uma vida de complicações cardiovasculares). Além disso, esses pacientes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

também apresentarão risco para complicações respiratórias (redução da complacência pulmonar e tendência à hipóxia hipercapnia), do metabolismo lipídico (como aumento de triglicerídios e LDL), hepáticas (esteatose), bem como complicações gastrointestinais ou neurológicas. Resposta A.

239306.

Comentário: A obesidade tem sido associada ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, estando relacionada a 10% de todas as mortes oncológicas em não fumantes e presente em aproximadamente 14% de todas as mortes por câncer em homens e 20% em mulheres. Dados combinados de 57 estudos de coorte sugerem que a cada 5 kg m2 de aumento no IMC aumenta o risco de mortalidade por neoplasias em até 10%. O percentual de ocorrência de câncer relacionado ao sobrepeso e obesidade depende do órgão acometido pelo tumor, destacando-se as as neoplasias de cólon e reto, mama, endométrio, esôfago (adenocarcinoma), vesícula biliar, pâncreas, rins, próstata, colo uterino e ovários e, em menor proporção, Linfoma não Hodking, mieloma múltiplo, estômago e fígado. Resposta CERTA.

239307.

Comentário: Assertiva ERRADA A obesidade, mesmo em crianças, está associada a aterosclerose subclínica. Resposta B.

239340.

Comentário: Todas as gestantes devem receber uma dose de dTpa a partir de 20 semanas de gestação, mesmo que já tenham feito uso de três doses anteriormente (independentemente de quanto tempo tem a última dose). A afirmativa está correta. Resposta letra A.

239351.

Comentário: Vamos relembrar quais são as recomendações atuais do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra o HPV Devem se vacinar contra HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Também fazem parte do grupo de pessoas que devem receber a vacina, aquelas que vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV Aids), transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos de nove a 26 anos de idade. Voltando ao enunciado perceba que a menina encontra-se na faixa etária de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vacinação e portanto deve ser vacinada. Além disso, lembre-se que a vacinação é um tipo de abordagem pautada nos preceitos da prevenção primária, pois atua combatendo os efeitos dos fatores de risco, minimizando a incidência da doença. Resposta letra A.

211939.

Comentário: Estamos realizando o atendimento a um adolescente de 11 anos com queixa de baixa estatura. O primeiro passo desta avaliação é verificarmos se, de fato, existe baixa estatura. A descrição de uma estatura entre os percentis 25 e 50 nos indica que a estatura do paciente é adequada para a sua idade, pois a baixa estatura é caracterizada por uma estatura para idade abaixo do percentil 3. Porém, para afirmarmos que o crescimento está adequado, não basta isso é fundamental que seja feita a avaliação da velocidade de crescimento. Lembre-se de que, antes de ter baixa estatura, a criança com alguma condição patológica irá apresentar uma desaceleração de sua velocidade de crescimento. A análise da adequação da velocidade de crescimento deve ser obrigatoriamente feita levando-se em conta o estadiamento puberal do paciente. Em um escolar ou adolescente impúbere, como o do caso, o limite inferior da normalidade da velocidade de crescimento costuma ser de 5 cm. Como há descrição de uma velocidade de 7 cm ano, não há razão para preocupação. Devemos tão somente tranquilizar a família e seguir o acompanhamento deste paciente. Neste momento, ele é mais baixo do que seus colegas, provavelmente, porque os mesmos já entraram em puberdade e já iniciaram o estirão puberal. Resposta letra D.

214466.

Comentário: Para crianças acima de 5 anos, o diagnóstico de obesidade é realizado quando o escore Z for superior a 2 e menor ou igual a 3. Quando superior a 3, ela é considerada como portadora de obesidade grave. Devido a este pequeno detalhe, o item está incorreto. Resposta errado.

214471.

Comentário: Estamos diante de um escolar de oito anos de idade com obesidade grave (IMC z-score de 3,34). A criança com obesidade apresenta maior risco para algumas comorbidades alterações do metabolismo glicídico e alteração no metabolismo lipídico, por exemplo. Para essas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crianças, sempre é recomendado um rastreamento dessas alterações, com avaliação do colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e também glicemia de jejum. Em geral, também é recomendado a avaliação de transaminases para rastreamento de esteatose hepática. Tudo que está descrito na afirmativa está verdadeiro. Resposta letra A.

214483.

Comentário: A vacina oral contra poliomielite é feita de vírus vivo atenuado e é recomendado, pelo Ministério da Saúde, que os reforços da vacina contra poliomielite sejam feitos com a vacina oral aos 15 meses e aos quatro anos. Devemos evitar a vacinação de crianças em algumas situações pelo risco de poliomielite pelo vírus vacinal em todas as crianças imunocomprometidas e nos seus contatos domiciliares o vírus vacinal pode ser eliminado pelas fezes do indivíduo que foi vacinado. Através dessa eliminação, o contactante domiciliar imunodeprimido pode entrar em contato com o vírus vacinal e desenvolver a poliomielite através dele. Logo, nesse caso, por mais que a criança não tenha características de imunossupressão, ela convive com a mãe que é imunodeprimida. Essa criança irá receber as doses e reforços com a vacina inativada. Resposta letra A.

179198.

Comentário: Realmente, só faltou ser dito que a síndrome começava com a letra T e terminava com urner... temos todos os elementos para o diagnóstico da síndrome de Turner, relacionada, mais comumente, com a monossomia do cromossomo X. As principais manifestações clínicas são a baixa estatura e a disgenesia gonadal, que será causa de atraso puberal (hipogonadismo hipergonadotrófico). O diagnóstico desta condição ainda na infância é importante para o rastreamento de possíveis comorbidades associadas e também para a instituição de tratamento. O uso de GH nestas pacientes melhora o prognóstico de estatura na vida adulta e deve ser prontamente instituído, tão logo o diagnóstico seja confirmado. Resposta letra C.

179207.

Comentário: Foram feitas cinco afirmativas em relação a várias vacinas do Programa Nacional de Imunizações. A opção A está correta ainda que seja uma vacina de agente vivo, a vacina BCG deve ser feita o mais precocemente possível nas crianças com exposição vertical ao HIV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Lembre-se de que, ainda que tenha sido infectada, esta criança não estará imunodeprimida e não há riscos com a vacina. A opção B está absolutamente errada a vacina contra hepatite B pode ser feita mesmo nos prematuros com menos de 36 semanas, independentemente do peso de nascimento. Nos casos em que a mãe é portadora crônica do vírus, a vacina deve ser feita nas primeiras 12 horas de vida, havendo a recomendação de que também seja feita a imunoglobulina para hepatite B. A opção C está errada a vacina contra rotavírus é administrada por via oral em duas doses, aos dois e quatro meses. A opção D está errada a vacina pneumocócica conjugada é ofertada para todas as crianças, ainda no primeiro ano de vida, desde o ano de 2010. As crianças com doenças pulmonares crônicas recebem, após os dois anos, a vacina pneumocócica polissacarídica (pneumo 23). E, por fim, a opção E está errada a vacina contra hepatite A é feita em dose única aos 15 meses de idade, não podendo ser administrada no primeiro ano de vida.

Resposta letra A.

177670.

Comentário: Ao utilizarmos os gráficos de estatura por idade para a classificação nutricional de uma criança, temos o seguinte quando a estatura estiver abaixo do escore-Z -3, a criança tem muito baixa estatura por idade quando é maior ou igual ao escore-Z -3 e menor que o escore-Z -2 tem baixa estatura para idade e quando é maior ou igual ao escore-Z -2 tem estatura adequada para idade. Logo, caso Rafaela esteja entre o escore-Z 0 e -1, terá estatura adequada. Resposta letra B.

177674.

Comentário: De acordo com o Ministério da Saúde e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de até cinco anos, temos a seguinte classificação com base no Índice de Massa Corporal (IMC) IMC maior que escore-Z 1 (ou percentil 85) e menor ou igual ao escore-Z 2 (percentil 97) tem risco de sobrepeso maior que escore-Z 2 (percentil 97) e menor ou igual ao escore-Z 3 (percentil 99,9) tem sobrepeso (como foi o caso descrito) e maior que o escore-Z 3 tem obesidade. Resposta letra A.

177678.

Comentário: Questão bem direta. De fato, todas estas comorbidades estão associadas com a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

obesidade na infância e podem se desenvolver ainda nos primeiros anos de vida. Por esta razão, o rastreamento dessas condições é rotineiramente realizado nas crianças com obesidade (cabe apenas lembrar que não há critérios para a definição de síndrome metabólica nas crianças menores de dez anos). Resposta letra A.

177688.

Comentário: Esta questão teve seu gabarito modificado após recurso, pois, inicialmente, a banca havia considerado que a afirmativa estava errada. Ao acompanharmos a criança e o adolescente com sobrepeso e obesidade, é importante que tenhamos os seguintes conceitos a perda ponderal nem sempre será necessária, pois conforme ocorre o crescimento estatural, o peso pode tornar-se adequado para a estatura da criança. Além disso, qualquer mudança alimentar deve ser feita com bastante cautela, pois a carência de determinados micronutrientes em fases importantes do crescimento pode ser bastante deletéria. Em 2012, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento sobre o manejo da obesidade infantil e lá constam as seguintes orientações nas crianças com obesidade (IMC p95 cuidado, pois este é o percentil citado neste documento) quando não há comorbidade, objetiva-se a manutenção do peso para crianças menores de 7 anos e redução de peso para aquelas acima desta idade já quando há comorbidade, objetiva-se a redução de peso. Resposta letra A.

177650.

Comentário: Quando o recém-nascido é coabitante de um paciente com tuberculose pulmonar bacilífera, devemos adotar algumas medidas especiais... Em primeiro lugar, o neonato não deverá receber a BCG ao nascer. Em segundo, inicia-se a quimioprofilaxia primária (ou prevenção da infecção latente) com isoniazida por três meses (pra evitar que a criança torne-se infectada). Após esse período, realiza-se uma prova tuberculínica (PT) se for reatora (5 mm - sugerindo infecção), concluímos o tratamento da infecção latente para evitar que a criança, ora infectada, torne-se DOENTE (com mais 3 meses de isoniazida). Caso a PT seja negativa, vacinamos a criança e encerramos o caso. Assertiva certa. Resposta A.

177655.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Quando o recém-nascido é coabitante de um paciente com tuberculose pulmonar bacilífera, devemos adotar algumas medidas especiais. Em primeiro lugar, o recém-nascido não deve receber a vacina BCG ao nascer. Em segundo, inicia-se a quimioprofilaxia primária (ou prevenção da infecção latente) com isoniazida por três meses (para evitar que a criança se torne infectada). Após esse período, realiza-se uma Prova Tuberculínica (PT) se ela for reatora (5 mm sugerindo que infelizmente a criança tornou-se INFECTADA), concluímos o tratamento da infecção latente para evitar que a criança, ora infectada, torne-se doente. Caso a PT seja negativa, só então vacinamos a criança e encerramos o caso. Assertiva errada. Resposta B.

177660.

Comentário: Quando o recém-nascido é coabitante de um paciente com tuberculose pulmonar bacilífera, devemos adotar algumas medidas especiais... Em primeiro lugar, o neonato não deverá receber a BCG ao nascer. Em segundo, inicia-se a quimioprofilaxia primária (ou prevenção da infecção latente) com isoniazida por três meses (pra evitar que a criança torne-se infectada). Após esse período, realiza-se uma prova tuberculínica (PT) se for reatora (5 mm - sugerindo infecção), concluímos o tratamento da infecção latente para evitar que a criança, ora infectada, torne-se DOENTE (até a data da publicação desta questão, feito com mais 6 MESES DE ISONIAZIDA, isto é, até completar 9). Caso a PT seja negativa, vacinamos a criança e encerramos o caso. Assertiva errada. Resposta B.

177666.

Comentário: O tratamento da infecção latente pelo bacilo de Koch deve ser realizado em todo paciente HIV sem sinal de tuberculose doença que (1) seja contactante de bacilífero, (2) tenha prova tuberculínica atual reatora, (3) história de prova tuberculínica reatora, ainda que a atual seja não reatora e (4) tenha cicatriz de tuberculose não tratada na radiografia de tórax. Assertiva certa. Resposta A.

177593.

Comentário: Quando o recém-nascido é contactante de tuberculose bacilífera, devemos adotar algumas medidas especiais... Em primeiro lugar, o neonato não deverá receber a BCG ao nascer.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Ao mesmo tempo, inicia-se a quimioprofilaxia primária - ou prevenção da infecção latente - com isoniazida por três meses, para evitar que a criança torne-se infectada. Ao final desse período, realiza-se prova tuberculínica (PT) se for reatora (5 mm), concluímos o tratamento da infecção latente com mais três meses de isoniazida. Caso a PT seja negativa, vacinamos a criança e encerramos o caso. Assertiva errada. Resposta B.

154323.

Comentário: Um dos principais exames complementares realizado na investigação dos quadros de baixa estatura é a radiografia das mãos e punho esquerdos para determinação da idade óssea. A avaliação da idade óssea nos permite ter uma ideia acerca da maturação endócrina biológica do paciente. Nos casos de atraso constitucional do crescimento e da puberdade e nas endocrinopatias, tipicamente iremos observar uma idade óssea atrasada em relação à idade cronológica. Os outros exames indicados até poderão ser solicitados, mas principalmente quando houver suspeita de alguma causa mórbida subjacente. A avaliação de idade óssea será feita ainda que a velocidade de crescimento esteja normal, para diagnóstico diferencial das variantes da normalidade. Resposta letra D.

152074.

Comentário: Afirmativa claramente errada. As duas vacinas recomendadas ao nascer são a vacina BCG e a vacina contra hepatite B. A primeira dose da vacina antimeningocócica é feita apenas aos três meses de idade. Resposta letra B.

152127.

Comentário: A afirmativa havia sido considerada errada pela banca, mas a questão acabou sendo anulada após o recurso, pois a redação do texto dava margem a dúvidas. Sabemos que as doenças comuns da infância não costumam representar contraindicações verdadeiras para a administração de vacinas. Porém, lembre-se de que nos casos de doença diarreica com desidratação, a vacina contra o rotavírus, feita aos dois meses, deveria ser adiada. Talvez por não ter indicado precisamente que o quadro de diarreia não era acompanhado de desidratação, a banca tenha preferido anular a questão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152154.

Comentário: A questão trata de uma paciente jovem que apresentou resultado citopatológico de lesão intraepitelial de alto grau, na qual foi acertadamente indicada colposcopia com biópsia dirigida, cujo histopatológico evidenciou neoplasia intraepitelial cervical (NIC) grau III. O achado histopatológico de NIC III é compatível com alteração de alto grau e uma conduta excisional está indicada. Até o momento, existe evidência científica de pequeno benefício em vacinar mulheres previamente tratadas para lesões no colo do útero, vagina ou vulva, que poderiam apresentar menos recidivas. Desta forma, a vacinação nesses casos não é uma conduta que deva ser recomendada, mas sim individualizada, o que torna a assertiva ERRADA. Resposta letra B.

134984.

Comentário: A síndrome de Cushing é a resultante fenotípica da exposição crônica a concentrações elevadas de glicocorticoides, apresentando níveis sanguíneos elevados de cortisol e outros glicocorticoides. A iatrogenia é a causa mais comum da síndrome, resultado de terapêutica com glicocorticoides prolongada e especialmente em altas doses, usadas no tratamento das doenças proliferativas. A afirmativa está certa

134993.

Comentário: Ao avaliarmos a criança com hipotireoidismo, devemos nos lembrar de que, na infância, podemos ter o hipotireoidismo congênito ou o hipotireoidismo adquirido. A banca está, certamente, falando sobre o hipotireoidismo adquirido, que deve ser considerado no diagnóstico diferencial das crianças com baixa estatura. As manifestações clínicas são variadas, em função da intensidade da falta dos hormônios tireoidianos e do tempo de evolução da doença. Costuma ser encontrada, inicialmente, a presença de bócio. Com a diminuição da produção hormonal, há sonolência, hipoatividade, lentidão, palidez, pele seca, hipotermia, bradicardia, obstipação, mixedema e diminuição da velocidade de crescimento, levando à baixa estatura. Na avaliação da idade óssea, esta mostra-se bastante atrasada em relação à idade cronológica. Assim, a afirmativa está certa.

135001.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bem simples A afirmativa está, evidentemente, errada. A síndrome de Turner é causada pela monossomia do cromossomo X (cariótipo 45X). O fenótipo dos indivíduos acometidos é um fenótipo feminino. Por isto, este diagnóstico deve ser considerado quando avaliamos meninas com baixa estatura. Essas pacientes são candidatas à terapia com hormônio de crescimento e os resultados obtidos variam bastante, em função do momento em que o tratamento é iniciado e dada a presença de outras comorbidades. Porém, como regra geral, há uma melhora na previsão de estatura final. Afirmativa errada.

135006.

Comentário: O termo baixa estatura idiopática é usado para caracterizar uma situação na qual o paciente tem baixa estatura mas não tem um diagnóstico etiológico preciso para o distúrbio. É, na verdade, um diagnóstico de exclusão Os seguintes critérios podem ser usados para seu diagnóstico altura 2 DP para a idade cronológica peso e altura de nascimento 2 DP para a idade gestacional proporções corporais normais sem evidência de qualquer doença crônica ausência de doença endócrina sem evidência de problema psicossocial ingestão alimentar adequada e velocidade de crescimento normal. Além disso, essas crianças devem ter sido submetidas a uma avaliação que mostre não haver deficiência de GH. Assim, a afirmativa está errada.

135084.

Comentário: A afirmativa está CORRETA. Existem diversas causas de raquitismo na infância, que incluem a hipovitaminose D, a deficiência de cálcio e fósforo e em quadros de acidose tubular renal. A causa mais comum é, de fato, a deficiência da vitamina D, que se relaciona com a baixa ingestão do micronutriente e pouca exposição à luz solar, e também com síndromes disabsortivas e doenças relacionadas com o metabolismo desta vitamina. Apenas relembrando, a síndrome de Fanconi ocorre por uma disfunção no túbulo renal proximal, com perda renal de fosfato (levando à hipofosfatemia), aminoácidos, bicarbonato, glicose e outras moléculas que são reabsorvidas no túbulo proximal.

108193.

Comentário: Antes de mais nada, vamos nos familiarizar com os valores considerados ideias na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prática pediátrica. Ainda que possa haver algumas variações na literatura, aceita-se que os valores considerados desejáveis e aumentados são, respectivamente os seguintes colesterol total 150 mg dl e 170 mg dl LDL-c 100 mg dl e maior ou igual 130 mg dl HDL-c 45 mg dl e triglicerídeos 100 mg dl e maior ou igual 130 mg dl. Assim, fica fácil perceber que esta criança apresenta uma dislipidemia e necessita de alguma intervenção. O primeiro passo sempre será a modificação de hábitos, principalmente os alimentares. Porém, ao ser realizada a prescrição nutricional, o que encontramos em documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a distribuição do valor energético diário seja feita da seguinte forma gordura 30% do valor energético diário (saturada 7% poli-insaturada 10% monossaturada 10 a 15% trans 1%) carboidratos 50 a 60% proteína 10 a 20%. Assim, pelas pequenas diferenças que podemos encontrar na literatura, a própria banca reconheceu que há divergências e optou por anular a questão (no gabarito original a mesma tinha sido considerada correta).

108241.

Comentário: Esta criança provavelmente apresenta uma deficiência vitamínica, mas não de vitamina A. Identificamos neste enunciado sinais que apontam para o diagnóstico de raquitismo, relacionado à hipovitaminose D. O raquitismo é caracterizado pelo deficit de mineralização do osteoide de um osso em crescimento, especialmente no local da placa de crescimento (antes do fechamento epifisário). As manifestações clínicas principais incluem craniotabes, atraso no fechamento das fontanelas e formação de bossa frontal rosário raquítico, sulco de Harrison, depressão esternal, peito de pombo, cifoses e escolioses na coluna vertebral alargamento de punhos e joelhos, genu varum, genu valgo, coxa vara , hipotonia muscular, ventre ou abdome em batráquio, hérnias. Resposta letra B.

79673.

Comentário: O enunciado nos traz uma criança de 4 anos de idade que apresentava crescimento adequado até os seus 2 anos de vida. No último ano, apresentou uma velocidade de crescimento de 3 cm ano. Nesta faixa etária (pré-escolar 2 aos 6 anos) a velocidade de crescimento esperada é de cerca de 7-8 cm ano. Desta forma, observamos que a criança da questão está bem abaixo do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

esperado. Um deficit na velocidade de crescimento é indicativo de possíveis patologias associadas à baixa estatura. Na realidade, a questão apresenta um enunciado pobre. Mas bastava saber que a velocidade de crescimento está diminuída, pois apenas uma alternativa é compatível com uma velocidade de crescimento diminuída, a letra B (deficit do hormônio de crescimento). Contudo, cabe relembrá-los que a principal causa endócrina de baixa estatura é o hipotireoidismo. Gabarito letra B.

88640.

Comentário: O raquitismo por resistência à vitamina D, também conhecido como raquitismo vitamina D dependente do tipo 2 é um distúrbio autossômico recessivo caracterizado por mutações no gene que codifica o receptor da vitamina D, impedindo uma resposta fisiológica normal ao 1,25-diidroxi-vitamina D. Neste caso, os níveis de 1,25-D são extremamente elevados. Já o raquitismo vitamina D dependente do tipo 1 apresenta mutações no gene que codifica a 1- alfa -hidroxilase renal, impedindo a conversão de 25-hidroxi-vitamina D em 1,25-diidroxi-vitamina D. Pacientes com este distúrbio apresentam níveis normais de 25-D, porém níveis baixos de 1,25-D. AFIRMATIVA ERRADA. Gabarito letra B.

82103.

Comentário: ERRADA. O auxograma ou gráfico de crescimento nos mostra uma criança de 10 anos de idade cronológica, com um atraso importante na idade óssea, porém idade mental bem próxima à cronológica. Não há como estarmos diante de um caso de hipotireoidismo congênito, uma vez que esta condição tem como grande manifestação clínica retardo mental (idade mental abaixo da cronológica) e baixa estatura.

64301.

Comentário: Atualmente, para o diagnóstico nutricional de excesso de peso, utilizam-se as novas curvas da OMS (2006-2007), especialmente os gráficos de IMC X Idade, Peso X Idade e Peso X Estatura. A interpretação das curvas é dividida entre crianças de 0 a 5 anos incompletos, crianças de 5 a 10 anos incompletos e adolescentes (10-19 anos). Para as crianças de 5 a 10 anos, como nosso paciente, temos, nas curvas de IMC x IDADE Escore-z -3 Magreza acentuada Escore z -3 e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Escore z -2 Magreza Escore z -2 e Escore z 1 (p85) e Escore z 2 e Escore z 3 Obesidade grave O nosso paciente em questão encontra-se com o IMC acima do p85 (ou Escore Z 1), o que o classifica como portador de SOBREPESO.

64302.

Comentário: Sabemos que a obesidade é uma realidade no atendimento a crianças e adolescentes, em número cada vez maior tanto em países pobres quanto em países ricos, e tornou-se um importante problema de saúde no Brasil. Fatores genéticos, perinatais, alimentares, ambientais e endocrinometabólicos estão envolvidos na patogênese dessa doença. É importante termos em mente que a grande maioria dos casos de obesidade (mais de 90%) é decorrente da reunião entre predisposição genética, alto consumo calórico e baixo gasto energético o que configura obesidade primária, não havendo condição patológica associada. Nosso paciente apresenta numerosos fatores de risco para a doença sabemos que existe uma relação entre o baixo peso ao nascimento (e não apenas o elevado peso ao nascer) e um maior risco de obesidade no futuro. Além disso, o fato de ter iniciado o desmame aos 2 meses e meio (precoce, portanto), também o predispõe ao desenvolvimento de obesidade. Para tornar ainda mais complicada a vida do nosso paciente, seus pais também são obesos Lembrem-se a obesidade nos pais eleva muito o risco da doença nos filhos. Quando ambos os genitores são obesos, esse risco alcança cerca de 80% E somado a essa história, ainda temos um cardápio com diversos erros alimentares associado a nenhuma atividade física.

64303.

Comentário: Sabemos que a obesidade é uma realidade no atendimento a crianças e adolescentes, em número cada vez maior tanto em países pobres quanto em países ricos, e tornou-se um importante problema de saúde no Brasil. Fatores genéticos, perinatais, alimentares, ambientais e endocrinometabólicos estão envolvidos na patogênese dessa doença. É importante termos em mente que a grande maioria dos casos de obesidade (mais de 90%) é decorrente da reunião entre predisposição genética, alto consumo calórico e baixo gasto energético o que configura obesidade primária, não havendo condição patológica associada. A história alimentar do nosso paciente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apresenta erros grosseiros que devem ser corrigidos. É importante que sejam adotados comportamentos duradouros, como ingestão de alimentos de menor densidade calórica. Além disso, deve-se orientar a criança a não realização de lanches nos intervalos das grandes refeições, além da exclusão de guloseimas da dieta. Somado a isso, é fundamental que as refeições sejam realizadas em ambientes apropriados, longe de televisão ou computador, e realizada a correta mastigação dos alimentos.

52607.

Comentário: A absorção dos compostos vitamínicos parece sofrer a interferência de uma série de fatores. Dentre eles, têm sido citadas as parasitoses intestinais, sobretudo a giardíase, a ascaridíase e a estrongiloidíase, particularmente em pacientes com uma alta carga parasitária, assim como a deficiência de zinco. Foi observado que pacientes com ressecções intestinais têm um nível de absorção precário e que doenças pancreáticas diminuem a absorção de preparações lipossolúveis. Alguns autores alertam para o fato de que quadros nosológicos subjacentes, como a fibrose cística, podem levar a uma má absorção de vitamina A. Portanto, a afirmativa está correta- resposta letra A.

52609.

Comentário: A carência de vitamina C tem como principal causa a ingestão inadequada. Essa vitamina (o ácido ascórbico) é encontrado em frutas e hortaliças verdes e sua deficiência é chamada de escorbuto. As manifestações clínicas geralmente são mais evidentes no período entre 6 meses e 2 anos de vida, iniciando com sintomas inespecíficos, como anorexia e irritabilidade, com hipersensibilidade dolorosa, principalmente à troca de fraldas. São comuns manifestações músculo esqueléticas- como exemplo a postura semiologicamente conhecida como posição de rã alterações cutaneomucosas- como a hemorragia gengival alterações hematopoiéticas- como anemia por deficiência de ferro e folato, já que a vitamina C facilita a absorção de ferro e auxilia na conversão de ácido fólico para sua forma ativa. Com base no exposto, vemos que a hipovitaminose C não ocasiona beribéri, sendo essa alteração característica da deficiência de vitamina B1 (tiamina). Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49153.

Comentário: A assertiva está errada. Nos quadros de baixa estatura familiar o paciente cresce dentro do seu canal genético e a sua a altura final será baixa, pois o seu alvo-genético está abaixo da média populacional. É diferente do que ocorre na baixa estatura constitucional, ou atraso constitucional do desenvolvimento, quando o paciente cresce abaixo do seu canal genético e tem uma previsão de estatura na vida adulta normal, dentro do seu alvo genético (que deverá ser normal, evidentemente). Assim, o prognóstico do adolescente com quadro de baixa estatura constitucional é de uma altura final maior que o de outro adolescente de mesma idade e altura com o diagnóstico de baixa estatura familiar. Se fizermos a radiografia de mão e punho esquerdos para avaliação da idade óssea desses dois casos, encontraremos no paciente com baixa estatura familiar uma idade óssea compatível com a idade cronológica já no paciente com baixa estatura constitucional essa idade óssea revela-se caracteristicamente atrasada. Isso confere a este último a certeza de que tem um potencial de crescimento maior que o do primeiro. Resposta letra B.

49169.

Comentário: Os métodos de avaliação do estado nutricional são assim classificados MÉTODOS DIRETOS inquéritos alimentares, avaliação antropométrica e a realização de exames laboratoriais bioquímicos. MÉTODOS INDIRETOS avaliação subjetiva global e exame clínico físico. Portanto, provas bioquímicas e antropometria são métodos DIRETOS de avaliação nutricional, e não indiretos. Resposta questão errada.

49182.

Comentário: Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), do Ministério da Saúde, baseados em orientações da Organização Mundial da Saúde para a avaliação nutricional de crianças, os índices antropométricos adotados pela Vigilância Nutricional são peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e IMC por idade. A avaliação da medida de peso ao nascer também tem importância fundamental, já que o baixo peso ao nascer é um dos principais fatores de risco nutricional ao final do primeiro ano de vida. O perímetro braquial também é medida de avaliação do estado nutricional. Portanto, podemos considerar que a questão apresentada está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CORRETA.

49185.

Comentário: O problema desta questão é que ela limita o campo de atuação da vigilância nutricional. A vigilância nutricional não se limita apenas a acompanhar o padrão de crescimento da criança. O seu objetivo é avaliar e acompanhar o estado nutricional da criança, identificando e prevenindo os casos de desnutrição, que irá acarretar na redução da mortalidade desta faixa etária (objetivo mais amplo). Essas informações irão servir de base para as decisões a serem tomadas pelos responsáveis pelas políticas, planejamento e gerenciamento de programas, relacionados à melhoria dos padrões de consumo alimentar e estado nutricional de crianças. Por isso, podemos considerar que a questão está errada.

49187.

Comentário: Uma questão sobre vigilância nutricional. Vamos lá. Fazem parte das ações da vigilância nutricional tanto os métodos diretos (inquéritos alimentares, antropometria, provas bioquímicas) como os indiretos (exame físico, avaliação subjetiva global) de avaliação nutricional, os quais são aplicados para analisar a situação de saúde e nutrição presentes e futuras, através do acompanhamento ao longo do tempo desses indicadores. A vigilância nutricional, através de suas ações, irá possibilitar a promoção da saúde da população desta faixa etária, prevenindo a ocorrência de complicações relacionadas à desnutrição infantil. Sendo assim, a questão está correta.

49191.

Comentário: Segundo a OMS e os dados do Ministério da Saúde, o uso de indicadores antropométricos na avaliação do estado nutricional de indivíduos ou coletividades é, entre outras estratégias, a mais adequada e viável para ser adotada em serviços de saúde, considerando as suas vantagens, tais como baixo custo, simplicidade de realização, facilidade de aplicação e padronização, amplitude dos aspectos analisados, além de não ser invasiva. É aplicável em todas as fases do curso de vida e permite a classificação de indivíduos e grupos segundo o seu estado nutricional. Portanto, a afirmativa está CORRETA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27537.

Comentário: O Marasmo é uma das formas de desnutrição grave. Vamos ver cada uma das opções. Opção A Errada. O Marasmo é mais comum nos lactentes com menos de 1 ano, embora possa ocorrer em outras faixas etárias. Opção B Correta. O aspecto senil, com criança irritada e faminta são características EXCLUSIVAS do Marasmo. As crianças marasmáticas mantem o apetite preservado, com aspecto faminto a perda do tecido subcutâneo leva ao aspecto senil, com pele enrugada e perda da gordura de Bichat. Opção C, D e E Erradas. As lesões de cavidade oral (queilite angular, língua lisa) são manifestações de carência vitamínica podendo estar presente em ambas as formas de DEP. A presença de edema, hipoalbuminemia, esteatose, hipoatividade, apatia são mais frequentes na forma de DEP do Kwashiorkor.

29720.

Comentário: Afirmativa correta. Um pré-escolar de 3 anos com quadro de anasarca nos faz pensar inicialmente em três possibilidades diagnósticas insuficiência hepática crônica cirrose, síndrome nefrótica e desnutrição calórico-protéica grave (kwashiorkor). Na insuficiência hepática crônica verificamos hipoalbulinemia com lipidograma não característico na síndrome nefrótica observamos hipoalbulminemia com hipercolesterolemia e na desnutrição hipoalbulminemia e hipocolesterolemia.

8586.

Comentário: O enunciado limita-se a transmitir um caso de baixa estatura, sem nos fornecer dados clínicos importantes como peso, passado mórbido, altura dos pais (para cálculo do alvo genético) velocidade de crescimento e exame físico. Entretanto, em praticamente todos os casos de baixa estatura solicita-se a idade óssea como avaliação complementar inicial, obtida através da radiografia de mão e punho esquerdos. O cálculo da idade óssea é feito comparando-se os centros de ossificação da criança com padrões para cada faixa etária contidos em atlas específicos. Não é necessária a radiografia bilateral, bastando-se apenas a imagem da mão e punho esquerdos. De posse de uma boa história, exame físico, velocidade de crescimento (cm ano), alvo genético e idade óssea, podemos identificar duas importantes causas benignas de baixa estatura, que são a baixa estatura familiar e o atraso constitucional do crescimento. As dosagens hormonais (ex

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hormônios tireoidianos, adrenais e gonadais) serão solicitadas apenas se na história ou exame físico houver indícios clínicos que sugiram alguma patologia endócrina subjacente.

334886.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre vacinas. A letra A está incorreta a vacina contra rotavírus está contraindicada se fora da faixa etária determinada em crianças com deficiências imunológicas por doença ou uso de medicamentos que causam imunossupressão com alergia grave (urticária disseminada, dificuldade respiratória e choque anafilático) provocada por algum dos componentes da vacina ou por dose anterior da mesma e com doença do aparelho gastrintestinal ou história prévia de invaginação intestinal. Doença do refluxo gastroesofágico não é uma contraindicação. A letra B está incorreta não está indicado realizar PPD após BCG. Essa vacina é realizada em dose única. A letra C está incorreta não é preciso dar outra dose da rotavírus se o bebê golfar ou regurgitar após tomar a vacina. A letra D está incorreta mesmo as crianças que já tiveram tétano, difteria, doença causada pelo Hib e ou coqueluche, devem ser imunizadas, uma vez que estas doenças não conferem proteção permanente contra novas infecções. E, por fim, a letra E é a afirmativa correta a VOP é feita na rotina de vacinação infantil nas Unidades Básicas de Saúde e é aplicada nas doses de reforço dos 15 meses e dos 4 anos de idade e em campanhas de vacinação para crianças de 1 a 4 anos. Resposta letra E.

343418.

Comentário: O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda para adolescentes de 10 a 19 anos, as seguintes vacinas hepatite B (três doses - iniciar ou completar o esquema, de acordo com situação vacinal) Meningocócica (ACWY para adolescentes de 11 a 12 anos) febre amarela (dose única, para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação reforço, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade) tríplice viral (Iniciar ou completar 2 doses, de acordo com situação vacinal) HPV (duas doses) dupla adulto a cada 10 anos. A banca liberou como gabarito letra A, mas não está correto. Como dito, em adolescentes de 11 a 12 anos é feita a vacina meningocócica ACWY e não a meningocócica C. Além disso, não sabemos a situação vacinal desse adolescente para determinar se ele irá

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

necessitar receber as demais vacinas. Ao nosso ver, a questão deveria ter sido anulada.

334911.

Comentário: Segundo a SBIN, assim como o Prograna Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, as vacinas ao nascimento são BCG e hepatite B. Resposta letra C.

343477.

Comentário: O Ministério da Saúde (MS) recomenda, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), duas vacinas ao nascer BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) e hepatite B. Resposta letra C.

343482.

Comentário: O Ministério da Saúde (MS) disponibiliza, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), um calendário específico para pacientes idosos. Segundo o programa, indivíduos idosos devem receber as seguintes vacinas hepatite B recombinante (três doses - iniciar ou completar o esquema, de acordo com situação vacinal) difteria e tétano (mesma recomendação em relação a hepatite B, entretanto, os indivíduos devem receber reforço a cada 10 anos ou em caso de ferimentos graves, a cada cinco anos) febre amarela (dose única para pessoas de até 59 anos de idade, não vacinadas) sarampo, caxumba e rubéola (uma dose - entre 30 e 59 anos de acordo com a situação vacinal) influenza (anualmente) pneumocócica 23-valente (uma dose, seguida de reforço após um ano - recomendada para pessoas com 60 anos de idade que estejam acamados ou institucionalizados). Dentre as alternativas, apenas a vacina contra o rotavírus não é indicada. Resposta letra C.

307109.

Comentário: Em relação à imunização, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção (ex. a vacina contra a hepatite B, tétano e difteria). A letra B está incorreta. Na verdade, a vacina tríplice (sarampo, caxumba e rubéola) que é indicada aos 12 meses, e aos 15 meses é realizada uma dose da vacina tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), que corresponde a segunda dose da vacina tríplice viral e a primeira de varicela. A letra C está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incorreta. Pelo contrário Estudos demonstraram que o uso de paracetamol de forma profilática para crianças que irão receber alguma vacina, reduz a concentração de anticorpos, reduzindo a imunogenicidade da vacina. A letra D também está incorreta. Antigamente, o Ministério da Saúde orientava a suspensão do aleitamento materno por no mínimo 14 dias, preferencialmente por 28 dias, após a vacinação da febre amarela em mães que estejam amamentando. Entretanto, após discussões, e baseado em evidências científicas, foi consenso de que o período de interrupção do aleitamento materno pós-vacinação contra a febre amarela da mãe, poderia ser reduzido para 10 dias. Por indicar uma recomendação desatualizada, a alternativa está incorreta. A letra E está incorreta. As vacinas de vírus ou bactérias vivas não devem ser administradas em gestantes, pelo maior risco de desenvolvimento da doença. Como a questão não apresenta alternativa correta, foi anulada pela banca.

301299.

Comentário: A vacina BCG (Bacilos de Calmette-Guérin) é produzida com bacilos vivos, atenuados. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), seu esquema vacinal é em dose única (aplicada ao nascimento), não havendo necessidade da aplicação de uma segunda dose de reforço. Portanto, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

301300.

Comentário: A vacina inativada contra poliomielite (VIP) está indicada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Já a vacina oral atenuada (VOP) é administrada aos 15 meses e 4 anos, como reforço. A VOP é contraindicada em crianças com imunossupressão primária ou secundária, ou que tenham contato domiciliar com imunossuprimidos, crianças submetidas a transplantes e crianças com histórico de paralisia flácida associada a dose anterior de VOP. Filhos de mãe HIV antes da definição diagnóstica também não devem receber a vacina. A afirmativa está, portanto, incorreta. Resposta Letra B.

301301.

Comentário: Afirmativa correta. A vacina anti-pneumocócica-10 é recomendada em duas doses no primeiro ano de vida, com um reforço entre 12 e 15 meses (preferencialmente aos 12 meses). Faz

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

parte do calendário básico de todas as crianças com até quatro anos. Para as crianças não vacinadas com idade entre um e quatro anos, recomenda-se uma dose única da vacina (pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias). Esta vacina é licenciada apenas para menores de cinco anos. A SBP recomenda, sempre que possível, o uso da vacina anti-pneumocócica-13, pelo seu maior espectro de proteção, no esquema de três doses no primeiro ano (2, 4, e 6 meses) e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses de vida. Crianças saudáveis com esquema completo com a VPC10 podem receber uma dose adicional da VPC13, até os cinco anos de idade, com o intuito de ampliar a proteção para os sorotipos adicionais. Resposta Letra A.

301302.

Comentário: O número de doses da vacina contra o HPV varia conforme a idade e presença de comorbidades. Dentro do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI) recomenda-se duas doses da vacina (esquema 0 a 6 meses) para as meninas de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e para os meninos de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal para imunocomprometidos é de três doses (0-2-6). A SBP diverge um pouco, recomendando a vacinação tanto para meninos quanto para meninas a partir dos nove anos. Pela SBP, quando o esquema é iniciado até os 14 anos, são feitas duas doses após esta idade, são sempre feitas três doses. Assim, no PNI a vacina é dada sempre em duas doses, em meninas dos 9 aos 14 anos e em meninos dos 11 aos 14 anos e a afirmativa está incorreta. A banca forneceu como gabarito inicial a letra A, porém retificou e deixou como gabarito final a letra B. Resposta letra B.

301303.

Comentário: O ressurgimento do sarampo ao redor do mundo, tem relação direta com a migração de indivíduos contaminados para áreas com alto índice de pessoas suscetíveis para a doença e levada contagiosidade do vírus. No Brasil, especialmente em regiões do norte. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela Organização Mundial da saúde (OMS), mas no início de 2018, casos importados da Venezuela deflagraram importantes surtos em Roraima e no Amazonas, onde a cobertura vacinal estava bem abaixo dos necessários

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

95%, assim como ocorreu em outros países. Até esse ponto, a assertiva está correta, entretanto, não há relato do aparecimento de cepas resistentes à vacina sarampo, caxumba e rubéola, o que torna a assertiva errada. Resposta letra B.

273320.

Comentário: Nas questões sobre baixa estatura, o primeiro passo aqui é definir se a criança tem baixa estatura ou não. Definimos o problema, quando a estatura estiver abaixo do percentil 3 ou do escore-Z -2. Repare que a estatura do adolescente está exatamente sobre o p3. o que não estabelece tal diagnóstico. Porém, como a criança está no limite sempre daremos sequência na investigação avaliando a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimeto dessa criança foi boa, pois é esperado que um pré-pubere ganhe em média 5 a 6 cm ano. Logo, deduzimos que sua VC está dentro do esperado e que se trata de uma variante normal do crescimento. Dentro dessa variante normal, temos duas possibilidades retardo constitucional ou baixa estatura genética familiar. Para diferenciá-las, devemos olhar a Idade Óssea (IO) e compará-la com a cronológica (IC). Se a IO for igual à IC, trata-se de uma baixa estatura familiar se a IO for menor que a IC, estamos diante de um retardo constitucional do crescimento. Hipotireoidismo e deficiência de GH são condições que alteram o crescimento, mas os pacientes apresentam velocidade de crescimento diminuída. Resposta letra C.

263348.

Comentário: Nada entristece mais um pediatra do que dar o diagnóstico de uma condição que poderia ter sido evitada... Em primeiro lugar, responda qual o diagnóstico deste pré-escolar A descrição das lesões vesico-pústulo-crostosas indica a presença de um polimorfismo regional, o que é compatível com o diagnóstico de varicela. O atual calendário do Programa Nacional de Imunizações prevê a administração de duas doses da vacina de varicela. A primeira dose é feita aos 15 meses, na forma da vacina tetraviral (sarampo rubéola caxumba varicela lembre-se de que a vacina tríplice viral, feita aos 12 meses) não tem o componente varicela). A segunda dose é feita aos 4 anos, na forma da vacina varicela. Cabe lembrar que uma dose da vacina tem o principal objetivo de evitar as formas graves da doença e não necessariamente vai impedir a ocorrência de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quadros brandos. A segunda dose é importante justamente pelo fato de reduzir a ocorrência de todas as formas. Resposta letra B.

273327.

Comentário: Bem tranquila. Dentre as citadas, a tríplice viral é a única de vírus vivo atenuado e por isso, está contra indicada na gestação. As gestantes não imunizadas devem receber 3 doses de vacina contra hepatite B. Em toda gestação, está indicada uma dose de dTpa a partir da 20ª semana. Apesar de a vacina citada não ser a recomendada pelo PNI, a DTPa não está contra indicada. Por fim, a vacina contra influenza também deve ser realizada na gravidez, podendo ser feita em qualquer idade gestacional. Resposta letra B.

291477.

Comentário: Questão que aborda, de forma bem direta, o calendário vacinal. Lembre-se do calendário proposto nos primeiros seis meses de vida da criança ao nascer é feita a vacina BCG e a vacina contra hepatite B aos dois e quatro meses são feitas a vacina penta, a vacina contra rotavírus, a vacina pneumocócica 10-valente e a vacina inativada contra poliomielite aos três e cinco meses é feita a vacina meningocócica-C aos seis meses são feitas a terceira dose da penta e da vacina inativada contra poliomielite. Como foi dito que a criança tem todas as vacinas atualizadas até os cinco meses, vamos apenas recomendar as vacinas indicadas aos seis meses. Resposta letra A.

274611.

Comentário: Temos uma questão sobre efeitos colaterais da vacina contra hepatite B. Por ser um imunizante constituído de agente não vivo, esperamos efeitos pouco exuberantes, entre eles, dor no local da injeção, febre baixa, mal estar, cefaleia e fadiga, o que torna a letra B correta. Não há febre alta, alterações hematológicas (como trombocitopenia) nem mesmo exantema maculopapular. Logo, as alternativas A, C e D estão incorretas. Cabe lembrar que esta vacina é aplicada em 4 doses pelo calendário do PNI ao nascer, na forma monovalente, e aos 2, 4 e 6 meses, na forma pentavalente. Resposta letra B.

274613.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Bem tranquila. A caxumba é uma doença infecciosa viral aguda e autolimitada, imunoprevenível, que cursa com febre e edema uni ou bilateral das parótidas, glândulas sublinguais e submaxilares, podendo também evoluir para orquite, pancreatite e meningoencefalite. O diagnóstico é clínico-epidemiológico e o tratamento é apenas de suporte. Resposta letra D.

263363.

Comentário: Nem havia a necessidade de lermos todo o enunciado e conhecermos os hábitos deste escolar, pois o que a banca avaliou nesta questão foi apenas o conhecimento do candidato acerca da classificação nutricional tendo como base o gráfico de índice de massa corporal. O primeiro desafio era calcularmos o valor do IMC peso (em kg) altura 2 (em m) . Com um pouco de atenção, você deveria encontrar um IMC de 21,89 kg m 2 . Colocando este valor no gráfico, observamos que o ponto marcado se situa entre as curvas do escore-Z 2 e 3. Acima de cinco anos, como no caso, o IMC maior que escore-Z 1 e menor ou igual a 2 indica sobrepeso maior que 2 e menor ou igual a 3 indica obesidade maior que 3 indica obesidade grave. Lembre-se de que, abaixo dos cinco anos, as mesmas faixas indicam, respectivamente, risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Assim, este escolar apresenta obesidade. Resposta letra A.

274615.

Comentário: É bem provável que este lactente tenha um quadro de hipofosfatemia genética primária. O raquitismo hipofosfatêmico dominante ligado ao X é a forma mais comum de raquitismo hereditário, com uma incidência estimada de 1 20.000 indivíduos. A principal característica da doença é uma perda renal inadequada de fosfato, que leva a uma hipofosfatemia com fosfatúria elevada e mineralização óssea defeituosa. Os pacientes apresentam raquitismo e osteomalácia, deformidades em membros inferiores, dores ósseas, baixa estatura, anormalidades dentárias e metabolismo alterado da vitamina D. Os níveis de fosfato sérico estão baixos, mas a excreção urinária do fosfato está alta. Os níveis de cálcio sérico e do PTH estão normais e a fosfatase alcalina está elevada. Apenas uma absorção deficiente de fosfato não justifica todas as alterações citadas (letra B errada). Já a síndrome de Fanconi é caracterizada por um distúrbio generalizado no túbulo proximal, o que impede a reabsorção de diversos elementos, culminando em hiperfosfatúria,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

glicosúria renal, aminoacidúria, proteinúria tubular e acidose tubular renal proximal (letra A errada). E, finlamente, a osteodistrofia renal é uma alteração decorrente da doença renal crônica que leva à alteração da matriz óssea com desmineralização que predispõe o paciente à dor óssea, fraturas patológicas e deformidades esqueléticas. O quadro é marcado por hiperparatireoidismo secundário de etiologia multifatorial e é caracterizado por aumento do PTH, por isso não pode ser o nosso diagnóstico (letra D errada). Resposta letra C.

274618.

Comentário: Tanta coisa para ser perguntada e o autor pergunta sobre epônimo De qualquer forma, serve para aprender doença de Heine-Medin, ou poliomielite, é uma doença infecciosa causada pelo poliovírus, um enterovírus neurotrópico que danifica os neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral. A principal manifestação clínica é a fraqueza flácida aguda com distribuição e extensão que podem variar desde alguns grupos musculares até tetraplegia e insuficiência respiratória. A incidência desta doença reduziu drasticamente após a introdução da vacina, que atualmente é administrada na forma de VIP aos 2, 4 e 6 meses com reforço aos 15 meses e 4 anos na forma de VOP. Resposta letra D.

263376.

Comentário: Questão inusitada. Em primeiro lugar, lembre-se das recomendações para vacinação do HPV. A vacina para o HPV integra o calendário do adolescente do Programa Nacional de Imunizações. Para o sexo feminino, no ano de 2020, a recomendação era de vacinar as meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias (15 anos incompletos) e para os meninos de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Nesta população são feitas apenas duas doses da vacina, com intervalo de seis meses. Logo, ambos os irmãos têm indicação de receber a vacina. Apenas a irmã está na consulta... Será que por conta disso você vai indicar a vacina apenas da irmã, como indicado na letra B Não Aproveite a oportunidade e de a orientação para a família sobre a importância desta vacina para ambos. Resposta letra C.

273351.

Comentário: Questão sobre vacinação. Letra A INCORRETA. Um estudo de escala inédita

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

realizado pelo Instituto Serum Statens e publicado na edição de março de 2019 da revista Annals of Internal Medicine reforçou que a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) não aumenta a probabilidade de desenvolvimento de transtornos do espectro do autismo (TEA). Letra B INCORRETA. A vacina é elaborada com vírus inativado e não pode levar ao aparecimento dos sintomas de gripe. Letra C INCORRETA. A vacinação simultânea está entre as principais orientações de melhores práticas na imunização, uma vez que esta prática não interfere na resposta imunológica das vacinas e tampouco potencializa os efeitos colaterais. Letra D CORRETA. A dTpa é uma das vacinas previstas no Calendário de Vacinação das Gestantes e deve ser aplicada nas futuras mães a partir da 20ª semana de gestação, com uma dose somente. A vacina acelular é segura para a grávida e o bebê e visa proteger recém-nascidos e lactentes pequenos da coqueluche grave. Resposta letra D.

273360.

Comentário: A isoniazida está indicada na presença de abscesso subcutâneo frio, úlcera grande, linfadenite regional supurada. Além disso, quando há o surgimento de uma lesão de aspecto verrucoso durante a evolução da cicatriz - no caso de não cicatrização, deve ser feita a prescrição de isoniazida (letra A incorreta). A DTP pode causar eventos adversos sistêmicos, como febre, sonolência, anorexia, vômitos, choro persistente, Episódio Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH), convulsão e encefalopatia (letra B correta). A vacina de febre amarela é composta por um vírus vivo atenuado e, como regra geral, não devem ser administradas em imunossuprimidos, gestantes e pacientes com neoplasias (letra C incorreta). A VOP (vacina oral da poliomielite) foi substituída pela VIP durante o primeiro ano de vida pelo risco de causar poliomielite vacinal (letra D incorreta). Resposta letra B.

291513.

Comentário: Vamos Avaliar cada alternativa a respeito do vírus HPV. A opção A está incorreta a vacina quadrivalente confere proteção contra o HPV tipos 6, 11, 16 e 18. Os tipos 16 e 18 são considerados os tipos oncogênicos, ou de alto risco os tipos os tipos 6 e 11 não são considerados oncogênicos e se relacionam com a formação de verrugas anogenitais. A opção B está correta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

além de oferecer a proteção para os tipos 6 e 11, a eficácia conferida pela vacina bivalente (proteção apenas para os tipo 16 e 18). A opção C está incorreta ainda que a eficácia da vacina seja alta não compreende todos os subtipos do HPV. Há outros tipos com potencial oncogênico e há possibilidade de desenvolvimento de doença mesmo em mulheres vacinadas. E, por fim, a opção D está incorreta a coleta para o teste de DNA-HPV é semelhante à do exame citológico papanicolau, e há estudos quanto à possibilidade de auto coleta de amostra de secreção vaginal para o teste, o que facilitaria o acesso às mulheres com dificuldades geográficas e resistência à coleta por profissionais de saúde. Resposta letra B.

291517.

Comentário: A questão abordou os cuidados com um recém-nascido contactante de um caso de tuberculose bacilífero, no caso, o contactante era a própria mãe. Nestas situações, a criança não receber a vacina BCG logo após o nascimento e inicia quimioprofilaxia primária com isoniazida ou rifampicina. O objetivo disso é evitar que a criança seja infectada. Após três meses, deve ser realizada a prova tuberculínica. Quando é encontrado um resultado reator, deve ser completado o tempo de tratamento da infecção lactente (seis meses de isoniazida ou quatro de rifampicina) nestes casos, não é mais feita a vacina. Quando o resultado é não reator, a quimioprofilaxia é suspensa e a vacina é administrada. A amamentação deve ser mantida, sendo recomendado que, enquanto permanecer bacilífera, a mãe amamente em ambiente arejado e com uso de máscara cirúrgica. Apesar de a resposta original nos parecer correta (opção A), a questão foi anulada.

263427.

Comentário: Lembre-se de que o sarampo é uma doença altamente transmissível e, deste modo, esta lactente pode ter sido contaminada. A principal medida de profilaxia pós exposição é a vacinação, que pode ser feita a partir dos seis meses, em até 72 horas (3 dias) após o contato. A vacina não pode ser feita em menores de seis meses e nem em grávidas ou imunodeprimidos. No caso em tela, a criança já tem 10 meses e, deste modo, deve receber a vacina. As doses feitas no primeiro ano de vida não devem ser consideradas doses válidas para a rotina e esta criança deverá seguir o esquema habitual proposto pelo Ministério da Saúde (tríplice viral aos 12 meses e tetraviral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aos 15 meses). Resposta letra D.

266504.

Comentário: Questão de interpretação de texto (e de lógica também) quanto mais pessoas vacinadas, menor o número de contaminados e consequentemente, menor o número de casos e de óbitos pela doença (não só pela COVID-19, mas em qualquer patologia imunopreveníveI). Afirmativa correta. Resposta letra A.

263437.

Comentário: Vamos revisar qual a conduta recomendada para profilaxia de hepatite B em casos pós violência sexual. A imagem em anexo mostra em destaque especificamente o caso do paciente em questão - o agressor tem a sorologia desconhecida e o paciente não teve resposta vacinal após o esquema convencional. Nesses casos, a recomendação é de realizar um novo esquema com 3 doses, não sendo recomendada a realização da imunoglobulina, que só será realizada em caso de agressor sabidamente reagente (o que não parece muito lógico, mas esta é a recomendação do Ministério da Saúde). O acompanhamento sem nenhuma medida adicional só estaria indicado se o paciente tivesse resposta vacinal adequada, com anti HBs reagente. Resposta letra A.

244486.

Comentário: Aqui temos que avaliar 3 questões Como está a criança em relação ao peso para a idade, quanto ao IMC para idade e quanto à estatura para a idade. P I Consideramos a criança eutrófica se ela estiver entre os percentis 10 e 97. Sabemos que P10 está um pouco abaixo que o escore Z -1 (que corresponde ao P15) e que P97 corresponde ao Z 2. Logo, Z 1,8 está neste intervalo e a criança é considerada eutrófica quanto ao peso para a idade. IMC I Para crianças maiores de 5 anos, consideramos sobrepeso o Z escore entre 1 e 2, como é o caso descrito. E I Consideramos a estatura adequada para a idade se estiver entre P10 e P97, logo, algo abaixo do escore Z -1 (que corresponde ao P15) até Z 2, como é o caso da criança. Resposta correta Letra E.

244506.

Comentário: Questão direta sobre as imunizações vigentes no calendário vacinal do ministério da saúde. No calendário de 2019, aos 12 meses de idade, as três vacinas indicadas são 1 dose da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) reforço da pneumocócica 10 Valente (pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) reforço da Mmeningocócica C (doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C). Resposta letra A.

227419.

Comentário: A questão traz representação gráfica do IMC uma criança, em gráfico adequado para a idade. Observa-se que o paciente está entre os escores z (EZ) 0 e 1, sendo considerado com peso adequado para sua altura. Lembrando que de 0 a 19 anos, é considerado eutrófico o indivíduo que se encontra entre p 3 e p 85 (EZ -2 e EZ 1). Gabarito A

227420.

Comentário: A questão traz representação gráfica do IMC uma criança, em gráfico adequado para a idade. Observa-se que o paciente está abaixo do escores z (EZ) -3, sendo considerado com magreza acentuada. Vamos lembrar que a classificação do Ministério da Saúde não traz os termos desnutrição e subnutrição e sim, magreza acentuada (EZ -3) e magreza (EZ entre -3 e -2). Gabarito B

227421.

Comentário: O item está certo. Para crianças e adolescentes até 19 anos, dizemos que o e-Z maior que 1 e 2 caracteriza sobrepeso maior que 2 e 3 caracteriza o obesidade e maior que 3 caracteriza obesidade. Como o indivíduo A está com IMC acima do e-Z 3, definimos obesidade grave. Resposta letra A.

227422.

Comentário: ERRADO. A vacina contra o HPV é a medida mais eficaz para prevenção contra a infeção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Realizda em 2 doses, sendo a segunda 6 meses após a primeira dose A vacina também é disponibilizada para os indivíduos do sexo feminino e masculino com HIV AIDS e também para imunodeprimidos (submetidos a transplantes de órgãos sólidos, transplante de medula óssea ou pacientes oncológicos). Essa população recebe a vacina dos 9 aos 26 anos e o esquema é com 3 doses (0 - 2 - 6).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227449.

Comentário: A vacina do Sarampo (tríplice viral) é contraindicada durante a gestação por ser uma vacina de vírus vivo atenuado. Portanto, afirmativa ERRADA.

230630.

Comentário: Em caso de pessoa em situação de violência sexual não imunizada ou com esquema vacinal incompleto para hepatite B, o Ministério da Saúde recomenda vacinação para hepatite B e IGHAHB. A IGHAHB pode ser administrada até, no máximo, 14 dias após a violência sexual, embora se recomende seu uso nas primeiras 48 horas a contar do ato. Resposta letra D.

206169.

Comentário: Síndrome de Turner é a anormalidade dos cromossomos sexuais mais comum nas mulheres, ocorrendo em 1 a cada 1.500-2.500 crianças do sexo feminino nascidas-vivas. A constituição cromossômica pode ser ausência de um cromossomo X (cariótipo 45,X), mosaicismo cromossômico (cariótipo 45,X 46,XX), além de outras anomalias estruturais do cromossomo X. As anormalidades típicas da síndrome de Turner incluem baixa estatura, disgenesia gonadal, pescoço alado, linha posterior de implantação dos cabelos baixa, fácies típica, tórax alargado com aumento da distância entre os mamilos, linfedema congênito, principalmente em extremidades, cúbito valgo, tireoidite autoimune com ou sem hipotireoidismo, anormalidades renais, cardiovasculares, sendo a coarctação da aorta e a aort bicúspide as mais frequentes, e auditivas, além de deficiência cognitiva em algumas atividades, embora a inteligência média seja considerada normal. Baixa estatura é o achado mais comum da síndrome de Turner. Caracteristicamente há retardo leve do crescimento na fase intrauterina, redução progressiva da velocidade de crescimento durante a infância e marcada ausência de crescimento na fase puberal. Pacientes com síndrome de Turner não tratadas apresentam altura média na idade adulta de 136 a 147 cm. Resposta letra D.

203026.

Comentário: Sobre a vacina do HPV, a ANVISA aprovou a vacina quadrivalente para uso em meninas e mulheres com 9 a 26 anos de idade e a bivalente para administração em meninas e mulheres com 10 a 25 anos. Atualmente, ambas as vacinas pode ser administradas até os 45 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Sobre isso, vamos avaliar cada opção Letras A e B O ideal é a que imunização seja feita antes do início da vida sexual. A - INCORRETA e B - CORRETA Letra C Não há necessidade de captura híbrida para vacina. INCORRETA Letra D É importante lembrar que mesmo mulheres vacinadas deverão realizar colpocitologia, pois a vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV. INCORRETA Letra E A vacina pode ser feita para qualquer paciente, independente dos fatores de risco associados, de preferencia antes do inicio da vida sexual. INCORRETA Resposta letra B.

206144.

Comentário: Vamos analisar as alternativas em relação a desnutrição no ambiente hospitalar Letra A - Incorreta na fase inicial da resposta endócrino metabólica e inflamatória ao trauma, há hipermetabolismo, com hiperglicemia, portanto não é o momento ideal de se iniciar a reposição de carboidratos. Entretanto, algumas referências consideram que a terapia nutricional no trauma é minimizaria o catabolismo, impedindo que o paciente se desnutra ou, se a desnutrição já estiver instalada, que ela não se agrave. Por isso, item polêmico. Letra B - Correta pacientes com neoplasia, idade avançada, infecção e tempo de internação hospitalar prolongado tem maior risco de desenvolver desnutrição. Letra C - Correta as reservas de glicogênio duram apenas 12 a 24h no jejum. Letra D - Correta pacientes com desnutrição severa, como o marasmo e o kwashiorkor, que se desenvolvem em casos de desnutrição prolongada, devem ser tratadas com recuperação nutricional lenta, pelo risco de desenvolvimento de síndrome de realimentação, potencialmente fatal, podendo levar meses e até mais de 1 ano. Gabarito inicial letra A. Mas após recurso a questão foi ANULADA.

212106.

Comentário: A vacinação com BCG não impede a infecção, nem o adoecimento pelo Mycobacterium tuberculosis . Seu objetivo primordial é reduzir o risco de o imunizado desenvolver formas graves de tuberculose, isto é, miliar e meníngea. Assertiva correta. Resposta A.

212043.

Comentário: Questão simples. Os subtipos 16 e 18 do HPV são aqueles considerados oncogênicos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mais comuns, associados a aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo de útero. Portanto, eles são os principais alvos para o desenvolvimento de vacinas. Afirmativa ERRADA. Resposta letra B.

212044.

Comentário: A vacina quadrivalente foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde a partir de 2017 para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, oferecendo proteção contra os subtipos 6, 11, 16 e 18. Os subtipos 6 e 11, no entanto, são subtipos que não parecem oferecer nenhum risco de progressão para malignidade e são incluídos na vacina para proteção contra a formação de condilomas. Afirmativa ERRADA. Resposta letra B.

212072.

Comentário: Vamos relembrar A vacina tríplice viral está contraindicada na gestação por ser composta de vírus atenuados. Contudo, ela pode ser utilizada no puerpério e na amamentação. Ou seja, a assertiva encontra-se CORRETA e o nosso gabarito é a letra A.

206114.

Comentário: Questão retirada na íntegra do documento Recomendações para o manejo da coinfecção TB-HIV em serviços de atenção especializada a pessoas vivendo com HIV AIDS do Ministério da Saúde. Vamos aprender Cinco etapas para prevenção da transmissão de TB em unidades de saúde 1) Reconhecer o SR ou paciente com TB pulmonar ativa é o primeiro passo nas medidas administrativas. Pode ser obtido com a preparação de um profissional de saúde para realizar a busca ativa de SR em todo paciente que chega a unidade, interrogando a presença e duração da tosse. Ação rastrear. A correta. 2) Oferecer ao SR máscara cirúrgica para uso durante sua permanência na unidade e instruí-lo com relação à etiqueta da tosse (levar o braço ou lenço à boca quando tossir). Ação educar. B correta. 3) SR ou pacientes com TB de vias aéreas em atividade ainda infectantes devem esperar atendimentos ou procedimentos em áreas bem ventiladas . Ação separar. C incorreta. 4) Priorizar o atendimento do paciente no serviço, independentemente do motivo da procura. O paciente deve passar à frente na fila de consultas, exames e ou dispensa de medicamentos. Ação priorizar. D correta. 5) Proceder à investigação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

necessária para afastar ou confirmar o diagnóstico de TB nos SR. Ação investigar Tb. Perceba que somente a letra C encontra-se INCORRETA e portanto é o nosso gabarito.

212130.

Comentário: Vamos relembrar No Sistema Único de Saúde (SUS), três tipos de vacina estão disponíveis para as pessoas a partir dos 60 anos de idade hepatite B, dupla adulto (difteria e tétano) e febre amarela (apenas para idosos que estejam morando ou passando por áreas com recomendação de vacina). Além da vacinação rotineira, outras duas vacinas importantes também poderão estar disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação para a população idosa. São elas a vacina contra a influenza e a pneumocócica 23-valente. A Vacina pneumocócica 23-valente é administrada durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, nos indivíduos de 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e ou em instituições fechadas como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento asilos, casas de repouso. Ou seja, a assertiva encontra-se correta e o nosso gabarito é a letra A.

183947.

Comentário: Aproveitemos para rever os critérios diagnósticos de síndrome metabólica pelo ATP III - Circ. abdominal 102 cm homens 88cm em mulheres. - Glicose 100 mg dL ou diagnóstico prévio de diabetes - TG 150 mg dL ou tratamento para dislipidemia - HDL 40 mg dL em homens ou 50 mg dL em mulheres ou tratamento para dislipidemia - PAS 130 mmHg ou diastólica 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial Assertiva errada. Resposta B. mento para hipertensão arterial

183890.

Comentário: Errado. A imunização passiva é aquela adquirida pela administração de anticorpos já formados e que promove proteção transitória contra determinado agente. Ela é feita pela administração de anticorpos heterólogos (de animais previamente vacinados) ou homólogos (de plasma de seres humanos). Existe um risco elevado de anafilaxia e reações de hipersensibilidade com deposição de imunocomplexos com o uso de imunoglobulina derivada de animais. Já a imunização ativa é quando induzimos uma resposta imunológica celular e humoral duradoura.

183867.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Correto. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nos últimos anos foram incluídas vacina para varicela e hpv. Resposta letra A.

159565.

Comentário: De acordo com as recomendações de profilaxia para raiva do Ministério da Saúde, em condições de acidentes com animais silvestres , como é o caso, além dos cuidados locais com a ferida já descritos pelo enunciado, deve-se sempre administrar 5 doses de vacina anti-rábica nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. Como o ferimento é GRAVE (profundo e múltiplo), também está indicada o tratamento com soro anti-rábico no atendimento inicial. Portanto, a assertiva está CERTA.

154488.

Comentário: A vacina SCR ou MMR, composta de vírus vivos atenuados, protege contra sarampo, caxumba e rubéola e deve ser administrada aos 12 meses outra vacina contendo os mesmos vírus atenuados a tetra viral, complementada com varicela é aplicada aos 15 meses. Também de vírus vivos atenuados é a vacina contra febre amarela, fornecida para moradores de área endêmica, a partir dos 9 meses, com reforço aos quatro anos para viajantes, deve ser administrada 10 dias antes (não marcaremos E). A vacina contra hepatite A é inativada, sendo indicada em dose única para crianças entre os 15 e os 23 meses os que perderam a chance de se vacinarem nessa faixa etária, podem contar com o imunobiológico até os quatro anos de idade. Resposta D.

159564.

Comentário: O auxograma, como já dito no enunciado, é uma ferramenta gráfica útil na avaliação do crescimento de uma criança e permite de forma bem direta e visual a comparação do crescimento e do desenvolvimento sob múltiplos aspectos. Em geral também é descrita a idade genital (IG), mas isso não foi representado nesta questão. Vamos analisar o que está sendo mostrado no auxograma B. Temos uma criança com idade cronológica de oito anos, compatível com a idade mental. Há apenas uma diferença muito discreta da idade óssea, o que sequer deve

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser considerado. Porém, nota-se que a criança é baixa e tem um peso inadequado para a idade (a sua idade altura e idade peso correspondem ao esperado para uma criança de apenas cinco anos). Tal configuração é característica do que já foi chamado de nanismo primário , uma nomenclatura pouco usada nos dias de hoje. Nesta situação, não há nenhuma condição mórbida subjacente (seria um provável caso de baixa estatura familiar). Assim, a afirmativa é verdadeira. Resposta letra A.

158059.

Comentário: Conforme descrito no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil recomenda-se o tratamento da infecção latente da tuberculose, mesmo sem prova tuberculínica (PT), nas seguintes situações - Recém-nascido coabitante de caso índice bacilífero (tratar com isoniazida 6 meses e depois desse período vacinar para BCG) - Pessoa vivendo com HIV aids com cicatriz radiológica sem tratamento prévio da infecção latente da tuberculose - Pessoas vivendo com HIV aids contato de caso de tuberculose pulmonar - Pessoa vivendo com HIV aids com registro documental de ter tido PT 5mm e não submetido ao tratamento da ILTB na ocasião. Dito isso, vamos analisar as assertivas A) Incorreta. A quimioprofilaxia primária é realizada utilizando-se a isoniazida por 3(três) meses e não 6(seis). B) Incorreta. A alternativa é praticamente toda correta. O errado está no caso do PPD 5mm, deve-se completar mais 3(três) meses com isoniazida. C) Incorreta. Como citado anteriormente, na ausência de PPD devemos tratar com isoniazida por 6 meses. D) Incorreta. Como citado anteriormente. E) Correta. Na ausência de PPD, os neonatos devem receber tratamento com isoniazida por seis meses e vacinação com BCG após o tratamento. Dessa forma, percebemos que o nosso gabarito é a letra E.

159569.

Comentário: Vejamos o que está acontecendo no auxograma do paciente C. O paciente apresenta um importante atrasado na idade óssea em relação à sua idade cronológica. Isso até seria compatível com o quadro de baixa estatura por hipotireoidismo. Porém, no hipotireoidismo a Idade Óssea (IO) também está atrasada em relação à Idade Estatural (IE). Além disso, no auxograma clássico dessa condição identificação uma Idade Peso (IP) acima da Idade Estatural (IE). Além

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

disso, no hipotireoidismo é descrito um atraso na Idade Mental (IM). O auxograma descrito em D é o clássico do hipotireoidismo. O auxograma indicado em C é mais compatível com o diagnóstico de nanismo pituitário (deficiência de hormônio de crescimento). Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

159576.

Comentário: A afirmativa está errada. O auxograma mostrado em D é típico de hipotireoidismo há atraso na idade mental idade peso maior que a idade estatural idade óssea atrasada em relação à idade cronológica e também atrasada em relação à idade estatural. O auxograma típico do nanismo pituitário (deficiência de GH) é o indicado em C note que não há atraso de idade mental e que a idade óssea está atrasada em relação à idade cronológica, mas é maior que a idade somática (idade estatural e idade peso). A idade peso é compatível com a idade estatural (a criança é proporcional, no sentido de não haver emagrecimento ou sobrepeso). Resposta letra B.

159579.

Comentário: A afirmativa está errada. O auxograma representado em E exemplifica o que ocorre em uma criança com um quadro de nanismo por desnutrição energético proteica. Note como há atraso da idade peso em relação à idade estatural, o que aponta para emagrecimento. Estas crianças também apresentam atraso de idade óssea em relação a idade cronológica, mas a idade óssea é maior que a idade somática (peso e estatura). A idade mental pode ter atraso a privação nutricional pode ter impacto no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Resposta letra B.

159583.

Comentário: O auxograma é um método gráfico que permite a análise de diferentes aspectos do crescimento. A imagem representada em A nada mais é do que aquilo que se espera encontrar em uma criança saudável uma harmonia entre a idade cronológica, estatural, peso, óssea e mental. Resposta letra A.

159592.

Comentário: Uma criança de 4 anos que apresenta um peso para a idade acima do escore-Z 3, pressão arterial acima do percentil 99 e LDL acima de 100 mg dl, levanta a suspeita de que se trata

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de um possível quadro de Síndrome Metabólica (SM). Antes de tudo, vale lembrar que não há critérios estabelecidos para caracterizar SM em crianças menores de 10 anos de idade. Com relação à obesidade, podemos apenas inferir, pois o percentil do IMC para idade não foi fornecido. No entanto, posso confirmar que o paciente apresenta hipertensão, pois encontra-se com valores acima do p95. Logo, devemos fornecer um tratamento para esta criança, composto por dois pilares planejamento dietético, com o objetivo de melhorar a qualidade da dieta, incentivar o consumo de frutas, verduras e alimentos integrais e reduzir o consumo de sódio, gordura saturada e açúcares, além de esclarecimento e avaliação comportamental, como incentivar a fazer as principais refeições à mesa com a família, realizar 6 refeições ao dia, enfim, promover uma mudança no estilo de vida da família da criança o segundo passo é estimular a atividade física, com realização de atividades ao ar livre. Ressaltamos que, nessa idade, não se deve utilizar de dietas restritivas ou terapia farmacológica. Gabarito certo

168480.

Comentário: Após o mapa apresentado na questão, vamos acompanhar o que relatou o Ministério da Saúde em 10 02 2017 A vacinação de rotina é ofertada em 19 estados do país com recomendação para imunização. Neste momento, também precisam se vacinar pessoas que vão viajar ou vivem nas regiões que estão registrando casos da doença leste de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo, oeste da Bahia, além do noroeste do Rio de Janeiro que está localizado na divisa com áreas que têm registros de casos. No mapa, é nítida a concentração de casos confirmados no Espirito Santo, logo, a melhor resposta é a letra D.

159615.

Comentário: A vacina contra o HPV já vem integrando o calendário do Programa Nacional de Imunizações. Desde 2016, a recomendação é de que sejam feitas apenas duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre as mesmas, para a população feminina a partir dos nove anos (desde janeiro de 2017, a faixa etária feminina contemplada passou a ser de nove a 14 anos). Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

159589.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: De acordo com o Calendário Nacional de Imunizações vigente no período do concurso, as vacinas que devem ser administradas para uma criança de 2 meses são pentavalente (DTP Hib HepB), antipolio forma inativada (VIP), antipneumocócica 10V e antirotavírus oral humano. À princípio, o correto deveria ser a pentavalente em substituição a tetravalente e a anti-hepatite B, pois desde 2012 que o Ministério da Saúde publicou a união dessas duas vacinas em uma forma única. No entanto, a banca optou em separá-las e considerou como certo o gabarito da questão.

168470.

Comentário: O enunciado apresenta uma criança de 10 anos com MORDEDURA ANIMAL EM FACE, e o autor solicita a conduta frente ao caso. Sabe-se que sua vacinação anti-tetânica está em dia e adequada (3 doses, sendo a última há menos de 5 anos). Logo, para PROFILAXIA CONTRA A RAIVA PÓS-EXPOSIÇÃO temos que 1) ferimento de alto risco (face e profundo) 2) animal doméstico observável. Portanto, a conduta é 1) lavar com água e sabão 2) Iniciar vacina com 2 (duas) doses, uma no dia 0 e outra no dia 3 3) Observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspender o tratamento e encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completar o esquema até 4 doses. Aplicar mais duas doses uma entre o 7º e 10º dia e outra dose no 14º dia. Além disso, para evitar a infecção piogênica secundária da ferida, recomenda-se antibioticoprofilaxia. Resposta letra C.

159609.

Comentário: A vacina contra febre amarela é composta pelo vírus vivo atenuado, sendo então contraindicada em gestante pois a risco para a saúde do feto. Pore m, o me dico pode avaliar sua utilizac a o quando os riscos de adquirir a doenc a superam os riscos potenciais da vacinac a o, com em casos de surto. Gabarito errado.

168488.

Comentário: Em 2016, a recomendação do Ministério da Saúde (MS) era a aplicação da vacina contra a Febre Amarela em duas doses em todos aqueles que moram ou se deslocam para as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

áreas de recomendação da vacina, sendo a primeira a partir dos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade (com intervalo mínimo de 30 dias entre a dose anterior). Em casos de surtos era recomendado antecipar 1 dose a partir de 6 meses, porém não considerando essa dose válida, ou seja, se uma criança recebesse uma dose entre 6 e 9 meses, teríamos que iniciar o esquema com a 1 dose a partir de 9 meses e o reforço aos 4 anos. No entanto, a partir de abril de 2017, o MS adotou a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é a aplicação de uma dose única da vacina para toda a vida. Além disso, a dose entre 6 e 9 meses em caso de surto não é mais recomendada. De todo modo, como essa criança de 2 anos recebeu a vacina quando a recomendação ainda era vigente, não deveríamos considerar a dose válida e a criança deveria ser vacinada no momento, porém basta uma dose e ela estará imunizada por toda a vida sem indicação de reforço. Logo, não há resposta correta na questão.

159581.

Comentário: A vacina tetraviral é uma atualização da vacina tríplice viral e consiste na combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e catapora, apresentada sob a forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses. Todos os quatro componentes desta vacina obrigatória são altamente imunogênicos e eficazes, dando imunidade duradoura por praticamente toda a vida. O calendário básico de imunizações do Sistema Único de Saúde (SUS) passou a contar, a partir de setembro de 2013, com a vacina tetravalente viral que inclui a imunização contra a varicela (catapora) , além de sarampo, caxumba e rubéola , já contempladas na tríplice viral. Em 2017, para crianças, há ampliação da oferta da dose, que passa a ser administrada de 15 meses até 4 anos . Antes, a aplicação era feita entre 15 meses e menores de 2 anos. A recomendação é uma primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) aos 12 meses e uma segunda dose a tetra viral aos 15 meses . O seu principal objetivo é controlar e eliminar o sarampo, a caxumba, a rubéola assim como evitar formas graves de catapora. Portanto, o nosso gabarito é a letra A (CORRETO).

159591.

Comentário: Vamos responder a essa questão segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Ministério da Saúde. Segundo tal referência, a definição de Parotidite é Doença viral aguda, caracterizada por febre e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a parótida e, às vezes, glândulas sublinguais ou submandibulares. Em homens adultos, ocorre orquiepididimite em, aproximadamente, 20% a 30% dos casos em mulheres, pode ocorrer ooforite com menor frequência, acometendo cerca de 5% dos casos. Cerca de 1 3 das infecções podem não apresentar aumento, clinicamente aparente, dessas glândulas. O sistema nervoso central, com frequência, pode estar acometido sob a forma de meningite asséptica, quase sempre sem sequelas. Mais raramente, pode ocorrer encefalite . Ainda segundo esse guia, temos como definição de caso suspeito Paciente com febre e aumento de glândulas salivares, principalmente parótidas . Ou seja, nossa assertiva encontra-se CORRETA e portanto, o nosso gabarito é a letra A.

133996.

Comentário: Vamos analisar as opções sobre o kwashiorkor A) INCORRETA. No marasmo ocorre o aspecto de extremo aspecto emagrecido com atrofia muscular. No kwashiorkor existe edema e relativa preservação da gordura subcutânea, o que disfarça a carência energético-proteica. B) CORRETA. C) CORRETA. O marasmo e o kwashiorkor são formas graves da deficiência energético - proteica. D) INCORRETA. A faixa etária predominante do kwashiorkor é mais comum no 2º e 3º anos de vida. Em função de duas opções corretas, letras B e C, a banca anulou a questão.

129076.

Comentário: Vamos analisar as alternativas sobre o tema alimentação saudável . A CORRETA. Os ácidos graxos ou gorduras trans são um tipo de gordura formado pelo processo de hidrogenação natural, que ocorre quando o animal rumina, ou durante o processo industrial de hidrogenação parcial, que transforma os óleos líquidos em gorduras mais consistentes à temperatura ambiente. Gordura vegetal hidrogenada é aquela na qual são adicionadas moléculas de hidrogênio. Este processo, conhecido como hidrogenação, transforma os óleos vegetais líquidos em gorduras mais consistentes à temperatura ambiente. B INCORRETA. Alimentos que usam como conservante o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sódio podem ser doces, como refrigerantes. C INCORRETA. Ervas aromáticas são amplamente utilizadas para a substituição do sal. D INCORRETA. A tabela apresenta uma forma de organização com início pelo valor energético, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar, sódio, outros minerais e vitaminas, nesta ordem. E INCORRETA. Existe diferença entre alimentos light e diet . Os termos diet e light podem, opcionalmente, ser utilizados nas embalagens de alimentos. No entanto, os critérios e as condições para o uso dessas duas expressões são diferentes. Enquanto o termo light é usado para indicar uma informação nutricional de menor concentração calórica, o termo diet é usado em alguns produtos para fins especiais, para indicar a substituição do açúcar por adoçante e nem sempre possui menor teor calórico. Gabarito letra A.

111336.

Comentário: Questão bem simples O principal cuidado era não errar na hora da conta. O cálculo do alvo genético no sexo masculino é feito da seguinte forma altura do pai (altura da mãe 13) 2. O alvo-genético permite que seja avaliada a herança (estatura dos pais) na determinação da faixa de estatura final. Lembre-se de que uma criança que cresce muito aquém do seu alvo-genético deve ser avaliada, ainda que não tenha baixa estatura. Fazendo as contas com os dados fornecidos, chegamos ao valor de 168 cm. Resposta letra D.

111284.

Comentário: A baixa estatura familiar é uma variante da normalidade, ou seja, não é considerada uma baixa estatura patológica. Nesses casos, a criança é baixa, mas cresce em um ritmo constante, dentro do alvo genético e apresenta idade óssea compatível com a idade cronológica. A idade estatural é menor que ambas. Resposta letra C.

97778.

Comentário: O enunciado descreve um neonato com uma evolução de lesão cutânea pós-BCG típica do esperado, ou seja, formação de mácula, pústula, úlcera e cicatriz ao longo de 6 a 12 semanas. Em até 10% das crianças vacinadas também poderá ocorrer um infartamento ganglionar em região axilar, supra ou infraclavicular, com linfonodo frio medindo até 3 cm de diâmetro. A conduta portanto, é expectante. Gabarito letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97806.

Comentário: O enunciado nos apresenta um pré-escolar com déficit de peso, hiporexia, xerodermia, xeroftalmia e nictalopia (dificuldade de enxergar à noite), sinais e sintomas típicos da carência de vitamina A. De fato, as alterações mais características do déficit de vitamina A são as manifestações oculares, que se desenvolvem em um contínuo de gravidade. Essas lesões se desenvolvem insidiosamente e são raras antes de 2 anos. O sintoma mais precoce é a diminuição da visão no escuro, até a completa cegueira noturna (nictalopia ou hemeralopia). O epitélio da córnea torna-se queratinizado, predispondo a infecções camadas de células escamosas e secas se desenvolvem e configuram a xeroftalmia. Em estágios mais avançados, com a infecção e infiltrado de linfócitos, a córnea torna-se enrugada, mole e se degenera irreversivelmente (ceratomalácia). Em casos muito graves, a córnea se rompe e permite o extravazamento do cristalino e humor vítreo. A conjuntiva bulbar também sofre queratinização e desenvolve placas as manchas de Bitot, outra lesão de surgimento precoce. As glândulas lacrimais também podem queratinizar e ter seus ductos entupidos , diminuindo com isso a lubrificação e a manutenção do filme lacrimal. Gabarito letra A.

75503.

Comentário: A presença de fratura, baixa estatura para a idade, deformação do tórax e da curvatura da coluna vertebral e hipotonia muscular em um pré-escolar sem acompanhamento regular é fortemente sugestivo de raquitismo. O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela diminuição da mineralização da placa epifisária. A formação e o crescimento ósseo dependem da produção da matriz óssea, composta principalmente por colágeno, e de sua mineralização através da deposição dos cristais de hidroxiapatita, compostos basicamente de cálcio e fósforo. A falha do processo de mineralização tem como uma das principais causas a inadequada concentração extracelular desses íons, e a falta ou comprometimento da ação dos elementos responsáveis por sua absorção, particularmente a vitamina D. A vitamina D no organismo é proveniente da dieta e, principalmente, da sua síntese na pele a partir da conversão do 7-diidrocolesterol, sob a ação do calor e dos raios ultravioleta. Assim, uma dieta pobre e a pequena exposição à luz solar são fatores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de risco para a doença. O quadro clínico geralmente revela atraso no fechamento das fontanelas e no crescimento, fronte olímpica e craniotabes, e a alteração de ossos longos e coluna vertebral também é comum. O alargamento das epífises ósseas, revelado na radiografia apresentada, auxilia no diagnóstico. Resposta letra E.

138711.

Comentário: A grande preocupação quanto a essa ferida é a contaminação do vírus da raiva. Para isso ela deve ser lavada com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas (povidine, digluconato de clorexidina ou álcool-iodado) e remover corpos estranhos e tecidos desvitalizados. Aproximação dos bordos da ferida com auxílio de sutura com ponto simples.

138712.

Comentário: Para responder essa questão temos que saber a situação vacinal do adolescente. Ele tem vacina prévia de tétano A questão fala que a vacinação é desconhecida, ou seja, vamos lidar com um paciente não vacinado. Outro ponto importante, diz respeito a natureza da lesão. Qual é o risco para tétano Como ele apresenta uma ferida em decorrência a mordedura, temos que lidar como ferida de alto risco para tétano. Juntando os dados, temos que o adolescente tem que receber 3 doses da vacina antitetânica com intervalo de 60 dias entre as doses soro antitetânico ou imunoglobulina antitetânica, uma doses que deve ser aplicada IM em sítio diferente ao da vacina.

138713.

Comentário: Temos ou não quer fazer antibiótico em mordedura de cão Como foi uma lesão profunda em tecidos nobres (face) devemos iniciar o tratamento com antibiótico pelo risco de infecção secundária. Vale a pena lembrar que o mesmo raciocínio se aplica para mordedura por gatos. Os antimicrobianos sugeridos são amoxicilina clavulanato ou ampicilina sulbactam por cinco dias.

138714.

Comentário: Para responder essa questão, precisamos de dois dados a gravidade da lesão e as condições do agressor. A lesão é grave, pois apresentou diversas lacerações na face. Já o cão não é suspeito de raiva. Nessa situação, o que fazer Lavar o ferimento com água e sabão Observar o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

animal durante 10 dias após exposição Iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3 Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, dar continuidade ao esquema profilático, administrando o soro e completando o esquema até 5 doses aplicar uma dose entre o 7o e o 10o dia e uma dose nos dias 14 e 28 . Portanto existe sim a necessidade de profilaxia, que deve ser feito como citado acima.

75535.

Comentário: Vamos relembrar o Ministério da Saúde se baseia nas curvas da OMS para a avaliação nutricional das crianças. Para as crianças acima de 5 anos, como a nossa em questão, temos que um IMC acima do p97 (ou escore Z 2) configura obesidade. A paciente do caso tem um IMC de 22,4 que, quando plotado no gráfico IMC X idade, encontramos uma medida acima do p97. Portanto, nossa paciente está, de fato, obesa. Quanto à avaliação da pressão arterial, sabemos que avaliação da PA em crianças é feita com base em tabelas que consideram o sexo, a estatura e a idade do paciente. Nossa criança, do sexo feminino, encontra-se no percentil 75 de estatura, então podemos analisar a tabela de PA oferecida em uma criança de 7 anos, no p75 de estatura, temos que o p95 de PA sistólica é 115 mmHg, e o p95 de PA diastólica é 75 mmHg. A paciente apresenta PA sistólica e PA diastólica acima destes valores e, por essa razão, podemos classificá-la como hipertensa. Lembrem-se de que uma PA abaixo do p90 é normal. Acima do p90, classificaremos como pré-hipertensão e, acima do p95 de PA, hipertensão. Assim, temos uma paciente que apresenta obesidade (IMC x idade acima do p97) e hipertensão (PA acima do p95) e o tratamento e acompanhamento estão corretamente descritos na opção C. Cuidado com a opção A definimos obesidade grave como uma medida do IMC acima do p99,9 no gráfico IMC x idade, e o uso de tratamento farmacológico não constitui primeira linha de tratamento da HAS deste caso. Resposta letra C.

75458.

Comentário: O quadro clínico descrito sugere o chamado episódio hipotônico-hiporresponsivo. A reação hipotônica hiporresponsiva é evento adverso relacionado à vacina DTP, associada ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

componente pertussis. Trata-se de um episódio de instalação súbita, nas primeiras 48h de aplicação da vacina, durando de alguns minutos a algumas horas. Geralmente, tem prognóstico bom. Sua ocorrência indica uso de DTP acelular nas próximas doses. Resposta letra C.

75506.

Comentário: Como é aplicada a vacina contra a febre amarela Após 9 meses de idade em moradores de área endêmica, com dose de reforço de 10 em 10 anos. Mas essa jovem não é moradora de tal área. O que fazer então Recomendar a vacina de FA com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem para o Acre e avisar que a validade é de 10 anos. Lembrar-se, sempre, da comprovação vacinal junto ao paciente. Resposta D.

75511.

Comentário: Questão ruim, em que não é possível chegar à resposta correta. Ela diz que a paciente com 22 semanas de gestação recebeu uma dose da vacina dupla para adulto há 3 anos, no entanto não nos informa se este esquema vacinal está completo ou não. Caso o esquema esteja completo, não há necessidade de dose de reforço, já que este só é indicado quando a última dose foi aplicada há mais de 5 anos. Agora, se o esquema estiver incompleto, ela deve receber as vacinas restantes ainda durante a gestação. Esta informação incompleta da questão impede que a melhor conduta seja tomada para o caso. O gabarito da banca foi letra D, não aplicar vacina antitetânica, considerando que a paciente já tinha completado o esquema vacinal anteriormente. Esta questão deveria ter sido anulada. No entanto, a banca permaneceu com a letra D como gabarito.

75547.

Comentário: A questão quer saber qual medida teria maior impacto na prevenção das lesões induzidas pelo HPV. A resposta é simples vacinação contra o vírus HPV. As vacinas são compostas por VLPs (vírus Like Particle), que não contém o DNA infectante do vírus, mas sim seu capsídeo viral. O objetivo da vacina é a prevenção do surgimento de lesões induzidas pelo HPV e, até o momento, não tem objetivo terapêutico na regressão de lesões já existentes. A ANVISA aprovou a vacina quadrivalente para o uso em meninas e mulheres com 9 a 26 anos de idade e a bivalente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para meninas e mulheres entre 10 e 25 anos. Como a paciente da questão possui 16 anos, ela pode utilizar qualquer uma das duas vacinas e essa é a resposta da questão. Em relação as outras opções, tome cuidado pois a captura híbrida tem como objetivo identificar a presença do HPV e o exame citopatológico identifica as alterações causadas pelo vírus, portanto estas condutas são apenas diagnósticas e não previnem o surgimento de lesões Há uma divergência na literatura se os anticoncepcionais orais são fator de risco para câncer de colo de útero, mas definitivamente eles não diminuem sua incidência. Por fim, muitas pessoas podem ser portadoras assintomáticas do HPV e a avaliação do namorado por um urologista não será capaz de reduzir a transmissão do vírus. Gabarito letra A.

137684.

Comentário: Ao plotarmos esta criança no gráfico, percebíamos que a mesma tem o diagnóstico nutricional de obesidade. Da mesma forma que ocorre na população adulta, a obesidade na infância também implica no maior risco de diversas comorbidades, sendo que muitas delas são assintomáticas e serão identificadas apenas pelo rastreamento. Dentre essas temos as alterações do metabolismo lipídico e glicídico e a hipertensão arterial. Vale ainda lembrar que a obesidade associa-se com o desenvolvimento de esteatose hepática (já é a principal causa de doença hepática crônica em adolescentes americanos) e isso também deverá ser avaliado. No gabarito oficial a banca indicou que deveria ser feita a investigação de síndrome metabólica e, diante disso, cabe lembrar que as alterações encontradas s na síndrome metabólica podem ser investigadas, mas que esse diagnóstico não pode ser estabelecido antes dos dez anos de idade. O gabarito oficial foi Síndrome metabólica, ou dislipidemias, ou hipertrigliceridemia, ou hipercolesterolemia, ou Resistência Insulínica ou diabetes tipo 2 Hipertensão arterial. Exames Glicemia de jejum Perfil lipídico (ou Triglicerídeos, Colesterol total e frações - HDL, LDL e) Função hepática (ou Alanina aminotransferase, ou TGP, ou TGO TGP).

137685.

Comentário: A avaliação do índice de massa corporal é uma avaliação bastante simples e muito utilizada na prática clínica. Porem, sabemos que esse índice talvez não seja o melhor para traduzir

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a adiposidade de um indivíduo. Outras medidas podem ser empregadas. Uma delas é a medida da circunferência abdominal. É sabido que a elevação da medida da circunferência abdominal pode ser relacionada com maior risco cardiovascular e aumento significativo da prevalência de obesidade e síndrome metabólica em adolescentes. Existe mais de uma técnica para a medida da circunferência e existem tabelas que indicam quais os valores são considerados normais nas diversas idades. Deve-se ter o cuidado de se adotar a técnica usada na confecção da tabela que será empregada. Outras medidas que podem ser feitas são as de outras circunferências e pregas, como indicado no gabarito, que foi Circunferência Abdominal deve-se marcar, inicialmente, o ponto médio entre a última costela fixa (décima) e a borda superior da crista ilíaca, local onde a fita inextensível será colocada. Essa medida serve para a avaliação indireta da gordura visceral. Prega tricipital mede-se a distância úmero-olécrano na parte lateral do braço com este fletido a 90o. No ponto médio em região posterior, pinça-se a dobra de pele com profundidade de 2cm e mede-se esta prega com auxílio de um adipômetro. Circunferência braquial mede-se a distância úmero-olécrano na parte lateral do braço com este fletido a 90o. No ponto médio em região posterior, faz-se a medida com o braço agora estendido. Prega subescapular mede-se com auxílio do adipômetro (plicômetro ou paquímetro) um prega de pele de 2cm de profundidade localizada a 2cm abaixo da escápula.

137686.

Comentário: O tratamento da obesidade infantil é um desafio para o pediatra, que depara-se a cada dia com um maior número de casos dessa condição. O tratamento deve ser centrado na abordagem dietética, modificação do estilo de vida, ajustes na dinâmica familiar, incentivo à prática de atividade física e apoio psicossocial. Em relação ao planejamento dietético, este deve ser introduzido em etapas. Na etapa 1 são feitos esclarecimentos é a etapa onde o profissional conhece os hábitos alimentares da criança, desmistifica aspectos relacionados com as mudanças alimentares, informa que não alimentos proibidos e estimula o conhecimento sobre a alimentação saudável. Na etapa 2, propor-se mudanças de comportamento, como não alimentar-se diante da TV, que sejam feitas seis refeições ao dia e que cada refeição tenha uma duração adequada. Na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

etapa 3, tem início uma diminuição gradativa na quantidade de alimentos ingeridos. Na etapa 4, a qualidade começa a ser modificada. A etapa 5, final, é a etapa de manutenção. O gabarito oficial trouxe várias dessas recomendações e foi Alimentar (qualquer três dos itens abaixo elencados) Não proibir nenhum alimento, mas restringir reduzir o consumo de alimentos muito calóricos (ricos em açúcar e gordura, como salgadinhos, biscoito recheado, fastfood, refrigerantes) restringir o uso de embutidos e o excesso de sal associar, em média, seis porções de frutas e verduras, leite semidesnatado ou derivados lácteos não gordurosos, três porções por dia associar alimentos ricos em fibras, preferencialmente os cereais integrais não prescrever alimentos light organizar o horário das refeições junto com toda a família não comer assistindo a televisão evitar líquidos em excesso durante as refeições, evitar refrigerantes orientar estas medidas para o lanche da escola. Comportamental (qualquer dois dos itens abaixo relacionados) Atividades regulares ao ar livre, como andar de bicicleta, passear no parque, jogar bola, etc. inscrever a criança em atividades regulares, como futebol, natação, capoeira etc. limitar o tempo de videogame, televisão e computador organizar o horário das refeições junto com toda a família avaliar a presença de fatores de estresse e a necessidade de psicoterapia para o binônio família orientar a mãe a não supervalorizar a alimentação nem forçar a criança a comer quando já estiver satisfeita ou comer mais quando doente.

137560.

Comentário: Pela simples análise das possíveis respostas já poderíamos inferir que esta criança tem um quadro de desnutrição. Dentre as inúmeras alterações descritas, a que mais chama a nossa atenção é a presença do edema. As formas graves de desnutrição com edema são características do quadro de kwashiorkor. O quadro de kwashiorkor é tradicionalmente aceito como sendo o resultado de uma desnutrição predominantemente proteica. São crianças que mantém aporte energético relativamente preservado, mas têm grande carência de proteínas em sua dieta. Atualmente, sabe-se que não é apenas isso que leva ao desenvolvimento de kwashiorkor, mas ainda é esta a teoria mais encontrada mesmo nos concursos. Todos os quadros de desnutrição grave com edema devem ser obrigatoriamente internado e as primeiras fases do tratamento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(estabilização e recuperação) devem ser feitos em caráter ambulatorial. Resposta letra A.

137564.

Comentário: Pelas alternativas, você reparou que se trata de uma complicação supurativa após aplicação da vacina BCG. Nesse caso, como agir Esse paciente apresenta uma linfadenopatia regional supurada de 3 cm. Devemos realizar a notificação e prescrever a ISONIAZIDA. Portanto, resposta letra D.

137700.

Comentário: O evento adverso descrito provavelmente está relacionado com a vacina DTP. O episódio hipotônico-hiporresponsivo caracteriza-se pela ocorrência de alterações do tônus, da consciência e da cor. Quando ocorre em até 48 horas após a vacina DTP, as doses subsequentes estão contraindicadas. A vacina deverá ser substituída pela DTPa (tríplice bacteriana acelular). Lembre-se de que caso a vacina esteja substituindo uma dose da pentavalente, as doses de vacina contra hepatite B e hemófilo serão feitas separadamente. Resposta letra C.

138395.

Comentário: Na profilaxia da varicela, a imunoglobulina humana antivaricela-zóster (IGHAV), obtida de plasma humano contendo títulos altos de IgG contra o vírus da varicela, está indicada na presença de três condições susceptibilidade, contato significativo e condição especial de risco - Condição especial de risco crianças ou adultos imunodeprimidos crianças com menos de um ano de idade em contato hospitalar com VVZ gestantes recém-nascidos de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos 5 últimos dias de gestação ou até 48 horas depois do parto recém-nascidos prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela recém nascidos prematuros, com menos de 28 semanas de gestação(ou com menos de 1.000g ao nascer), independentemente de história materna de varicela. - Suceptibilidade pessoas imunocompetentes e com comprometimento imunológico sem história bem definida da doença e ou de vacinação anterior pessoas com imunodepressão celular grave, independentemente de história anterior de varicela. Contato significativo contato domiciliar contínuo (permanência junto com o doente durante pelo menos uma hora em ambiente fechado contato hospitalar (pessoas internadas no mesmo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quarto do doente ou que tenham mantido com ele contato direto prolongado, de pelo menos uma hora). Geralmente as apresentações contêm 125 UI por frasco, com o volume variando de 1,25 a 2,5mL. A dose é de 125UI 10kg de peso, com dose máxima de 625UI, até 96 horas após a exposição. Resposta letra B.

138408.

Comentário: Nos preocupa o fato de uma criança que nasceu com 1.850g pesar apenas 1.900g no final do primeiro mês de vida, mas não é disso que fala esta questão. As duas vacinas feitas ao nascer são a vacina BCG e a vacina contra hepatite B. Nas crianças nascidas com menos de 2.000g, a BCG deve ser adiada até este peso ser atingido. Lembre-se de que esta vacina é feita por via intradérmica, o que é bastante difícil em uma criança com peso inferior a este ponto de corte. Já para a vacina contra hepatite B não apresenta quaisquer contraindicações. Resposta letra B.

138413.

Comentário: A definição da profilaxia antirrábica deve ser feita com base no tipo de agressão e na avaliação da situação do animal agressor. Os ferimento profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo são considerados acidentes graves. A conduta em caso de acidente grave por um cão ou gato sem suspeita de raiva no momento da agressão, como neste caso, consiste em lavar com água e sabão observar o animal durante 10 dias após exposição iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3 se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, dar continuidade ao esquema profilático, administrando o soro e completando o esquema até 5 doses aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose nos dias 14 e 28. Resposta letra A.

138589.

Comentário: A única vacina que encontra-se contraindicada em indivíduos que sejam comunicantes domiciliares de pacientes imunossuprimidos é a vacina oral contra a poliomielite. Lembre-se de que esta vacina é uma vacina composta por um microrganismo vivo atenuado e um dos eventos adversos associados é o desenvolvimento de paralisia pelo vírus vacinal. Este evento pode ocorrer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

no indivíduo imunizado e também em seus contactantes, pois o vírus vacinal é excretado nas fezes. Deste modo, esta criança não recebe a vacina oral (sabin) e faz todas as doses do esquema apenas com a vacina inativada. Todas as demais vacinas podem ser feitas sem restrições.

Resposta letra B.

31031.

Comentário: A assertiva está errada. Em relação ao diagnóstico do Diabetes Mellitus (DM) e intolerância à glicose na infância, encontramos o seguinte 1) Glicemia de jejum alterada glicemia de jejum (oito horas sem ingestão calórica) acima de 110 mg dl e abaixo de 126 mg dl. 2) Tolerância alterada à glicose glicemia de 140 a 200 mg dl aos 120min do Teste de Tolerância à Glicose oral (TTGo). 3) Diabetes mellitus sintomas típicos (perda de peso, poliúria, polidipsia) e glicemia ao acaso (qualquer horário do dia, independentemente da última refeição) maior ou igual a 200 mg dl ou glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg dl em duas ocasiões ou resposta ao TTGo com glicemia maior ou igual 200 mg dl 2 horas após a ingestão de glicose (1,75 g kg ou 75 g). Assim, o escolar descrito não pode receber o diagnóstico de DM com base na glicemia encontrada, apresentando apenas glicemia alterada de jejum. Em relação aos pontos de corte para definirmos a glicemia alterada de jejum, algumas referências consideram o limite inferior 110 mg dl, como descrito, enquanto outros consideram um ponto de corte mais baixo, definindo a alteração quando a glicemia é superior a 100 mg dl. Em relação à síndrome metabólica na infância, embora exista claramente um aumento de sua prevalência nas crianças e adolescentes, não há consenso acerca dos critérios empregados para sua definição nessa população. O departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria propõe o seguinte para a definição da síndrome metabólica em adolescentes entre 10 e abaixo de 16 anos aumento da circunferência abdominal (maior que o p90, segundo sexo e idade) associado a pelo menos duas das quatro anormalidades a seguir hipertrigliceridemia (maior ou igual a 150 mg dl baixo HDL-colesterol (menor que 40 mg dl) hipertensão arterial (sistólica maior ou igual a 130 mmHg e diastólica maior ou igual a 85 mmHg) intolerância à glicose (glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg dl, sendo recomendado o TTGo ou presença de DM tipo 2. Notem que essa tabela traz como ponto de corte o valor de 100 mg dl

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para a intolerância à glicose. De todo modo, ainda que essa classificação não se proponha a avaliar especificamente uma criança de oito anos, não seriam preenchidos os critérios mínimos para a classificação da síndrome no paciente descrito.

138737.

Comentário: Na avaliação do paciente com baixa estatura, uma das primeiras informações que devemos obter é a velocidade de crescimento. Sabemos que as crianças com velocidade de crescimento normal, como regra geral, possuem uma variante da normalidade, ou seja um quadro de baixa estatura familiar ou um quadro de atraso constitucional do crescimento e da puberdade. Nosso paciente tem atraso puberal, pois já completou 14 anos e não entrou em puberdade. Será que o diagnóstico é, então, de um retardo constitucional do crescimento e da puberdade Foi este o diagnostico da banca, porém, causa espanto uma idade óssea compatível com a idade cronológica (a pequena diferença indicada não configura um atraso), pois não seria esse o esperado para este diagnóstico. Talvez a banca tenha armado uma pegadinha... Ao indicar que o paciente tem uma idade óssea de 13,5 anos e uma idade óssea de compatível com a idade cronológica quisesse que o candidato percebesse que não havia baixa estatura, mas apenas o atraso puberal e, neste contexto, apenas um atraso constitucional é o mais comum (ainda que este costume vir acompanhado de baixa estatura...) Caso um tanto confuso, que trouxe como resposta a letra C.

138722.

Comentário: Lembre-se, antes de qualquer coisa, que esta é uma questão anterior à introdução da vacina tríplice bacteriana acelular do adulto (dTpa) no calendário das gestantes, o que só ocorreu em 2014. Em relação ao tétano, especificamente, a recomendação é de que a gestante tenha recebido 3 ou mais doses de vacina antitetânica e que a última dose tenha sido feita há menos de cinco anos. No caso apresentado, acredita-se que ela tenha 3 ou mais doses, mas a última parece ter sido feita há mais do que cinco anos (não nos foi dito se o reforço feito na adolescência foi ou não realizado...). Por esta razão, está recomendada uma dose de vacina contra o tétano. Mais uma vez não se esqueça de que desde 2014 recomenda-se que ainda que a última dose da vacina tivesse sido feita menos do que cinco anos antes da gestação, seria recomendada uma dose da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dTpa, para proteção adicional para coqueluche. Resposta letra C.

22205.

Comentário: A vitamina B12 está presente principalmente em carnes, leite e ovos. A dieta vegetariana estrita exclui qualquer alimento de origem animal de seu cardápio. Nessa situação, a mãe tem deficiência de vitamina B12 e a criança em aleitamento materno exclusivo também a terá. A grande dúvida surgida em relação a esse enunciado foi a falta de detalhes em relação à dieta materna trata-se de uma mãe vegetariana estrita (vegan), que não consome nenhum alimento de origem animal, ou trata-se de uma mãe vegetariana que não consome apenas carnes A assertiva foi considerada correta pela banca.

352183.

Comentário: A pelagra (pele agra , termo cunhado devido ao clássico aspecto cutâneo associado a esta condição) é a síndrome clínica clássica da deficiência de vitamina B3 (niacina)... Seus sinais e sintomas são lembrados pelos 3 D demência (confusão mental), dermatite (rash cutâneo hiperpigmentar e descamativo, semelhante às queimaduras solares graves, em áreas fotoexpostas - a pele tende a ficar espessa nessas regiões) e diarreia ... Além dessas alterações clássicas, pode-se observar também outras manifestações menos específicas como glossite (língua vermelha), mucosite oral global, náuseas e vômitos. Logo, dentre as opções de resposta, a única que cita alterações não esperadas no quadro de pelagra é a letra A as regiões abdominal e glútea não são áreas fotoexpostas ... Resposta letra A.

351600.

Comentário: A questão traz um paciente de 8 anos que sofreu mordedura no pé, causada por um cão saudável, que pertence ao vizinho. O Ministério da Saúde modificou recentemente o fluxograma de profilaxia da raiva humana. Assim, atualmente, em acidentes com cães ou gatos domésticos, caso o animal seja observável, a conduta inicial é a mesma, independente da gravidade do acidente lavar o ferimento com água e sabão e observar o animal por 10 dias, sem iniciar profilaxia. Vamos às alternativas Letra A correta. Como vimos, em caso de acidentes com cães e gatos domésticos observáveis, a conduta inicial será sempre a observação. Caso o animal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

permaneça sadio por 10 dias, encerrar o caso sem condutas adicionais. Letra B incorreta. Essa seria a conduta em caso de acidente grave com animal não observável. Letra C incorreta. Como vimos, não há indicação de profilaxia imediata em caso de animais passíveis de observação. Letra D incorreta. Novamente, de acordo com o fluxograma atual, não há indicação de profilaxia imediata em caso de animais passíveis de observação, seja com vacina ou soro, independente da gravidade do acidente. Resposta letra A.

334721.

Comentário: A questão traz uma paciente que sofreu mordida na mão direita, por animal silvestre. O Ministério da Saúde, em sua nota técnica de 2022, reforça que em casos de agressões por morcegos e outros mamíferos silvestres, o acidente é sempre classificado como grave. A conduta adequada é lavar o local com água e sabão, abundantemente, e iniciar imediatamente o esquema profilático com SAR ou IGHAR e a administração de 4 (quatro) doses de vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular (IM) ou 4 (quatro) doses nos dias 0, 3, 7 e 14 pela via intradérmica (ID). De fato, de modo geral, mordeduras em extremidades (cabeça, mãos, pés) ou em mucosas, são consideradas graves. Porém, como vimos, o simples fato de uma mordedura ser por animal silvestre já permite a classificação como grave, independente da classificação. De acordo com o MS, frente a uma possível exposição ao vírus da raiva, não se recomenda a sutura dos ferimentos - quando absolutamente necessário, deve-se aproximar as bordas com pontos isolados. Assim, a afirmativa I está correta e a afirmativa III está incorreta. A afirmativa II é polêmica, dentro do contexto dado pela questão (animal silvestre). A banca considerou a afirmativa correta, e não aceitou recursos.

334722.

Comentário: Acerca das vacinas, vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. A vacina da influenza é do tipo inativada, não havendo contraindicações para pacientes com imunodeficiência. Letra B incorreta. As vacinas de vírus vivos atenuados estão contraindicadas para um grupo restrito de pessoas como imunodeficientes e gestantes. Os cardiopatas podem recebê-las sem qualquer risco. Letra C correta. Os profissionais de saúde devem estar com a caderneta de vacinação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

atualizada para proteção própria e também de seus pacientes. Letra D incorreta. Os pacientes esplenectomizados não são considerados como imunodeficientes e podem, portanto, receber as vacinas indicadas pelo calendário nacional. Estes pacientes, inclusive, apresentam risco maior de infecções por germes encapsulados, devendo estar imunizados, principalmente, para estes agentes. Resposta letra C.

321162.

Comentário: A questão apresenta um erro, segundo as novas atualizações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e, por tal motivo, foi corretamente anulada. Vejamos cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. Segundo recente atualização (2022), a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). A letra B está correta. A vacina disponibilizada pelo PNI é do tipo quadrivalente, garantindo proteção contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18. A letra C está correta. A vacina deve ser administrada em 2 (duas) doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre elas. E por fim, a letra D também está incorreta. Indivíduos de 9 (nove) a 45 anos de idade , vivendo com HIV Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos, devem receber 3 (três) doses da vacina com intervalo de 2 (dois) meses entre a primeira e segunda dose e 6 (seis) meses entre a primeira e terceira dose (0, 2 e 6 meses). Por conter duas alternativas incorretas, a questão foi corretamente anulada pela banca.

320433.

Comentário: A questão deseja saber qual a alternativa correta com relação à vacinação durante o pré-natal. Vamos analisar cada uma delas Letra A correta. A vacinação contra hepatite B é recomendada para todas as gestantes não imunizadas. Letra B incorreta. A vacina contra raiva é composta por vírus inativado e pode ser utilizada durante a gravidez em situações pós-exposição. Letra C incorreta. A vacina para sarampo é composta por vírus vivo atenuado, sendo contraindicada na gestação. Letra D incorreta. A vacinação contra a rubéola é contraindicada durante a gravidez, por ser composta de vírus vivo atenuado. Letra E incorreta. O Ministério da Saúde recomenda que toda gestante, independentemente da idade gestacional, seja vacinada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

contra influenza durante a campanha anual. Resposta letra A.

334733.

Comentário: Todas as feridas decorrentes de mordedura devem ser inicialmente limpas abundantemente e realizada hemostasia. Em relação a sutura, no geral não está indicada devido ao risco de contaminação por bactérias da boca do animal agressor. No entanto, algumas referências preconizam que quando a lesão é em área de importância estética, como a face, a ferida deve ser debridada e suturada por planos. Além disso, a profilaxia antibiótica deve ser iniciada. Resposta letra C.

346854.

Comentário: Estamos diante de um adolescente de 13 anos que recebeu a última vacina aos 10 anos. Tem registro de duas doses da vacina hepatite B, duas doses da vacina tríplice viral e a última dose da tríplice-bacteriana aos seis anos. Devemos, então, completar o esquema da vacinação contra hepatite B, além de orientar sobre a HPV (uma dose agora e outra em seis meses) e meningo ACWY (é oferecida uma dose entre 11 e 12 anos). Não há necessidade da dupla adulto, visto que ainda não completou 10 anos da última dose. Resposta letra B.

346855.

Comentário: A BCG quase sempre deixa uma cicatriz característica, com até 1 cm de diâmetro, no local em que foi aplicada como rotina, no braço direito. Essa reação é esperada A resposta à vacina demora cerca de três meses (12 semanas), podendo se prolongar por até seis meses (24 semanas), e começa com uma mancha vermelha elevada no local da aplicação, evolui para pequena úlcera, que produz secreção até que vai cicatrizando. A revacinação de crianças que não desenvolveram cicatriz deixou de ser recomendada pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2019. Resposta letra B.

320442.

Comentário: Os anticorpos da classe IgG atravessam a placenta a partir da 13ª semana de gestação e principalmente no 3º trimestre podem conferir proteção passiva até aproximadamente os 12 primeiros meses de vida, sendo de grande importância neste período de resposta humoral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ainda relativamente ineficiente no lactente. São vacinas indicadas durante a gestação influenza, hepatite B e tétano e coqueluche. A vacina influenza é recomendada para toda gestante, a cada gravidez, em qualquer fase gestacional, preferencialmente no período que antecede a temporada de circulação do vírus na região. A imunização protege a mãe, que tem maior risco de complicações na gestação, e o bebê nos primeiros meses após o nascimento, quando as crianças estão em maior risco de hospitalização e óbito. A vacina dTpa (difteria, tétano e pertussis acelular) está recomendada para todas as gestantes após a 20ª semana de gestação em gestantes com história vacinal incompleta ou desconhecida para tétano, deve ser aplicada também a vacina dT (uma ou duas doses, dependendo do histórico), sendo a dTpa aplicada após a 20ª semana para completar o esquema de três doses. A vacinação de rotina com dTpa durante a gestação reduz em cerca de 90% o risco da criança contrair a coqueluche nos primeiros meses de vida. A vacina contra hepatite B deve ser aplicada em gestantes sem vacinação prévia ou com esquema incompleto, para totalizar três doses. Algumas outras vacinas podem ser consideradas durante a gestação em algumas circunstâncias, mas não são recomendadas de rotina pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) hepatite A B, meningocócicas C e ACWY, meningocócica B e febre amarela. Não existem dados de segurança em relação às vacinas meningocócicas durante a gestação, mas podem ser recomendadas em situações específicas de alto risco. As vacinas pneumocócicas podem ser consideradas em gestantes com comorbidades, como doença cardíaca ou pulmonar crônica, diabetes, hemoglobinopatias, dentre outras. Já as vacinas tríplice viral, varicela, HPV e dengue são contraindicadas na gestação a vacina contra rotavírus não é recomendada em adultos ou crianças acima de sete meses e 29 dias. Resposta letra E.

335092.

Comentário: Essa questão deseja saber qual é a alternativa correta em relação às vacinas na gestação. Vamos analisar cada uma delas Letra A correta. A vacina dTpa deve ser administrada a partir de 20 semanas em todas as gestações. Letra B incorreta. A vacina da gripe pode ser realizada em qualquer trimestre da gestação. Letra C incorreta. A vacina tríplice viral, de vírus atenuado, é contraindicada durante a gestação. Letra D incorreta. A vacina contra febre amarela

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não é recomendada na gestação podendo ser realizada por gestantes que irão viajar para zonas endêmicas, avaliando risco benefício. Resposta letra A.

336284.

Comentário: De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria devemos recomendar a triagem lipídica para crianças e adolescentes abaixo de 2 anos não há recomendação de triagem entre 2 e 8 anos realizar triagem apenas se a criança apresentar algum fatores de risco (história familiar de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica em homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos, história familiar de hipercolesterolemia com colesterol total 240mg dl ou história familiar desconhecida, além de outros fatores de risco cardiovascular como hipertensão, diabetes melito, tabagismo passivo, ou obesidade com IMC 95%) (letras C e D erradas) entre 9 e 11 anos realizar a triagem para todas as crianças (letra B certa) entre 12 e 16 anos realizar a dosagem de dois perfis lipídicos em jejum (com pelo menos duas semanas de intervalo entre as dosagens, mas em menos de 12 semanas entre uma dosagem e outra) e realizar uma média com os valores apenas na presença de história familiar positiva, ou um novo fator de risco (letra A errada) entre 17 e 21 anos realizar nova triagem universal. Resposta letra B.

346871.

Comentário: Dentre as doenças que estão listadas nas alternativas, a única que não possui vacina específica, é a hepatite C (letra C incorreta). A poliomielite é prevenida através da administração da vacina inativada contra a poliomielite (VIP), administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade e da vacina oral contra a poliomielite (VOP), administrada como reforço aos 15 meses e 4 anos de idade (letra A correta). A vacina contra a febre amarela é realizada aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos de idade (letra B correta). A vacina contra a coqueluche é administrada junto a vacina penta, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com reforço aos 15 meses e 4 anos de idade (letra D correta). Resposta letra C.

334763.

Comentário: A questão aborda aspectos relacionados à vacinação de crianças e adolescentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Sobre este tema, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. Atualmente, não há recomendação de revacinar crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentam cicatriz vacinal, independentemente do tempo transcorrido após a vacinação. A letra B está incorreta. A primeira dose pode ser administrada a partir de 1 (um) mês e 15 dias até 3 (três) meses e 15 dias. A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 (três) meses e 15 dias até 7 (sete) meses e 29 dias. A letra C está incorreta. A vacina contra a febre amarela é indicada para crianças entre 9 (nove) meses de vida a menores de 5 (cinco) anos de idade. Deve-se administrar uma dose aos 9 (nove) meses de vida, e uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade. A letra D está correta. A vacina DTP é indicada como reforço, o primeiro aos 15 meses de idade e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade. A vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade (seis anos, 11 meses e 29 dias). Na indisponibilidade da vacina DTP, como reforço administrar a vacina penta. Resposta letra D.

306713.

Comentário: O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), recomenda que a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) seja administrada em meninas de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meninos de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) em duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Resposta letra D.

291938.

Comentário: Pelo gabarito divulgado pela banca, subentende-se que a criança recebeu a vacina BCG e Hepatite B. É claro que sempre temos que confirmar a situação vacinal olhando a caderneta, e não pelo simples relato dos pais Infelizmente, quando os responsáveis não possuem o documento que comprova o recebimento de vacinas, temos que considerar a criança não imunizada e administrar todas as vacinas recomendadas até a idade atual. A única exceção é a BCG, que podemos utilizar como comprovação a cicatriz em região deltoidea do braço direito (quando o paciente desenvolve a cicatriz). De todo modo, considerando que essa criança já recebeu as vacinas do nascimento, temos que recomendar as vacinas dos 2, 3, 4 e 5 meses. De acordo com PNI do Ministério da Saúde, as vacinas são - 2 meses pentavalente, VIP e rotavírus e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pneumocócica 10 valente - 3 meses meningocócica C - 4 meses pentavalente, rotavírus e pneumocócica 10 valente - 5 meses meningocócica C É importante lembrar que a 1 dose da vacina contra o rotavírus deve ser feita até no máximo 3 meses e 15 dias, e a 2 dose deve ser feita até 7 mesese 29 dias, por isso tal vacina não está indicada nesse momento. Cabe a ressalva que deve-se respeitar no mínimo 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose de todas as vacinas. Resposta letra D.

304877.

Comentário: Felipe recebeu, corretamente, todas as vacinas que deveria ter recebido até os quatro meses de idade. Não foram feitas, ainda, as vacinas recomendadas aos cinco meses (meningocócica C) e aos seis meses (penta e VIP). Lembre-se de que são feitas apenas duas doses da vacina pneumocócica 10-valente, aos dois e quatro meses, e um reforço aos 12 meses. Além disso, a partir dos seis meses, as crianças já podem receber a vacina contra influenza durante as campanhas (não sabemos se na ocasião do atendimento estaríamos ou não na fase da campanha, mas não haveria uma opção de resposta possível além do gabarito). Deste modo, as vacinas indicadas estão corretamente citadas na reposta letra D.

291956.

Comentário: O exame dos contactantes de um caso de tuberculose deve sim ser feito, porém, nem todos os contactantes necessitam de tratamento, seja da TB doença, seja da ILTB. Apenas os contactantes com infecção confirmada necessitarão de tratamento... Como as demais são conceituais e corretas, resposta C.

257360.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A) CORRETA A BCG é administrada em dose única, logo após o nascimento. B) ERRADA Alternativa mais absurda de todas Não há sentido algum aplicar a vacina após a doença, pois ela tem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra a doença. Mas para fins didáticos, vale lembrar que vacina contra a febre amarela é administrada em dose única, aos 9 meses de idade, para todo o território nacional. C) CORRETA As 3 doses da vacina contra a polimielite são feitas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com a sua forma inativada, a VIP, aos 2, 4 e 6 meses de idade, enquanto as doses de reforço e campanha são feitas com a sua forma atenuada, a VOP. D) CORRETA A segunda dose da vacina contra o rotavírus deve ser administrada de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias, respeitando um intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses, não devendo ser administrada fora destes prazos recomendados. Resposta letra B.

287349.

Comentário: Em relação ao desenvolvimento pôndero estatural, mesmo que a banca não tivesse fornecido os percentis, temos alguns valores esperados para o final do primeiro ano de vida - relação ao peso de nascimento, é esperado que a criança triplique aos 12 meses e ganhe em torno de 25 cm neste mesmo período. Note que a criança cresceu até mais do que isso (alternativas C e D incorretas). Consideramos como peso adequado para a idade crianças entre 0 e 10 anos que se situam entre os escores Z - 2 e Z 2 (alternativa A incorreta). Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, como sempre um tema controverso - as principais referências falam que aos 12 meses, a criança fala outras palavras além de mama e papa e que anda com uma das mãos apoiadas. A criança parece ter um bom desenvolvimento, apresenta alimentação adequada e, sendo a alternativa B realmente a mais correta. Resposta letra B.

287865.

Comentário: A vacina pentavalente contempla a cobertura para cinco doenças DTP (difteria, tétano e coqueluche), hemófilos tipo B e hepatite B. A VIP é a vacina inativada contra a poliomielite. É feita por via intramuscular e possui como desvantagens o fato de não impedir a propagação do vírus selvagem por via intestinal, não proteger os comunicantes dos vacinados e ser mais cara do que a vacina oral (VOP). E, finalmente, a VORH é a vacina oral contra o rotavírus humano, que tem por objetivo impedir casos graves de diarreia em menores de 5 anos de idade. Resposta letra D.

287866.

Comentário: Sabemos que de acordo com as diretrizes atuais, a vacina de febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a maioria das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo, exceto com as vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

rubéola) ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) em crianças menores de 2 anos de idade. Neste caso, deve ser respeitado o intervalo de 30 dias entre as duas vacinas. Resposta letra A.

287900.

Comentário: A questão nos pede para avaliar três partes de uma sentença a 1 parte está correta sabemos que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e complementado até os 2 anos protege a criança contra o desenvolvimento da obesidade. Além disso, o cuidado com os alimentos complementares, tanto em relação à idade de introdução quanto à qualidade desses alimentos também contribuem para a instalação e manutenção da obesidade na infância. O leite de vaca também está entre os fatores de risco para o excesso de peso e fome oculta, visto sua composição nutricional não ser adequada para essa faixa etária. A 2 parte está correta A obesidade é fator de risco para todas essa doenças hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2, na denominada síndrome metabólica, na qual a resistência insulínica e a hiperinsulinemia explicam a relação entre a obesidade e as demais anormalidades. Doenças cardiovasculares, alteração da resposta imunológica, doenças degenerativas e alguns tipos de câncer também estão relacionados. Além disso, a obesidade é a causa mais comum de cálculo biliar em crianças sem outras condições predisponentes (anemia hemolítica, história de uso de nutrição parenteral). A 3 parte está correta o sedentarismo está claramente envolvido na obesidade, por isso criar o hábito de vida ativo na infância reduz a incidência de obesidade e doenças cardiovasculares na idade adulta. A atividade física também pode exercer outros efeitos benéficos a longo prazo, como aqueles relacionados ao aparelho locomotor. A atividade física favorece um aumento da massa óssea na adolescência e pode reduzir o risco de aparecimento de osteoporose em idades mais avançadas, principalmente em mulheres pós-menopausa. Portanto, a sentença está totalmente correta. Resposta letra A.

255624.

Comentário: A questão não nos diz se está perguntando sobre o calendário vacinal do PNI do Ministério da Saúde ou da SBIM SBP, logo coube recurso, pois pelo PNI, aos 12 meses a criança deve receber a 1ª dose da vacina contra o sarampo sob a forma de tríplice viral (sarampo, caxumba

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e rubéola) e aos 15 meses deve receber a 2ª dose sob a forma tetra viral, que inclui a varicela. Pela SBIM, aos 12 meses e aos 15 meses a criança deverá receber a vacina contra varicela com sarampo, caxumba e rubéola, seja sob a forma separada (tríplice viral varicela), seja sob a forma de tetra viral. A vacina contra febre amarela é recomendada a partir dos 9 meses rotineiramente e não apenas para residentes ou viajantes para determinadas áreas. A 1ª dose da hepatite B é recomendada ao nascer, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Crianças sem a cicatriz da BCG após 6 meses da aplicação da vacina não precisam mais ser revacinadas. Essa é uma orientação recente e muito importante nas provas. Como coube recurso, a questão não apresenta resposta totalmente correta. Se ela dissesse se tratar do calendário vacinal da SBIM, a alternativa B estaria correta.

232113.

Comentário: Vamos analisar como se dá a disseminação do vírus rábico no organismo a partir do ponto de inoculação à luz do Portal do Ministério da Saúde A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura, arranhadura, lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso centra (sentido centrifugo). A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica (sentido centrípeto) e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Ou seja, exatamente como descrita na letra E, nosso gabarito.

227095.

Comentário: Vamos analisar as alternativas referentes a vacinação. A- CORRETA A vacina contra Haemophilus (Hib) faz parte da pentavalente, indicada aos dois, quatro e seis meses de idade. B- INCORRETA A contraindicação é para as crianças nascidas com menos de 2.000 g, devendo a vacina ser adiada até que este peso seja atingido. C- CORRETA Segundo o calendário do Ministério da Saúde, a primeira dos, aos 12 e 15 meses. D- CORRETA A vacina é recomendada tanto para as meninas, quanto para os meninos, sendo que neste último é oferecida de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234427.

Comentário: Questão de imunização com várias informações para revisarmos. A BCG deve ser dada assim que a criança nasce, desde que ela tenha mais de 2Kg, e pode ser dada até 4 anos 11 meses e 29 dias. A ausência de cicatriz vacinal atualmente não exige nova dose da BCG. A vacina oral contra o rotavírus humano é produzida a partir de cepas atenuadas do vírus e possui apenas um sorotipo (G1P8). A primeira dose deve ser administrada entre 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias de vida. A segunda dose deve ser dada entre 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Deve-se manter o mínimo de 4 semanas entre as doses. A vacina quadrivalente do HPV está disponível no PNI em duas doses, no esquema de 0 e 6 meses, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. A vacina de febre amarela não pode ser administrada simultaneamente com a tríplice viral ou tetra viral em menores de 2 anos, estando indicado um intervalo de 30 dias entre as vacinas. Resposta correta Letra B.

227271.

Comentário: A dTpa deve ser administrada a cada gravidez, visto que os anticorpos possuem curta duração. Portanto, a vacinação durante uma gravidez não manterá alto nível de anticorpos protetores em gestações subsequentes. Desde janeiro de 2017, o Ministério da Saúde recomenda a dTpa a partir da 20ª semana, mesmo em mulheres com esquema vacinal completo e recente. Mulheres, por outro lado, que nunca foram vacinadas para o tétano devem receber duas doses de dT e a terceira será uma dTpa. Resposta letra B.

243022.

Comentário: A contraindicação é entendida como uma condição do usuário a ser vacinado que aumenta, em muito, o risco de um evento adverso grave ou faz com que o risco de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença contra a qual se deseja proteger. Para todo imunobiológico, consideram-se como contraindicações a ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior e história de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos. São situações que devem ser avaliadas em suas particularidades para a indicação ou não da vacinação Usuários que fazem uso de terapia com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

corticosteroides devem ser vacinados com intervalo de, pelo menos, três meses após a suspensão da droga (é considerada imunossupressora a dose superior a 2 mg kg dia de prednisona ou equivalente para crianças e acima de 20 mg kg dia para adultos por tempo superior a 14 dias) Como a criança faz corticoide em dose imunossupressora, as vacinas de vírus vivos atenuados estão contraindicadas. Logo, não devemos recomendar a aplicação da vacina tetraviral, febre amarela e a vacina BCG (letras B, C, D e E errads). Resposta letra A.

243030.

Comentário: Vacinas vivas atenuadas, de um modo geral, não devem ser administradas em imunossuprimidos pois os micro-organismos, mesmo atenuados, podem provocar doença nessa população específica. Isso inclui as seguintes vacinas BCG, rotavírus, poliomielite oral, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), febre amarela e varicela. BCG é uma sigla que significa Bacilo de Calmette Guérin, sendo a vacina composta por cepa de Mycobacterium bovis atenuada com glutamato de sódio é digno de nota que crianças verticalmente expostas ao HIV, mesmo que tenham de fato sido infectadas pelo HIV na gestação, podem receber a imunização no momento do nascimento pois ainda não houve tempo hábil para uma imunodeficiência se instalar (as crianças com sinais de imunodeficiência ou com mais de 5 anos de idade não devem ser vacinadas). Corticoterapia em doses elevadas, quimioterapia e radioterapia também são contraindicações à BCG (a vacina deverá ser adiada até 3 meses após a suspensão da medicação imunossupressora). As vacinas não vivas ou inativadas não conferem risco para imunossuprimidos. Fazem parte desse grupo hepatite A e B, anti-hemófilos, poliomielite injetável, tríplice bacteriana, Influenza, anti-pneumocócica, anti-meningocócica, e vacina contra o HPV. Gabarito letra C.

246394.

Comentário: Questão que nos pediu uma condição favorável para o aparecimento de surtos de febre amarela. Vamos, então, relembrar algumas deslocamento, por motivos diversos, de pessoas susceptíveis para a área endêmica de febre amarela silvestre (letra A - INCORRETA) abundância de vetores, frequentemente relacionada a fatores meteorológicos, como o calor somado às chuvas (letra B - INCORRETA) baixa cobertura vacinal da população residente nas áreas endêmicas e de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transição para febre amarela silvestre (letra D - CORRETA) presença de primatas que, por apresentar alta viremia, são verdadeiros amplificadores e disseminadores do vírus, embora não possam transmitir a doença diretamente aos homens (letra C - INCORRETA) aparecimento de macacos mortos sem causa determinada. Resposta letra D.

246803.

Comentário: O escorbuto é a doença causada pela deficiência de vitamina C (ácido ascórbico), uma substância fundamental para o funcionamento das células, particularmente do tecido conjuntivo. As principais fontes dessa vitamina são as frutas cítricas e hortaliças verdes. Os sintomas iniciais do escorbuto são inespecíficos e incluem irritabilidade, anorexia, febre baixa, taquipneia. Um sintoma que chama a atenção é a hipersensibilidade dolorosa nos membros inferiores, notada principalmente nas trocas de fralda. Ela se deve à hemorragia subperióstea e faz com que a criança assuma uma posição antálgica característica, chamada de posição de rã (joelhos e quadris fletidos com a coxa rodada externamente). Outra alteração característica são as hemorragias gengivais, principalmente acima dos incisivos centrais superiores. Resposta letra A.

199568.

Comentário: Tema frequente em prova. Para saber as indicações de profilaxia para raiva, precisamos analisar 2 fatores as condições do animal agressor e o tipo de exposição. Confira nas imagens em anexo as situações possíveis. Infelizmente, esta tabela precisa ser decorada para a prova. Vamos analisar a situação do paciente em questão o acidente é considerado grave por causa da localização da lesão (mão), mas não há suspeita de raiva no momento da agressão. Nesta situação, seguindo o protocolo, devemos iniciar o esquema com vacina no dia do acidente e no 3º dia após a lesão, além de observar o animal por 10 dias. Se a suspeita de raiva for descartada, encerrar o caso e não administrar outras doses da vacina. Se o animal morrer, sumir ou desenvolver sintomas de raiva, administramos o soro antirrábico além de completar o esquema com mais 2 doses da vacina, uma entre o 7º e o 10º dia e outra no 14º dia. Agora, atenção para o detalhe se o animal agressor for doméstico, sem nenhuma suspeita de raiva, com histórico vacinal completo, como é o caso do animal em questão, está permitido apenas observar o animal, sem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

indicar a profilaxia com a vacina inicialmente, indicando apenas se o animal morrer, desaparecer ou desenvolver sintomas de raiva. Por isso, resposta letra C.

202747.

Comentário: Vamos relembrar algumas características sobre a Raiva A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e ou lambedura desses animais. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. O período de incubação está relacionado à localização, extensão e profundidade da mordedura, arranhadura, lambedura ou tipo de contato com a saliva do animal infectado da proximidade da porta de entrada com o cérebro e troncos nervosos concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral. Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença (período de transmissibilidade). A morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas (E correta e B e C incorretas). Não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus em animais silvestres. Entretanto sabe-se que os quirópteros (morcegos) podem albergar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente (A, e D incorretas). Ou seja, apenas a única assertiva correta é a letra E.

199501.

Comentário: Vejamos as alternativas A) Incorreta. É recomendável monitorar o nível de proteção destes pacientes através de testes sorológicos de 2 a 4 semanas após a vacinação, quando se atinge o nível máximo. Se o nível de anticorpos estiver abaixo ao considerado de proteção, ou seja, 0,5UI mL, uma dose de reforço deve ser administrada. B) Correta. Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 2-3 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença (período de transmissibilidade). A morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas. C) Correta. A raiva é de extrema

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

importância para saúde pública, devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras. Frente a uma possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão, ou outro detergente, o que contribui na diminuição do risco de infecção, devendo ser realizado o mais rapidamente possível após a agressão e, após, deve-se buscar imediatamente assistência médica, para avaliação e, se necessário, aplicação de vacina e soro antirrábico. D) Correta. São considerados ferimentos graves Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mãos, polpas digitais e ou planta do pé Ferimentos profundos,múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo Lambedura de mucosas Lambedura de pele onde já existe lesão grave Ferimento profundo causado por unha de animal. Resposta letra A.

199502.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) CORRETA A vacina BCG é constituída pelo Mycobacterium bovis atenuado e aplicada por via intradérmica. B) CORRETA A vacina tríplice viral é constituída por agentes vivos atenuados, sendo contraindicada em indivíduos portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida. C) ERRADA A primeira dose da vacina oral contra o rotavírus pode ser administrada de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias de vida. Até então, ela está correta. No entanto, não existe nenhuma interferência se for aplicada em conjunto com a vacina conjugada contra o meningococo C. Por esta afirmação, a alternativa está incorreta. D) CORRETA Perceba que a questão pediu o intervalo mínimo e não o que é realizado no calendário vacinal. Deve-se respeitar um intervalo de 4 semanas entre as doses, além dos prazos recomendados de aplicação de cada uma delas. Resposta letra C.

199554.

Comentário: Na gestação são contraindicadas as vacinas de vírus vivo atenuado devido ao risco teórico de contaminação fetal, como sarampo, caxumba e varicela. A raiva é uma vacina de vírus inativado e segura na gestação, portanto pode ser administrada. Vale ressaltar que, mesmo que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não fosse, a raiva é uma doença tão grave que a vacina não deveria ser evitada devido ao risco potencial de transmissão para o feto. Resposta letra D.

220300.

Comentário: Após a aplicação da vacina BCG na inserção inferior do músculo deltoide direito, é esperado o surgimento de algumas alterações no local, que costumam evoluir entre seis e 12 semanas da seguinte forma após 3 a 4 semanas da aplicação surge um nódulo no local entre 4 a 5 semanas o nódulo evolui para uma pústula em seguida evolui para uma úlcera de 4 a 10 mm de diâmetro entre 6 a 12 semanas finalmente, forma-se uma crosta. Durante a evolução dessa lesão, pode ocorrer o enfartamento ganglionar axilar (também supra ou infraclavicular), não supurado, que desaparece espontaneamente e não necessita de tratamento medicamentoso e ou cirúrgico. Esse gânglio é homolateral ao local da aplicação, firme, móvel, clinicamente bem perceptível, frio, indolor, medindo até 3 cm de diâmetro, e não é acompanhado de sintomatologia geral. Desaparece espontaneamente, sem necessidade de tratamento (letra C errada). Para recém-nascidos com peso inferior a 2 kg a vacina está contraindicada. Além disso, imunodeficiências congênitas e adquiridas são contraindicações absolutas. Resposta letra C.

212927.

Comentário: A obesidade infantil é uma enfermidade que pode desenvolver-se desde os primeiros meses de vida, definida pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo, de origem multifatorial, cujo desenvolvimento sofre influência de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos. O desenvolvimento da obesidade origina-se de um desequilíbrio energético que ocorre quando o número de calorias consumidas é superior ao número de calorias utilizadas para a obtenção de energia, ocasionando ganho ponderal. Além do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, a inatividade física também é um fator determinante, que juntamente com a ingestão excessiva de calorias, correspondem de 95 a 98% dos fatores exógenos associados ao ganho de peso. E em menor proporção, os autores consideram distúrbios pré-existentes como fatores endógenos (5%) para o desencadeamento da obesidade. Dentre seus principais fatores de risco, quatro fatores estão expostos nas opções da questão, exceto o sexo. Não há predisposição ou maior prevalência

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

no sexo feminino ou masculino para a enfermidade descrita. Resposta letra E.

196802.

Comentário: Vamos avaliar cada afirmativa 1ª Verdadeira. A fase intrauterina é um período crítico para o desenvolvimento da obesidade, assim como o primeiro ano de vida e a adolescência. 2ª Falsa. O lazer passivo deve ser limitado e atividades físicas devem ser estimuladas por pais e pediatras. A Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece que o tempo de tela deve ser limitado a 2 horas em crianças e adolescentes de 6 a 19 anos. 3ª Verdadeira. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e a manutenção da amamentação até os 2 anos de idade tem sido associado a menores taxas de obesidade na vida adulta. 4ª Falsa. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de produtos light e diet rotineiramente em crianças, com a finalidade de redução calórica. 5ª Verdadeira. Frutas e hortaliças são importantes elementos de uma dieta saudável e seu consumo em quantidade adequada pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Estimativas indicam que o consumo inadequado de frutas e hortaliças está entre os dez principais fatores de risco para a carga total global de doença em todo o mundo. Considera-se suficiente o consumo mínimo de 400 g de frutas e hortaliças diariamente, o que equivale a cinco porções desses alimentos. Resposta Letra D.

212931.

Comentário: O zinco é um mineral que se encontra amplamente distribuído em todo o corpo humano. Apesar da quantidade, a sua deficiência está relacionada a quadros patológicos graves que surgem em sua grande maioria em função da deficiência alimentar, presença de compostos quelantes nos alimentos, distúrbios no processo de absorção gastrointestinal ou aumento na excreção urinária. Em algumas fases da vida, as necessidades deste mineral estão aumentadas, como na gestação, infância e puberdade. As pessoas raramente consomem muito zinco. Geralmente, o excesso de zinco ocore pelo consumo de alimentos ácidos ou de bebidas enlatadas em recipientes com revestimento de zinco (galvanizadas). Em certas indústrias, a inalação de vapores de óxido de zinco pode resultar em excesso de zinco. No caso do excesso de zinco, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos e diarreia. A inalação de vapores de óxido de zinco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pode causar respiração rápida, sudorese, febre e um gosto metálico na boca, uma doença chamada febre do fumo metálico. O consumo excessivo e prolongado de zinco pode reduzir a absorção de cobre, provocar anemia e afetar o sistema imunológico. Resposta letra B.

212945.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) CORRETA O calendário proposto para o prematuro deve ser seguido de acordo com a idade cronológica do bebê. A vacina BCG é a única que pode sofrer atraso, pois não deve ser feita em recém-nascidos com menos de 2 kg. B) CORRETA Vacinas de virus vivo não devem ser feitas em ambiente intrahospitalar, pois existe risco de disseminação viral, em um meio de pacientes muitas vezes com imunidade comprometida. C) ERRADA Esta é uma grande questão na vacinação de prematuros, dada as limitações na resposta humoral e celular dos bebês pré-termo. D) CORRETA A vacina acelular deve ser priorizada neste grupo de pacientes. E) Correta. Não apenas em prematuros, mas em qualquer recém-nascido, a vacinação deve ser adiada em casos de instabilidade hemodinâmica ou infecções graves. Resposta letra C.

199617.

Comentário: Esta questão aborda as medidas de profilaxia pós-exposição a um caso de varicela. Sabemos que existem duas estratégias de prevenção que podem ser adotadas nestes casos vacinação de bloqueio ou uso de imunoglobulina humana antivaricela-zóster. A vacina, para fins de bloqueio, pode ser feita a partir dos nove meses de idade, salvo contraindicações, como a gestação ou imunodepressão (a vacina é composta por micro-organismos vivos atenuados). O uso de corticoide inalatório, como neste caso, não representa uma contraindicação, pois não leva à imunodepressão. A recomendação é de que a vacina seja feita até o quinto dia após exposição (devendo ser, preferencialmente, feita até o terceiro dia). A imunoglobulina, por sua vez, deve ser feita até 96 horas após a exposição e é usada especialmente para os imunodeprimidos e grávidas suscetíveis que tiveram contato com um caso de varicela (seja numa situação de exposição hospitalar ou de exposição domiciliar). A imunoglobulina também é indicada para os recém-nascidos prematuros que tiverem contato com um caso de doença (neste caso avaliar a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

idade gestacional de nascimento e a história materna de doença) e para os recém-nascidos de mulheres com quadro de varicela de cinco dias antes até dois dias após o parto. No nosso caso, temos uma criança de 13 meses que não recebeu nenhuma dose de vacina contra varicela (pelo Ministério da Saúde, a primeira dose é feita apenas aos 15 meses) e que deve ser considerada suscetível. Para sua proteção, pode ser recomendada a vacina de bloqueio. Cabe indicar que, pelo Ministério da Saúde, a vacina não seria fornecida para este paciente (é feita apenas para controle de surtos em ambiente hospitalar e, mais recentemente, passou a ser feita para controle de surtos em creches). Ainda assim, sequer havia a opção de não se fazer nada... Resposta letra C.

196765.

Comentário: Toda criança nascida de mãe com tuberculose durante a gestação e no momento do parto deve ser clinicamente avaliada no sentido de excluir doença ativa. Após a exclusão, recomenda-se a quimioprofilaxia primária ou tratamento da infecção latente. O RN não deverá ser vacinado com a BCG ao nascer e receberá a isoniazida por três meses. Após esse período, faz-se a prova tuberculínica (PT). Se o resultado for 5 mm, a isoniazida deve ser mantida por mais três a seis meses. Caso a PT 5 mm, a medicação deve ser interrompida e a vacinação para BCG efetuada. Resposta letra A.

199582.

Comentário: A questão abordou alguns conceitos bem diretos sobre o tema obesidade infantil, mas, por não se basear das classificações propostas pelo Ministério da Saúde, acabou sendo anulada. Vejamos cada uma das opções. A opção A está inquestionavelmente errada o diagnóstico de obesidade é determinado pela avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), mas, na infância e adolescência, não usamos um ponto de corte único, mas sim os valores dos percentis ou escore-Z. A opção B também está errada entende-se que a etiologia da obesidade é multifatorial. A causa mais comum de obesidade na infância e adolescência é a obesidade exógenas. Ainda que exista um componente genético, não é este o único determinante do distúrbio. A associação de alimentação hipercalórica e sedentarismo excessivo é a principal responsável pelo distúrbio energético positivo que leva ao aumento do peso. A opção C está errada diversas síndrome

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

genéticas cursam com obesidade e a síndrome de Prader-Willi é um exemplo clássico. Porém, a síndrome de Williams-Beurem não é. Esta é caracterizado por alterações cardíacas, sendo as mais frequentes a estenose aórtica e pulmonar, dismorfias faciais (nariz arrebitado, ponte nasal achatada, região orbital profunda, macrostomia, lábio inferior volumoso, bochechas proeminentes e filtro nasal longo) e características de personalidade, cognição e linguagem. A opção D foi considerada correta pela banca e era o gabarito original. Tal afirmativa está, de fato, correta se levarmos em conta a proposta de classificação do CDC, encontrada no Nelson, Tratado de Pediatria. Segundo esta referência, as crianças maiores de dois anos com IMC entre os percentis 85 e 95 têm sobrepeso já aquelas com percentil maior ou igual ao 95, têm obesidade. Não é o isso o que diz o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo estas fontes, abaixo de cinco anos, o IMC maior que escore-Z 1 (percentil 85) e menor ou igual a 2 (percentil 97) indica risco de sobrepeso maior que 2 e menor ou igual a 3 (percentil 99,9) indica sobrepeso maior que 3 indica obesidade. Lembre-se de que, a partir dos cinco anos, as mesmas faixas indicam, respectivamente, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Deste modo, a questão acabou por ser anulada.

215144.

Comentário: Diante de um lactente de 7 meses, espera-se que ele tenha recebido a seguintes vacinas BCG (dose única), hepatite B (ao nascer e em conjunto com a pentavalente), anti-polio (com a forma VIP, 3 doses), pentavalente (DTP Hib HepB, 3 doses), rotavírus oral (VORH, 2 doses), pneumocócica 10 valente (2 doses) e meningococo C (2 doses). Primeiro, acho desnecessário as bancas fornecerem a hepatite B separada da tetravalente e a anti-polio na forma oral (VOP) ao invés da inativada (VIP), que demonstra um descaso ou até mesmo desatualização com relação ao tema. Mas independente disso, este lactente tem atraso da segunda dose da VORH, mas que pode ser administrada até 7 meses e 29 dias, assim como de todo o esquema da pneumocócica 10 valente e meningocócica 10 valente. Nesta ocasião, o menor deve receber a VORH e as primeiras doses das outras duas. No entanto, nenhuma alternativa apresenta esta resposta. Diante disso, a questão foi anulada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174381.

Comentário: Vamos analisar as alternativas, iniciando pelas incorretas B) ERRADA Depende se a linfadenopatia está supuruada ou não, pois o uso de isoniazida está indicado somente na presença de linfadenopatia supurada. Caso contrário, é necessário somente a notificação e seguimento. C) ERRADA A vacina contra a febre amarela é composta por vírus vivo atenuado e diante disso, a administração em gestantes deve ser analisada individualmente na vigência de surtos. D e E) ERRADAS Vamos analisar em conjunto, pois versam sobre a mesma vacina. O grande motivo pela substituição da forma oral pela injetável da vacina contra a poliomielite foi o número de indivíduos com paralisia pós-vacinal, que ocorre em pacientes vacinados com a forma oral como no comunicante., A incidência dos casos está relacionada com a ocorrência da mutação do poliovírus no intestino dos indivíduos vacinados com a VOP, excretados ao ambiente e disponível às populações suscetíveis a tal. Mesmo que a forma injetável não cubra a forma selvagam do vírus, o Ministério da Saúde optou pela troca até mesmo porque a doença está erradicada no país. Por fim, a alternativa correta, letra A o episódio hipotônico-hiporresponsivo manifesta-se nas primeiras 48 horas (geralmente nas primeiras seis horas) que sucedem a aplicação da vacina DTP ou Tetra Pentavalente, associado ao componente pertussis da vacina. Sua ocorrência indica o uso de DTP acelular nas doses subsequentes. Resposta letra A.

188016.

Comentário: A deficiência da vitamina C leva a uma síndrome clínica denominada ESCORBUTO, no qual o paciente apresenta um distúrbio generalizado dos tecidos conjuntivos, manifestando-se por fragilidade capilar, que leva a sangramentos superficiais (petéquias, equimoses, epistaxe, entre outros) e inflamação espontânea de mucosas, principalmente das gengivas. Sabemos também que está vitamina é um importante cofator para a síntese do colágeno e, a sua deficiência, levará a prejuízo direto na cicatrização de feridas. Para completar a síndrome, alguns sintomas gerais podem estar presentes, como anorexia, irritabilidade, febre baixa, fadiga, hipotonia, depressão, taquipnéia e hipersensibilidade dolorosa dos MMII (como no caso). Resposta correta letra D.

187452.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O principal indicador usado para o diagnóstico da obesidade na prática clínica é o Índice de Massa Corporal (IMC). De acordo com a classificação adotada pelo Ministério da Saúde, utilizando-se a curva do índice de massa corpórea (IMC) de acordo com a idade em menores de 5 anos, temos - acima de escore Z 1 risco de sobrepeso - acima de escore Z 2 sobrepeso - acima de escore Z 3 obesidade. Para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, os mesmos pontos de corte caracterizam, respectivamente, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Assim, a classificação correta está indicada na letra C.

187478.

Comentário: A recomendação da profilaxia contra o tétano acidental é determinada com base na avaliação de 3 parâmetros 1) tipo de ferimento 2) situação vacinal 3) presença de comorbidades (ex paciente desnutrido, imunodeprimidos e idosos). No caso descrito, temos um pré-escolar com ferimento de alto risco. A conduta nestes casos varia de acordo com a situação vacinal, da seguinte forma - três ou mais doses da vacina e última dose há menos de cinco ano (é o que faremos nesse caso, pois a criança recebeu a terceira dose com 15 meses de idade e, o próximo reforço será feito somente aos 4 anos) cuidados com o ferimento. - três ou mais doses da vacina e última dose entre cinco e dez anos reforço da vacina (Obs pacientes idosos, imunodeprimidos e desnutridos, poderão receber, além da vacina, a profilaxia passiva com SAT ou IGHAT). - três ou mais doses da vacina e última dose há mais de dez anos reforço da vacina. - menos de três doses ou vacinação incerta vacina e imunização passiva (SAT IGHAT). Resposta correta letra D.

172538.

Comentário: Existe uma grande preocupação com a transmissão vertical do vírus da hepatite B. Cerca de 70 a 90% das infecções ocorridas em menores de 5 anos cronificam e um percentual desses casos evolui para doença hepática avançada. Assim, quando a mãe é sabidamente portadora crônica do vírus da hepatite B (HBsAg), recomenda-se que, além da vacina contra hepatite B (feita, preferencialmente, nas primeiras 12 horas de vida), o recém-nascido também receba a imunoglobulina hiperimune para a hepatite B. A imunoglobulina deve ser administrada, preferencialmente simultaneamente com a vacina, em locais anatômicos diferentes, ambas por via

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

intramuscular. Se isso não ocorrer, pode ser feita até no máximo 7 dias após o parto. Logo, gabarito letra C.

172560.

Comentário: Vamos analisar as alternativas sobre obesidade infantil A) Correta A programação fetal é definida pela alterações do metabolismo do feto na vigência de comorbidades metabólicas maternas, destacando-se a obesidade, subnutrição e diabetes materna. Ao longo dos anos, foi observada frequente associação entre ganho de peso e diabetes na gestação com obesidade na descendência, o que levou a conclusão que tais patologias podem ter efeitos transgeracionais e, deste modo, contribuir para as proporções epidêmicas da obesidade. B) Correta A teoria do fenótipo poupador é definida pela capacidade do feto em se adaptar a um ambiente intra-uterino adverso, otimizando o uso de suprimentos energéticos reduzidos para poder garantir a sua sobrevivência. Entretanto, esse processo adaptativo levaria ao favorecimento metabólico de órgãos nobres em detrimento de outros, conferindo alterações persistentes no crescimento e função dos tecidos. C) Correta Um dos principais objetivos de intervenção precoce da obesidade é justamente pelo fato de o excesso de peso na infância ser um importante preditor de sobrepeso na fase adulta. Além da obesidade futura, a criança com excesso de peso apresenta risco elevado de desenvolver comorbidades associadas, como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. D) Errada O aleitamento materno tem efeito protetor contra a obesidade infantil, especialmente quando relacionado a um período de amamentação exclusiva acima de três meses. E um dos fatores envolvidos nessa proteção é a presença do hormônio leptina no leite materno. Ele inibe o apetite, aumentando a sensação de saciedade do lactente, tanto que animais que não produzem leptina são extremamente obesos. O erro do item está na dose-dependência, pois não há qualquer comprovação de que quanto maior a ingestão de leite materno proporcionalmente reduz o risco do desenvolvimento de obesidade infantil futura. Resposta letra D.

172768.

Comentário: Diante de uma criança OBESA existe uma triagem de exames complementares básicos que deverão ser solicitados com o objetivo de rastrear as doenças associadas mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prevalentes e atuar precocemente. Isso se justifica porque a síndrome metabólica composta por hipertensão, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL, confere um aumento do risco de doenças cardiovasculares, que têm uma prevalência de 30% nos adolescentes obesos. Os exames são 1) GLICEMIA DE JEJUM 2) TGO E TGP 3) LIPIDOGRAMA (colesterol, triglicerídeos, HDL e LDL). Resposta letra A.

155399.

Comentário: Questão conceitual sobre tétano. Vamos às alternativas. A Incorreta. O período de incubação do tétano pode ser tão curto como 2 dias ou até 38 dias, com a maioria dos casos ocorrendo em 7 a 10 dias após a exposição. O período de incubação é tipicamente mais curto no tétano neonatal. A inoculação de esporos em locais do corpo distantes do sistema nervoso central (por exemplo, mãos ou pés) resulta em um período de incubação mais longo do que a inoculação próxima ao sistema nervoso central (por exemplo, a cabeça ou o pescoço). B Correta. O sulfato de magnésio é a droga mais utilizada no tratamento da disautonomia que ocorre comumente no tétano generalizado, auxiliando no efeito dos benzodiazepínicos e bloqueadores neuromusculares. C Incorreta. Uma vez que a toxina tetânica não pode ser desligada do sistema nervoso uma vez impregnada nos neurônios, cuidados de suporte são o principal tratamento para o tétano. Em pacientes com tétano grave, é comum ocorrer imobilidade prolongada com necessidade de ventilação mecânica, sendo justificada a intubação precoce, inclusive com traqueostomia precoce, para evitar o risco de broncoaspirações e facilitar a toalete brônquica. D Incorreta. A droga mais indicada para o controle da disautonomia é o sulfato de magnésio. E Incorreta. Apesar de possuírem pouco efeito relativo no manejo do tétano, os antibióticos são recomendados as drogas de escolha são o metronidazol ou penicilina G cristalina. Resposta B.

162597.

Comentário: As principais vacinas indicadas nos indivíduos com qualquer forma de imunossupressão são as vacinas de microrganismos vivos. Dentre as vacinas listadas, a única que se enquadra nesta categoria é a vacina contra varicela. De todo modo, cabe lembrar, que as crianças com HIV aids poderão receber algumas vacinas de agentes vivos se não apresentarem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

imunossupressão grave ou sintomatologia clínica grave. Resposta letra D.

162526.

Comentário: Questão tranquila sobre a profilaxia do tétano acidental. Como a situação é de um ferimento com risco mínimo de tétano, a conduta mais importante é a limpeza e desinfecção da ferida, com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas e debridar o foco de infecção. Não há indicação de imunoglobulina ou do soro antitetânico. A vacina só deve ser fornecida de acordo com o esquema habitual da vacina antitetânica (dT ou DTP), que exige uma dose de reforço a cada 10 anos após a última dose administrada. Portanto, apenas o paciente da situação III exige uma vacina extra para proteger contra o risco de tétano por outros ferimentos futuros. Resposta LETRA D.

155469.

Comentário: O enunciado apresenta um LACTENTE DE 16 MESES com duas doenças 1) desnutrição grave, com baixo peso, edema de membros inferiores e hipoalbulminemia 2) síndrome infecciosa aguda grave - pneumonia muito grave, caracterizada por letargia taquipneia dispnéia (gemência) estertores crepitantes em bases pulmonares distúrbios eletrolíticos (hiponatremia e hipocalemia). Temos uma infecção grave em um desnutrido, o que aumenta consideravelmente o risco de morte. Portanto, na abordagem ao desnutrido grave na emergência encontram-se 1) expansão volêmica se sinais de baixo débito, no máximo 10 ml kg EV 2) correção da hipoglicemia 3) início da antibitoticoterapia de amplo espectro ainda na primeira hora de atendimento. A hiponatremia e a hipocalemia devem ser distúrbios de instalação crônica, e devem ser tratadas de forma cautelosa. A nutrição deve ser feita por via enteral, quando o paciente estiver estabilizado. Resposta letra E.

162551.

Comentário: A sorologia descrita nos indica que esta gestante não apenas é portadora do vírus da hepatite B, como está em fase de replicação viral. Deste modo, o risco de transmissão vertical é mais elevado. As medidas adotadas neste caso incluem a administração da vacina contra hepatite B, que é feita nas primeiras 12 horas de vida para todos os recém-nascidos, e também o uso da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

imunoglobulina hiperimune para hepatite B. O ideal é que a imunoglobulina seja feita o mais rapidamente possível, mas é possível administrá-la até o sétimo dia de vida. A banca não trouxe esta conduta completa em nenhuma das opções. Assim, a melhor afirmativa, ainda que incompleta, é a letra B.

148556.

Comentário: Diante de uma paciente previamente vacinada contra o tétano e com esquema completo (3 doses), a conduta a ser tomada é aplicar dose de reforço preferencialmente entre a 27º e 36º semanas de gestação, podendo ser aplicada a partir da 20º semana. Somente será prescrito 2 doses quando a gestante apresentar esquema incompleto e que tenha recebido apenas uma dose da vacina e iniciar o novo esquema de vacinação em gestantes com vacinação desconhecida. Resposta letra C.

131664.

Comentário: O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela diminuição da mineralização da placa epifisária de crescimento e a osteomalácia é caracterizada pela diminuição da mineralização do osso cortical e trabecular, com acúmulo de tecido osteoide não mineralizado ou pouco mineralizado. São processos que, em geral, ocorrem associados. Após o fechamento da cartilagem epifisária, ao término do crescimento, apenas a osteomalácia permanece. As manifestações clínicas da deficiência de vitamina D são relacionadas ao metabolismo do cálcio e podem demorar meses para aparecer na dependência da velocidade de crescimento da criança, do grau de deficiência desta vitamina e do conteúdo de cálcio na dieta. Hipocalcemia, hipofosfatemia e fosfatase alcalina elevada são os achados mais comuns. Em função da ausência de resposta correta, a questão foi anulada.

127207.

Comentário: Vamos analisar as opções sobre o tema deficiências vitamínicas A - ERRADA. Classicamente, a deficiência de vitamina A causa manifestações oculares, desde a hemeralopia (cegueira noturna), até a amaurose plena. B - ERRADA. Tal deficiência geralmente leva ao raquitismo ou à osteomalácia. C - ERRADA. O caso seria de hemorragias difusas por deficiência de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

síntese de fatores de coagulação. D - ERRADA. Nas crianças prematuras, a deficiência de vitamina E pode provocar problemas oculares (retinopatia) e hemorragia cerebral, dois problemas que podem ser consequência da exposição a altas concentrações de oxigênio nas incubadoras. Nas crianças maiores, os sintomas da deficiência de vitamina E ocorrem quando existe má absorção intestinal e assemelham-se aos de uma perturbação neurológica e insuficiência cardíaca, mas não hemorragia. Esses sintomas incluem reflexos diminuídos, dificuldade em andar, visão dupla, perda do equilíbrio e fraqueza muscular. E - CERTA. Gabarito letra E.

131689.

Comentário: Questão direta. As vitaminas lipossolúveis são aquelas solúveis em lipídios, dependentes destes para serem absorvidas. São elas as vitaminas A, D, E e K. Classicamente, utilizamos a regra mnemônica ADEK . A vitamina C trata-se de vitamina hidrossolúvel. Resposta letra B.

106410.

Comentário: Craniotabes é o nome dado ao amolecimento da calota craniana, que pode ser verificado na palpação da mesma e acomete principalmente as regiões parietal e occipital. Pode ocorrer no raquitismo ou ainda em outras doenças como a osteogênese imperfecta, sífilis e hidrocefalia. O raquitismo pode ser causado por deficiência de vitamina D (diversas etiologias), deficiência nutricional de cálcio e fósforo e ainda por perda renal desses elementos. Outras alterações esqueléticas estão presentes no raquitismo como o rosário raquítico, sulco de Harrison (depressão na porção inferoanterior do tórax), escoliose, cifose e lordose acentuadas, deformidades em varo ou valgo nos membros, alargamento de pulsos e tornozelos.

77331.

Comentário: Questão que aborda carência de micronutrientes. A deficiência de iodo pode causar cretinismo em crianças, surdo-mudez, anomalias congênitas, bem como a manifestação clínica mais visível como o bócio. Desde o estabelecimento da obrigatoriedade de adição de iodo no sal na década de 50, o Ministério da Saúde realizou quatro pesquisas para avaliar o impacto desta intervenção no Brasil, sendo por meio destas registradas uma significativa redução nas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prevalências de bócio (20,7% em 1955 contra 1,4% em 2000). Item que poderia gerar dúvida seria a letra D, pois cegueira noturna está classicamente associada a carência de vitamina A. No entanto, é importante lembrar que a deficiência de zinco está associada à diminuição de liberação hepática de vitamina A, o que pode contribuir para os sintomas de cegueira noturna. Sendo assim, letra E correta.

88927.

Comentário: A classificação nutricional de Waterlow (1976) baseia-se nos parâmetros peso estatura (90%) e estatura idade (95%), a fim de avaliar se a criança é normal, desnutrida aguda (estatura idade 95% e peso estatura 90%), desnutrida crônica ou pregressa (estatura idade 95% e peso estatura 90%) ou se é desnutrida crônica em atividade (estatura idade 95% e peso estatura 90%). Neste caso, ambas as medidas estão abaixo do preconizado, ou seja, há deficit de peso e estatura, demonstrando que existe desnutrição crônica ainda em atividade. Gabarito letra D.

43976.

Comentário: Vamos às afirmativas I- Correta. A causa mais comum de obesidade na infância é a obesidade exógena. O sobrepeso e a obesidade têm em sua gênese a adoção de hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo crescente. É papel do pediatra buscar a modificação desses hábitos ainda na infância. II- Veja bem, um escolar e um adolescente que estão no percentil 97 têm sobrepeso, segundo a proposta do Ministério da Saúde. O rastreamento da dislipidemia está recomendado na presença de alguns fatores de risco, como hipertensão arterial, obesidade, tabagismo ou dieta rica em gorduras saturadas e ou ácidos graxos trans. Notem que o sobrepeso não está incluído aqui. O mesmo para a avaliação do metabolismo glicídico. Ainda assim, esta assertiva foi considerada correta pela banca. III- Claramente errada. De forma alguma o restante do exame físico pode ser suprimido. Diante de um adolescente ou criança obesa, o exame físico minucioso permite a identificação de alterações que possam sugerir outras causas que não a causa exógena para a etiologia da obesidade, além de permitir a identificação de outras comorbidades associadas, como a hipertensão arterial. IV- Errada. A resistência insulínica pode ser encontrada, principalmente em adolescentes. A presença de acantose nigricans, um achado frequente que, por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

si só, pode levar a uma suspeita de hiperinsulinismo deve sempre ser avaliada nestes pacientes. Assim, I e II foram consideradas corretas e a resposta é a letra B.

32497.

Comentário: Uma série de complicações pode advir do quadro de obesidade na infância, tornando a intervenção sobre este quadro uma necessidade imperativa. Essas complicações podem ser divididas pelos sistemas que são acometidos. Assim, temos as seguintes associações 1) quadros dermatológicos acanthosis nigricans , infecção fúngica, estrias, celulite, acne, hirsutismo e furunculose 2) quadros ortopédicos joelho valgo (genu valgum), epifisiólise de cabeça do fêmur, osteocondrites, artrites degenerativas e pé plano 3) quadros cardiovasculares hipertensão arterial sistêmica 4) quadros respiratórios síndrome da apneia obstrutiva do sono e asma 5) quadros hepáticos e gastrointestinais colelitíase, doença gordurosa não alcoólica, refluxo gastroesofágico e constipação intestinal 6) quadros genitourinários síndrome dos ovários policísticos, pubarca precoce e incontinência urinária e 7) quadros neurológicos e psicológicos pseudotumor cerebral e problemas psicossociais. Assim, a única opção que traz sinais de doenças associados à obesidade é a opção A. Os erros identificados nas outras opções são geno varo, diabetes mellitus tipo 1, insuficiência venosa, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

23084.

Comentário: A principal causa (90%) de obesidade na infância e na adolescência é a obesidade exógena. A prevalência da obesidade nunca atingiu números tão altos quanto os observados atualmente. As mudanças de estilo de vida e de hábitos alimentares explicam esse fato. O hipotireoidismo, síndrome de Cushing e a síndrome de Prader-Willi são causas de obesidade, porém, com prevalência muito reduzida em comparação às causas exógenas. Na síndrome de Sotos, ou gigantismo cerebral, a criança apresenta-se acima do percentil 90 já ao nascimento para peso e para comprimento.

9424.

Comentário: Relembrando as características clínicas do Kwashiorkor, uma forma grave de desnutrição energético-proteica provocada principalmente pelo déficit nutricional de proteínas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Déficit de estatura e peso Aspecto consumido, fato este observado principalmente nos músculos dos membros superiores e inferiores. Este fato pode ser mascarado pelo edema. Edema, que é muito frequente e considerado a manifestação clínica mais importante desta síndrome. Vale ressaltar que o edema pode afetar qualquer parte do corpo, sendo que em crianças que deambulam, mais frequentemente, o edema se inicia com ligeiro intumescimento dos pés se estendendo pelas pernas. Posteriormente o edema pode acometer mãos e face (fácies de lua). Em meninos pode ser notado edema em bolsa escrotal. Alterações mentais comportamentais a criança se apresenta apática, hipoativa, anorética e desinteressada pelos fatos que ocorrem ao seu redor ela geralmente não sorri, mesmo quando estimulada, e está permanentemente irritada, sem apetite. Presença de tecido celular subcutâneo, diferentemente da criança marasmática. Pele a pele da face está frequentemente despigmentada, desenvolvendo-se dermatoses em áreas de atrito, como, por exemplo, na região inguinal e no períneo. Surgem áreas de hiperpigmentação que, eventualmente, descamam. Cabelos apresentam alteração de textura, cor (discromias) e são quebradiços. Os cabelos pretos tornam-se castanhos ou avermelhados. Pode estar presente o sinal da bandeira , que consiste na alteração segmentar (em faixas) da cor dos cabelos, traduzindo períodos alternados de pior e melhor nutrição. Fezes podem estar liquefeitas, com sangue e alimentos não digeridos. Anemia está presente na maioria dos casos. É, em parte, devido à deficiência proteica para síntese de eritrócitos, deficiência de ferro e de ácido fólico, parasitoses intestinais e infecções frequentes. Hipoalbuminemia e redução da proteína sérica total, relação com a intensidade do edema, são observadas em praticamente todos os pacientes. Geralmente as crianças com esta síndrome têm hepatomegalia (esteatose hepática).

9428.

Comentário: Crianças obesas iniciam a puberdade mais precocemente, são mais altas durante as fases iniciais da maturação sexual e também apresentam aceleração da maturação óssea com aumento concomitante da densidade mineral óssea... Logo, a opção incorreta é a letra D As PRINCIPAIS comorbidades associadas à obesidade na infância são asma, síndrome metabólica (aumento da gordura central, dislipidemia, hipertensão arterial e intolerância à glicose), síndrome

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dos ovários policísticos, esteatose hepática, doenças ortopédicas, discriminação social, apnéia obstrutiva do sono e alterações dermatológicas...

8091.

Comentário: Opção A incorreta. O indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal é o peso de nascimento da criança. Pesos ao nascer menores que 2.500 g podem ser decorrentes de prematuridade e ou déficit de crescimento intrauterino. Recém-nascidos com menos de 2.500 g são classificados, genericamente, como de baixo peso ao nascer. Vários fatores podem influir negativamente no crescimento intrauterino, sendo que, no nosso meio, os mais importantes são o fumo, o álcool e outras drogas, a hipertensão arterial, as doenças infecciosas crônicas, as doenças sexualmente transmissíveis, o estado nutricional da gestante, o curto intervalo interpartal (menor do que dois anos), a elevada paridade, a idade materna (19 anos e 35 anos), a gestação múltipla e as anomalias congênitas. Muitos desses fatores têm causas socioeconômicas e podem ser prevenidos com uma boa cobertura por parte dos serviços de saúde e controle pré-natal. Opção B incorreta. O IMC é um bom índice para avaliação de baixo peso, sobrepeso e obesidade, justamente porque leva em consideração o peso em relação à estatura. Opção C incorreta. A taxa de mortalidade infantil na faixa escolar pode sofrer com fatores de confundimento como maus tratos, nível educacional dos pais, particularidades locais e regionais, etc. Opção D incorreta. A estatura e o peso são dados antropométricos fundamentais para avaliar o crescimento da população infantil. Entretanto, o peso é uma medida mais sensível, ou seja, se altera precocemente frente a um agravo de saúde. Além disso, sua aferição é fácil e culturalmente aceita, de modo a permitir que qualquer profissional da área de saúde possa utilizá-la. A estatura sofre interferência se o agravo de saúde se perpetua ao longo do tempo. Opção E correta. Houve uma redução nas taxas de desnutrição energético-proteica nos últimos anos, e ascensão das taxas de obesidade entre a população pediátrica.

8095.

Comentário: A síndrome de recuperação nutricional ocorre durante o tratamento correto dos casos de desnutrição grave, sendo mais exuberante nos casos de kwashiorkor, observado entre o 20º e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

40º dias de tratamento. Consiste em alterações orgânicas, bioquímicas e celulares que costumam regredir por volta da 10ª a 12ªsemana após o início do tratamento. Não se sabe ao certo a etiologia dessas alterações. As manifestações clínicas observadas nessa síndrome clínica variam de intensidade e as mais comumente encontradas são Hepatomegalia à custa do lobo esquerdo, com maior aumento sendo encontrado por volta da quinta semana após o início do tratamento Distensão abdominal com circulação venosa colateral e ascite Fácies de lua cheia Alterações de pele e fâneros sudorese intensa em região cefálica, hipertricose, unhas com desnível transversal, cabelos com pontas mais claras) Telangiectasias mais visíveis em face. Dentre as alterações bioquímicas mais frequentes encontramos Hipergamaglobulinemia Eosinofilia Aumento da volemia. Como podemos observar, a hiperpotassemia não faz parte das alterações hidroeletrolíticas encontradas na síndrome de recuperação nutricional.

363890.

Comentário: Esta questão descreve uma gestante com 20 semanas de idade gestacional que recebeu imunização completa contra o tétano na última gestação há um ano, ou seja, três doses. A questão deseja saber qual alternativa indica a conduta adequada na gestação atual. Letra A incorreta. Gestantes com esquema vacinal completo contra o tétano há menos de 5 anos não necessitam de dose de reforço de dT. Entretanto, independente da necessidade de reforço de dT, toda gestante deve receber uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação. Letra B correta. Desde novembro de 2014, o Ministério da Saúde introduziu a vacina tríplice bacteriana acelular do adulto (dTpa) contra difteria, tétano e coqueluche (pertussis acelular) no Calendário Nacional de Vacinação da gestante, como reforço ou complementação do esquema da vacina dupla adulta (difteria e tétano). O objetivo é diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos recém-nascidos através de passagem de anticorpos maternos por via transplacentária. A vacina deve ser administrada a cada gravidez, visto que os anticorpos possuem curta duração. Letra C incorreta. A paciente não possui indicação de nenhuma dose de dT. Apenas uma dose de dTpa a partir de 20 semanas. Letra D incorreta. A paciente não possui indicação de nenhuma dose de dT. Apenas uma dose de dTpa a partir de 20 semanas. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330087.

Comentário: A aferição da pressão arterial (PA) deve fazer parte da consulta de puericultura para todas as crianças maiores de 3 anos (ou antes, em situações especiais). De acordo com as últimas diretrizes sobre pressão arterial na infância (2017), temos as seguintes classificações PA normal quando PAS e PAD percentil 90 PA elevada quando PAS e ou PAD percentil 90 e percentil 95 ou 120 80 para percentil 95 (o que for menor) hipertensão estágio I quando PAS e ou PAD maior ou igual ao percentil 95 e menor que percentil 95 12mmHg OU 130 80 a 139 89mmHg (o que for menor) hipertensão estágio II quando PAS e ou PAD maior ou igual que o percentil 95 12mmHg ou maior ou igual a 140 90 (o que for menor). Resposta letra C.

334805.

Comentário: Questão sobre crescimento infantil que solicitava que o candidato plotasse no gráfico o peso da criança, para posteriormente realizar o diagnóstico nutricional. A questão não deixa dúvida de que este bebê está abaixo do zscore -3. Vamos então relembrar as classificações de peso para idade para crianças entre 0 e 10 anos abaixo do percentil 0,1 ou de zscore -3 muito baixo peso para a idade entre os percentis 0,1 e 3 ou entre os zscores -2 e -3 baixo peso para a idade entre os percentis 3 e 97 ou entre os zcores -2 e 2 peso adequado para a idade acima do percentil 97 ou de zscore 2 peso elevado para a idade. Portanto, a criança da questão deve ser classificada como muito baixo peso para a idade. Resposta letra B.

334806.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. A vacina pneumo-23 é indicada para crianças maiores de dois anos. Letra B correta. A vacina pneumo-13 é do tipo conjugada com a proteína CRM197 e tem alta cobertura para as infecções causadas por pneumococo. Letra C incorreta. A vacina pneumo-10 está disponível pelo PNI em três doses para crianças de dois, quatro e doze meses de idade. Letra D incorreta. A vacina pneumo-13 é superior à vacina pneumo-10 por conferir proteção por mais tipos de sorotipos do pneumococo. Resposta letra B.

334807.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre a vacina contra poliomielite. A letra A está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incorreta a VOP é uma vacina oral atenuada bivalente, ou seja, composta pelos vírus da pólio tipos 1 e 3. A letra B está incorreta a VOP é uma vacina oral atenuada, ou seja, composta pelos vírus da pólio enfraquecidos . Por ser uma vacina viva cujo agente pode ser excretado nas fezes, é contraindicada a adminstração em imunodeprimidos e em seus respectivos contatos. A letra C está incorreta a VIP é, de fato, indicada em países onde a doença foi erradicada. No entanto, não há superoridade em soroconversão, tampouco menor custo em relação a VOP. E, por fim, a letra D está correta o esquema apresentado é o preconizado atualmente no Brasil pelo MS - três doses de VIP aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Resposta letra D.

332003.

Comentário: O Ministério da Saúde indica a vacinação com a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) aos 12 meses e com a tetraviral (protege também contra a varicela) aos 15 meses. O adiamento das doses deve ser considerado quando a criança apresenta um quadro febril moderado a grave. Perceba que estamos diante de um provável resfriado comum Logo, não há motivo para pensar em adiar a imunização. Resposta letra D.

334813.

Comentário: Vamos relembrar as classificações nutricionais de IMC pela OMS, reforçando que há uma diferença na classificação de sobrepeso obesidade para crianças menores e maiores de 5 anos. Para crianças até 5 anos de idade (como a da questão) abaixo de zscore -3 magreza grave abaixo do zscore -2 magreza entre zscore -2 e 1 eutrofia acima de zscore 1 risco para possível sobrepeso acima de zscore 2 sobrepeso acima de zscore 3 obesidade. Para crianças acima de 5 anos a classificação muda apenas nos limites superiores acima de zscore 1 sobrepeso acima de zscore 2 obesidade acima de zscore 3 obesidade grave. Portanto a criança da questão deve ser classificada com sobrepeso. Resposta letra C.

334820.

Comentário: Com relação à desnutrição proteico-calórica Letra A errada. O marasmo é decorrente de uma deficiência calórica total, ou seja, deficiência de proteínas e calorias. A criança geralmente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cursa com quadros infecciosos, com emagrecimento acentuado, anemia e diarreia. Letra B certa. O Kwashiokor caracteriza-se por deficiência de proteína na dieta e tem como marca o edema com presença de dermatoses em áreas de atrito, alteração de cabelos, visceromegalias e hipoalbuminemia. Letra C errada. As deficiências de micronutrientes mais importantes são vitamina A, ácido fólico, zinco, cobre e ferro. Letra D errada. Classifica-se como desnutrição ou magreza quando, pela curva de IMC, o paciente encontra-se entre os Zscores -2 e -3. Quando ele encontra-se abaixo do Zscore -3 é classificado como desnutrido grave ou magreza acentuada. Resposta letra B.

334821.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre as vacinas do PNI. A letra A está incorreta a vacina BCG está indicada o mais precocemente (preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida), mas não há indicação de repetir a vacina, nem em casos de ausência de cicatriz vacinal. A letra B está correta a vacinação contra poliomielite, pelo PNI, está indicada com a utilização da VIP nas 3 primeiras doses, sendo os reforços com 15 meses e 4 anos preconizada a utilização da VOP. A letra C está incorreta a vacinação contra febre amarela está indicada para todos os residentes do Brasil, com 1 dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. E, por fim, a letra D está incorreta em prematuros com peso inferior a 2kg ou idade gestacional inferior a 33 semanas está indicada a vacinação contra hepatite B com 4 doses. Resposta letra B.

334822.

Comentário: A questão solicita várias classificações distintas. A puberdade normal pode iniciar-se entre os 8 e os 13 anos de idade em meninas e entre os 9 e os 14 anos de idade em meninos, portanto este menino, que ainda não apresenta nenhum sinal de desenvolvimento puberal, pode ser classificado como puberdade normal. Com relação à curva de IMC para idade, para crianças acima dos 5 anos, consideramos a seguinte classificação abaixo de Zscore -3 magreza grave abaixo do Zscore -2 magreza entre Zscore -2 e 1 eutrofia acima de Zscore 1 sobrepeso acima de Zscore 2 obesidade e acima de Zscore 3 obesidade grave. Portanto, pelo IMC, este menino deve ser classificado como sobrepeso. Com relação à estatura por idade para adolescentes,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

classificamos como abaixo de Zscore -3 muito baixa estatura para a idade entre Zscores -3 e -2 baixa estatura para a idade acima de Zscore -2 estatura adequada para a idade. Como este menino, ao plotar no gráfico, está entre -2 e -3, é classificado como baixa estatura. Além disso, a questão ainda solicita a provável origem da baixa estatura. Ao calcular o alvo desta criança ()altura do pai altura da mãe 13) 2 170cm, que pode variar entre 162 e 178cm) e considerando a idade óssea, que está abaixo da esperada, concluímos que trata-se de baixa estatura familiar. Portanto, a única resposta possível é a letra B. Resposta letra B.

339815.

Comentário: As crianças de 0 a 5 anos são consideradas em risco de sobrepeso quando os valores de IMC estão entre os percentis 85 e 97 ou entre os escores z 1 e 2 com sobrepeso, quando os valores de IMC estiverem entre os percentis 97 e 99,9 ou entre 2 e 3 escores z e com obesidade, quando os valores estiverem acima do percentil 99,9 ou acima de 3 escore z. Logo, essa criança está com risco de sobrepeso, já que ela está com IMC entre 85 e 97. Resposta letra C.

321598.

Comentário: Esta questão traz uma particularidade está sendo abordado, especificamente, o calendário vacina proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O Programa Nacional de Imunizações utiliza a vacina pneumocócica conjugada 10-valente no esquema de duas doses, administradas aos 2 e 4 meses, seguidas de um reforço aos 12 meses, podendo ser aplicada até os 4 anos e 11 meses de idade. A SBP recomenda sempre que possível, o uso preferencial de vacinas de maior valência pelo seu maior espectro de proteção. Temos duas outras vacinas pneumocócicas conjugadas (13 e 15-valente) licenciadas no país no esquema de três doses no primeiro ano de vida (2, 4, e 6 meses) e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses. Crianças saudáveis com esquema completo com a vacina 10-valente podem receber dose(s) adicional(is) da vacina 13 ou 15-valente, até os cinco anos de idade, com o intuito de ampliar a proteção para os sorotipos adicionais. A vacina pneumocócica 14-valente também é disponibilizada gratuitamente no CRIE para crianças com algumas comorbidades. Resposta letra D.

321599.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre a vacina BCG. A letra A está correta a BCG é indicada em dose única. A letra B está incorreta a BCG deve ser aplicada logo ao nascimento, desde que a criança tenha peso maior que 2000 g. A letra C está incorreta só existe um tipo de vacina BCG. E, por fim, a letra D também está incorreta a BCG não deve ser aplicada em bebês que sejam coabitantes de um caso de tuberculose bacilífero. Resposta letra A.

321600.

Comentário: A exposição prolongada a mídias digitais e telas na infância tem sido associada a diversos problemas, como problemas de saúde mental, transtornos do sono, sedentarismo, bullying digital, entre outros. Assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) sugere limites de tempo de exposição a mídias digitais e telas, de acordo com a faixa etária, para minimizar o dado gerado pela exposição prolongada. A SBP orienta evitar a exposição de crianças menores de dois anos às telas, mesmo que passivamente (tempo zero de tela) (letra B correta) limitar o tempo ao máximo de uma hora por dia, supervisionada, para crianças com idades entre dois e cinco anos (letras A e C incorretas) limitar o tempo a uma ou duas horas por dia, sempre com supervisão, para crianças com idades entre seis e 10 anos (letra D incorreta) limitar o tempo de telas e jogos de videogames a duas ou três horas por dia, sempre com supervisão, para adolescentes entre 11 e 18 anos, evitando jogos de videogame no período noturno. As crianças devem ser estimuladas a realizar atividades ao ar livre, e as telas não devem ser utilizadas durante as refeições e nos períodos que antecedem o sono. Resposta letra B.

339833.

Comentário: A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim) indicam que a vacina que deve ser aplicada para prevenção de infecções pneumocócicas seja a pneumo 13-valente, aplicada aos dois, quatro, seis e doze meses de idade. Há uma pequena diferença da recomendação do PNI que indica a vacina pneumo 10-valente aos dois, quatro e doze meses. Resposta letra D.

339834.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas acerca da vacina BCG. Letra A correta. A vacina da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

BCG deve ser aplicada em dose única. Letra B incorreta. A vacina é indicada logo ao nascimento. Letra C incorreta. Só há um tipo de vacina da BCG. Letra D incorreta. A vacina é contraindicada em pacientes com imunodeficiência ou filhos de mães que receberam imunomoduladores durante a gestação. Resposta letra A.

300815.

Comentário: Estamos diante de uma criança de 12 meses de idade que apresenta estatura e perímetro cefálico (PC) dentro do esperado para a idade. Em relação a estatura idade, a baixa estatura para a idade é definida pelo escore Z (EZ -3 e EZ -2, que corresponde ao percentil 3). Em relação ao PC, é considerado anormal se percentil 2. O que temos é uma criança com baixo peso, com peso abaixo do percentil 5 (o peso que apresenta, seria adequado para uma criança de oito meses). Esses achados conotam uma falha do crescimento, do inglês, failure to thrive (FTT) . A falha de crescimento é muitas vezes multifatorial na etiologia. Uma maneira de classificar as causas potenciais é pensar em três grandes categorias, que explicam o fato do paciente não estar ganhando peso adequadamente. As categorias incluem diminuição da ingestão, aumento da produção e aumento da demanda calórica. Além disso, as causas podem ser descritas como orgânicas ou inorgânicas. Existem várias condições patológicas subjacentes ou causas orgânicas que podem levar às três categorias descritas acima. Por exemplo, um paciente com uma anormalidade na deglutição, pode não ser capaz de ingerir calorias suficientes para ganhar peso. Por outro lado, um paciente com diarreia crônica pode estar perdendo mais calorias do que consome. Por fim, um paciente com cardiopatia congênita pode ter demandas calóricas aumentadas e ser incapaz de compensá-las. Embora haja uma infinidade de causas orgânicas potenciais, as causas inorgânicas são mais comuns. As causas inorgânicas incluem algumas razões externas para não obter calorias suficientes. Exemplos podem incluir mistura inadequada de fórmulas infantis, recusa de alimentação ou negligência dos pais. Como a criança apresenta exame fisico normal, é mais provável que a causa para a falha do crescimento, seja de origem não orgânica. Resposta letra D.

300824.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O índice é a combinação entre duas medidas antropométricas (por exemplo, peso e estatura) ou entre uma medida antropométrica e uma medida demográfica (por exemplo, peso para a idade, estatura para a idade). A importância do índice é a possibilidade de produzir uma avaliação mais rica e complexa do estado nutricional de crianças ou adultos a partir da integração de dados antropométricos e demográficos. Os índices antropométricos podem ser expressos em percentis ou em escores-z. A estatura idade (E I), expressa o crescimento linear da criança. É o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança. É considerado o indicador mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população, pois tem valor sobre processos crônicos. Por exemplo, quando uma criança apresenta desnutrição crônica, o peso e a estatura estão comprometidos. Resposta letra D.

317168.

Comentário: Que longo enunciado Para resumir, temos uma paciente com dispneia aos pequenos esforços, importante carga tabágica e exposição a fogão de lenha em casa, perda ponderal, disfagia progressiva, etilismo ativo, além de exame físico revelando MV reduzido difusamente e abdome escavado e doloroso em epigástrio. Muitos diagnósticos sindrômicos para serem investigados Com isso em mente, vamos às alternativas Afirmativa I - incorreta. Recentemente, a USPSTF (US Preventive Services Task Force), passou a recomendar o rastreamento anual com TC de baixa dose em pacientes de 50 a 80 anos tabagistas ou que tenham cessado dentro de 15 anos, que possuam histórico de carga tabágica de 20 maços ano. A radiografia de tórax definitivamente não é um bom método de screening para câncer de pulmão . Afirmativa II - correta. A história de perda ponderal, disfagia progressiva e a presença de fatores de risco para tumor de esôfago certamente chamam a nossa atenção, o que indica uma endoscopia digestiva alta. Além disso, pacientes com 45-50 anos devem ser rastreados para câncer colorretal através da colonoscopia. Afirmativa III - incorreta. O rastreio com a Densitometria Mineral Óssea está indicado para todas as mulheres acima de 65 anos e, para as com menos de 65, na presença de fatores de risco, como baixo peso, tradicionalmente classificado como abaixo de 57 kg Logo, há indicação para realização do rastreamento. Afirmativa IV - incorreta. A paciente certamente deve ser vacinada para COVID-19

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e para vacina sazonal de influenza. Entretanto, a vacina recomendada para cobertura do pneumococo é a vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica), que deve ser administrada em uma dose durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso. Recomenda-se apenas um reforço 5 anos após a dose inicial. Resposta letra C.

314123.

Comentário: A questão apresenta a encefalopatia de Wernicke, que está associada com a deficiência de vitamina B1 (tiamina). É um quadro raramente encontrado em crianças e associa-se principalmente ao alcoolismo. A tríade clássica é ataxia, alterações oculomotoras e confusão mental. A carência da tiamina pode levar de dois a três meses para manifestar os sinais e sintomas que inicialmente são leves como insônia, nervosismo, irritação, fadiga, perda de apetite e energia e evoluem para quadros mais graves como parestesia, edema de membros inferiores, dificuldade respiratória e cardiopatia. Logo, esta é a resposta correta Analisando as demais alternativas a hipovitaminose B12 também pode cursar com encefalopatia, assim como demais sintomas como adinamia, anorexia, hiperestesia, dermatites, inclusive perioral, glossite, alopecia, conjuntivite, ataxia, mialgias, diminuição do aprendizado e retardo mental a hipovitaminose A está associada a cegueira noturna e demais alterações oculares por fim, a hipovitaminose C leva ao escorbuto. Os sintomas podem ser fadiga, artralgia, problemas de cicatrização, inflamação gengival e equimoses. Resposta letra B.

314124.

Comentário: A dor durante a manipulação dos membros inferiores associada a alterações hemorrágicas no exame físico, nos lembram do escorbuto, causado pela deficiência de vitamina C. O paciente apresenta um distúrbio generalizado dos tecidos conjuntivos, manifestando-se por fragilidade capilar, que leva a sangramentos superficiais (petéquias, equimoses, epistaxe, entre outros) e inflamação espontânea de mucosas, principalmente das gengivas. Sabemos também que esta vitamina é um importante cofator para a síntese do colágeno e, a sua deficiência, levará a prejuízo direto na cicatrização de feridas. Um sintoma que chama a atenção é a hipersensibilidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dolorosa nos membros inferiores, notada principalmente nas trocas de fralda. Ela se deve à hemorragia subperióstea e faz com que a criança assuma uma posição antálgica característica, chamada de posição de rã (joelhos e quadris fletidos com a coxa rodada externamente). Logo, este é o diagnóstico da questão. Analisando as demais alternativas a hipovitaminose A está associada a cegueira noturna e demais alterações oculares a hipovitaminose B1 causa a beribéri, cuja tríade clássica é composta por ataxia, alterações oculomotoras e confusão mental por fim, a hipovitaminose B12 pode cursar com encefalopatia, assim como demais sintomas como adinamia, anorexia, hiperestesia, dermatites, inclusive perioral, glossite, alopecia, conjuntivite, ataxia, mialgias, diminuição do aprendizado e retardo mental. Resposta letra D.

302865.

Comentário: Recém-Nascidos (RN) expostos a casos de tuberculose pulmonar podem ser infectados pelo M. tuberculosis (MTB) e desenvolver formas graves da doença. Nessas situações, recomenda-se a prevenção da infecção pelo MTB. O RN não deverá ser vacinado com a BCG ao nascer. Recomenda-se utilizar a isoniazida por três meses e, após esse período, faz-se a Prova Tuberculínica (PT). Se o resultado da PT for 5 mm, a isoniazida deve ser mantida por mais três meses, completando seis meses de tratamento, e o RN não deverá ser vacinado para BCG, uma vez que já apresenta resposta imune ao bacilo da tuberculose. Caso resultado da PT 5 mm, a isoniazida deve ser interrompida e a vacinação para BCG efetuada. As mães com tuberculose bacilíferas podem amamentar. Recomenda-se a amamentação com uso de máscaras e a diminuição do contato com a criança. Sendo assim, apenas a conduta 3 está correta. Resposta letra A.

308243.

Comentário: O Ministério da Saúde recomenda que a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) seja administrada em meninas de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meninos de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) em duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Resposta letra A.

314127.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Em relação ao calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), vamos analisar cada uma das alternativas Letra A incorreta. A vacina BCG (Bacillus de Calmette-Guérin) deve ser feita em dose única, a partir do nascimento, o mais precocemente possível Letra B incorreta. A vacina contra o rotavírus é indicada em duas doses, seguindo os limites de faixa etária primeira dose aos 2 meses (limites de 1 mês e 15 dias até, no máximo, 3 meses e 15 dias) e a segunda dose aos 4 meses (limites de 3 meses e 15 dias até no máximo 7 meses e 29 dias). Letra C correta. Pelo calendário da SBP, a vacina Hib é recomendada em três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. Entretanto, quando utilizada pelo menos uma dose de vacina combinada com componente pertussis acelular (DTPa Hib IPV, DTPa Hib, DTPa Hib IPV,HB, etc.), disponíveis em clínicas privadas e nos CRIE, uma quarta dose da Hib deve ser aplicada aos 15 meses de vida (pelo calendário da SBP, recomenda-se a aplicação dessa quarta dose). Letra D incorreta. A vacina contra a varicela é recomendado aos 12 meses de idade (separado ou em associação a tetraviral) e uma dose de reforço entre 15 meses e quatro anos de idade. Resposta letra C.

294288.

Comentário: A atual recomendação do Ministério da Saúde (MS) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é que a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) seja administrada em meninas de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meninos de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) em duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Como a adolescente em questão recebeu apenas uma dose e já se passaram 6 meses da primeira dose, a recomendação é que ela receba a segunda dose da vacina, aproveitando que ela ainda não completou 15 anos. Resposta letra A.

313222.

Comentário: Analisando as alternativas em relação ao crescimento letra A está correta, porque até os dois anos de vida, o prematuro deve ser avaliado conforme sua idade corrigida, que é a idade que a criança teria se tivesse nascido com 40 semanas de idade gestacional. Letra B está correta, já que apesar de rotineiramente observarmos a recuperação pôndero-estatural (catch-up) nos dois a três primeiros anos de vida, a criança tem até o fim da idade escolar para apresentá-la. Letra C

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

também está correta. Reparem que a alternativa destaca a avaliação de desnutrição aguda, que é aquela em que há alteração de peso, mas ainda não há interferência na altura da criança. Assim, o melhor parâmetro para avaliá-la é a curva de peso para altura, que mostrará uma criança magra para sua estatura. Por fim, letra D está incorreta porque é a partir dos dois anos de idade que a criança terá sua altura influenciada por fatores genéticos. Resposta letra D.

313223.

Comentário: A varicela é uma doença autolimitada e são necessários apenas cuidados gerais destinados a evitar infecção bacteriana secundária e obter alívio dos sintomas, como higiene local e agentes antipruriginosos. Crianças sadias com pequeno risco de complicações não necessitam de tratamento específico (realizado com aciclovir). O aciclovir deve ser considerado para pessoas sadias com moderado risco para doença grave, como as crianças com mais de 12 anos de idade, aquelas com doenças cutâneas ou pulmonares crônicas, as que recebem a terapia com salicilato de longo prazo ou ainda aquelas que recebam terapia contínua ou intermitente de corticosteroides. Resposta letra B.

316344.

Comentário: Vacinação é um tema recorrente em prova, por isso, guarde bem os conceitos que serão discutidos nessa questão. Durante a gravidez, devemos lembrar que vacinas compostas de partículas ou vírus inativados podem ser administradas com segurança, enquanto as compostas por vírus atenuados (vivos) não devem ser administradas. Vamos avaliar cada uma das afirmativas, em busca da que não deve ser administrada durante a gestação. Letra A incorreta. A vacina antitetânica, composta por toxoide tetânico deve ser admnistrada durante a gestação, a depender do estado vacinal da paciente. Letra B incorreta. A vacinação contra a hepatite B, composta por partículas virais, é recomendada para evitar contaminação da gestante e prevenir a transmissão vertical. Devem ser aplicadas três doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 180 dias entre a primeira e a terceira dose. Letra C incorreta. A antirrábica, vacina contra a raiva, tem em sua composição vírus inativado sendo, por isso, seu uso considerado seguro durante a gestação. Letra D correta. A vacina do sarampo é composta por vírus vivo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

atenuado sendo, portanto, contraindicada em gestantes. Resposta letra D.

294299.

Comentário: Ratos comuns (ex. Rattus norvegicus), coelhos, hamsters e demais roedores urbanos não são animais transmissores de raiva humana, logo, não há necessidade de profilaxia para raiva neste caso. Resposta A.

316358.

Comentário: Qualquer tipo de acidente desse tipo temos que analisar 2 variáveis o animal que provocou a lesão e o tipo de ferimento. Vamos devagar 1- Tipo de ferimento LEVE ferimento superficial no tronco ou nos membros, exceto mãos e pés lambedura de lesões superficiais. GRAVE ferimento nas mucosas, no segmento cefálico, nas mãos ou nos pés ferimento profundo, mesmo que puntiforme ferimentos múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo que intactas ferimento causado por morcego ou outros mamíferos silvestres. Voltando ao caso, estamos diante de um acidente grave. 2- Animal causador cão não passível de observação por 10 dias. Ok, e qual deverá ser a conduta Tranquilizar a paciente e sua mãe, lavar a ferida com água e sabão e iniciar profilaxia com vacina antirrábica (dias 0, 3, 7 e 14) e soro (SAR ou IGHAR). Resposta letra D.

313248.

Comentário: Em toda gestação, independentemente do histórico prévio, devemos administrar uma dose da vacina tríplice bacteriana acelular (dTpa), a partir da vigésima semana. Só com essa informação, já eliminamos as alternativas B, C e D. Além da tríplice bacteriana, também há recomendação que a gestante seja imunizada para hepatite B, caso seja suscetível (mais um motivo para a alternativa D estar incorreta) e que recebe vacina contra influenza, que pode ser administrada em qualquer idade gestacional. Resposta letra A.

311968.

Comentário: Para respondermos corretamente à questão, basta lembrarmos do calendário vacinal segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Ao nascer BCG e hepatite B. Dois e quatro meses pentavalente (DPT Hib hepatite B) VIP pneumocócica 10 valente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

rotavírus. Três e cinco meses meningocócica C. Seis meses pentavalente VIP (a depender da sazonalidade, também será administrada a vacina contra influenza). Nove meses febre amarela. Após esse período, as próximas vacinas serão aplicas com 12 meses. Resposta letra B.

313258.

Comentário: Temos o caso de uma criança de 5 anos que foi vítima de mordedura profunda no dedo indicador direito. Para começar, o acidente é considerado grave ou leve Acidentes leves Ferimentos superficiais pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés). Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras, causadas por unha ou dente, lambedura de pele com lesões superficiais. Acidentes graves Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e ou planta do pé. Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosas. Lambedura de pele onde já existe lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animal. Temos um ACIDENTE GRAVE. E quem causou o acidente Apresenta suspeita de raiva no momento da agressão Não Trata-se de um cão SEM SUSPEITA de raiva no momento da agressão. Sendo assim, a conduta completa inclui Lavar com água e sabão Observar o animal durante 10 dias após exposição Iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3, e no caso do Observar o animal durante 10 dias após a exposição e no caso de A suspeita de raiva ser descartada após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e encerrar o caso. O animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completar o esquema até 4 doses, aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose no 14º dia. Resposta letra B. No entanto, relembre que, segundo nota técnica do ano de 2022, a conduta em caso de acidente grave por animal passível de observação por 10 dias e sem sinais sugestivos de raiva é não iniciar a profilaxia e manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva indicar vacina (dias 0, 3, 7 e 14) e soro.

316375.

Comentário: A varicela é uma doença altamente contagiosa, cuja transmissão ocorre de pessoa a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pessoa, por meio de contato direto ou de secreções respiratórias (aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões de pele. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. O período de transmissibilidade varia de 2 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta. Por este motivo, o retorno da criança ao ambiente escolar depende da fase das lesões cutâneas, isto é, todas as lesões deverão estar na fase de crosta. Resposta Letra D.

318001.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas a respeito das vacinas a) CORRETA. As vacinas citadas fazem parte do calendário da criança e ou do adolescente e são capazes de prevenir, além de outras doenças, a meningite bacteriana. B) INCORRETA. A primeira parte da afirmativa é verdadeira, mas o principal benefício da vacina BCG é conferir proteção contra formas graves, como tuberculose miliar e meníngea. c) INCORRETA. A vacina DTPa está indicada para crianças que desenvolveram episódio hipotônico hiporresponsivo ou convulsão ao receber a dose de DTP. Crianças que desenvolveram encefalopatia não podem receber mais o componente Pertussis, sendo recomendada a administração da vacina DT (dupla tipo infantil). d) INCORRETA. A vacina oral contra rotavírus é uma vacina atenuada (não inativada), que previne diarreia causada por este agente. É contraindicada para crianças com malformações intestinais não corrigidas ou com história prévia de invaginação intestinal. Resposta letra A.

294330.

Comentário: Se a suplementação é indicada para crianças de 6 a 59 meses, sabidamente as duas faixas etárias (lactente e pré-escolares) são as de maior risco. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a deficiência de vitamina A seja responsável, anualmente, por 250 mil a 500 mil crianças cegas, com cerca de 14 milhões de pré-escolares com dano ocular entre 1995 e 2005. Para a OMS, o Brasil apresenta moderada prevalência de deficiência de vitamina A em pré-escolares, ou seja, entre 10 e 20%, que é a faixa etária de maior risco. Desta forma, os pré-escolares tem maior prevalência do que os lactentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

295418.

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas feitas em relação às recomendações vacinais da pequena Maria Clara. A opção A está incorreta a vacina contra hepatite B deve ser feita logo após o nascimento e não se trata de uma vacina de vírus atenuado. Trata-se de uma vacina composta apenas pelo antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg). Cabe indicar que no caso desta criança devem ser obrigatoriamente feitas quatro doses desta vacina. Isso é sempre indicado para todas as crianças nascidas com menos de 2.000 g ou 33 semanas atualmente todas as crianças acabam recebendo quatro doses dentro do PNI, pois recebem a vacina ao nascer e mais três doses da vacina na forma da vacina penta. Todavia, crianças vacinas em clínicas privadas de vacinação podem receber apenas a doses feita ao nascimento e mais duas doses após, pois não é usada a mesma vacina penta usada na rede pública. Em uma situação como a do caso, mesmo crianças vacinadas na rede privada devem receber quatro doses. A opção B também está errada a vacina BCG tem como contraindicação o peso inferior a 2.000 g, podendo ser feita quando a criança atinge este peso. A opção C está errada a vacina contra rotavírus não deve ser feita em crianças com malformações congênitas do trato gastrointestinal não corrigidas e pode ser feita em Maria Clara, todavia, a vacinação dos prematuros é feita conforme a idade cronológica, não corrigida. Além disso, a primeira dose da vacina é feita aos dois meses. Finalmente, a opção D está correta a vacina penta (DTP anti-hemófilo tipo b hepatite B) é feita em três doses, aos dois, quatro e seis meses. O esquema será modificado apenas se acontecerem eventos adversos, como, por exemplo, o episódio hipotônico hiporresponsivo. Resposta letra D.

294331.

Comentário: A questão apresenta os sintomas habitualmente descritos na hipovitaminose B12, que são adinamia, anorexia, hiperestesia, dermatites, inclusive perioral, glossite, alopecia, conjuntivite, ataxia, mialgias, diminuição do aprendizado e retardo mental. Logo, esta é a resposta corrta. Analisando as demais alternativas a hipovitaminose A está associada a cegueira noturna e demais alterações oculares a deficiência de vitamina B1, a tiamina, é a causadora da beribéri. A carência da tiamina pode levar de dois a três meses para manifestar os sinais e sintomas que inicialmente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

são leves como insônia, nervosismo, irritação, fadiga, perda de apetite e energia e evoluem para quadros mais graves como parestesia, edema de membros inferiores, dificuldade respiratória e cardiopatia por fim, a hipovitaminose C leva ao escorbuto. Os sintomas podem ser fadiga, artralgia, problemas de cicatrização, inflamação gengival e equimoses.

308296.

Comentário: Segundo classificação do Ministério da Saúde, crianças de zero a cinco anos que apresentam IMC maior que p85 e menor ou igual a p97 estão em risco de sobrepeso. Se o IMC estiver acima do p97, temos o diagnóstico de sobrepeso. Visto isso, a questão não apresenta alternativa que contemple resposta correta e foi acertadamente anulada.

294337.

Comentário: A vacina contra a dengue foi licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA em 2016. Trata-se de uma vacina de vírus vivos atenuados, tetravalente, composta por quatro cepas recombinantes vivas atenuadas de vírus da dengue. A vacina está licenciada no Brasil para indivíduos de 9 a 45 anos de idade no esquema de três doses (0, 6 e 12 meses) e é recomendada para indivíduos previamente infectados por um dos vírus da dengue (soropositivos com ou sem história da doença). A vacina não deve ser administrada em indivíduos portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, incluindo aqueles em terapia imunossupressora. Também não deve ser aplicada em gestantes, lactantes e pessoas que vivem com HIV Aids. Resposta nove anos.

316386.

Comentário: O objetivo primário da vacina BCG é proteger contra as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea), que são mais comuns nos menores de 1 ano, e a vacina não é capaz de evitar a infecção tuberculosa em si (letra D incorreta). Desde janeiro de 2019, o MS da saúde deixou de recomendar a revacinação das crianças que não evoluíram com formação de cicatriz seis meses após a dose inicial, como era feito até então, pois a ausência de cicatriz não implica em ausência de proteção (letra B incorreta, letra A correta). A revacinação só estará indicada em situação específica, como o contato domiciliar com paciente com hanseníase, em que estaria indicado para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

essa paciente maior de 1 ano, sem cicatriz vacinal, a vacinação com 1 dose adicional. A ausência de cicatriz vacinal não tem relação com imunodeficiência é a ocorrência de BCGíte pós-vacinal que caracteriza um de sinais de alarme para imunodeficiência primária, sendo essa uma situação em que deveríamos indicar investigação apropriada (letra C incorreta). Resposta letra A.

318015.

Comentário: Pacientes que apresentaram quadro de desnutrição energético-protêica, também irão ter, com frequência, carência de micronutrientes e vitaminas. Assim, quando o pacientes se recuperar da fase crítica e o tratamento entrar na fase de manutenção, está indicado que haja aporte de calorias, proteínas e suplementação de vitaminas e micronutrientes em regime ambulatorial. Resposta letra C

311984.

Comentário: A baixa estatura é caracterizada por uma estatura por idade abaixo do percentil 3 para idade e sexo, ou abaixo do escore-z - 2 (letra A não apresenta patologia e a letra D apresenta uma provável patologia). A puberdade fisiológica em meninos ocorre entre os nove e 14 anos de idade e o primeiro sinal é o aumento do volume testicular. Em seguida, ocorre a pilificação pubiana e o aumento do pênis (letras B e C não apresentam patologias). Resposta letra D.

265846.

Comentário: O autor até facilitou , já que as vacinas de sarampo e rubéola são realizadas juntas, na forma de tríplice viral, uma vacina composta por vírus vivos atenuados. A vacina contra hepatite B é inativada e deve ser realizada se a gestante não for imunizada. A dTpa (difteria, tétano e pertussis) está recomendada em todas as gestações, a partir da 20ª semana. A salk (VIP) é a vacina inativada contra poliomielite. Não há recomendação formal de que seja realizada na gestação, mas também não há contraindicação à sua realização. Resposta letra B.

285089.

Comentário: Bem direta. Atualmente, a vacina contra HPV está recomendada para meninas com idade entre 9 e 14 anos e para meninos entre 11 e 14 anos, em duas doses com intervalo de 6 meses entre elas. A vacina está disponível também para pacientes com HIV, submetidos a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transplantes de órgãos sólidos, medula óssea ou pacientes oncológicos, em esquema de 3 doses, aplicadas nos tempos 0 - 2 - 6 meses. Pessoas desses grupos recebem a vacina dos 9 aos 26 anos. Resposta letra D.

281832.

Comentário: A complicação historicamente relacionada a vacina contra o rotavírus é a invaginação ou intussuscepção intestinal. Antigamente, houve uma suspeita relação entre a vacina contra o rotavirus e invaginação (intussuscepção) intestinal, provavelmente provocada por uma intensa resposta inflamatória intestinal provocada pela vacina, cujos vírus derivavam de macacos. A vacina atual é feita de vírus humanos e não há essa relação com a complicação, mas só podemos marcar essa opção. Resposta letra D.

273155.

Comentário: A caxumba é uma infecção aguda, autolimitada, causada por um vírus de RNA da família Paramyxoviridae. O quadro clínico é caracterizado por febre, edema parotídeo uni ou bilateral e possibilidade de evoluir para meningoencefalite e orquite. Como acontece com boa parte das doenças virais da infância, a disseminação ocorre de pessoa a pessoa por meio do contato direito com góticulas, produzidas através da saliva e espirros. O período máximo da infecção ocorre de 1-2 dois antes até cinco dias após o início do edema parotídeo. Resposta letra A.

285092.

Comentário: Não temos dúvidas que estamos diante de um acidente grave, visto que o ferimento envolveu área da mão. O grande questionamento seria quando a suspeita de raiva ou não do cão. O fato dele ser um cão que foi recém-chegado na casa da vizinha, a questão não sinalizou qualquer suspeita de raiva no momento da agressão. Pelo contrário, por ser um cão de fácil acesso, é possível realizar a observação deste. Logo, o esquema a ser feito é o de acidente grave cão sem suspeita de raiva no momento da agressão, que pelo esquema do Ministério da Saúde, as condutas são Lavar com água e sabão. Observar o animal durante 10 dias após exposição Iniciar esquema profilático com duas doses uma no dia 0 e outra no dia 3. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dar continuidade ao esquema profilático, administrando o soro e completando o esquema até 4 doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose no dia 14 Logo, a alternativa A é a única que responde corretamente a questão. Resposta letra A.

277459.

Comentário: A desnutrição grave suprime a resposta imune, por isso muitos pacientes acabam evoluindo com infecção. Nesse sentido, devemo considerar que todas crianças com desnutrição grave têm infecção e devem receber antibióticos desde o início do tratamento. No geral, os pacientes são oligossintomáticos. (letra A incorreta e B correta). Além disso, a criança com desnutrição com frequência não apresenta sinais de irritação meníngea. podendo apresenta apenas sonolência e apatia (letra C incorreta). Em relaçào ao tratamento, os antibióticos de escolha são sulfametoxazol trimetoprima, naqueles sem sinais aparentes de infecção ou gentamicina ampicilina, naqueles com sinais sugestivos (letra D incorreta). Resposta letra B.

274511.

Comentário: A Sociedade Brasileira de Pediatria, em conformidade com a Academia Americana de Pediatria, recomenda o tempo de tela adequado para cada idade, de acordo com a maturação e desenvolvimento cerebral. Os estudos mostram a associação entre excesso de exposição a telas na primeira infância e atraso no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, atrasos sociais, descontrole emocional, além de comportamentos agressivos, alterações sociais e de sono e até mesmo dificuldades alimentares. A recomendação de exposição a mídias para crianças menores de 2 anos é tempo zero (letra C errada), pois as evidências das pesquisas mostram que as interações sociais com os cuidadores são muito mais eficazes e estimulantes para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, da interação social e das habilidades motoras (letras B errada). A letra B está errada, pois generalizou a idade. Entre a idade de 2 anos completos e 5 anos a recomendação é de 1 hora por dia ao todo, ou seja, somando-se o período diário que a criança permanece na TV, celular, tablets e videogames (letra D errada). Crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1-2 horas dia, sempre com supervisão de pais responsáveis. Adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

videoga- mes a 2-3 horas dia, e nunca deixar virar a noite jogando. Resposta letra A.

265905.

Comentário: Não precisava nem saber os números exatos para acertar a questão - bastava lembrar que a recomendação, em adultos não vacinados ou sem comprovação de vacinação, é que sejam realizadas 3 doses de vacina contra hepatite B, porque esse é o número de doses que comprovadamente induz títulos protetores de anti-HBs. As alternativas B e D estão incorretas porque trazem o conceito contrário, de que as três doses não conferem ou conferem pouca proteção. A alternativa C traz o conceito correto - para relembrar, se um paciente tem comprovação de uma ou duas doses da vacina, basta prescrevermos as doses faltantes, não sendo necessário reiniciar o esquema. Resposta letra C.

274826.

Comentário: Vamos relembrar todas as vacinas recomendadas até os 6 meses Ao nascimento BCG hepatite B. Aos 2 meses pentavalente (hepatite B, hemofilus B, DTP), VIP, pneumocócica 10 valente e rotavírus. Aos 3 meses meningocócica C. Aos 4 meses as mesmas vacinas realizadas aos 2 meses. Aos 5 meses meningocócica C. Aos 6 meses pentavalente, VIP. Agora é só agrupar tudo essa criança, aos 6 meses de vida, precisa ter recebido uma dose de BCG, uma de hepatite B, 3 doses de pentavalente, 3 doses de VIP, 2 doses de rotavírus, 2 doses de meningocócica C e 2 doses de pneumocócica 10 valente. Resposta letra B.

282051.

Comentário: Ao avaliar um escolar de 9 anos com baica estatura (estatura abaixo do escore z -2 ou percentil 3), o primeiro passo é avaliar a velocidade de crescimento, pois é considerado a melhor medida para avaliação do crescimento linear. A banca não forneceu a velocidade de cresimento, mas a banca te induz a pensar que houve uma desaceleração de seu crescimento nos últimos anos (sabemos que as variantes da normalidade cursam com velocidade de crescimento normal) Repare também que além de baixa estatura, há atraso puberal, idade óssea atrasada e desinteresse escolar, o que fala a favor de uma endocrinopatia. A que mais comumente causa a baixa estatura é o hipotireoidismo. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

282056.

Comentário: Vejamos as alternativas A letra A está errada sabemos que a vacina contra febre amarela está indicada aos 9 meses e passou a ser indicado reforço aos 4 anos de idade. A letra B esá correta a vacina meningocócica ACWY passou a ser ofertada pelo PNI para adolescentes de 11 a 12 anos de idade, em uma dose. A letra C está errada a vacina da BCG não possui mais indicação de ser refeita quando não for observada cicatriz vacinal. A letra D está errada aos 6 meses a vacina contra poliomielite aplicada é a VIP, que é intramuscular. A VOP está indicada nos reforços aos 15 meses e 4 anos de idade. Resposta Letra B.

231936.

Comentário: O Ministério da Saúde recomenda que toda gestante, independentemente da idade gestacional, deve receber a vacina contra o Influenza durante a campanha anual. Logo, a gestante em tela pode receber a vacina imediatamente. Resposta letra A.

229819.

Comentário: É importante a adoção de atividades de prevenção primária, tais como estímulo à dieta com boa qualidade nutricional e à prática de atividades físicas regulares, com a finalidade de eliminar ou diminuir, de maneira eficaz e efetiva, o risco de obesidade. Para isso, o Ministério da Saúde lançou os 10 passos para ter uma alimentação saudável, que tem por objetivos principais orientar para escolhas alimentares mais adequadas e evitar a obesidade e demais síndromes metabólicas. Resposta letra B. Questão correta e não passível de recurso

229821.

Comentário: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, o Ministério da Saúde instituiu este ano a dose zero , que é indicada para todas as crianças de 6 a 12 meses, devendo ser vacinada. É importante esclarecer que a dose zero não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança, ou seja, a vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomado ou não a dose zero. Resposta letra C.

246529.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre a raiva humana I - O período de incubação dessa infecção neurotrópica viral é de 1 mês a 90 dias. O período de incubação é mais curto quando a exposição ocorre em áreas ricamente inervadas (ex. na face). CORRETA. II - Essas são as manifestações da forma paralítica . A forma encefalítica clássica é caracterizada por hidrofobia, aerofobia, espamos faríngeos, instabilidade autonômica e coma. INCORRETA. III - A raiva é uma das doenças infecciosas mais letais conhecidas e há poucos casos de sobreviventes descritos na literatura. As principais causas de óbito são asfixia secundária a espasmos musculares ou convulsões generalizadas na raiva encefalítica ou fadiga respiratória na raiva paralítica. CORRETA. Resposta D.

241704.

Comentário: A questão aborda o calendário de pessoas que vivem com HIV a partir dos 13 anos. A letra A está correta é recomendável fornecer dose dobrada de vacina anti-hepatite B, em quatro doses no total. A letra B está incorreta em termos de contagem de células CD4, apenas o resultado 200 cel ml contraindica de forma absoluta a vacinação contra febre amarela a contagem entre 200 e 350 cel ml permite que a vacina seja considerada. A letra C está incorreta a vacina contra varicela está recomendada, sendo necessária a avaliação do estado imunológico. Para aqueles maiores de 13 anos não imunizados, são feitas duas doses com intervalo entre elas de um mês. A letra D está incorreta a vacina anti-HPV está indicada a partir de nove anos até os 26 anos de idade para o sexo masculino ou até 45 anos para o sexo feminino (orientação vigente a partir de 2021 apenas), independentemente da contagem de CD4, com esquema de três doses, em intervalos de zero, dois e seis meses. A letra E está incorreta a vacina contra influenza deve ser fornecida anualmente a essa população. Resposta letra A.

254232.

Comentário: A única certeza que temos é que Roberto recebeu a BCG, por isso não será necessário realizar esta vacina (alternativas A e C incorretas). Como não há comprovação de nenhuma outra vacina, iremos considerar que todas estão em atraso e começar o esquema do zero . As vacinas que ele já deveria ter recebido até o momento são pentavalente, VIP, pneumocócica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10, meningocócica C e rotavírus. A primeira dose desta última, no entanto, só pode ser realizada até 3 meses e 15 dias de vida, por isso não iremos realizá-la (pelo risco aumentado de invaginação intestinal). Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina